

 临床思维指南



精神障碍

典型病例分析

科学的临床思维方法是正确临床决策的基础。凝聚着国内资深医学专家的经验 and 智慧，通过对历经多年积累的典型及疑难病例的综合分析，书中所展示的精炼的思维方法和清晰的诊断思路，将引领勤奋好学的临床医生们走进探索成功的殿堂。

● 主 编 翁永振 副主编 江镇康

Jingshen Zhangai Dianxing Bingli Fenx

 科学技术文献出版社



临床思维指南

精神障碍典型病例分析

Jingshen Zhiangai Dianxing Bingli Fenxi

封面设计
宋雪梅

ISBN 7-5023-4267-2



9 787502 342678 >

ISBN 7-5023-4267-2/R·1023

定价: 38.00元

临床思维指南

精 神 障 碍

典型病例分析

主 编 翁永振

副主编 江镇康

编 者 (按姓氏拼音排列)

鲍 枫	杜万君	郭 崧	江 伦	江镇康	姜 涛
梁月竹	李 樱	李建茹	刘稚颖	马胜民	马 辛
牛光胜	盛利霞	沈东郁	田祖恩	翁永振	项玉涛
许克勤	许 英	向应强	谢家康	杨建虹	杨蕴萍
于 靖	于庆波	郑 毅			

科学技术文献出版社

Scientific and Technical Documents Publishing House

北 京

图书在版编目(CIP)数据

精神障碍典型病例分析/翁永振主编.-北京:科学技术文献出版社,
2003.9

(临床思维指南)

ISBN 7-5023-4267-2

I. 精… II. 翁… III. 精神障碍-病案-分析 IV. R 749

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 012444 号

出 版 者 科学技术文献出版社
地 址 北京市复兴路 15 号(中央电视台西侧)/100038
图书编务部电话 (010)68514027,(010)68537104(传真)
图书发行部电话 (010)68514035(传真),(010)68514009
邮 购 部 电 话 (010)68515381
网 址 <http://www.stdph.com>
E-mail:stdph@istic.ac.cn;stdph@public.sti.ac.cn
策 划 编 辑 李卫东
责 任 编 辑 樊雅莉
责 任 校 对 唐 炜
责 任 出 版 王芳妮
发 行 者 科学技术文献出版社发行 全国各地新华书店经销
印 刷 者 三河市富华印刷包装有限公司
版 (印) 次 2003 年 9 月第 1 版第 1 次印刷
开 本 787×960 16 开
字 数 441 千
印 张 25.25
印 数 1~6000 册
定 价 38.00 元

© 版权所有 违法必究

购买本社图书,凡字迹不清、缺页、倒页、脱页者,本社发行部负责调换。

(京)新登字 130 号

内 容 简 介

精神障碍威胁着人类的健康,但是危害人们的主要精神疾病的病因至今未明确,对病因未明精神疾病的诊断缺乏客观检查的依据,而主要依靠对病例资料的分析。本书对首都医科大学附属北京安定医院多年来积累的病例资料进行筛选,将常见的精神疾病的典型病例进行分析、总结,做出诊断;同时对常见疾病的治疗原则做了介绍,对治疗方法和预后进行讨论。

本书内容还包括病历采集、精神检查方法的介绍,其中的技巧不但有书本知识的综合,也有安定医院医生长期临床经验的总结;所收录的病例有些是多年随访的纪录,有不少病例就诊时关于诊断存在分歧,经多年观察诊断已经明确,书中对分歧的原因做了分析,有助于读者思考。

本书适合于精神科临床医师阅读,可供医疗系学生在临床实习时参考使用,也可以作为科普读物以丰富人们有关精神障碍方面的知识。

科学技术文献出版社是国家科学技术部系统惟一一
家中央级综合性科技出版机构,我们所有的努力都是为
了使您增长知识和才干。

前言

多数精神疾病的病因至今尚不清楚,其中包括占住院床位 50% 以上的精神分裂症,以及近年来备受关注的多发病——抑郁症。由于病因不明,因此尚没有可靠的实验室检查指标作为多数精神障碍诊断的参考依据,但是我们通过多年来临床资料的积累和长期对疾病规律的研究,发现大部分相同诊断的病例有相似的临床表现、类似的预后且对相同的治疗有相近的疗效,可见,相同的诊断可能有共同的生物学改变。由于精神疾病的临床表现、症状结构错综复杂,如精神分裂症病人有抑郁症状,有 30% 左右的情感性障碍的病人有精神病性症状,因此常有诊断错误。由于诊断的失误,难以制订正确的治疗方案,延误治疗,从而痛失最佳治疗时机,使相当数量的病人长期处于精神残疾状态。

自从 20 世纪中叶抗精神病药物用于临床以后,改变了精神疾病的治疗面貌,以后又不断开发出各种抗抑郁药、抗焦虑药、抗躁狂药等。由于抗精神病药物的不断丰富,医生的选药空间不断扩大,这就对医生提出更高的要求,不仅要求医生对抗精神病药物有丰富的知识和用药经验,更重要的是对疾病的诊断水平要求更高。由于常见的精神疾病没有客观的生物学指标作为诊断参考依据,因此精神科医生必须具备良好的临床诊断技能。精神科医生应该掌握收集资料、描述精神症状的能力和临床分析资料的技能。为了达到上述目的,本书向读者提供较为典型的精神障碍的病例,对每个病例进行讨论分析,做出诊断和鉴别诊断,同时叙述治疗的经过和对预后的推测。本书的读者对象主要是低年资精神科医师、通科医生和医学生,可作为临床技能训练的参考读物。

首都医科大学附属北京安定医院是一所有 80 多年历史的精神专科医院,分科齐全,有成人精神科、儿童精神科、老年精神科、临床心理科、司法精神病学、物质依赖防治科和中医精神科等,全院有 900 张床位,日平均门诊病人在 400 名左右,因此有丰富的病例资料。本书的作者为经验丰富的在临床工作多年的医师、临床心理师,由于专业有所区别,不同作者对病例的分析方法也有所不同,请读者谅解。

由于水平和能力所限,本书的内容难免有疏漏和谬误之处,请读者不吝指教。

主编

2003 年 8 月于北京

科学技术文献出版社



科学技术文献出版社方位示意图

科学技术文献出版社 北京 中关村大街

地址：北京市中关村大街27号（原北京图书馆旧址）

目 录

第一章	精神障碍及精神状态的检查	(1)
第二章	精神分裂症	(30)
第三章	情感性精神障碍	(100)
第四章	其他精神病性障碍	(128)
第五章	应激相关障碍	(143)
第六章	阿尔茨海默病	(161)
第七章	脑血管病所致精神障碍	(178)
第八章	癫痫所致精神障碍	(188)
第九章	躯体感染所致精神障碍	(200)
第十章	颅脑损伤所致精神障碍	(208)
第十一章	颅内肿瘤所致精神障碍	(219)
第十二章	脑变性疾病所致精神障碍	(230)
第十三章	躯体疾病所致精神障碍	(245)
第十四章	神经症及心理因素相关生理障碍	(255)
第十五章	人格障碍	(272)
第十六章	癯症	(286)
第十七章	精神发育迟滞	(299)
第十八章	儿童期精神障碍	(314)
第十九章	精神活性物质与非依赖性物质所致精神障碍	(367)

精神障碍及精神状态的检查

第一节 什么是精神健康、精神障碍和精神疾病

在讨论精神健康以前,首先要了解什么是健康,按一般人的理解,健康就是没有病,疾病就是失去了健康,但是,健康和疾病都是生命所固有的,疾病是生命的一部分,是威胁生命或对生命不利的有待克服的风险。人具有社会性,又有精神活动,这使疾病的概念更为复杂,而且人们对疾病的认识在不断地发展。世界卫生组织(WHO)提出的健康十大准则有以下内容:

1. 有充沛的精力,能从容不迫地担负日常生活和繁重工作,而不感到过分紧张与疲劳。

2. 处世乐观,态度积极,乐于承担责任,事无大小,不挑剔。

3. 善于休息,睡眠好。

4. 应变能力强,能适应外界环境的各种变化。

5. 能够抵抗一般性感冒和传染病。

6. 体重适当,身体匀称,站立时头、肩、臂位置协调。

7. 眼睛明亮,反应敏捷,眼睑不发炎。

8. 牙齿清洁,无龋齿,不疼痛;牙龈颜色正常,无出血现象。

9. 头发有光泽,无头屑。

10. 肌肉丰满,皮肤有弹性。

可见健康包含躯体及心理、社会功能等内容。精神医学的任务是增进精神(心理)健康,目前,在它的分类和命名中很少使用疾病(disease)这个术语,大多数的情况下采用精神障碍(mental disorder)一词。精神障碍的判定离不开文化及价值观的衡量尺度,因此,精神障碍概念的形成,不但有医学家和生物学家参与,还要有心理学家、社会学家、教育学家、法律学家和人类学家的加入。精神障碍应该将心理学和社会学标准结合起来衡量,如精神发育迟滞需由心理学标准——智商低下和社会学标准——适应能力下降来共同界定。如果患者只有轻度智力低下(如 IQ 低于 70),但是能够适应简单体力劳动和自食其力,并能被社会所接受,那么不能单用心理学标准来诊断为精神发育迟滞。同样,因患精神分裂症导致社会角色改变,譬如一位高级会计师在患精神分裂症后不能胜任原工作,改任报纸分发员,虽然收入下降,但是工作出色,经常获得奖励,按照精神病学的标准,该患者在病后有残留心理功能缺损,但是在改变患者的环境后,他尚具备良好的社会功能;换句话说,此患者在特定的环境中的精神是健康的。

第二节 精神障碍的诊断

精神科的诊断程序与其他临床各科是一样的。第一步:采取病史;第二步:根据病史资料进行检查:包括体格检查、实验室检查和必要的特殊检查(精神科必须包括精神检查);第三步:分析病例,将收集的资料进行分析、综合,总结出病例的特点;第四步:按疾病或精神障碍的诊断标准做出诊断,鉴别诊断。但是,精神科的诊断有其特殊之处:①由于精神病人常常否认有病,病史需要由其家属或其监护人提供;②精神检查是精神科极为重要的内容,其他各科并无此项内容。

第三节 病史对精神障碍诊断的作用

收集病史的目的在于获得病人的信息,用于诊断、估计预后及制订治疗方案。由于精神疾病多数缺乏客观指征,实验室检查的结果很少有支持或排除诊断的信息。精神科的诊断主要依靠精神科医生从病人(精神检查)或其监护人获得的信息。因此,医生必须具备搜集上述信息的技巧,并有分析所获信息的能力和知识才能做出正确诊断。至今,现有的一切评定或诊断的方法所得出的结果,其准确性都

没有超过医生根据上述信息所做出的判断和结论。在精神科,从目前医学发展水平来说,详细可靠的病史和对患者精神症状的具体描述和动态观察,仍是诊断精神障碍的重要依据。当然,各种心理测查和其他医学检查的结果,可能有一定的参考价值。

第四节 如何采集病史

一、住院病人病历的采集

+++++

因为没有客观的指标作为诊断的依据,医生的主观随意性有可能极大地影响诊断,使诊断的可信性受到挑战。在 20 世纪 50 至 60 年代之间,我国对精神分裂症的诊断范围被扩大,影响了国内外的学术交流和治疗预计、预后估计的有效性。从 20 世纪 80 年代以后,全世界的精神科专家进行广泛的探讨,按临床症状及临床发展过程进行客观描述,制定诊断标准,按公认标准进行诊断,摒弃推测性和主观印象性诊断方法。中国制订了“中国精神障碍分类与诊断标准”(CCMD),于 2001 年 4 月出版了第 3 版(CCMD-3)。另外,在世界卫生组织(WHO)的主持下制订了国际疾病分类第 10 版(international classification of diseases, ICD-10)以及美国制订的标准——精神障碍诊断和统计手册(diagnostic and statistical manual for mental disorders, DSM-IV)。这 3 种版本在主要常见病的诊断标准上非常接近,但是又符合制订国的国情和文化特征,而 ICD-10 则吸收了各国专家的意见,可被多数国家的专家所接受。由于用客观描述精神障碍或症状的方法,对精神障碍的诊断容易取得一致的意见,诊断的可信性大有提高,从而有助于学术交流和提高治疗水平;这使精神病学向科学化又靠近了一大步。这一大步的迈进在于精神科的专业人员对精神状况描述的重要性的认识。描述是一切门类科学发展的前提,只有把自己所观察到患者的精神状况(事实)进行准确的描述,才能做出正确的诊断。相同的事实由不同的观察者进行描述,对这种描述进行分析很容易得出共同的结论。

精神科医师中的初学者希望听几堂课或看几本书就掌握症状或精神障碍诊断的技能是不现实的,本书的目的之一就是让初学者认识到描述在精神病学中的重要性,可作为锻炼描述技能的参考。

在采集病史中,患者本人或病史报告者,常用笼统的言语表达,如:“他常胡说

八道!”如果将这句话写入病历就没有意义,病历采集者应提出具体的问题,请病史报告人将所见所闻具体描述出来。如向病史报告者提问:“他胡说些什么话?”“他说这些话的时候有哪些动作或什么表情?”如果能将被访人的具体描述言语记录下来,对诊断就很有参考价值。如果病人的言语很生动,伴有欣喜的表情,就有躁狂症的可能性;如果病人说话的内容离奇古怪,或者语句凌乱或者只是词句的堆砌而无法使人理解,那么患者就可能患有精神分裂症。

采集病史要求有一定技巧,首先医生和被访者之间应当是平等的关系,既应当耐心听取他们的叙述,又要适当插话引导,从访谈中获得有用的信息。

(一)住院病历的书写格式

1. 个人资料
2. 主诉
3. 现病史
 - A. 起病
 - B. 诱因
 - C. 疾病的演变过程
4. 既往病史
 - A. 精神病史
 - B. 躯体疾病史
 - C. 饮酒史或物质滥用史
5. 个人史
 - A. 母亲孕产期
 - B. 儿童早期(从出生到3岁)
 - C. 儿童中期(从3岁到11岁)
 - D. 儿童晚期(从少年期到青春期)
 - E. 成人期:职业史,婚姻史,教育史,社交活动,生活现状,性心理史
6. 家族史

(二)病历采集的内容

1. 个人资料

包括姓名、性别、年龄、婚姻、职业、籍贯、民族、文化程度、政治面貌、宗教信仰、工作单位、家庭住址、电话号码、资料来源。还应指出患者是自愿住院的,经过别人

5. 个人史

(1) 母亲孕产史

医生要考虑患者出生的家庭环境,父母是否想生这个孩子?母亲怀孕和分娩时有什么问题?婴儿出生时有什么缺陷或损伤?母亲妊娠期的情绪和躯体状态如何?怀孕过程中母亲有什么健康问题?母亲是否酗酒或滥用药物?

(2) 儿童早期(从出生至3岁)

睡眠形式的早期障碍情况,当要求未被满足时的表现,如有撞头、扭动身体等行为,提示可能由于母爱剥夺或发育障碍。父母是否有精神病或躯体病,妨碍了与患者相互交流?

患者与陌生人接触或与父母分开时,是否表现出过多的焦虑?了解患者兄弟姐妹的情况和患者受母乳喂养,还是用牛奶喂养?记录行走、讲话、出牙、语言、运动发育的时间顺序和情况。记录行为问题的症状,如吮大拇指、发脾气、肌抽搐、撞头、摇头、夜惊、害怕、尿床、咬指甲等。儿童开始表现的性格也是重要的,是否经常害羞、吵闹、活动过多、退缩、好学、外向、胆小、活跃、友好?记录患者不断增长的注意力情况,承受挫折和克制某些愿望的能力。患者参加游戏时,愿意扮演主动角色,还是被动角色?最喜欢的游戏或玩具是什么?他愿意自己玩,还是愿意跟别人一起玩,或根本不愿意跟别人一起玩?

(3) 儿童中期(从3岁到11岁)

儿童如何分辨自己的性别?家庭对孩子的惩罚情况,谁给孩子立规矩?孩子的良知形成受谁影响?早年的学校生活,尤其是患者如何忍受第一次与母亲分离?患者有几个朋友?亲密程度如何?患者在伙伴中的地位,是否受大家欢迎?是否参加集体活动?患者能和伙伴合作吗?患者和其他同伴玩耍时能否遵守游戏规则,是否不讲道理。患者与同学交往中表现的主见、冲动、攻击、被动、焦虑、反社会行为。学习阅读、发展智力和运动技巧情况,如患者学习能力差,他如何应付?这种情况对他有什么影响?还要了解患者出现噩梦、手淫、恐怖症、尿床、纵火、虐待动物等情况。

(4) 儿童晚期(从少年期到青春期)

了解患者通过发展与同龄人的关系和参加集体活动,自何时开始从父母那里独立出来。医生应该确定患者在人群中的价值观。

6. 家族史

有些精神疾病是家族性的,并可能与遗传有关。应该记录患者家族成员中何人(和患者的血缘关系)曾经或正在患有精神疾病,其具体表现是什么,诊断如何。

第五节 如何做精神检查

精神检查对精神障碍者来说和患躯体疾病者的体格检查具有同等意义。精神检查所得的信息提供患者的思维、情绪、行为状况的资料,以固定格式系统地记录下来。将精神检查资料结合病史内容进行分析,可以构成诊断和鉴别诊断。

精神检查可以获得目前的精神症状的资料,而病史可获得以前的精神障碍的信息。例如,精神检查时,患者否认幻听,而在病史中有明确的记录,这样医生才能根据描述性的记录对病人有一个全面的评价,摒弃推论性的诊断。从1980年以后,各国精神障碍诊断标准都强调对精神症状具体描述,各国学者都认为,只有观察到的信息才有价值。如只记录“话多”而没有具体描述就没有太大价值,如果凭借动作多、话多而推论诊断“思维奔逸”,这种推论通常是不可靠的。细致的描述所做出的诊断能提高其可信性。所观察到的资料只做忠实的记录,不要进行推测和解释。如“可见情绪低落”这样解释性的用词在精神检查记录中出现是不可取的。

格式化的精神检查记录是必要的,借以表明检查和记录是完整的。在精神检查过程中手段是灵活的,精神检查的信息可以凭观察获得,也可从特殊检查获得,和患者交谈是精神检查的重要手段。有经验的医生在精神检查中可以同时做几件事情:建立和患者良好的关系、阐明或补充病史中的信息、观察患者的情绪状态和观察其他精神状态。在精神检查的过程中,尽可能避免审问式的精神检查。有时患者在医生面前有些紧张或病人不善言谈,医生应当对他们采取以下措施,改变审问式的谈话,像是朋友似的聊天。可以采用以下方法:

(1) 鼓励

病人:“我嘴笨,我怕说不清楚。”

医生:“我认为您刚才说得就很明白!”

(2) 增强信心

医生:“我能理解您的体验,您的体验确实很可怕,我相信如果您同意接受治疗会有很好疗效。”

(3) 同情

医生:“我看到当您谈到您的母亲去世时流了眼泪。”

(4) 非言语交流

用体态、面部表情,来表示对病人所谈的内容感兴趣、关心,并予以注意。

(5) 在病人语塞时予以引导

有时病人对医生的问题难以理解,一时答不上来。病人一时语塞,感到很尴尬,医生应改变话题,将复杂的问题分解和将问题简化,如:“您现在胃口和睡眠有什么变化?”

(6)多问几个“为什么”打开病人的思路

医生:“为什么您出门就害怕?”

(7)善于引导话题,不随病人话题走

病人:“我整夜都不能睡觉。”

医生:“您的胃口好吗?”或:“您是不是感到整天没力气?”

(8)减低病人的心理负担

病人:“我收入不抵支出,我老想有点节余,可是我做不到,挺烦的!”

医生:“哦!我就不太在意,有不少人也入不敷出。”

(9)给病人一些不成熟的建议

病人:“工作真难!我的领导像一只老鹰一样,总盯着我,老鸡毛蒜皮似的挑剔。”

医生:“您为什么不向他简单地写张条子说说您的难处。”

精神检查的书写:在精神检查中所获得的信息应当按规定的格式进行整理,并做出完整及有条理的记录。下面是常用的精神检查记录格式。

(一)精神检查记录格式

1. 一般表现

(1)意识状态:意识是否清晰,有何种意识障碍(包括意识障碍的水平和内容)。

(2)定向力:对时间、地点及人物的定向能力。自我定向如姓名、年龄、职业等。

(3)接触情况:主动或被动,合作情况及程度,对周围环境的态度等。

(4)日常生活:包括仪表、饮食、大小便及睡眠情况,参加病房集体活动及工娱治疗情况,女患者能否主动料理经期卫生等。

2. 认识活动

(1)知觉障碍

①错觉:种类、出现时间及频度。与其他精神症状的关系及影响。

②幻觉:种类、出现时间及频度。与其他精神症状的关系及影响。

③感知综合障碍:种类、出现时间及频度等。

(2)注意力:是否集中,是否涣散,可能影响的因素有哪些。

(3)思维障碍

度、自发或被动交谈,言语的句法结构等。任何缄默不语状况都应描述。例如,躁狂症患者可能说话声音很高,速度很快。抑郁症患者可能说话声音很低,吞吞吐吐等情况都应具体描述。

举例:

患者主动攀谈而语速很快,有时语速紧迫,难以打断(附以具体的句子),语声高亢,表达的节奏和语调正常,言语吐字不清,难以听懂。

3. 情绪表达

多年来用心境和情感表述情绪,至今仍在应用。心境一般指的是主导的情绪状态,在一段时间内是稳定的。情感随着个人思维内容的改变而改变。有的学者认为没有必要区别心境和情感,不要企图分别对心境和情感进行检查,而是对患者情绪的客观表现和主观体验进行检查和描述。

情绪表达的描述包括:①主观体验:指的是被检查者对自己内在情绪的表述,如“我感到愉快”,“我感到悲伤”或不安或绝望或很鼓舞等;②客观观察:指的是被检查者情绪的面部表情、说话声调和体态等。客观的外部表现和内在体验可能不协调,如病人面带愁容并泪汪汪地说他自己心情很好。外部和内部的情绪成分可能变化很快或很少变化;可能反应是强烈的或者是迟钝的;可能情绪状态的表现和所涉及的话题是协调或不协调的。在精神检查中应将气质和情绪区别开,有人可能长期倾向于乐观或者忧郁,有的人对上述情感流露或者丰富或者克制,以上特征都是每个人气质的差异而不是情绪的表达。一个人的气质特征有时难以在一次精神检查中确定。

4. 思维

思维可分为思维形式和思维内容。

(1)思维形式:指的是观念连接的方式,而不是其具体内容。各种思维应有逻辑地联系在一起而且有目的性,如果不是这样,可以视为思维形式障碍,有些思维形式障碍和诊断密切联系在一起。如果病人说话铿锵有声并且观念飘忽,有可能是躁狂症的症状,如果思维连接混乱或者经常中断,应该有精神分裂症的可能。

思维松散的检查方法主要是将病人的说话内容记录下来。

举例:患者,19岁,男性,因精神障碍第1次住院。问病人:“为什么来住院?”病人回答:“我……我看电视,可是报纸还没有拿到,我……小芳也上学去了。有时候还是一个人待着好,你说,过一个雨天。”可见此病人有明显的思维连接缺乏逻辑性,他的思维也没有目的性。

思维奔逸和思维松散有明显差别,试将以下的例子和思维松散进行比较。

举例:患者,37岁,男性,因兴奋话多,精力充沛,睡眠减少而第5次住院。患者一见医生,未经询问便滔滔不断地说话,而且速度非常快:“我刚从广州回来,那里橘子多的是,又甜又没有核,没有人能管得了我,我的爸爸也没辙,我吃了很多橘子,嗨了。我爸爸火气大,他是个大老板,他玩牌输了好多钱,他一点儿也不在乎……”

语词新作也是思维形式障碍的表现之一,可表现为自造文字或自造一段话,其含义只有病人自己才明白。

举例:我入院以前经过一个公园,说明天气热,但是又不太热。

思维中断是另一种常见的思维形式异常。

举例:医生和一位55岁的男病人谈话。

医生:今天您喝酒比以前多吧?

病人:不多。我一直好酒量(停顿)没喝醉过。

医生:通常您每天喝多少?

病人:也就半斤左右。有时候一斤……不……[停顿]。

医生:什么?

病人:刚才说什么来着?您问我什么来着?

(2)思维内容:思维内容描述病人的想法。异常的思维内容有妄想、援引观念等。妄想是较为固定的和歪曲的信念,它不符合现实并不能被不同的人群所认同,包括不同的宗教信仰或不同民族和文化的人群。患者对妄想坚信不移,不能被现实所纠正。思维内容障碍不在此描述,请参阅相关书籍。

一次仔细的精神检查应将自杀和暴力的潜在可能予以估计,有时可以直接询问,如:“您有没有伤害自己的想法?”“有没有不想活的想法?”

5. 感知觉

知觉障碍,最常见的是幻觉,也就是虚妄的知觉。可以在精神检查时询问病人:“您是不是能听到别人听不到的声音或说话声?”或问病人:“您是不是能看到别人看不见的东西或人?”有时病人自称有“幻听”或“幻视”,此时不应反驳或肯定,应该请病人具体描述他的感受和体验。幻觉是常见的精神病性症状,对诊断有价值,需予以详细描述。错觉发生在真实的刺激之后,但是病人对所产生的知觉予以错误的解释。例如,有一个病人看到在墙上有一片窗帘的影子,他说看见了鬼影,并且在威胁自己,这就是错觉,错觉可能在谵妄状态中较为常见。人格解体和现实解体(感到自己或世界不是真实的)常记录在知觉障碍项目中。

6. 意识状态

意识和清醒状态,主要描述中枢神经功能的完整性及灵敏性。意识和清醒状态的异常见于谵妄,或由药物、内科疾病引起的精神病性障碍等。警觉状态指的是清醒程度,可为完全清醒到毫无反应,病人的警觉状态可以是波动的。

7. 定向力

定向力通常指的是对人物、地点、时间的判定能力。如果病人有定向力障碍,应判定其障碍的程度。例如,病人知道自己住在医院里,但是不知道在哪个医院;病人是不是认为现在住的是旅馆而不是医院;病人是否知道自己所处的城市;病人是否知道当天的年、月、日和星期几;如果病人不能正确回答,应了解病人能否判定当时的季节和谈话时间(上午或下午);有时病人住院后,可能发生轻度时间定向障碍。

8. 注意力

注意力指的是一个人的意识活动指向一定事物的稳定性。注意力是认知功能的组成部分,通过谈话很容易判定。如病人忘记医生所提的问题,或病人在回答问题时把前一句话忘了,其中采用 100 连续减 7 的检查,可以判断其注意力,主要目的不在于检查病人的计算力。如果要检查其计算力,应另加检查。倒背 3 位数也是一种检查注意力的方法。

9. 记忆力

记忆力障碍可分为远记忆力障碍、近记忆力障碍和即刻记忆障碍。即刻记忆检查可用 3~4 位数字倒背,或介绍 3~4 位在场的医护人员的姓名,请病人复述。正常成人很容易背诵或倒背 5~6 位数字。近记忆力检查可以询问其几分钟至数小时以前所经历的事情。远记忆力检查可令其回忆 2~3 年以前的经历,有必要时应与手头的资料进行核对。

10. 计算力

计算力指的是心算能力,可用由简到繁的方法进行检查,如先问 $3+5$ 等于几?然后再问 $27+18$ 等于几?等。再进一步:杂志 3 元 5 角一本,您付出 10 元钱,应该找回多少钱?一般不用连续减 7 的方法进行计算力检查,因为这需要良好的注意力参与。

11. 知识的检查

知识的检查应该考虑文化水平,和其职业、所处的社会环境等因素。根据病人的具体情况询问一些常识性的问题如:我国的节日名称和日期,最近国内外发生的大事,国家主要负责人的姓名等问题。

- 00.1 阿尔茨海默病,老年前期型 [F00.0 阿尔茨海默病痴呆,老年前期型]
- 00.2 阿尔茨海默病,老年型 [F00.1 阿尔茨海默病痴呆,老年型]
- 00.3 阿尔茨海默病,非典型或混合型 [F00.2 阿尔茨海默病痴呆,非典型或混合型]
- 00.9 其他或待分类的阿尔茨海默病 [F00.9]
- 01 脑血管病所致精神障碍 [F01 血管性痴呆]
- 01.1 急性脑血管病所致精神障碍 [F01.0 急性血管性痴呆]
- 01.2 皮质性血管病所致精神障碍 [F01.1 多发梗塞(脑皮质为主)血管性痴呆]
- 01.3 皮质下血管病所致精神障碍 [F01.2 脑皮质下血管性痴呆]
- 01.4 皮质和皮质下血管病所致精神障碍 [F01.3 皮质和皮质下血管性痴呆]
- 01.9 其他或待分类的血管病所致精神障碍 [F01.8 其他; F01.9 待分类的血管性痴呆]
- 02 其他脑部疾病所致精神障碍 [F02 在它处分类的其他疾病所致痴呆]
- 02.1 脑变性病所致精神障碍 [F02 在它处分类的其他疾病所致痴呆]
- 02.11 皮克(Pick)病所致精神障碍 [F02.0 皮克病痴呆]
- 02.12 亨廷顿(Huntington)病所致精神障碍 [F02.2 亨廷顿病痴呆]
- 02.13 帕金森(Parkinson)病所致精神障碍 [F02.3 帕金森病痴呆]
- 02.14 肝豆状核变性(Wilson 病)所致精神障碍 [F02.8 在它处分类的其他特定疾病所致痴呆]
- 02.2 颅内感染所致精神障碍 [F02.8 在它处分类的其他特定疾病所致痴呆]
- 02.21 急性病毒性脑炎所致精神障碍 [F02.8 在它处分类的其他特定疾病所致痴呆]
- 02.22 克-雅(Creutzfeldt-Jacob)病所致精神障碍 [F02.1 克-雅病痴呆]
- 02.23 脑炎后综合征 [F07.1]
- 02.3 脱髓鞘脑病所致精神障碍 [F02.8 在它处分类的其他特定疾病所致痴呆]
- 02.31 急性播散性脑脊髓炎和急性出血性白质脑炎所致精神障碍 [F02.8 在它处分类的其他特定疾病所致痴呆]
- 02.32 多发性硬化所致精神障碍 [F02.8 在它处分类的其他特定疾病所致痴呆]

02.4 脑外伤所致精神障碍 [F07]

02.41 脑震荡后综合征[F07.2]

02.42 脑挫裂伤后综合征 [F07.8 其他器质性人格和行为障碍]

02.5 脑瘤所致精神障碍 [F02.8 在它处分类的其他特定疾病所致痴呆]

02.6 癫痫所致精神障碍[F02.8 在它处分类的其他特定疾病所致痴呆]

02.9 以上未分类的其他脑部疾病所致精神障碍 [F02.8]

03 躯体疾病所致精神障碍 [F02.8 在它处分类的其他疾病所致痴呆]

03.1 躯体感染所致精神障碍 [F02.8 在它处分类的其他疾病所致痴呆]

03.11 人类免疫缺陷病毒(HIV)所致精神障碍[F02.4 人类免疫缺陷病毒性痴呆]

03.2 内脏器官疾病所致精神障碍 [F02.8 在它处分类的其他疾病所致痴呆]

03.3 内分泌疾病所致精神障碍 [F02.8 在它处分类的其他疾病所致痴呆]

03.4 营养代谢疾病所致精神障碍 [F02.8 在它处分类的其他疾病所致痴呆]

03.5 结缔组织疾病所致精神障碍 [F02.8 在它处分类的其他疾病所致痴呆]

03.51 系统性红斑狼疮所致精神障碍 [F02.8 在它处分类的其他疾病所致痴呆]

03.6 染色体异常所致精神障碍 [F02.8 在它处分类的其他疾病所致痴呆]

03.7 物理因素所致精神障碍 [F02.8 在它处分类的其他疾病所致痴呆]

03.9 以上未分类的其他躯体疾病所致精神障碍 [F02.8]

03.91 围生期精神障碍 [F53 其他待分类的围生期精神和行为障碍]

09 其他或待分类器质性精神障碍 [F06.8;F06.9;F09]

器质性精神障碍第5位编码表示:

0x.xx1 器质性智能损害(痴呆)[——]

0x.xx2 器质性遗忘 [F04 非酒精或精神活性物质所致器质性遗忘综合征]

0x.xx3 器质性人格改变、习惯与冲动改变、性心理改变 [F07 器质性人格与行为障碍]

0x.xx4 器质性意识障碍(如谵妄)[F05 非酒精或精神活性物质所致谵妄]

0x.xx5 器质性精神病性症状 [F06.0 器质性幻觉障碍;F06.1 器质性紧张性障碍;F06.2 器质性妄想性(精神分裂样)障碍]

0x.xx6 器质性情感障碍 [F6.3]

0x.xx7 器质性癔症样综合征 [F06.5 器质性解离障碍]

0x.xx8 器质性神经症样综合征 [F06.4 器质性焦虑症; F06.6 器质性情绪不稳(脆弱)障碍]

1 精神活性物质所致精神障碍或非成瘾物质所致精神障碍[F10—F19 精神活性物质所致精神障碍和行为障碍; F55 非成瘾药物滥用]

10 精神活性物质所致精神障碍 [F10—F19 精神活性物质所致精神障碍和行为障碍]

10.1 酒精所致精神障碍 [F10 酒精所致精神障碍和行为障碍]

10.2 阿片类物质所致精神障碍 [F11 阿片类物质所致精神障碍和行为障碍]

10.3 大麻类物质所致精神障碍 [F12 大麻类物质所致精神障碍和行为障碍]

10.4 镇静催眠药或抗焦虑药所致精神障碍 [F13 镇静催眠药所致精神障碍和行为障碍]

10.5 兴奋剂所致精神障碍 [F14 可卡因; F15 其他兴奋剂所致精神障碍和行为障碍]

10.6 致幻剂所致精神障碍 [F16 致幻剂所致精神障碍和行为障碍]

10.7 烟草所致精神障碍 [F17 烟草所致精神障碍和行为障碍]

10.8 挥发性溶剂所致精神障碍 [F18 挥发性溶剂所致精神障碍和行为障碍]

10.9 其他或待分类的精神活性物质所致精神障碍 [F19]

精神活性物质所致精神障碍第4位编码表示:

10.x1 急性中毒 [F1x.0]

10.x2 有害使用 [F1x.1]

10.x3 依赖综合征(成瘾综合征) [F1x.2]

10.x4 戒断综合征 [F1x.3]

10.x5 精神病性障碍 [F1x.5]

10.x6 智能损害(痴呆) [F1x.73]

10.x7 遗忘综合征 [F1x.6]

10.x8 残留性或迟发性精神障碍 [F1x.7 残留性或迟发性精神病性障碍]

精神活性物质所致精神障碍第5位编码表示:

10.xx1 意识障碍(如谵妄、昏迷)[F1x.03 急性中毒并谵妄;F1x.05 急性中毒并昏迷]

10.xx2 幻觉症[F1x.52 幻觉为主]

10.xx3 妄想症[F1x.51 妄想为主]

10.xx4 抑郁综合征[F1x.54 抑郁为主]

10.xx5 躁狂综合征[F1x.55 躁狂为主]

10.xx6 病理性中毒[F1x.07]

10.xx7 病理性重现(闪回)[F1x.70]

11 非成瘾物质所致精神障碍[F55]

11.1 非成瘾药物所致精神障碍[F55.8 不产生依赖的其他物质滥用]

11.2 一氧化碳所致精神障碍[F55.8 不产生依赖的其他物质滥用]

11.3 有机化合物所致精神障碍[F55.8 不产生依赖的其他物质滥用]

11.4 重金属所致精神障碍[F55.8 不产生依赖的其他物质滥用]

11.5 食物所致精神障碍[F55.8 不产生依赖的其他物质滥用]

11.9 其他或待分类的非成瘾物质所致精神障碍[F55.8;F55.9]

2 精神分裂症(分裂症)和其他精神病性障碍[F20—F29 精神分裂症;分裂型障碍和妄想性障碍]

20 精神分裂症(分裂症)[F20]

20.1 偏执型分裂症[F20.0]

20.2 青春型(瓦解型)分裂症[F20.1]

20.3 紧张型分裂症[F20.2]

20.4 单纯型分裂症[F20.6]

20.5 未定型分裂症[F20.3]

20.9 其他型或待分类的精神分裂症[F20.8;F20.9]

分裂症的第4位编码表示:

20.x1 精神分裂症后抑郁[F20.4]

20.x2 精神分裂症缓解期[F20.x5 精神分裂症缓解型]

20.x3 精神分裂症残留期[F20.x4 精神分裂症残留型]

20.x4 慢性精神分裂症[F20.x8 其他病程类型]

20.x5 精神分裂症衰退期[F20.x8 其他病程类型]

21 偏执性精神障碍[F22 妄想性精神障碍]

22 急性短暂性精神病[F23 急性短暂精神病性障碍]

- 22.1 分裂样精神病 [F23.2]
- 22.2 旅途性精神病 [F23.9 待分类的急性短暂精神病性障碍]
- 22.3 妄想阵发(急性妄想发作)[F23.3]
- 22.9 其他或待分类的急性短暂性精神病 [F23.8;F23.9]
- 23 感应性精神病[F24 感应性妄想障碍]
- 24 分裂情感性精神病 [F25 分裂情感性障碍]
- 24.1 分裂情感性精神病,躁狂型 [F25.0]
- 24.2 分裂情感性精神病,抑郁型 [F25.1]
- 24.3 分裂情感性精神病,混合型
- 29 其他或待分类的精神病性障碍 [F28;F29]
- 29.1 周期性精神病 [F28 其他非器质性精神障碍]
- 3 心境障碍(情感性精神障碍)[F30—F39]
- 30 躁狂发作 [F30]
- 30.1 轻性躁狂症(轻躁狂)[F30.0]
- 30.2 无精神病性症状的躁狂症 [F30.1]
- 30.3 有精神病性症状的躁狂症 [F30.2]
- 30.4 复发性躁狂 [F30.8 其他躁狂发作]
- 30.41 复发性躁狂症,目前为轻躁狂 [F30.8 其他躁狂发作]
- 30.42 复发性躁狂症,目前为无精神病性症状的躁狂 [F30.8 其他躁狂发作]
- 30.43 复发性躁狂症,目前为有精神病性症状的躁狂 [F30.8 其他躁狂发作]
- 30.9 其他或待分类的躁狂 [F30.8;F30.9]
- 31 双相障碍 [F31]
- 31.1 双相障碍,目前为轻躁狂 [F31.0]
- 31.2 双相障碍,目前为无精神病性症状的躁狂 [F31.1]
- 31.3 双相障碍,目前为有精神病性症状的躁狂 [F31.2]
- 31.4 双相障碍,目前为轻抑郁[F31.3]
- 31.5 双相障碍,目前为无精神病性症状的抑郁 [F31.4]
- 31.6 双相障碍,目前为有精神病性症状的抑郁 [F31.5]
- 31.7 双相障碍,目前为混合性发作 [F31.6]
- 31.9 其他或待分类的双相障碍 [F31.8;F31.9]

31.91 双相障碍,目前为快速循环发作 [F31.8]

32 抑郁发作 [F32]

32.1 轻性抑郁症(轻抑郁)[F32.0]

32.2 无精神病性症状的抑郁症 [F32.1]

32.3 有精神病性症状的抑郁症 [F32.2]

32.4 复发性抑郁症 [F33]

32.41 复发性抑郁症,目前为轻抑郁 [F33.0]

32.42 复发性抑郁症,目前为无精神病性症状的抑郁 [F33.2]

32.43 复发性抑郁症,目前为有精神病性症状的抑郁 [F33.3]

32.9 其他或待分类的抑郁症 [F32.8;F32.9 ;F33.8;F33.9]

33 持续性心境障碍[F34]

33.1 环性心境障碍 [F34.0]

33.2 恶劣心境 [F34.1]

33.9 其他或待分类的持续性心境障碍 [F34.8;F34.9]

39 其他或待分类的心境障碍 [F38;F39]

心境障碍的第5位编码表示:

3x.xx1 意识障碍(如谵妄)(e.g,delirium)[F38]

3x.xx2 伴躯体症状 [F38]

3x.xx3 慢性 [F38]

3x.xx4 缓解期 [F38]

4 癡症、应激相关障碍、神经症[F40—F49 神经症性,应激相关障碍,及躯体形式障碍]

40 癡症 [F44 解离(转换)障碍]

40.1 癡症性精神障碍 [F44.8 其他解离(转换)障碍]

40.11 癡症性遗忘 [F44.0]

40.12 癡症性漫游 [F44.1]

40.13 癡症性身份识别障碍 [F44.81;多种人格障碍]

40.14 癡症性精神病 [F28 其他非器质性精神病性障碍]

40.141 癡症性附体障碍 [F44.3 癡症性出神和附体障碍]

40.142 癡症性木僵 [F44.2 解离性木僵]

40.2 癡症性躯体障碍[F44.8 其他解离(转换)运动障碍]

40.21 癡症性运动障碍[F44.4 解离(转换)运动障碍]

- 40.x 癔症性抽搐发作[F44.5 解离(转换)抽搐发作]
- 40.23 癔症性感觉障碍[F44.6 癔症性感觉麻木和感觉丧失]
- 40.3 混合性癔症躯体—精神障碍[F44.7 混合性解离(转换)障碍]
- 40.9 其他或待分类癔症[F44.8 其他;F44.9 待分类解离(转换)障碍]
- 40.91 Ganser 综合征[F44.80]
- 40.92 见于童年和青少年的短暂的癔症性障碍[F44.82 见于童年和青少年的短暂的解离(转换)障碍]
- 41 应激相关障碍[F43]
- 41.1 急性应激障碍[F43.0 急性应激反应]
- 41.11 急性应激性精神病(急性反应性精神病)[F23.8 其他急性应激性短暂精神病]
- 41.2 创伤后应激障碍[F43.1]
- 41.3 适应障碍[F43.2]
- 适应障碍突出症状用第5位编码表示:
- 41.31 短期抑郁反应[F43.20 短暂抑郁反应]
- 41.32 中期抑郁反应[F43.1 长期抑郁反应]
- 41.33 长期抑郁反应[F43.21]
- 41.34 其他恶劣情绪为主的适应障碍[F43.23 以其他恶劣心境为主]
- 41.35 混合性焦虑抑郁反应[F43.22]
- 41.36 品行障碍为主的适应障碍[F43.24 品行障碍为主]
- 41.37 心境和品行混合性障碍为主的适应障碍[F43.25 心境和品行的混合性障碍为主]
- 41.9 其他或待分类的应激相关障碍[F43.8 其他;F43.9 待分类的严重应激反应和适应障碍]
- 42 与文化相关的精神障碍[F43.8]
- 42.1 气功所致精神障碍[F43.8]
- 42.2 巫术所致精神障碍[F43.8]
- 42.3 恐缩症[F43.8]
- 42.9 其他或待分类的与文化相关的精神障碍[F43.8;F43.9]
- 43 神经症[F40—F49]
- 43.1 恐惧症(恐怖症)[F40 恐惧焦虑障碍]
- 43.11 场所恐惧症[F40.0]

- 43.12 社交恐惧症(社交焦虑症)[F40.1]
- 43.13 特定的恐惧症[F40.2 特定的(单项)恐惧障碍]
- 43.2 焦虑症[F41 其他焦虑症]
- 43.21 惊恐障碍[F41.0]
- 43.22 广泛性焦虑[F4.1]
- 43.3 强迫症[F42 强迫性障碍]
- 43.4 躯体形式障碍[F45 躯体形式障碍]
- 43.41 躯体化障碍[F45.0 躯体化障碍]
- 43.42 未分化躯体形式障碍[F45.1 未分化的躯体形式障碍]
- 43.43 疑病症[F45.2 疑病障碍]
- 43.44 躯体形式自主神经紊乱[F45.3 躯体形式的自主神经功能紊乱]
- 被病人视为症状起源的器官或系统用第 5 位编码表示:
- 43.441 心血管系统功能紊乱[F45.30]
- 43.442 高位胃肠道功能紊乱[F45.31]
- 43.443 低位胃肠道功能紊乱[F45.32]
- 43.444 呼吸系统功能紊乱[F45.33]
- 43.445 泌尿生殖系统功能紊乱[F45.34]
- 43.45 持续性躯体形式疼痛障碍[F45.4]
- 43.49 其他或待分类躯体形式障碍[F45.8;F45.9]
- 43.5 神经衰弱[F48.0]
- 43.9 其他或待分类的神经症[F48]

5 心理因素相关生理障碍[F50—F59 伴有生理紊乱和躯体因素的行为综合征]

- 50 进食障碍[F50]
- 50.1 神经性厌食[F50.0]
- 50.2 神经性贪食[F50.2]
- 50.3 神经性呕吐[F50.5]
- 50.9 其他或待分类非器质性进食障碍[F50.8;F50.9]
- 51 非器质性睡眠障碍[F51]
- 51.1 失眠症[F51.0 非器质性失眠症]
- 51.2 嗜睡症[F51.1 非器质性嗜睡症]
- 51.3 睡眠—觉醒节律障碍[F51.2 非器质性睡眠—觉醒节律障碍]

51.4 睡行症[睡行症(夜游症)F51.3]

51.5 夜惊[F51.4 睡惊症(夜惊)]

51.6 梦魇[F5.5 梦魇]

51.9 其他或待分类非器质性睡眠障碍[F51.8;F51.9]

52 非器质性性功能障碍 [F52 非器质性性功能障碍或疾病引起的性功能障碍]

52.1 性欲减退 [F52.0 性欲减退或缺失]

52.2 阳痿[F52.2 非器质性生殖器反应不良]

52.3 冷阴[F52.2 非器质性生殖器反应不良]

52.4 性乐高潮障碍 [F52.3]

52.5 早泄 [F52.4]

52.6 阴道痉挛[F52.5 非器质性阴道痉挛]

52.7 性交疼痛[F52.6 非器质性性交疼痛]

52.9 其他或待分类性功能障碍[F52.8;F52.9]

6 人格障碍、习惯和冲动控制障碍、性心理障碍 [F60—F69 成人人格和行为障碍]

60 人格障碍 [F60 特定的人格障碍]

60.1 偏执性人格障碍 [F60.0]

60.2 分裂样人格障碍 [F60.1]

60.3 反社会性人格障碍[F60.2 社交紊乱型人格障碍]

60.4 冲动性人格障碍(攻击性人格障碍)[F60.30 情绪不稳型人格障碍,冲动型]

60.5 表演性(癡症性)人格障碍[F60.4 表演型人格障碍]

60.6 强迫性人格障碍[F60.5]

60.7 焦虑性人格障碍[F60.6 焦虑(回避)型人格障碍]

60.8 依赖性人格障碍[F60.7]

60.9 其他或待分类的人格障碍[F60.8;F60.9]

61 习惯与冲动控制障碍[F63]

61.1 病理性赌博[F63.0]

61.2 病理性纵火[F63.1]

61.3 病理性偷窃[F63.2]

61.4 拔毛症(病理性拔毛发)[F63.3]

- 61.9 其他或未特定的习惯和冲动障碍[F63.8;F63.9]
 - 62 性心理障碍(性变态)[F64 性身份障碍;F65 性偏好障碍;F66 与性发育和性指向有关的心理和行为障碍]
 - 62.1 性身份障碍[F64]
 - 62.11 易性症[F64.0 性别改变症]
 - 62.19 其他或待分类的性身份障碍[F64.8;F64.9]
 - 62.2 性偏好障碍[F65]
 - 62.21 恋物症[F65.0]
 - 62.211 异装症[F65.1 恋物性异装症]
 - 62.22 露阴症[F65.2]
 - 62.23 窥阴症[F65.3]
 - 62.24 摩擦症[F65.8 其他性偏好障碍]
 - 62.25 性施虐与性受虐症[F65.5]
 - 62.26 混合型性偏好障碍[F65.6 性偏好多相障碍]
 - 62.29 其他或待分类的性偏好障碍[F65.8;F65.9]
 - 62.3 性指向障碍[F66 与性发育和性指向有关的心理和行为障碍]
 - 62.31 同性恋[F66.x1]
 - 62.32 双性恋[F66.x2]
 - 62.39 其他或待分类的性指向障碍[F66.8;F66.9]
 - 7 精神发育迟滞与童年和少年期心理发育障碍[F70—79;F80—F89]
 - 70 精神发育迟滞[F70—F79]
 - 70.1 轻度精神发育迟滞[F70]
 - 70.2 中度精神发育迟滞[F71]
 - 70.3 重度精神发育迟滞[F72]
 - 70.4 极重度精神发育迟滞[F73]
 - 70.9 其他或待分类的精神发育迟滞[F78;79]
- 第4位编码用来指明相关行为障碍的程度:
- 70.x1 无或轻微的行为障碍[F7x.0]
 - 70.x2 显著的行为障碍,需要加以关注或治疗[F7x.1]
 - 70.x9 其他或待分类的行为障碍[F7x.8;F7x.9]
- 71 言语和语言发育障碍[F80 言语和语言技能特定性发育障碍]
 - 71.1 特定言语构音障碍[F80.0]

- 83 特发于童年的情绪障碍[F93]
 - 83.1 儿童分离性焦虑症[F93.0]
 - 83.2 儿童恐惧症(儿童恐怖症)[F93.1 儿童恐惧性焦虑障碍]
 - 83.3 儿童社交恐惧症[F93.2 儿童社交性焦虑障碍]
 - 83.9 其他或待分类的童年情绪障碍[F93.8;F93.9]
 - 83.91 儿童广泛焦虑症[F93.8 其他儿童情绪障碍]
- 84 儿童社会功能障碍[F94]
 - 84.1 选择性缄默症[F94.0]
 - 84.2 儿童反应性依恋障碍[F94.1]
 - 84.9 其他或待分类的儿童社会功能障碍[F94.8;F94.9]
- 85 抽动障碍[F95]
 - 85.1 短暂性抽动障碍(抽动症)[F95.0]
 - 85.2 慢性运动或发声抽动障碍[F95.1]
 - 85.3 Tourette 综合征(发声与多种运动联合抽动障碍)[F95.2]
 - 85.9 其他或待分类的抽动障碍[F95.8;F95.9]
- 86 其他童年和少年期行为障碍[F98]
 - 86.1 非器质性遗尿症[F98.0]
 - 86.2 非器质性遗粪症[F98.1]
 - 86.3 婴幼儿和童年喂食障碍[F98.2]
 - 86.4 婴幼儿和童年异食癖[F98.3]
 - 86.5 刻板性运动障碍[F98.4]
 - 86.6 口吃[F98.5]
- 89 其他或待分类的童年和少年期精神障碍[F98.8;F98.9]
- 9 其他精神障碍和心理卫生情况[F09;F29;F99]
 - 90 待分类的精神病性障碍[F29;F99]
 - 91 待分类的非精神病性精神障碍[F99]
 - 92 其他心理卫生情况[F99]
 - 92.1 无精神病[——]
 - 92.2 诈病[Z76.5]
 - 92.3 自杀[——]
 - 92.31 自杀死亡[——]
 - 92.32 自杀未遂[——]

- 92.33 准自杀[——]
- 92.34 自杀观念[——]
- 92.4 自伤[X60—X84]
- 92.5 病理性激情[F23.9 待分类的急性短暂性精神病性障碍]
- 92.6 病理性半醒状态[F51.8 其他非器质性睡眠障碍]
- 92.9 其他或待分类的心理卫生情况[F99]
- 99 待分类的其他精神障碍[F99]

由于 ICD-10 修改委员会的主任曾参与 CCMD-3 的编写工作会议,中国的专家也曾参与 ICD-10 的修改工作,因此 CCMD-3 和 ICD-10 有许多相近之处,故将 ICD-10 的诊断名称及编码附录在方括号之内。

第七节 精神障碍的常用治疗方法

精神障碍的治疗应尽可能早期将药物、心理、社会治疗结合起来。药物治疗是治疗原因不明的精神疾病的基本措施,同时心理、社会治疗对药物治疗充分发挥疗效提供条件,使病人有机会恢复或部分恢复其原有的功能和重返社会。

一、药物治疗

+++++

(一) 抗精神病药

1. 第一代抗精神病药(传统抗精神病药、典型抗精神病药)

- (1) 低效价/高剂量抗精神病药,常用药有:氯丙嗪、舒必利、硫利嗪等。
- (2) 高效价/低剂量抗精神病药,常用药有:氟哌啶醇、奋乃静、三氟拉嗪、氟奋乃静等。

2. 第二代抗精神病药(非传统抗精神病药、非典型抗精神病药)

- (1) 5-羟色胺/多巴胺平衡拮抗药:利培酮(risperidone),齐哌西酮(ziprasidone)等。
- (2) 作用于多受体的抗精神病药:氯氮平(clozapine)、奥氮平(olanzapine)、奎硫平(quetiapine)等。

3. 抗精神病药选择策略

第一代抗精神病药和第二代抗精神病药的疗效很接近,其主要差别是毒副反应。

(1) 第一线用药:指的是首选治疗精神分裂症或其他精神障碍的药物。

①第一代抗精神病药:对阳性症状有效,对阴性症状疗效较差。多数第一代抗精神病药的毒副反应比第二代抗精神病药明显,尤其是锥体外系的毒副反应作用更为突出。

②第二代抗精神病药(氯氮平除外):可先试用作用于受体的较简单的药物,即5-羟色胺/多巴胺平衡拮抗药,如利培酮或齐哌西酮等。如果无效再选用作用于多受体的药物,如奎硫平、奥氮平等。

(2) 第二线用药:经第一线药物充分治疗无效后,候选的药物,主要为氯氮平。氯氮平影响的受体最广泛,疗效也肯定;但是有一部分因各种原因而中断氯氮平治疗引起复发的病人,用其他药物治疗常常无效,从而失去选择其他药物治疗的机会。但是,氯氮平是治疗“难治性精神分裂症”公认的有效药物。

(二) 抗抑郁药

1. 三环类和四环类抗抑郁药

阿米替林,多塞平,马普替林等。

2. 选择性5-羟色胺重吸收抑制药(SSRIs)

氟西汀,西酞普兰,帕罗西汀,舍曲林等。

3. 单胺氧化酶抑制药(MAOIs)

马氯贝胺等。

4. 去甲肾上腺素和5-羟色胺重吸收抑制药(SNRIs)

文拉法新等。

5. 其他抗抑郁药

米氮平,安非他酮,奈法唑酮等。

抗抑郁药有许多种类,但总体疗效很接近,不过对具体的病例,不同药物有不同疗效,因此在判定某种药物无效以后,再试用另一种药物也可能奏效。一般来说三环类抗抑郁药和四环类抗抑郁药的毒副反应较SSRIs和SNRIs明显。改用MAOIs时,有可能增加对原来用药的毒副反应,应按不同药物的半衰期留有不同清洗期,再换用MAOIs。

(三) 抗焦虑药

1. 苯二氮革类

大多数苯二氮革类抗焦虑药在数小时内起效。由于苯二氮革类抗焦虑药在用

药过程中出现耐受性和依赖,故有可能出现药物滥用和撤药反应。用药期间应杜绝饮酒,因为苯二氮草类抗焦虑药和酒精的相互作用可能引起威胁生命的反应。

2. 丁螺环酮

是另一类抗焦虑药,起效时间为2~3周。

(四) 抗躁狂药和情感稳定药

1. 碳酸锂

常用的抗躁狂药,由于治疗血药浓度和中毒血药浓度非常接近,故血液锂浓度检测是必要的。

2. 情感稳定药

为数种抗癫痫药,可用于治疗躁狂和预防双相情感性精神障碍的复发。常用药物有:丙戊酸钠,卡马西平,托吡酯等。

二、心理治疗

+++++

包括支持性心理治疗、行为矫正治疗、森田疗法和心理分析等治疗,在不同时期用于不同疾病。

三、康复治疗

+++++

目前多种精神疾病原因不明,而且有复发倾向,多次复发常导致精神残疾,精神康复措施有利于防止疾病复发及重返社会。

四、家庭干预

+++++

家庭干预有助于改善病人的直接社会环境,有利于减轻病人家庭的精神负担,防止精神疾病复发,以提高病人及其家庭的生活质量。

(翁永振)

28.25%。

二、病因和发病机制

(一) 遗传因素

系统的家谱调查证明遗传因素在精神分裂症的发生中具有一定作用。精神分裂症患者亲属中的患病率比一般居民高得多,与病人的血缘关系愈近,患病率则愈高。各级亲属中的发病几率(morbidity risk rate)为4.3%~16.4%,其中以子女、同胞及父母为最高,上海地区(1958)对1 198例精神分裂症患者的54 576名家属成员的调查表明,近亲中以父母及同胞的精神分裂症患病率最高,父母双方均为精神分裂症患者,其子女的发病几率为35%~68%。

分子遗传学技术的进步,使对精神分裂症第5号染色体的连锁分析有所发现。但是,其结果有待进一步积累资料和验证。

(二) 环境中的社会心理和生物学因素

1. 内分泌因素

各国学者有不同发现,但尚无定论。

2. 病前个性特征

国外有的学者发现精神分裂症病人病前约有50%~60%具有分裂性人格,同时病人亲族中可发现类似的个性特征。南京(1957)和上海(1958)分别对住院精神分裂症临床资料进行分析,发现病前性格具有主动性差、依赖性强、胆小、犹豫、敏感、好幻想等特点而属于神经类型弱型者均占患病总数的70%。广州(1963)对100例精神分裂症病人进行详细的生活史及个性特点的调查,发现神经类型属弱型者占40%,比对照组高7倍。病前神经类型属强型者,多在明显诱因下发病,预后较好。

3. 社会心理因素

美国学者发现,生活在芝加哥城内的贫穷人群的精神病首次住院率最高,以精神分裂症最多,而躁狂、抑郁症在不同社区的分布则没有一定规律(Faris, Dunham, 1930—1933)。我国的精神疾病流行病学研究有类似发现:精神分裂症的患病率在经济水平低的人群中为10.16‰,明显高于经济水平高的人群的4.75‰。

病因学研究的现有资料证明,遗传因素在精神分裂症的发生中具有重要作用。

多数病人具有内向的个性特征,有易感素质。社会和心理应激以及环境中的生物学因素,特别是围生期感染、中毒或外伤、母孕期的病毒感染等均可能作为环境危险因素而影响本病的发生。

(三)神经生化病理的研究

1. 多巴胺功能亢进假说

抗精神病药物如酚噻嗪类和丁酰苯类,其药理作用与中枢儿茶酚胺,特别是多巴胺(DA)受体功能阻滞有关,能控制精神病性症状。长期服用大量苯丙胺的患者,可以出现与精神分裂症妄想型十分相似的症状,苯丙胺的药理作用主要是抑制DA的再摄取,从而使受体部位的DA含量增高,功能亢进。说明DA功能亢进假说,至今仍然是一个富有吸引力的理论。

2. 5-羟色胺假说

近年来非典型性抗精神病药物氯氮平对难治性精神分裂症的治疗取得一定效果,此药是一个很强的5-HT_{2A}受体抑制剂,与D₂受体的结合力弱,引起了精神病学家对5-HT受体的研究兴趣。部分对D₂受体拮抗药物无效的病例,用氯氮平可获效,从而补充了可能为精神分裂症发病机制之一的D₂受体亢奋学说。

3. 血小板单胺氧化酶(MAO)活性的研究

有的学者发现男性精神分裂症病人MAO活性减低,分子活性明显低下,其意义有待进一步阐明。

4. 神经肽和精神分裂症

有报道认为精神分裂症患者脑脊液内有内啡肽含量改变,且随病情改善而下降。但用人工合成的β-内啡肽治疗精神分裂症的试验,未得出肯定结论。

5. 多巴胺功能系统和谷氨酸功能系统不平衡假说

M. Carlsson(1990)提出假说,认为精神分裂症是由于皮层下多巴胺功能系统和谷氨酸功能系统的不平衡所致,从广义来看,精神分裂症可看作一种多巴胺—谷氨酸反馈调节系统中神经递质不平衡所致的综合征。这一假说有待临床和基础研究的验证。

6. 额叶—纹状体功能缺陷假说

近年来脑成像技术在精神分裂症研究中的应用,为本病发生的神经科学基础提供了新的资料。有学者提出精神分裂症患者有额叶功能减低的现象,此看法得到脑血流图、PET和EEG研究资料的支持。

上述假说反映了近二十多年来神经科学的研究进展,并将在精神病学学科发

展中经受检验和得到发展。

由于精神分裂症的异源性,许多学者近年来运用各种先进的技术对精神分裂症进行研究,至今尚未发现肯定的病因,笔者只将部分研究所见简述如上,作为分析病例时的参考。

三、临床表现

(一)精神症状

精神分裂症的症状就其临床特点来说,可以分为带有特征性的症状和其他常见症状两大类。前者的主要特征是“精神分裂”,即精神活动脱离现实,与周围环境不协调,以及思维、情感、意志活动之间的互不配合。其他常见症状,则并不是各个类型都具有的。

1. 特征性症状

(1)思维联想障碍:思维联想过程缺乏连贯性和逻辑性,是精神分裂症最具有特征性的障碍。其特点是病人在意识清楚的情况下,思维联想散漫或分裂,缺乏具体性和现实性。最典型的表现是破裂性思维。

思维障碍的另一类形式,是病人用一些很普通的词句、名词,甚至以动作来表达某些特殊的,除病人自己之外旁人无法理解的意义,称象征性思维。如某一病人突然扑到正在急驶的汽车轮胎下面,表示要“投胎”。

精神分裂症患者的联想过程可突然中断(思维中断),或涌现大量的强制性思维(思维云集)。这类联想障碍往往伴有较明显的不自主感,病人感到难以控制自己的思想,并常常做出妄想性的判断,如认为自己的思维受外力的控制或操纵。

(2)情感障碍:情感迟钝、淡漠,情感反应与思维内容和环境变化不协调,是精神分裂症的重要特征之一。病人对周围事物的情感反应变得迟钝或平淡。随着疾病的发展,病人的情感体验日益贫乏,对一切皆无动于衷,甚至对那些使一般人产生莫大悲哀和痛苦的事件,病人表现冷淡无情,无动于衷,丧失了对周围环境的情感联系(情感淡漠)。

此外,可见到情感反应在本质上的倒错,病人流着眼泪唱愉快的歌曲,笑着叙述自己的痛苦和不幸(情感倒错),或对同一事物产生对立的矛盾情感。

(3)意志行为障碍:在情感淡漠的同时,病人的活动减少,缺乏主动性,行为被动、退缩,即意志缺乏(abulia)。有些病人吃一些不能吃的东西,如吃肥皂、昆虫、草

木,喝痰盂里的水,或伤害自己的身体(意向倒错)。病人可对一事物产生对立的意向(矛盾意向)。病人顽固拒绝一切,如让病人睁眼,病人却用劲闭眼(违拗);或相反,有时病人机械地执行外界任何要求(被动服从),任人摆布自己的姿势,如让病人将一只腿高高抬起,病人可在一个时间内保持所给予的姿势不动(蜡样屈曲),或机械地重复周围人的言语或行为(模仿言语、模仿动作)。

上述思维、情感、意志活动三方面的障碍使病人精神活动与环境脱离,行为离奇、孤僻离群,加之大多不暴露自己的病态想法,沉醉在自己的病态体验中,自乐自笑,周围人无法了解其内心的喜怒哀乐,称之为内向性(autism)。

2. 其他常见症状

(1)幻觉和感知综合障碍:最常见的是幻听,主要是言语性幻听。病人听见邻居、亲人、同事或陌生人说话,内容往往是使病人不愉快的。具有特征性的是听见两个或几个声音在谈论病人,彼此争吵,或以第三人称评论病人(评论性幻听)。语音常威胁病人、命令病人(如不许病人吃饭、让病人跳车)。

幻视也不少见。精神分裂症幻视的形象往往很逼真,颜色、大小、形状清晰可见。

幻触、幻嗅、幻味较少见。感知综合障碍在精神分裂症并不少见。

(2)妄想:妄想是精神分裂症最常见的症状之一。在部分病例中妄想可非常突出。内容上以被害妄想、关系妄想、影响妄想最为常见,精神分裂症病人妄想的内容经常是非常离奇的,或现实生活中根本不存在的现象,如病人认为电视台的节目主持人用目光和自己眉目传情以及“精神对话”。

原发性妄想几乎只见于精神分裂症,此时妄想的产生并不以感知、意识、情感或其他精神障碍,或病人的特殊心理状态为基础,而一旦出现病人立即深信不疑。

(3)紧张症综合征:此综合征最明显的表现是木僵、缄默少动、违拗或呈被动性服从,并伴有肌张力增高等。

精神分裂症病人一般没有意识障碍。妄想、幻觉和其他思维障碍一般都在意识清楚的情况下出现。无明显智能障碍。自知力缺如。

(二)躯体和神经系统变化

精神分裂症患者的神经系统检查,偶尔可发现少数神经系体征,但通常不稳定,并不具有定位意义。血液和脑脊液一般正常。

紧张症木僵状态病人的躯体变化则较为明显。神经系体征可见肌张力增高,腱反射亢进,极少数病人尚可出现病理反射及阵挛现象。

(三) 早期症状和临床类型

1. 早期症状

本病起病形式不一,可呈慢性、亚急性或急性。临床上以缓慢起病者最为常见。缓慢起病者占 64.3%~70.6%。早期症状以性格改变和类神经官能症症状最为常见。病人常对人冷淡,与人疏远,躲避亲人并怀敌意;不遵守纪律,对周围人的劝告不加理睬。好无故发脾气,不能自制,敏感多疑;或沉湎于一些脱离现实的幻想,自语,自笑;或无端恐惧。此时常常不容易被家人理解为病态。

部分病人亚急性起病,从可疑的症状出现到明显的精神异常约经 2 周到 3 个月时间。此时情感障碍表现为抑郁、忧愁,容易发生强迫性症状或疑病观念,继之产生妄想性体验,可持续数周至数月。

急性起病的病人,一般在 2 周以内发病。病人突然出现兴奋躁动,冲动毁物,行为反常,情感恐惧不安、困惑,或毫无原因的喜悦。此时病人可伴有意识障碍。在躯体感染、中毒或分娩等因素影响下起病的患者,起病急剧,常可出现意识障碍:病人兴奋躁动,出现幻觉错觉、定向错误、言语不连贯等。

2. 临床类型

按 CCMD-3,精神分裂症常见的类型有 5 型,即单纯型、紧张型、青春型、偏执型和未定型。

(1)单纯型:一般无幻觉和妄想。如有则为片断或一过性。此型病人在发病早期常不被人注意,往往经过数年病情发展较严重时才被发现。此型自动缓解者少,治疗效果和预后差。

(2)青春型:多在青春期急性起病。临床主要表现为言语增多,内容荒诞离奇,想入非非,思维零乱,甚至破裂;情感喜怒无常,变化莫测;表情做作,好扮弄鬼脸;行为幼稚、愚蠢、奇特,常有兴奋冲动。病人的本能活动(性欲、食欲)亢进,也可有意向倒错,如吃脏东西、吃痰、吃大小便等。幻觉生动,妄想片断,常零乱不固定,内容荒诞与病人的愚蠢行为相一致。

(3)紧张型:近年来有减少趋势。大多数起病于青年或中年。起病较急,病程多呈发作性。主要表现为紧张性兴奋和紧张性木僵,两者交替出现,或单独发生。临床上以紧张性木僵为多。

(4)偏执型:为 5 型中最常见的类型,占住院精神分裂症病人的 41.3%~56%。起病较缓慢,起初变得敏感多疑,逐渐发展成妄想,被害妄想最多见,其次是自罪妄想、影响妄想和嫉妒妄想等。幻觉中以言语性幻听最常见,内容多使人不愉

快:如讽刺、批评、评议、威胁、命令等。绝大多数病人都沉湎于幻觉或妄想体验之中,行为孤僻离群。此种内向性症状随着病情好转而逐渐消失。

(5)未定型:系指病人的精神症状符合精神分裂症的诊断标准,有明显的精神病性症状,如妄想、幻觉、破裂性思维或严重的行为紊乱,但又不宜归入单纯型、妄想型、青春型或紧张型者。此时往往存在不止一个类型的精神症状,但又难判断以哪个为主要临床相。

精神分裂症后抑郁:是指在精神分裂症残留期发生的抑郁发作,此时仍残留某些精神病性症状,可能是阳性症状或阴性症状,一般以阴性症状较为常见。在临床上往往难以分析这些症状的来由:是过去即存在,当时为其他主要症状所掩盖,也就是说残留的抑郁症状属于精神分裂症本身内在症状的组成部分;或者是患者对精神分裂症病情的心理反应。有时服用抗精神病药也可能引起抑郁症状。

(四)病程和预后

精神分裂症病程具有不断发展、逐渐加重的趋势。病程进行快慢不一,大部分病人遗留缺损症状;部分病人以衰退为转归;但也有的病人一生中发作一次;部分痊愈或仅遗留缺损。病期较短的初发病人,经过合理的治疗有可能恢复到病前的状态。但是多数病人在多次复发经治疗后难以恢复到病前的心理功能水平。

第二节 精神分裂症诊断标准

按中国精神障碍分类与诊断标准第3版即CCMD-3,精神分裂症诊断标准与病程分期如下:

本症是一组病因未明的精神病,多起病于青壮年,常缓慢起病,具有思维、情感、行为等多方面障碍及精神活动不协调。通常意识清晰,智能尚好,有的病人在疾病过程中可出现认知功能损害,自然病程多迁延,呈反复加重或恶化,但部分病人可保持痊愈或基本痊愈状态。

一、症状标准

+++++

至少有下列各项中的2项,并非继发于意识障碍、智能障碍、情感高涨或低落,单纯型分裂症另有规定。

(1)反复出现的言语性幻听。

- (2)明显的思维松弛、思维破裂、言语不连贯,或思维贫乏或思维内容贫乏。
- (3)思想被插入、被撤走、被播散,思维中断,或强制性思维。
- (4)被动、被控制,或被洞悉体验。
- (5)原发性妄想(包括妄想知觉,妄想心境)或其他荒谬的妄想。
- (6)思维逻辑倒错、病理性象征性思维,或语词新作。
- (7)情感倒错,或明显的情感淡漠。
- (8)紧张综合征,怪异行为,或愚蠢行为。
- (9)明显的意志减退或缺乏。

二、严重标准

+++++

自知力障碍,并有社会功能严重受损或无法进行有效交谈。

三、病程标准

+++++

(1)符合症状标准和严重标准至少已持续 1 个月,单纯型另有规定。

(2)若同时符合分裂症和情感性精神障碍的症状标准,当情感症状减轻到不能满足情感性精神障碍症状标准时,分裂症状需继续满足分裂症的症状标准至少 2 周以上,方可诊断为分裂症。

四、排除标准

+++++

排除器质性精神障碍及精神活性物质和非成瘾物质所致精神障碍。尚未缓解的分裂症病人,若又罹患本项中前述两类疾病,应并列诊断。

五、临床类型

+++++

20.1 偏执型分裂症[F20.0]

符合分裂症诊断标准,以妄想为主,常伴有幻觉,以听幻觉较多见。

20.2 青春型(瓦解型)分裂症[F20.1]

符合分裂症诊断标准,常在青年期起病,以思维、情感、行为障碍或紊乱为主,例如明显的思维松弛、思维破裂、情感倒错、行为怪异。

(4)最近 1 年症状相对稳定,无明显好转或恶化。

20.x4 慢性[F20.x8 其他病程类型]

【诊断标准】

(1)符合分裂症诊断标准。

(2)病程至少持续 2 年。

20.x5 分裂症衰退期[F20.x8 其他病程类型]

【诊断标准】

(1)符合分裂症诊断标准。

(2)最近 1 年以精神衰退为主,社会功能严重受损,成为精神残疾。

第三节 精神分裂症的典型病例分析

一、青春型分裂症

病例一

(一)病历摘要

患者张某某,男,31 岁,高中文化,未婚。

主诉:13 年来反复洗手;1 年来闭门研究哲学和太极图,自称要出版这方面的书籍;近 2 周加重,不理睬亲人及毁物。

现病史:患者 13 年前(1987 年)上高中时,无诱因逐渐感到害怕,对家人说夜里听见有人喊“打你!”经常在上课时东张西望,不能专心听老师讲课。走路时,必须在原路上往返数次,否则感到痛苦难忍;反复洗手,常把手洗得苍白也不停止;站在阳台或高处便想往下跳,看见菜刀就想拿来剁手。患者自述时间长了能自行控制和对抗这些想法,渐渐地也不再感到上述现象对自己有任何困扰。高中毕业后高考落榜,患者即做推销小商品的生意,但是生意中常与人吵架并赔钱。以后担任过市场征税员,便认为自己经历非凡,黑白两道都见识过了。做生意时认为合伙人的社会地位低,说他们比较肮脏,就不愿意与其打交道。生活自理能力逐渐减退,爱发脾气,摔东西,夜眠差,在数年间未经治疗。

1998 年患者经常外出逛商场,怀疑有坏人把商场东西拿走了。曾在某医院诊

为“躁郁症”，服氯米帕明，量不详，病情未见缓解。1999年患者赋闲在家，花很长时间琢磨哲学、辩证法、太极图，对新闻联播中对台关系的内容非常感兴趣，自称要考虑军国大事，如考虑怎样对台湾采取军事行动才能占领台湾，拒绝参加工作。常闭门不出，偶尔参加一些“公关协会”组织的活动。

近2周来，患者反复照镜子，自称：“怕胡子茬儿沾到嘴上。”患者有时反复把袜子晾在铁丝上又拿下来十余次而不能自止。患者的言语内容夸大而离奇，说自己准备出几本书，是关于“太极”、军事和天文方面的。对父母说自己组织了第9个民主党派，公关协会也是自己组织的，准备为全天下善良的人谋幸福，但未见兴高采烈的表情、话多和活动增多等现象。有时无故突然用脚踹家中的柜子，把穿衣柜踹坏，不理睬亲人。有时家人劝患者出去散步，常置之不理或拒绝，而闭门不出。起床、进餐和洗漱等日常生活需家人督促。经医务人员接诊，以“精神分裂症，强迫症待除外”而收住院。

既往史：无传染病和药物过敏史，否认手术、外伤和躯体疾病等病史。

个人史：同胞2人，排行第2。母孕期体健，足月顺产。幼年生长发育正常，学习成绩中等，顺利读至高中毕业，但是高考落榜。高中毕业后未正式参加工作，有时在家人帮助下做生意和炒股票，但能力差而无甚业绩。1992年以后待在家不出门。高中时交过一女朋友，具体不详。无烟酒嗜好和毒物接触史。病前性格：内向、胆小、怕羞、不合群、朋友少。兴趣不广，无特殊爱好。

家族史：患者祖父可疑有精神异常，表现为凭空认为儿子非亲生，怀疑妻子有外遇，不与人交往，未曾诊治。否认其他家庭成员有精神病史。

体格检查：

体温：36.4℃，脉搏：84次/分，呼吸：20次/分，血压：135/75 mmHg。发育正常，营养中等，全身皮肤黏膜无皮疹、黄染和出血，浅表淋巴结未触及。头颅五官未见异常。颈部对称，气管居中，甲状腺无肿大。胸部无畸形，双肺未闻及干、湿啰音，心界不大，心率84次/分，各瓣膜区未闻及病理性杂音。腹部平坦，全腹软，肝脾未及。会阴部和脊柱四肢未见异常。

神经系统检查：

头颅大小和形状正常，脊柱无畸形和叩压痛。颅神经检查未见异常，全身深、浅感觉和皮层感觉未见异常。肌力和肌张力正常，深反射和浅反射正常；巴宾斯基征（-）、踝阵挛和髌阵挛（-）。脑膜刺激征阴性。

实验室检查：

未见异常。

精神检查:

衣履欠整齐,衣服系扣,不系鞋带。年貌相符。病人意识清晰,对时间、地点、人物定向力完整。对医护欠合作,经家属强迫送住院,见到医生和护士也不理睬,在谈话时没有目光接触,不与周围人主动交往;日常生活,如饮食和起床需督促。未引出幻听、幻视和感知综合障碍。自述:“我同时建立和推翻了大爆炸的宇宙学说,黑洞的形成是……的;我要出书,我破译了太极图;建立了第9个民主党派,我要改造世界,为天下善良人谋幸福……”

问其现在工作情况时,则回答:“我在家里做‘庙算’。”患者将“庙算”解释为:“‘庙算’就是炒股票,在家里算,运筹帷幄,决胜于千里之外。”患者在谈话中提到“魔项”,患者将“魔项”解释为:“我在恶劣环境下,难免掉到狼群里,被戏弄一番,一低头就表明给坏人鞠了一躬,我管他们叫‘魔项’。”患者若不作解释,别人无法理解。坚信周围邻居嫉妒并暗地里向公安局报自己的黑材料,要害死自己,所以不敢出门。问病人如何知道有人在害自己,病人答称:“凭感觉。”患者的注意力有时不集中,对问话似乎没有听明白,需要再重复1~2次。记忆和智能检查未见异常。患者否认有病,认为家人送自己住院是害自己。

患者表情呆滞,在叙述自己要著书立说时,表情仍为呆滞,有时突然痴笑。不与家人和亲友主动交谈。

病人多待在床边,不参加各种活动,对将来的生活、学习和工作等无计划和要求。

(二) 病例分析

1. 诊断和诊断依据

- (1) 患者,男性,31岁,未婚。
- (2) 病前性格:内向、胆小、怕羞、不合群、朋友少。无特殊爱好。
- (3) 病史13年,无明显诱因缓慢起病,为持续性病程。
- (4) 精神症状

① 存在不典型和片断的强迫性症状,如见着菜刀就想拿来剁自己的手,见着车轱辘就想往里钻,患者虽特别难受,但不愿进行抵制。典型的强迫症状,当强迫观念出现时患者明知自己的想法不对而予以抵制,本患者没有主动抵制的愿望,因此,即使有强迫症状,也是不典型的。

② 存在明显的思维逻辑性方面的障碍如语词新作:用“庙算”表示“炒股票,在家里算,运筹帷幄,决胜于千里之外”;把“魔项”解释为“我在恶劣环境下,难免掉到

狼群里,被戏弄一番,一低头就表明给坏人鞠了一躬,我管他们叫‘魔项’。”该症状与特殊意义妄想的区别:特殊意义妄想表示周围人的言行和平凡的举动等,不仅与病人有关,且赋有特殊的意义;也与象征性思维不同,象征性思维是以某一具体的物品或动作来表示某些特殊的、除病人自己外旁人无法理解的抽象概念,如有一个病人高举苍蝇拍(具体物品)称:“这就是权力(抽象概念)。”显然,患者的“庙算”和“魔项”既与“周围人的言行和举动”无关,又与“具体的物品或动作”无联系,故可以排除特殊意义妄想和象征性思维。同时,患者还有逻辑倒错性思维,自述“我同时建立和推翻了宇宙大爆炸的学说,黑洞的形成是……的;我要出书,我破译了太极图;建立了第9个民主党派,我要改造世界,为天下善良人谋幸福……”,这段话推理过程离奇古怪,既无前提,又无逻辑依据,例如“同时建立和推翻了大爆炸的宇宙学说”是相互矛盾的,怎么同时又建立又推翻?与后面“黑洞的形成是……的”这个结论更无联系。

③被害妄想,毫无根据地说邻居暗地向公安局报自己的黑材料,要害死自己,认为家人也在害自己,由于该患者的妄想不是继发于其他症状之后,其妄想具有原发性质。

④情感淡漠和情感不协调:不与家人和亲友接触,有时突然痴笑,面无表情地谈“建立了第9个民主党派,我要改造世界,为天下善良人谋幸福……”,患者在自诩有远大“抱负”时,并无情感高涨相随,仍为表情呆滞,可见思维内容与情感不协调。

⑤意志活动缺乏:多待在床边,不参加各种活动,对将来的生活、学习和工作等无计划和要求,因此社会功能明显受损。无自知力,认为家人送自己住院是害自己。

因为患者在青春期末无明显诱因缓慢起病,连续病程,历时13年,以思维逻辑障碍为主,伴片断的不典型强迫性症状和被害妄想,情感淡漠,逐渐不工作和不出门,进行性的社会功能严重受损,所以诊断为:

20.2 精神分裂症,青春型[F20.1 青春型精神分裂症]

2. 鉴别诊断

(1)躁狂状态:病史13年,一般长达这么久的躁狂发作少见,其思维逻辑障碍并非在情感高涨的基础上继发,可以排除。

(2)强迫症:患者对反复出现的洗手动作,并不感到痛苦,也不愿自行抵制,因此不能做出强迫性症状的诊断。同时有社会功能严重受损,也不支持该诊断。

(3)分裂情感性精神病:虽然患者有自命不凡的言语,但是情感高涨并不突出,

没有周期性发作。本病不仅具有精神分裂症的明显特征,而且也应具备情感性精神障碍的某些特征。患者的临床表现不具备上述条件,故可以排除此诊断。

3. 治疗方案

本例患者以思维障碍为主,既有阳性症状又有阴性症状,故以非典型抗精神病药物为首选,如果经济条件允许,可选用利培酮。本例患者入院后经利培酮平均3 mg/d治疗3个月,除情感淡漠和社会功能受损无明显改善外,其他症状基本消失。建议进行心理社会干预,如社会独立生活技能训练和家庭干预等,以利于预防患者病情恶化,尽可能恢复其受损的社会功能和回归社会。

4. 预后估计

有利因素少,仅文化程度稍高和没有使用多种抗精神病药物的历史而可能对药物治疗反应好;但不利因素多,青春期缓慢起病,病期长,以阴性症状为主,性格内向,家族史阳性。因此仅用抗精神病药物治疗,其精神症状可能部分或完全消失,而社会功能损害则难以恢复。如果在药物治疗的同时,不进行社会独立生活技能训练和家庭干预等心理社会干预措施,其恶化的危险性很大。

(三) 问题思考

1. 诊断和诊断依据

- (1) 总结该病例的病程特点。
- (2) 该病例有哪些精神症状?

提示:强迫症状、逻辑倒错性思维、夸大妄想、情感不协调、破裂性思维、行为障碍(具体描述及做出诊断)。

2. 鉴别诊断

(1) 症状学的鉴别诊断

①该病例是否有强迫症状?是否典型?如果不具备强迫症状的诊断基本条件,在哪一方面不具备?

②该病例是否有重复动作,怎样与强迫性症状鉴别?

③该病例是否有夸大妄想?如果有夸大妄想是继发的还是原发的?如果是继发的继发在哪个症状的基础之后?

④该病例是否有社会功能障碍,有哪些症状能引起社会功能障碍?

⑤该病例是否有语词新作?为什么?如何与象征性思维鉴别?

⑥该病例是否有破裂性思维?

⑦该病例是否有系统的妄想?为什么?

⑧该病例是否有窥镜症?

(2)病症鉴别

①强迫症:该病例是否有强迫症状,为什么该病例能排除强迫症?

②假设该病例有典型的强迫症状能诊断为强迫症吗?为什么?

3. 治疗方案

(1)该病例在选择抗精神病药时应考虑哪些因素?应该首选哪一类药物?为什么?

(2)除了用药以外还应该考虑哪些治疗?为什么?

病例二

(一)病历摘要

患者郭某某,女性,22岁,高中文化,无业,未婚。病史由患者母亲提供,可靠。

主诉:患者自诉用“下颌”想事、自笑、砸电话和在地上睡觉2年多;加重3个月,懒散,疑心有人议论自己,伤人毁物。

现病史:患者于1997年6月,无明显诱因向母亲发脾气后离家出走,在外面租房子住或住旅店,断断续续找工作干。但是在工作期间生活自理能力差,表现为经常不洗脸、不洗脚和不刷牙,因不能完成工作任务,多次被雇主辞退。患者偶尔将上述情况告知姐姐,而被姐姐接回家,但是住不了几天,又再次离家外走。最后一次在工作时与人吵架,认为同事在害自己,其姐姐在接到通知后将患者领回家。回家后患者表现为行为怪异,自笑、呆愣,或自言自语,家里人也听不清她在说些什么。有时无原因地行为冲动,有时砸玻璃、砸电话、摔电视,打母亲和姐姐。不喜欢在床上睡觉,抱着被子在地上睡,告诉姐姐自己能用下巴(指下颌)和脑门想事。有时认为家人和邻居在议论她。曾在某医院门诊诊断为“精神分裂症”,口服氯丙嗪治疗,量不详,病情无好转。之后患者在家乡诊治,具体治疗情况不详,仍语乱如故,时而跪下磕头,时而从家中冲出而乱跑,日常生活不能自理,吃饭需督促,睡眠无规律,常在夜间无故大喊大叫。

1999年12月,患者突然打来访问她舅舅的朋友,姐姐阻止她,便打姐姐。母亲回家后,患者躲在姐姐身后,说怕声音,突然拿菜刀要砍母亲,其母亲和姐姐把刀夺下并藏了起来。患者大骂母亲是坏女人,姐姐是野女人。情绪不稳定,时哭时闹,生活无规律,常不吃飯,有时一天吃半个水果。家里无法护理而送入我院进一步诊治。

在地上,地便是床,地床更大,我喜欢在地上睡觉。”当问及患者为什么殴打自己舅舅的朋友时,患者称:“他(指她舅舅的朋友)来我家和我舅舅议论我,他来我家的目的就是来监视我。”患者对问话很难引起注意,常不回答问题而发呆。记忆和智能基本正常。患者对所患疾病无自知力,要求回家,认为自己没病,认为父母犯傻把自己送住院。

情感活动表现:常突然无故痴笑,问她为什么笑则不做回答,情感活动、谈话内容与环境无联系,周围人谈笑话不能引起患者共鸣。有情感倒错,谈到被辞退和自己的爷爷去世时则哈哈大笑。

生活懒散,不洗漱,常卧于床上不动,不参加病房组织的活动,也不与病友交往。有冲动和怪异行为,在病房突然无故起床砸玻璃,摔电话,砸电视,打病友,有时跪下磕头,患者对上述行为不做任何解释。对将来的学习、工作和婚姻等无计划和要求,问:“你想出院吗?”答:(点头)。问:“住在我们这儿别回家了!”答:“行!”问:“以后你想干什么?”答:“没想过。”问:“你想交个男朋友,或结婚吗?”答:(摇头)。

(二) 病例分析

1. 诊断和诊断依据

(1)患者女性,22岁,高中文化,无业,未婚。病前性格:内向、孤僻少语,朋友少,固执好强。无特殊爱好。

(2)病史2年多,无明显诱因亚急性起病,为持续性病程。

(3)精神症状

①逻辑倒错性思维。如问:“为什么在地上睡觉?”答:“床立在地上,地便是床,地床更大,我喜欢在地上睡觉。”患者把“床立在地上”作为“地便是床”的根据,并发明“地床”,推理显然不符合逻辑。

②关系妄想和被监视感:患者认为舅舅的朋友说话是在议论她,来家里监视她。

③情感倒错和不协调:常突然痴笑,问为什么笑则不回答,情感与环境无联系,周围人谈笑话不能引起患者共鸣,谈到被辞退和自己的爷爷去世时哈哈大笑。

④行为怪异和冲动行为。在病房中突然起床砸玻璃,摔电话,砸电视,打病友,有时跪下磕头,患者的上述行为没有任何目的,并受离奇想法的支配而在地上睡觉。

⑤意志缺乏:患者对许多活动没有明显的动机,例如问患者:“住在我们这儿别

回家了!”答:“行!”问:“以后你想干什么?”答:“没想过。”问:“你想交个男朋友,或结婚吗?”答:(摇头)。可见患者既不关心工作、学习,又对生活本能的需求很淡泊,如患者不主动进餐,不主动洗脸、刷牙,也没有出院和与异性相处的要求。

⑥无自知力,要求回家,认为自己没病,认为父母犯傻而把自己送入院。社会功能明显受损,日常生活不能自理,病后完全不能工作。

据以上临床特点,患者在青春期无明显诱因亚急性起病,持续性病程2年多,以思维逻辑障碍为主,伴关系妄想,情感倒错和不协调,有冲动和怪异行为,明显意志缺乏,逐渐不能参加工作和拒绝出门,伴进行性的社会功能严重受损,所以诊断为:

20.2 青春型分裂症 [F20.1 青春型精神分裂症]

2. 鉴别诊断

(1)情感障碍:患者病程中有冲动行为和少语、独自发呆,这些症状也可见于情感障碍。但患者的持续性病程和精神症状以思维障碍为主,主导情感是倒错和不协调及进行性的社会功能严重受损皆不支持情感障碍诊断。

(2)偏执型分裂症:偏执型分裂症符合分裂症诊断标准,以妄想为主。本病例虽有妄想症状,但是不系统,也不占主导地位,而是以思维逻辑紊乱、情感倒错、行为怪异为主,可以排除偏执型分裂症。

3. 治疗方案

本例患者症状以阳性症状为主,伴有阴性症状,因此以非典型抗精神病药物为首选。本例患者入院后经电痉挛治疗13次,利培酮治疗108天,平均剂量4 mg/d。精神症状明显好转,但残存偶尔自笑,有时发呆,自知力未恢复,仍认为自己没有病。一直不愿坚持服药。日常生活能自理,社会功能无显著改善,出院后对学习和工作无计划。建议进一步进行心理社会干预,如社会独立生活技能训练和家庭干预等,鼓励病人多和人交往,有助于进一步提高疗效。

4. 预后估计

有利因素为亚急性起病,病程较短,文化程度较高,家族史阴性;不利因素有青春期起病,性格内向,有阴性症状。因此经抗精神病药物治疗,其精神症状可部分消失,社会功能会有所改善。出院后如果进行社会独立生活技能训练和家庭干预等心理社会干预措施,可降低其恶化的危险性,且阻止其社会功能的进一步衰退。

别人欺负他,企图自杀,拒食。因家庭经济困难未延医诊治,后体力消耗而死。患者哥哥于1952年(时年27岁)有精神失常史,到1956年才“精神比较正常”,由国家分配工作,详情不了解。

体格检查:

体温、脉搏、呼吸、血压正常。发育正常,营养欠佳。全身皮肤稍有黄染,双侧巩膜轻度黄染。心肺听诊正常。肝脏肿大,于肋缘下2厘米可触及,质软,有轻度压痛。脾脏未触及。余躯体及神经系统检查未见异常。

实验室检查:

血尿常规、血沉、胸透正常。黄疸指数10 U,凡登白直接迟缓反应,血胆红质1.9 mg%,麝香草酚浊度实验3 U,脑磷脂絮状实验阴性。白蛋白4.57 g%,球蛋白2.29 g%,空腹血糖、血非蛋白氮正常。

精神检查:

意识清楚,时间、地点、人物定向力正常。表情呆愣,对外界漠不关心,主动及被动接触均差。生活尚能自理。饮食正常,夜眠欠佳。入院后患者有时呆愣,对大夫的问话只是用点头、摇头做出反应,不回答问题。有时则兴奋不安,大喊大叫,内容单调、刻板,例如叫喊同学、同事的姓名。患者胡乱唱歌,刚唱了一句“我们工人有力量”,竟接着唱另一首歌的歌词“你是灯塔”。有时自言自语的内容前后不连贯,无主题和中心思想,甚至是词的堆砌,例如“杀鸡用牛刀……滚出去……烂污货……小偷……打倒叛徒……三只手……”患者在大声自语的时候,面部表情呆板平淡。交谈中未发现错觉、幻觉和妄想。记忆和智能基本正常。患者否认自己有精神上的毛病,无自知力。患者的情感以淡漠和面部表情呆板为主,有时无故自笑。入院后患者有时冲动打人,撕毁被套、枕套,有时掀开被子,故意赤身裸体。入院后安于现状,无任何主动要求提出。

入院诊断:

1. 精神分裂症(青春型)
2. 传染性肝炎恢复期

住院经过:入院后给予营养支持治疗,用水合氯醛或副醛帮助患者入睡。患者仍言语凌乱,大喊大叫,冲动打人,撕衣毁物,乱扔室内物品,用鞋打自己的头部,或以头撞铁床,或站在床上,由一张床蹦跳到另一张床。患者曾把病友的鞋藏在自己的被褥里。有时仍自笑。本拟开始胰岛素治疗,后因患者体温 $37.4\sim 38.3^{\circ}\text{C}$,经胸部摄片后临床诊断为右肺浸润性肺结核,于1958年4月25日转至本院结核病区。经抗结核治疗肺结核病情好转,住结核病区4周后转回原病区。患者转回原

的表现也很突出,住院期间见其他病区女病人后突然拥抱接吻,劝阻时仍紧紧抱住异性不松手等。第二阶段从 1963 年年初开始,直至在本院病故。在此阶段,患者在精神异常表现中,“精神衰退”的迹象越来越明显并且不断加重,患者逐渐地表现为思维贫乏,情感淡漠,意志低下。患者经常衣服很脏,生活不能自理,在疾病后期连进食都需要督促,以致躯体情况每况愈下。1963 年 4 月肺结核复发,被确诊为右肺浸润型肺结核溶解播散期,经抗结核治疗(仍继续服用抗精神病药)至 1964 年 12 月,肺结核才处于静止期。到 1968 年 1 月 11 日,因肺结核再次复发,合并肺部感染,上消化道出血,抢救无效而死亡。随访结果提示本例患者在精神失常 11 年后(从 1952 年 2 月到 1963 年年初),精神分裂症由疾病的充分发展期转入慢性期“精神衰退”阶段。本病例还提示精神分裂症青春型患者在病程中虽然可能有多次自发性缓解(本病例有两次自发性缓解),但很容易复发,随着复发、恶化次数的增多,思维贫乏、情感淡漠、意志低下等“精神衰退”的表现越来越明显,这种疾病类型预后不佳。因此对精神分裂症青春型患者精神症状自发性缓解的机制和影响复发的因素进行深入研究,已经成为摆在精神科医师及科研工作者面前的一项紧迫而又艰巨的任务。

二、偏执型精神分裂症

病例一

(一) 病历摘要

患者陶某某,男性,42 岁,教师,大学文化,婚姻状况:离异。病史由患者女儿提供,可靠。

主诉:凭空听见喊自己的声音,诉对面楼有妓女陷害自己 9 月余,近月余加重。出现失眠,怕出门,向组织写汇报材料。

现病史:1999 年 5 月,患者无明显诱因凭空听到对面楼上有人喊他的名字,对面楼与其所住楼相隔 1 个大操场,相距约 60 多米。患者听到有男女的声音叫自己过去,但看不见人,因此患者踌躇不前,这些声音则说:“你怎么还不过来呀?”有的声音内容为批评患者不正经,辱骂他是流氓。当下楼时,听见声音说:“他下楼了,他下楼了。”但到外地去时,患者诉听不到这类声音了。所以患者怀疑对面楼里住的是妓女,要引诱他过去,目的是骗取他的钱财。为此告诫自己不能中她们的圈

套,坚决不能过去;并把这件事对家人说,家人都否认有声音存在,患者仍坚信不疑。一次女儿不在家,患者听见自己隔壁房间里有男女谈话的声音,推门一看,没有看见有女人,只有女婿1人。因此怀疑自己的女婿与其他的女人有染。患者心情整日紧张不安,诉心里老憋着闷气睡觉,也睡不安稳。有时半夜起来查看门窗是否关紧了,家里是否有陌生人溜进来。其间无兴奋话多,夸大和冲动伤人;未见悲观及自伤、自杀企图。病中患者无发热、头痛和昏迷抽搐史,无大、小便失禁。

近1月来在上街时,患者看到街上的人谈话,则疑心是那些妓女的同伙在向别人打听自己的情况。看到邻居聊天时则认为他们都知道了自己的“家丑”,所以感到特别委屈,觉得自己被别人冤枉了,便向学校和派出所写材料,汇报自己的情况,并为自己辩白。此后,其活动有所减少,成天待在家里,紧张不安,食欲明显减退。且听到对面楼里的声音出现得更频繁,内容多为辱骂性质。有时听见有女人的声音出现在自己房门口,在叫喊和议论他。近几日,女儿不在家时,患者又听见隔壁的房间内常有男女谈话的声音,突然推门进去又找不着人,所以更加怀疑女婿拈花惹草。经我院门诊以“妄想状态”收住院。

既往史:患白癜风10余年。否认有其他重大躯体疾病和外伤手术史,无药物过敏史。

个人史:同胞5人,排行老大。母孕期体健,足月顺产,自幼生长发育良好,适龄入学,成绩好。1978年考入某学院中文系,1982年毕业后至一所中学任教。工作能力强。嗜烟,每天吸20~30支,有20余年烟龄,不饮酒,无毒物接触史。1976年结婚,婚后育有两个女儿,和女儿感情好;但夫妻感情不融洽,1989年与妻子分居,1994年与妻子离婚。病前性格:内向,不合群,敏感多疑,较固执,我行我素,自尊心较强。

家族史:其母亲有明显的精神不正常,表现为无故认为有人要害她,并认为自己的家人不是原来的人,而是由别人冒充的,未诊治,已去世。两系三代其他成员无精神病、癫痫和白痴患者。

体格检查:

体温:36.4℃,脉搏:78次/分,呼吸:19次/分,血压:119/78 mmHg。发育正常,营养中等,皮肤有多处色素脱失,界限清楚,大小多为(4~5)厘米×(7~10)厘米,无渗出和肿胀,皮肤黏膜无皮疹、黄染和出血,浅表淋巴结未触及。头颅五官未见异常。颈部对称,气管居中,甲状腺无肿大。胸部无畸形,双肺未闻及干、湿啰音;心界不大,心率78次/分,各瓣膜区未闻及病理性杂音。腹部平坦,全腹软,肝脾未及。

神经系统检查:

头颅大小和形状正常,脊柱无畸形和叩压痛。颅神经检查未见异常,全身深、浅感觉和皮层感觉未见异常。肌力和肌张力正常,深反射和浅反射正常;巴宾斯基征(-)、踝阵挛和髌阵挛(-)。脑膜刺激征阴性。

实验室检查:

未见异常。

精神检查:

在其女儿陪同下步入病房,衣履欠整,年貌相符。意识清楚,定向力完整,知道自己所处的地点是医院,能正确分辨医护人员,在向窗外看一看后知道是上午。能自报姓名、年龄及以前的工作单位。入院后能自行更衣,对查体合作,接触被动,多待在床边,不参加病房所组织的各种活动。进食服药需督促,睡眠好,大小便正常。

患者称见不到人可凭空听到说话的声音,可以听到距自家数十米外楼内男女的谈话声,但是见不到人。患者述:“自去年5月份开始,我待在家里时总能听到对面楼里有些声音在喊我,有男的,有女的,但以女的居多。听声音像是十七八岁的小姑娘。开始时是喊我的名字,叫我过去,我不过去,她们就骂我,要破坏我的名声,但我不理会她们。”又称:“还有好几次我听见隔壁有男女说话的声音,但我推门一看却找不着女的。”“今年元宵节前后,我又听到好几个女的跑到我家门口来喊我,我不理会,她们说了一会儿话后就走了。我很奇怪家里人都听不见她们说话的声音。”言谈切题,未发现语句结构紊乱。

有大量的妄想,患者自述:“那些喊我的人,肯定不是什么好人。想想看就知道,年轻姑娘老是缠着我一个糟老头干嘛!成天喊我过去,那肯定是陷阱。把我骗过去之后,要捞取钱财,那些姑娘肯定是妓女。这年月下岗的人多,干这一行的自然就多了。那些男的则是保镖、打手。他们合伙来谋取我的财物,破坏我的名声。”有明显被害感:“有时候我看到街上有些人在谈话,我就推断肯定是那个团伙里的人在打探我的消息,他们准不怀好意。”“有时我看邻居的举动,例如,他们在一起说话,或是我开门时他们老探头出来看看,我就觉得我们家里的事全被他们知道了。”患者否认自己有病,觉得自己耳朵灵才听到这些声音。

情感活动,谈及对面楼里有人要害他时,患者显得气愤。转移话题后能恢复平静。情感反应与内心体验及外界环境尚协调。智能正常。意志活动缺乏,入院后多独处,对将来没有计划和打算,吃饭及洗漱皆需督促,很少与病友来往。患者安于住院现状,对被议论及认为被勾引之事也不加追究。生活能自理,未见明显的冲动行为,无自杀、自伤、毁物的行为。

(二) 病例分析

1. 诊断和诊断依据

(1) 患者男性, 42 岁, 教师, 大学文化, 离异。病前性格: 内向, 不合群, 敏感多疑, 较固执, 我行我素, 自尊心较强。

(2) 病史 9 月余, 无明显诱因缓慢起病, 为持续性病程。

(3) 精神症状

①真性言语性幻听。患者述: “自去年 5 月份开始, 我待在家里时总能听到对面楼里有些声音在喊我, 有男的, 有女的, 但以女的居多。听声音像是十七八岁的小姑娘。开始时是喊我的名字, 叫我过去, 我不过去, 她们就骂我, 要破坏我的名声, 但我不理会她们。”患者幻听的声音有明确的方向, 并且是通过耳朵听见的, 同时不受自己控制, 也就是说这些说话声想听或不想听都存在。患者幻听的内容为指令自己到对面大楼去, 可以判定为命令性幻听。

②被害妄想。患者称: “那些喊我的人, 肯定不是什么好人。想想看就知道, 年轻姑娘老是缠着一个糟老头, 成天喊我过去, 那肯定是陷阱。把我骗过去之后, 要捞取钱财, 那些姑娘肯定是妓女。这年月下岗的人多, 干这一行的自然就多了。那些男的则是保镖、打手。他们合伙来谋取我的财物, 破坏我的名声。”患者的妄想是从幻听的内容产生的, 也就是说妄想继发于幻听之后, 即是继发性妄想。

③关系妄想。患者称: “有时我看邻居的举动, 例如, 他们在一起说话, 或是我开门时他们老探头出来看看, 我就觉得我们家里的事全被他们知道了。”“有时候我看到街上有些人在谈话, 我就推断肯定是那个团伙里的人在打探我的消息。”可见患者将与己无关的现象和自己联系起来, 是关系妄想的特点之一。

④对疾病无自知力: 否认自己有病, 觉得自己耳朵灵才听到这些声音。

⑤意志缺乏: 对将来没有计划和打算, 吃饭及洗漱需督促。社会功能明显受损, 不能继续工作。

根据以上临床特点, 患者无明显诱因缓慢起病, 持续性病程 9 月余, 有命令性幻听, 在幻听的基础上继发关系妄想和被害妄想, 对疾病无自知力及社会功能明显受损, 诊断精神分裂症成立, 因其症状主要为幻觉妄想和继发的意志行为紊乱, 所以在分型上定为偏执型。诊断:

20.1 精神分裂症, 偏执型 [F20.0 偏执型精神分裂症]

2. 鉴别诊断

偏执性精神障碍: 该病和精神分裂症一样也有关系妄想和被害妄想, 但偏执性

精神障碍患者的妄想内容较为系统和固定,妄想内容和患者的处境有一定联系。患有此病的患者病前常有个性不健康的表现,如主观、固执、敏感、多疑、不安全感、好争论、自命不凡、强词夺理、爱空想、不能面对现实等。本病例在病前无上述人格特点,无现实基础作为诱因起病,患者的妄想内容继发于幻听,内容离奇而缺乏逻辑性;如患者说:“有时候我看到街上有些人在谈话,我就推断肯定是那个团伙里的人在打探我的消息。”其内容泛化,荒谬;同时社会功能严重受损,皆不支持偏执性精神障碍的诊断。

3. 治疗方案

本例患者症状以阳性症状为主,典型抗精神病药物为首选,可选氯丙嗪、奋乃静或氟哌定醇。患者入院后经氯丙嗪平均 450 mg/d 治疗 70 天,精神症状消失,情感活跃,希望出院后恢复工作。但自知力未恢复,仍认为自己的幻听是确实存在的,仍认为有人害自己才得了病,患者称现在听不见被命令的说话声音了。出院后不愿坚持服药,因为病已好了。社会功能恢复正常,日常生活能自理,要求继续回学校工作。建议进行心理社会干预,如社会独立生活技能训练和家庭干预等,以利于预防患者病情恶化,提高其社会功能和促进患者回归社会。

4. 预后估计

有利因素为文化程度高、病程短、有工作和没有用多种抗精神病药物的历史,因此可能对药物治疗反应好;不利因素有缓慢起病,性格内向,家族史阳性,离异,家庭结构不完整。因此经抗精神病药物治疗,其精神症状可能消失,社会功能会有所改善。但如果在药物治疗的同时,不进行社会独立生活技能训练和家庭干预等心理社会干预措施,出院后药物维持的依从性可能会很差,其复发的潜在危险性很大。

病例二

(一) 病历摘要

患者季某,男,60岁,汉族,大学文化,外语翻译,再婚,于2000年1月4日第3次住院。由妻子和女儿提供病史,并参阅既往门诊及住院病历,病史可靠详细。

主诉:敏感多疑31年;5个月来明显加重,疑心,行为异常。

现病史:患者于1969年(29岁)时,无明显原因首次精神失常。当时正值“文化大革命”期间,患者在单位的“专案组”工作,单位同事发现患者在工作中多疑,疑心自己做错了事。后来虽被调离了“专案组”,患者的疑心依旧,例如认为有人在他

的自行车上安装了窃听器,认为有人要逮捕自己等。1969年,患者全家下放到“五七”干校在农村劳动锻炼期间,认为有人故意把铁铲等工具放在他家门口,意思是让他用工具杀人,暗示自己去犯罪。一些4~5岁的孩子去患者家去玩,患者也疑心有人专门派孩子来探听他的言行和监视他的行动。患者曾被送往某精神病院门诊,在往返医院的路上,患者认为在火车、路上、理发店里到处有暗探在监视自己。

在口服氯丙嗪(用量不详)半年后,患者的上述精神症状有所减轻。后听说氯丙嗪对记忆力有影响,患者就自行停药。1970年9月起,患者疑心妻子有外遇,限制妻子与异性的接触。1973年患者夫妻回到北京原单位工作后,妻子分娩一女孩,患者竟骂这小女儿是“野种”。1974年4月,患者来我院初诊,门诊印象:妄想状态,给予奋乃静口服治疗。在1974—1984年,患者的治疗很不系统,未持续用药;每隔几个月到1年,由妻来门诊取药,患者每日只服6~10 mg 奋乃静。在这10年期间,患者的工作能力未受到明显的影响,除完成日常工作外,还有20万字的译著出版,但敏感多疑一直存在。例如,只要妻子下班后回家晚几分钟,患者就会询问妻子干什么去了。常常说某些领导对自己怀恨在心,有时称:“他们和我见面后都不理我。”

1984年5月,患者自行停药。1984年7月,患者用法语对其妻子讲:“你彻底背叛了我,我早晚要把你杀了。”1984年7月20日,患者自觉在进食馒头后心跳加快,自己数脉搏为120次/分,患者认为这是妻子在馒头里放了毒药,并认为这种毒药是和其妻子私通的某男人从国外带回来的。患者妻子也吃了馒头,并没有中毒,患者对此的解释是因为妻子事先已服用了解毒药。1984年7月下旬某日,患者回家后闻到了一股味道,认为这是妻子在房间里喷了毒药,故把窗帘拿下来洗,将洗窗帘的水盛在一个碗里准备去化验。1984年8月8日,为躲避妻子的“迫害”,患者突然乘火车到上海的亲戚家。到上海后仍认为到处有人跟踪监视他,10余天后又自行返回北京。返京后认为其妻与坏人勾结,把自己的肝脏破坏了。为了报复,患者买了两把菜刀企图对妻子行凶。于1984年8月17日首次住我院。

入院后,对上述症状能予以详述,当谈到其妻对其不忠时有相应的气愤、不满等情感反应。入院后予以舒必利治疗,于入院第57天,每日用量达1200 mg,又经治疗40天后患者自知力完全恢复,对住院前用刀架在妻子的脖子上,逼迫妻子交待“问题”的做法深感后悔。经试出院观察,病情稳定,于1984年11月3日以精神分裂症偏执型临床治愈之疗效出院。

患者出院后,间断地在门诊复查取药,休息3月余后即恢复工作。

1987年7月,患者已自行减药,将舒必利由1200 mg/d,减到只在每晚服400

~500 mg。1989年3月,患者精神症状复发,怀疑自己的身体得了病,经常独自去北京市多家综合医院检查身体。1989年1月底,患者再次到某医院门诊化验,结果均为正常。患者无根据地认为有一家医院诊断自己患了肝硬化和肝癌,再次就诊时则认为公安部门与医院串通,改了他的诊断。患者怀疑小女儿受公安部门委派,跟踪监视自己,故不让小女儿进家门。1989年4月,患者给正在国外工作的妻子写信,催促其妻立即回国。其妻曾多次在电话中向其解释不能立即回国的理由,但解释均无效果。1989年5月23日,其妻返京当天晚上,患者便追问其妻:“你托词迟迟不回国,是否已经有了第三者?”此时患者拒绝服用任何药物,理由是医院受公安局的指使,已经往药物里加入了致癌物质,目的是想害死他。患者说公安局在他家里装上了窃听器,其妻与公安局合谋要害死自己,目的为在自己死后能与“第三者”结婚。患者不吃家里做的饭菜,每日都到外面买饭吃,还买了一把菜刀随身携带。

于1989年6月1日第2次住院。入院后患者拒食拒药,声称单位领导、同事以及妻子成心与他作对,为了加害于他,才将他送进精神病院,否认自己有精神病。入院诊断同前,入院后给予系统的舒必利治疗,患者病情好转,于1989年9月间,患者妻子向法院提出离婚请求并获准离婚。尽管遇此不幸,患者病情尚稳定。1990年6月17日,患者主动向大夫述说,过去自己在下列四个方面有疑心:疑心前妻有外遇;疑心有人在自己的食物中放了毒药;疑心自己患了肝癌;疑心自己的小女儿受公安局指使,监视自己的言论行动。患者说以上四个方面的疑心是孤立存在的,彼此之间没有什么联系,现在认识到这些都是很荒谬的病态想法。考虑到患者已达临床治愈水平,住院期间曾将患者的舒必利由1200 mg/d减至800 mg/d。10个月后患者病情复发,只承认本次住院前对妻子在做法上有些过分,并否认有再次住院的必要。舒必利的用量恢复到1200 mg/d,持续1周后,患者的自知力、批判力又大部分恢复,继续治疗1月余后,患者又达临床治愈水平。经试出院观察于1992年7月20日以临床治愈之疗效出院。

再一次出院后,患者尚能坚持服药,定期门诊复查,并再婚。1993年起,患者又自行减药,经劝阻无效,仍继续减药。1996年8月,舒必利已减至500~600 mg/d,1997年起减至300 mg/d。随着药物的减量,患者的自知力、批判能力明显下降。1998年1月在门诊复查时,患者否认既往两次住院的必要性,要求门诊医生给其开“无精神病”的证明,并说现在已经完全停药了。1999年8月,患者精神病复发,症状明显,曾给中央某领导同志写信,一是控告其单位领导不给她出国的机会,二是要澄清他没有精神病这一事实。1999年9月起,患者怀疑这位中央领导同志派

人来害他,故很少出家门。1999年12月,怀疑妻子也被这位中央领导同志收买了,与外人勾结在一起加害于他,认为家里有窃听器,因而不许其妻进家门。怀疑家中饭里、水里都被人放了毒药,因而不吃家里的饭菜,到自由市场买水果、蔬菜充饥。患者说小伙子们都讥笑他,因而把铝质瓶盖放在自己的头顶,称这样做可以隐身。1999年12月中旬某一天,患者在家打电话后就将电话机砸坏,把电话线割断。2000年1月3日,患者说妻子正找人要害他,要置他于死地,因此深夜醒来后不敢再入睡,于2000年1月4日第3次住院。

既往史:1995年曾患“乙型肝炎”,1年后治愈。否认药物过敏史。

个人史:同胞5人,排行第5,有3个姐姐,1个哥哥。母孕期情况不详。上学后一贯学习成绩优良。大学本科外语系法语专业毕业。1967年自由恋爱与前妻结婚,妻子为大学时同班同学,婚后夫妻感情好。有两个女儿,体健。1989年与前妻离婚。1998年与现妻结婚,婚后夫妻感情好。个性特点:性格内向,比较孤僻,不爱与人交往。对工作认真负责。业余时间喜欢看电影、文艺演出、外国舞蹈等。无烟酒嗜好。

家族史:否认两系三代中有精神疾病患者。

体格检查及实验室检查:

躯体及神经系统检查无异常发现。入院常规化验正常。乙肝“两对半”免疫检验均阴性。

精神检查:

意识清楚,定向力完整。在强迫下步入病房时高喊“我没有病”。主动及被动接触均差。入院更衣时发现其衣服口袋里除现金、存折外,还藏有苹果、胡萝卜、铝质瓶盖等。在劝说下进食尚可。入院后未发现患者有感知觉和感知综合障碍。

患者认为在本次住院前有一伙人对其进行跟踪、监视和迫害,往其家里的水中、饭菜中放毒药。患者认为现在让其住院也是一种阴谋,病房里的医生护士都是公安局派来监视他的。入院后患者多次以手势或写字对医护人员的问话做出反应,经反复询问后才了解到,患者不开口讲话,是怕别人在他讲话时,乘机用电子手段伪造他的讲话声音,以便加害于他。患者无自知力。

记忆、智能无明显障碍。患者在谈到自己被害内容时表情愤怒。入院后患者坚决要求出院,还说宁愿死去,也不会向阴谋分子妥协,患者立誓:“最后要把你们(指医护人员)告上法庭。”

(二) 病例分析

1. 病历特点

(1) 男性, 现年 60 岁, 于青年时无明显诱因缓慢起病, 逐渐进展, 总病期已 31 年。

(2) 在长达 31 年的时间里, 只在 1984 年 7 月, 出现过短时间的“幻嗅”, 感知觉障碍在整个病程中不占主导地位。患者以被害妄想为首发症状, 病情进展后除关系、被害妄想外, 还有嫉妒妄想、疑病妄想等, 构成了妄想综合征。

(3) 患者以关系妄想、被害妄想为贯穿疾病始终的主导症状, 而嫉妒妄想和疑病妄想则只是在疾病的某一时期较为明显和突出。患者的妄想内容泛化, 这一妄想与其他妄想之间没有什么联系, 妄想的结构松散, 诸多妄想缺乏逻辑上的联系。到第 3 次住院前后, 受被害妄想的影响, 患者更出现把铝质瓶盖放在自己头顶上, 认为可以隐身, 用手势或写字与别人交流思想等明显的行为异常。患者的智能、记忆无障碍。思维、情感、意志行为活动之间尚协调。

(4) 患者无重大躯体疾患, 家族史阴性。诊断:

20.1 偏执型分裂症 [F20.0 偏执型精神分裂症]

2. 诊断依据及鉴别诊断

(1) 精神分裂症: 患者在青年时期无明显原因缓慢起病, 逐渐进展, 以妄想综合征为主要临床表现。妄想内容泛化, 明显的离奇, 如: 患者称头顶铝质瓶盖能够隐身, 妄想内容结构松散, 表现为诸多妄想缺乏逻辑上的联系, 这些妄想特点符合精神分裂症偏执型的临床特点。而且从病例资料内容分析, 本患者完全符合 CCMD-3 和 ICD-10 所规定的精神分裂症的症状学标准。且由于患者受精神症状支配, 其行为不能被家庭及社会所接受, 造成家庭关系破裂, 不能正常工作, 其严重程度已达诊断标准。病期达 31 年, 因此可以确诊为精神分裂症偏执型。

(2) 偏执性精神障碍: 本例患者以妄想综合征为主要表现, 并且从起病至此次住院, 达 31 年之久, 至今尚无“精神衰退”迹象, 因此需要与偏执性精神障碍鉴别。但偏执性精神障碍的妄想内容与现实生活有一定的联系, 妄想的形成有一定的现实基础, 不经了解, 较难辨别患者所谈内容的是非真伪。而且偏执性精神障碍的妄想内容比较固定, 妄想与妄想之间结构比较严密, 逻辑性较强, 这些特点显然与本例患者不符, 因此可以排除偏执性精神障碍的诊断。

3. 治疗计划和预后估计

因为患者既往两次住院均以舒必利治疗而使病情缓解出院, 而且缓解期社会

功能保持良好,能够工作及重新结婚,所以这次仍选用舒必利。但是由于舒必利没有镇静作用,本次住院后,患者受妄想支配,对医护人员采取对立态度,对治疗不合作,所以先给予氟哌啶醇肌内注射,待精神症状改善、患者对治疗合作后,再逐渐改为系统的舒必利治疗。根据患者既往两次住院时的治疗经验,估计经过系统的药物治疗,近期疗效可达临床治愈水平。但远期疗效如何,则要视患者本人、家属、医生等相互配合的程度而定。另外心理—社会康复措施对防止复发将起重要作用,这个措施可以提高病人的用药依从性,以期保持疗效稳定。

治疗经过:入院后给予氟哌啶醇肌内注射治疗,接触及敌对症状改善后改为口服舒必利。舒必利治疗 1 200 mg/d 共 88 天,患者自知力完全恢复,达临床治愈水平,经过试出院观察于 2000 年 6 月 26 日治愈出院。

评按:这是 1 例典型的精神分裂症偏执型病例。就目前的科学水平而言,偏执型的近期和远期疗效要比精神分裂症的其他一些类型要好。通过本例患者的病情演变过程,特别是在第 2 次住院期间试行减药后病情复发,可以了解到精神分裂症患者要想维持已经取得的疗效,就要坚持服用适宜剂量的抗精神病药物作为维持治疗。笔者在强调服用维持量药物重要性的同时,还强调不能忽视社会支持系统和心理社会康复措施的重要作用。本例患者于 1992 年 7 月第 2 次治愈出院后,1993 年初患者就开始自行减药,在 1993—1998 年这 5 年中,经过患者第 2 次住院时经治医生的耐心解释和劝说,门诊医生的多次用药指导,对于阻止和延缓患者的自行减药,使患者保持长达 5 年之久的缓解状态,同时社会功能良好,起到了重要的作用。但由于患者及其家属对精神分裂症有复发及难以根治的特点缺乏认识,以致在缓解一定时间后自行停药。为改变上述现象,国内外不少学者在探索心理社会康复及家庭干预的方法,提高患者的用药依从性,其中首都医科大学附属北京安定医院正在研究精神症状自我监控程式、药物治疗自我管理程式,用半定量式的独立生活技能训练的方法提高患者对精神分裂症的临床特点的认识,其中最重要的是使病人认识到该病具有复发性的特点。教会病人自己管理药物治疗技能,早期发现复发的先兆症状,而有及早求医的能力。再者,改变病人家属对病人的态度,减少家庭对病人的心理压力,改变家属原有的高情感表达现象,使病人生活在温馨轻松的家庭环境中而达到防止复发的目的。该例病人,如果将药物治疗—康复—家庭干预巧妙地结合起来,有望制止复发。

病例三

(一) 病历摘要

患者蔡某某,男性,53岁,已婚,大专文化,退休干部。病史由患者妻子和女儿提供,可靠。

主诉:近3年来患者认为有人在墙上装了窃听器,用红外线监视自己,伴有紧张害怕;近半月加重。

现病史:1992年秋天,患者无诱因逐渐出现敏感多疑,认为别人怀疑自己偷了东西,认为派出所动员邻居来监视自己,邻居家的一举一动都是针对自己的。邻居对自己打招呼是为了向别人传递信息。伴有夜眠差,经常从睡梦中醒来,有时坐立不安,对家人说自己冤枉。工作能力有所下降,有时出差错。

1993年6月,认为邻居来自己家串门的目的是来听自己和家人说话,因此要求家人在说话时打开收音机并放大音量,目的在于防止邻居窃听自己与家人谈话的内容。认为邻居家搞装修所产生的噪音也是故意打扰自己。上街时,不让家人左顾右盼,说怕别人丢了东西后怀疑自己。不允许家人晚上往外拿东西和出门,夜间要等到别人家都开灯了才让自家开灯,说借以防备别人用红外线监视自己。1993年12月住某精神病院治疗,具体诊治不详,无明显疗效而出院。至此患者不敢再上班,多待在家中,日常生活能自理,食欲正常。病中无发热、头痛、抽搐和昏迷等,体重未明显下降。不伴兴奋话多、自责和自伤自杀等。

近半月来,因楼上漏水与邻居吵架后症状加重,认为周围人一天24小时在监视自己,自己家对面工地上的灯光也是为了监视自己。患者用照相机将楼上邻居向自己房间内漏水的情况拍摄下来,将对面工地情况也拍摄下来。家人出门回家后,患者都要询问他们外出的详细经过,并将家人的行踪记录在日记里。同时每天记录周围发生的情况。因病情加重由家人送来住院治疗。

既往史:1991年曾在某院进行“肺纤维瘤切除术”,6个月前患“白内障”。无肝炎、结核等传染病史,否认其他重大躯体疾病和外伤史,无药物过敏史。

个人史:同胞5人,排行第2。母孕期体健,足月顺产,自幼发育正常。7岁入学,学习成绩好,顺利读至大专。1968年参加工作,从事机械制造工作,工作能力强,1973年起担任厂长。1994年因病离休。1969与现妻结婚,婚后感情好,有3女,均体健,与妻子和女儿感情深。无烟酒嗜好和毒物接触史。病前性格:内向,少语,讲原则,认真负责,谦让。喜欢下象棋。

家族史:否认父母两系三代中有精神病病史。无近亲婚配和其他遗传性疾病。

体格检查:

体温:36.2℃,脉搏:83次/分,呼吸:21次/分,血压:128/81 mmHg。发育正常,营养中等,全身皮肤黏膜无皮疹、黄染和出血,浅表淋巴结未触及。头颅五官未见异常。颈部对称,气管居中,甲状腺无肿大。胸部无畸形,有手术瘢痕;双肺未闻及干、湿啰音;心界不大,心率83次/分,各瓣膜区未闻及病理性杂音。腹部平坦,全腹软,肝脾未及。

神经系统检查:

头颅大小和形状正常,脊柱无畸形和叩压痛。颅神经检查未见异常,全身深、浅感觉和皮层感觉未见异常。肌力和肌张力正常,深反射和浅反射正常;巴宾斯基征(-)、踝阵挛和髌阵挛(-)。脑膜刺激征阴性。

实验室检查:

未见异常。

精神检查:

在其妻子和女儿陪同下步入病房,衣着整齐,年貌相符。意识清楚,定向力完整,知道这里是治疗精神病的医院,能正确分辨医护人员,在看窗外后知道是上午。能自报姓名、年龄及以前的工作单位。自行更衣,查体合作,接触被动,多待在床边,不参加病房组织的各种活动。进食服药须督促,失眠,大小便正常。

患者诉从3年前开始,总听见四面邻居家有电铃的声音,后来逐渐又听见邻居家和楼上搬东西、电钻和拉动铁床的声音等,白天和晚上都有。但否认听见说话的声音。问:“你怎么知道有红外线在监视自己,有感觉吗?”答:“身上没什么感觉,有一天下午我看到墙上有道红光,所以我认为外面人在用红外线监视我家。”患者回忆当天在下午1-2点钟看见的,确认在墙上有红光,确信是人为的,不可能是夕阳西下的霞光。未引出其他幻觉和感知综合障碍。

患者对问话能切题回答,语音、语速和语量基本正常。患者诉民警怀疑自己偷东西,后来又发动周围邻居监视自己,甚至对面工地上的灯光也是在监视自己,出门路上的人打招呼是在传递信息,一天到晚都有人在监视自己。患者认为邻居和楼上及单位上的人对自己使坏,到处弄出声响,用红外线监视是为了伤害自己的身体,趁自己和家人疏忽时谋财害命,所以不敢出门。将漏水的痕迹拍下来是为了以后申辩之用。

主动和被动注意增强,周围有声响时马上引起患者的警觉而观察其来源,交谈中不时主动观察周围的病友举动,认为周围的病友有可能在监视自己。智力正常。

自知力缺乏,认为自己只是神经衰弱,不应该住院。情感不协调,谈及别人疑心自己、监视自己和用噪音吵自己时,均未见相应的气愤等情感表现。未见情感高涨、低落和焦虑等表现。活动少,多独处,较少参加各项活动,未见本能活动增强,未见怪异行为。意志活动缺乏,入院后多在病房中独坐;对将来生活和工作没有打算,虽有出院要求,但是医生不同意也就不再坚持了。

(二) 病例分析

1. 诊断和诊断依据

(1)患者男性,53岁,已婚,大专文化,退休干部。病前性格:内向,少语,讲原则,认真负责,谦让。喜欢下象棋。

(2)病史3年多,无明显诱因而缓慢起病,为持续性病程。

(3)精神症状

①真性非言语性幻听:患者白天和晚上总听见四面邻居家有电铃的声音,后来逐渐又听见邻居家和楼上搬东西、电钻和拉动铁器的声音等。

②原始性幻视:患者确信:“有一天下午我看到墙上有道红光,所以我认为外面人在用红外线监视我家。”患者回忆当天在下午1~2点钟看见的,确认在墙上有红光,确信是人为的,不可能是夕阳西下的霞光。患者在幻觉的影响下又产生被监视感。

③关系妄想和被监视感:患者认为出门路上的人打招呼是在传递信息,民警怀疑自己偷东西,后来又发动周围邻居监视自己,甚至对面工地上的灯光也是在监视自己,一天到晚患者认为都被监视着。

④被害妄想:患者认为邻居、楼上及单位的人对自己使坏,到处弄出声响,用红外线监视是为了伤害自己的身体,趁自己和家人疏忽时谋财害命,所以不敢出门。

⑤情感不协调:谈及别人疑心自己、监视自己和用噪音吵自己时,均未见相应的气愤等面部表现和内心体验。

⑥意志缺乏:入院后多在病房中独坐;对将来生活和工作没有打算,虽有出院要求,但是医生不同意也就不再坚持了。

(4)对疾病无自知力,认为自己只是神经衰弱,没有必要住院治疗。

(5)社会功能明显受损:交往能力下降,不能继续工作。

据以上临床特点,患者无明显诱因缓慢起病,持续性病程已经延续3年多,有明显的被跟踪感;有反复出现的真性幻听,并在幻听的基础上继发关系妄想和被害妄想;情感不协调;具有受幻觉和妄想支配的异常行为,如因为怕被害而不敢出门。

体格检查:

心肺未见异常,腹部检查见腹软,肝脾未触及,四肢未见异常。

神经系统检查:

未见异常。

实验室检查:

HBsAg(+),肝功能正常,其他临床生化检查项目指标皆正常。

精神检查:

意识清楚,时间、地点、人物定向均正确。主动及被动接触都不好。患者入院后经常独坐于床上,不与病友交谈。其他病友主动和患者接触,患者面部表情呆板,不做任何回应。尚能简单回答医护人员所提出的问题,对医疗护理合作。入院后,患者的生活如洗漱、进食需要护士督促。夜间睡眠正常。

患者语量很少,语音低,语速未见异常。回答问题非常简单,经常用“不知道”回答不同的问题。问:“你为什么住院?”答:“不知道,我父亲送我来的。”问:“你为什么不去上学?”答:“成绩不好。”问:“你为什么不努力学?”答:“不知道。”问:“你在住院前说过别人吐痰和你有关系吗?”答:“不是吐痰,是咳嗽。”问:“别人咳嗽和你有关系吗?”答:“不知道。”问:“你见到陌生人有时候害怕吗?”答:“唔!”问:“怕什么?”答:“不知道!”问:“你觉得有人害你吗?”答:“不知道。”问:“你能凭空听到有人和你说话吗?”答:“没有。”反复问患者为什么在入院前在房间内大小便,患者始终不回答。医生反复询问患者有什么说的吗?都回答:“没有。”患者否认自己有精神上的毛病,否认住院的必要性。

患者的一般常识、记忆、智能未见明显异常。例如,患者能说出中国四大城市的名字:北京、上海、重庆和天津。能够说出四种蔬菜、水果、交通工具的名称。能够解释夏天穿浅色衣服的道理。简单心算能力正常,能将100连续减7心算完成。将“画蛇添足”的寓意解释为:“多此一举。”患者对家庭情况、个人经历能正确回忆,近记忆力未见异常。

患者面部表情呆板。当其父亲告诉患者独自留在医院而自己将要回家时,患者毫无表情。患者对医院环境毫不在意。

患者在入院后,经常独坐于床上,不参加病房的任何集体活动。未见木僵、违拗、蜡样屈曲等症,也未见冲动伤人或自伤,无外跑、毁物等行为。在入院后,无任何主动要求,问其对将来有什么打算,则答:“没有。”诊断:

20.4 单纯型分裂症[F20.6 单纯型精神分裂症]

(二) 病例分析

1. 病历特点

(1)患者现年18岁,病期3年余,少年患病,因为病史报告人不能说清发病的时间,故为缓慢起病,病后不断加重,无缓解期。

(2)起病无明显诱因,起病就以孤独、生活懒散、学习成绩下降等表现为主。社会功能明显受损,表现为学习能力下降,与同学交往减少。

(3)入院后精神检查提示患者以下述症状为主:

思维贫乏:表现为对问题回答简单,无主动言语。如:患者回答问题非常简单,经常用“不知道”回答不同的问题。如问:“别人咳嗽和你有关系吗?”答:“不知道。”问:“你见到陌生人有时候害怕吗?”答:“唔!”问:“怕什么?”答:“不知道!”问:“你觉得有人害你吗?”答:“不知道。”问:“你能凭空听到有人和你说话吗?”答:“没有。”患者入院后经常独坐于床上,不与病友交谈;其他病友主动和患者接触,患者面部表情呆板,不做任何回应。

情感淡漠:患者面部表情呆板。当其父亲告诉患者独自留在医院而自己将要回家时,患者毫无表情。患者对医院环境毫不在意。

意志缺乏(abulia):患者对任何活动都缺乏明显的动机,没有确切的企图和要求,不关心事业,不要求学习和工作。缺乏主动性和积极性,行为被动,个人生活也变得极为懒散,如不主动洗漱、进餐等。另外患者在新学期开学后,向家长要求不再读书了,未征得家长同意,就不再去上学。入院后,经常独坐于床上,不参加任何病房的集体活动;无任何主动要求,问其对将来有什么打算,则答:“没有。”意志缺乏和意志减退有明显差别,二者虽然表面有相似之处,但是意志减退患者可意识到应当去做自己需要做的事,而无力完成或做起来很吃力,意志减退常和抑郁情绪相伴随。患者所具有的意志障碍和意志减退不同,不是意志活动减少而是“没有”,“没打算”,同时也不伴有情绪低落,患者的意志障碍是意志缺乏,而不是意志减退。

病史中患者曾有援引观念,但是持续时间很短,在精神检查时未能发现幻觉和妄想,也没有发现智能和记忆障碍。

2. 诊断分析

根据病史和精神检查所见,本患者应诊断为精神分裂症单纯型。诊断依据:①患者具备精神分裂症的基本症状:思维贫乏,明显情感淡漠和意志缺乏。②自知力障碍,患者认为没有病,否认上述症状是病态,而且社会功能明显受损,病人已经丧失了求学能力、人际交往和生活自理能力。③病期已3年余,于少年起病。

3. 鉴别诊断

患者所具有的阴性症状在脑器质性精神障碍和严重的躯体疾病所致精神障碍中也可以见到,因此,应该和上述两种疾病鉴别。根据本例病史资料和体格检查、实验室所见,未发现躯体疾病,诊断躯体疾病所致精神障碍没有依据。另外,因为患者记忆力良好,计算力正常,智力无障碍,不具备慢性脑器质性精神障碍的基本症状。可以排除脑器质性精神障碍。

4. 治疗计划

由于患者的临床表现以阴性症状为主,应以第二代抗精神病药治疗为首选,如利培酮治疗,也可试用舒必利治疗,佐以技能训练,可能会有所好转。

5. 预后估计

单纯型分裂症是精神分裂症中预后最差的一个临床类型,目前尚无公认的特效抗精神病药。再者,患者14岁起病,而且病前性格内向,不爱讲话,不擅长交际。这些都不利于患者病后社会功能的恢复,因此本患者的近期和远期预后估计都不乐观。

病例二

(一) 病历摘要

患者曹某某,男性,22岁,学生,大专二年级文化。病史由患者姐姐和父亲提供,可靠。

主诉:失眠,食欲下降,想死,心烦,逃学等25个月,近3个月来加重,常一个人在家喊叫,不出门。

现病史:1997年10月底,患者无故不去上学,家人发现其睡眠颠倒,夜间无法入睡,白天贪睡;生活懒散,常不洗漱,不按时吃饭。有时诉心烦,因此不知该怎么办才好。1997年11月14日在我院门诊,诊断为“抑郁状态”,服多塞平50~150mg/晚治疗,2个月后病情未见好转。经家属督促而复学1个月,但仍然失眠,上课时注意力不集中,不作笔记,阶段考试常不及格,无法完成学习任务,不向学校请假便跑回家,自行放弃期末考试。以后病情逐渐加重,白天贪睡,夜间多不眠,独自看电视,对电视中的内容能讲得清楚。不愿出门,几乎整日待在家里,偶尔去外面浴池洗澡。在家常坐立不安,对父母说想先工作赚钱,或一边工作一边上学,但理不出头绪和拿不出具体办法。曾经父母介绍到一个公司上班,工作2天后便被辞退,同事说患者常发呆,无法完成简单的工作任务。1998年春节期间,患者觉得

在入院后,对自己的处境毫不关心,在医生进入病房主动找其交谈时,不和医生打招呼。在医生拍了其肩膀后才抬头看一眼,又低下头。

意识清楚,定向力完整,问患者:“现在是什么时候?”患者抬头向窗外看后,回答:“上午。”问:“你知道这里是什么地方?”答:“安定医院。”问:“你知道我是干什么的吗?”答:“医生。”经过一阵沉默,问:“你有什么问题想问我吗?”答:“没有。”

不主动向医生提问,回答问题简单。如问病人:“你叫什么名字?”答:“曹某某。”问:“你今年多大了?”答:“22。”问:“你现在上学吗?”答:“不。”问:“那么你现在干什么?”答:“休学了。”在交谈时,患者的目光不和医生接触,或目视他处,或低头看自己的手。

经督促能自理个人卫生和生活。不与病友和工作人员主动交往。未引出错觉和幻觉。思维联想过程:语量少,缺乏自发和主动性言谈,语调偏低,交谈被动。关于上学之事,患者一会儿想去现在的学校学习,一会儿又想边工作边学习,为此犹豫不决,提不出具体打算。思维内容:未引出确切的被害、夸大和罪恶妄想。

交谈时表情平淡,缺乏针对内容的相应情感反应,自述1年多来情绪低落,对自己的低落情绪没有深刻的描述;有自我评价过低的想法,如说自己素质低,活着没意思,对此缺乏进一步的解释,且无相应面部忧愁表情。交谈中,自觉近1年来兴趣、精力不如以前,看电视遇到高兴的事能高兴起来,自杀一次是因感到自己素质低、没前途,不如死了好;有时无原因心烦,喊叫几声就好了。智能正常。认为自己没有病,家人糊涂把自己送住院。在病房里对环境缺乏关注,医生主动与之交谈时,一副爱理不理的样子。

终日无所事事,想工作又缺乏具体的打算,问将来打算干什么,患者答“没怎么想”。在病房内多独处或卧床,少动,不主动与人交往。

(二) 病例分析

1. 诊断和诊断依据

(1)患者男性,22岁,学生,大专二年级文化。病前性格:内向,不爱说话,自尊心强,与同学交往少。

(2)病史25个月,无明显诱因缓慢起病,为持续性病程。

(3)精神症状

①思维贫乏:患者回答提问时语量少,回答问题只有几个字,在精神检查时问患者:“现在是什么时候?”患者抬头向窗外看后,回答:“上午。”问:“你知道这里是什么地方?”答:“安定医院。”问:“你知道我是干什么的吗?”答:“医生。”经过一阵沉

默,问:“你有什么问题想问我吗?”答:“没有。”缺乏自发和主动性言谈,语调偏低,交谈被动,回答切题但不深入,言谈内容肤浅无物。

②接触被动:在医生进入病房时,主动找病人交谈,病人表现为并不和医生打招呼。在医生拍了他的肩膀后才抬头看一眼,又低下头。

③情感淡漠,不协调:交谈时表情平淡,缺乏针对内容的相应情感反应,自述1年多来情绪低落,对自己的低落情绪没有深刻的描述;有自责和消极观念,如说自己素质低,活着没意思,对此缺乏进一步的解释,且无相应面部表情,几经询问亦无痛苦的体验。

④意志活动缺乏:近2年多不上学,终日无所事事,想工作又缺乏具体打算,问将来打算干什么,患者答“没怎么想”。在病房内多独处或卧床,少动,接触被动。吃饭和洗漱需督促。

(4)对自己的病无自知力:否认自己有病,认为家人糊涂把自己送住院。社会功能明显受损,不能继续学习。

根据以上临床特点,患者无明显诱因缓慢起病,持续性病程25个月。主要症状有思维贫乏,主导情感是淡漠而不是低落,意志活动缺乏,对将来缺乏打算,对病无自知力,社会功能明显受损。患者以缓慢发展的阴性症状为主要特征,无明显的阳性症状。诊断:

20.4 单纯型分裂症[F20.6 单纯型精神分裂症]

2. 鉴别诊断

(1)抑郁症:诊断抑郁症必须具备抑郁发作的特征。患者虽有心境低落的主诉,伴有心烦,曾有过一次自杀行为,但是患者两年多来并不是以心境低落为主,而是心情一直稳定,偶尔低落;入院前心情平静,入院后患者称心烦、不高兴。精神检查发现患者对心境低落的体验不深刻。由此可以认为,患者只有一过性抑郁情绪,但在整个病程中不占主导地位。而患者的社会退缩、意志活动缺乏更为突出,并有情感淡漠及思维贫乏。因此可以排除抑郁症的诊断。

(2)轻性抑郁症:本患者虽然有一过性的抑郁情绪,但是社会功能良好或只有轻度受损。但轻性抑郁症患者明显社会功能受损,以情感淡漠为主,故可以排除轻性抑郁症的诊断。

(3)关于本例的精神分裂症分型问题,有些专业工作者认为在病史中有抑郁情绪,并有自杀行为,不宜诊断为单纯型分裂症。但本症的分型有时有变化,应长期观察来判定。

3. 治疗方案

本例患者的症状以阴性症状为主,因此以舒必利或非典型抗精神病药物为首选。患者入院后经舒必利平均 700 mg/d 治疗 86 天,思维贫乏、情感淡漠和意志活动缺乏有所缓解;但自知力未恢复,虽然经治疗后思维表达能力有改善,但是仍无心境低落的体验,也无痛苦表情,认为自己没有病。自诉出院后不愿坚持服药,药物对自己没作用。社会功能无改善,不愿继续学习和参加工作。建议进行心理社会干预,如社会独立生活技能训练和家庭干预等,有可能继续改善精神症状,提高其社会功能。

4. 预后估计

有利因素为文化程度较高,家族史阴性;不利因素有缓慢起病,性格内向,以阴性症状为主。因此经抗精神病药物治疗,其精神症状可部分消失,社会功能会有所改善。

病例三

(一) 病历摘要

患者夏某某,男性,24 岁,高中文化,工人,未婚。病史由患者父母提供,可靠。

主诉:3 年来工作成绩下降,生活懒散,态度冷淡,寡言独处;加重半年,少语,多卧床,拒出门。

现病史:患者于 4 年前高中毕业后参加工作。学习努力,能完成任务,与其他同志关系融洽,也比较关心别人。3 年前,患者无明显诱因逐渐开始出现失眠,夜间入睡困难,白天常诉头痛,无恶心呕吐和昏迷抽搐。患者请假外出看病,经多家医院诊治未见异常。之后对工作拖拉,工作效率逐渐降低,常出差错,经领导多次提醒,仍无改进。同时患者表现为沉默、孤独和不再愿与同事接触,有时无故不上班,家人劝其看病也置之不理。病中无悲观厌世和自责自罪等,不伴兴奋话多、乱花钱和爱管闲事等。

1 年前开始经常发呆,更少主动讲话,常无故发笑,生活更加懒散,不洗脸刷牙,长久不洗澡理发。对家人漠不关心,其母亲曾摔伤在地,也无动于衷。已不能胜任正常工作,被单位辞退。近半年来,常独自发呆,不主动与家人说话或答话,家里来了亲戚亦视而不见,表情漠然。经常独自躺在床上,不再出门与朋友交往,日常生活不能自理,吃饭需督促,食欲下降,每天经督促能吃 6 两左右饭。病后体重下降 4 千克,大便秘结,每周解 2 次,小便正常。为进一步诊治,由家人送患者入院。

既往史:病前体健。无肝炎、结核等传染病史,否认其他重大躯体疾病和手术外伤史,无药物过敏史。

个人史:同胞3人,排行第2。母孕期体健,足月顺产,自幼发育正常。7岁入学,学习成绩好,顺利读至高中后参加工作。有1个姐姐和1个弟弟,与姐弟及父母感情深。无烟酒嗜好和毒物接触史。无恋爱史。病前性格:内向,少语,自幼胆小好哭,怕见生人,一向较孤僻,少与朋友交往。无特殊爱好。

家族史:否认父母两系三代中有精神病病史。无近亲婚配和其他遗传性疾病。

体格检查:

体温:36.1℃,脉搏:70次/分,呼吸:21次/分,血压:106/61 mmHg。发育正常,营养稍差,全身皮肤黏膜弹性稍差,无皮疹、黄染和出血,浅表淋巴结未触及。头颅五官未见异常。颈部对称,气管居中,甲状腺无肿大。胸部无畸形,双肺未闻及干、湿啰音;心界不大,心率70次/分,各瓣膜区未闻及病理性杂音。腹部平坦,全腹软,肝、脾未及。会阴部和脊柱四肢未见异常。

神经系统检查:

头颅大小和形状正常,脊柱无畸形和叩压痛。颅神经检查未见异常,全身深、浅感觉和皮层感觉未见异常。肌力和肌张力正常,深反射和浅反射正常;未见病理反射,踝阵挛和髌阵挛(-)。脑膜刺激征阴性。

实验室检查:

未见异常。

精神检查:

在父母陪同下步入病房,年貌相当,衣着欠整。定向力完整,对时间、地点、人物及自我定向正常。知道入院时间是上午,现在身处精神病医院,与之谈话的是医院医护人员,可正确回答自己的姓名、性别、年龄和自我简历。被动接触尚可。日常生活不能自理,吃饭、洗漱和起床需督促。患者经常卧床或呆坐,生活懒散,对周围事物不关心,行为孤独,不参加病房的文体等各项活动。住院数天后尚不知道主管医生是谁和同室病友的姓名。对治疗和检查从未提出任何要求。未引出幻觉和妄想。对医生的询问不作回答,或简单说“很好”,“没什么”。思想内容贫乏,表情呆滞,不暴露内心体验。主动和被动注意差,周围病友的活动不能唤起其注意。一般知识尚好,但对近几年国内外大事知道很少,远近记忆尚好。对病无自知力,认为自己住在哪里都一样。情感淡漠,父母来看患者和送水果等,其表情呆板,谈话时语调平淡,对周围环境变化无任何情感反应。意志行为显著减退,对将来学习、生活和工作等漠然置之。

(二) 病例分析

1. 诊断和诊断依据

(1)患者,男性,24岁,高中文化,工人,未婚。病前性格:内向,少语,自幼胆小好哭,怕见生人,一向较孤僻,少与朋友交往。无特殊爱好。

(2)病史3年,无明显诱因缓慢起病,为持续性病程。

(3)精神症状

①思维贫乏:患者回答提问时语量少,对医生的询问不作回答,或简单说“很好”,“没什么”。思想内容贫乏,不暴露内心体验。

②情感淡漠:父母来看患者和送水果等,其表情呆板,谈话时语调平淡,对周围环境变化无任何情感反应。

③意志缺乏:患者经常卧床或呆坐,生活懒散,对周围事物不关心,行为孤独,不参加病房的文体等各项活动。住院数天尚不知道主管医生是谁和同室病友的姓名。对治疗和检查从未提出任何要求。对将来学习、生活和工作等淡漠置之。

④对疾病无自知力。否认自己有病,但不要求出院,认为自己住在哪里都一样。社会功能明显受损,不能继续学习和工作。

据以上临床特点,患者无明显诱因缓慢起病,持续性病程3年。主要症状有思维贫乏,情感淡漠,意志活动明显缺乏,对将来缺乏打算,对病无自知力,社会功能明显受损。患者以逐渐加重的阴性症状为主要临床特征,所以诊断精神分裂症成立。诊断:

20.4 单纯型分裂症[F20.6 单纯型精神分裂症]

2. 鉴别诊断

抑郁症:患者有少语、少动等表现,这些症状也可见于抑郁症。但患者持续性病程3年多,精神检查中发现患者无抑郁体验,而其少语、少动等表现继发于情感淡漠和意志减退,因此不支持抑郁症的诊断。

3. 治疗方案

本例患者的症状以阴性症状为主,因此以舒必利或非典型抗精神病药物为首选。患者入院后经利培酮平均3 mg/d治疗85天,思维贫乏、情感平淡和意志活动缺乏有轻度缓解;自知力未恢复,仍认为自己没有病。社会功能无改善,仍不愿继续学习和参加工作。

4. 预后估计

有利因素为文化程度较高,家族史阴性;不利因素有缓慢起病,性格内向,以阴

性症状为主。因此经抗精神病药物治疗,其精神症状可部分缓解,但社会功能将改善不明显。由于患者以逐渐加重的阴性症状为主,所以在药物治疗的同时,应主要进行社会独立生活技能训练和家庭干预等心理社会干预措施,有利于降低其病情恶化的危险性和减缓社会功能的进一步衰退。

四、紧张型分裂症

病例一

(一) 病历摘要

患者刘某某,女性,23岁,初中文化,已婚。病史由患者丈夫和父母提供,可靠。

主诉:有时不语、肢体发僵、语乱反复发作5个月;加重半月,两眼瞪视,僵卧于床,大小便不能自理。

现病史:2000年4月,患者父母向患者借钱而其丈夫不情愿,夫妻之间为此产生矛盾。丈夫曾赌气说要离婚,经丈夫耐心解释,矛盾有所缓解。随后患者出现胸闷、心悸,体温波动在 $37\sim 37.5^{\circ}\text{C}$,到当地医院诊断为“心肌炎”,静脉输青霉素治疗。精神状况如常人。在出院后2周左右,出现失眠,经常早醒,在此期间未再提起借钱之事。在某日早晨3点钟左右,患者为自己7个月的孩子哺乳,当时孩子哭闹,但是患者双眼上视,表情呆愣,呼吸不规律,约半小时后逐渐好转。发病后2个月患者在家话少,逐渐不理家人,反应极为迟钝,双足跟误踩在煤火上烫着了也不知自行移开。有时突然平卧床上,不语,目光呆愣,全身僵直,大小便不能自理,日常生活需家人协助料理。时而语乱,说父亲是小虫,地上有老鼠爬,自称要穿上红衣服出去,有人在外面等自己,夜间叫小妹妹和已经去世的男友名字,并自语:“别再吓我,别刺激我,别抠我的眼睛。”自称“全身上都是财神”。清醒时日常生活可自理,并随同家人上山拜神,能哺育孩子和与家人正常交流。上述精神异常常间隔十数日突然发作数日,以上症状消失后又返回呆愣不语、卧床等表现。曾在某精神病院诊断为“散发性脑炎伴发精神障碍”。治疗情况不详,病情未见好转。近半月来僵卧于床,不语,两眼睁开,饮食减少,需家人喂食,夜眠尚可,日常生活需家人协助料理。病中未见自语自笑和冲动伤人等。因病情加重由家人送住院。

既往史:17岁时因与男友吵嘴而赌气服安眠药20片,具体情况不详,于当地

医院抢救后已愈。无外伤、昏迷和癫痫发作史,无药物过敏和手术史。

个人史:同胞3人,排行第3。母孕期正常,足月顺产,自幼生长发育正常。7岁上学,成绩一般,初中毕业后在家乡镇服装厂缝制衣服,工作认真努力。3年前与现夫恋爱结婚,生育1子,目前处于哺乳期,夫妻关系一般。无烟酒嗜好和毒物接触史。月经史:12岁开始来月经,周期为28~30天,末次月经时间是人院前1周(2000年9月18日)。病前性格:外向,开朗,自幼受父母溺爱,依赖性强,以自我为中心,必须满足自身要求。平日喜欢游泳,打牌。

家族史:否认两系三代有精神异常和癫痫患者,无近亲婚配史。

体格检查:

体温:36.1℃,脉搏:70次/分,呼吸:21次/分,血压:106/61 mmHg。发育正常,营养稍差,全身皮肤黏膜弹性差,无皮疹、黄染和出血,浅表淋巴结未触及。头颅五官未见异常。颈部对称,气管居中,甲状腺无肿大。胸部无畸形,双侧乳房未触及肿块,双肺未闻及干、湿性啰音;心界不大,心率70次/分,各瓣膜区未闻及病理性杂音。腹部平坦,全腹软,肝脾未及。

神经系统检查:

头颅大小和形状正常,脊柱无畸形和叩压痛。颅神经检查未见异常,全身深、浅感觉和皮层感觉未见异常。全身肌力和肌张力增高,深反射和浅反射正常减弱;未见病理反射,踝阵挛和髌阵挛(-)。脑膜刺激征阴性。

实验室检查:

心电图检查未见异常,其他实验室检查,如脑CT、MRI,脑脊液检查均未见异常。

对不合作患者的精神检查:

(1)一般情况:患者沉默不语,交谈时眼望说话的人,但并不回答。看见有人走近或周围有较大喧闹时,患者自动偏头去看。医生让其张口时,患者则咬紧牙关,让其闭口时,仍紧咬牙关不动。对任何要求均不合作,违拗,呼其名字,患者能将头朝向呼唤者,患者在向周围看时,可准确而快速地朝向事件发生的方向,听到有人走近说话时,可睁开眼看着说话人。听到某处突然有响动,则马上转头朝向声音发生处。因此可见其意识是清楚的。

(2)言语与姿态:入院时患者在工作人员及家属搀扶下进入病房,终日平卧在床,有时可自行翻身,调整姿态。若有外力碰触时,全身发硬;肌张力阵发性增高,检查者将患者下肢抬高后再松开手,则双下肢保持原抬高位置不动,在10~20秒内方自行缓慢放下,但未见四肢折刀样肌张力改变。患者不能自行料理生活,完全

由家属照顾,进食时需将饭放在嘴边才张开,大小便不能自理,任其自行排出于床上。偶尔在家属搀扶下在床上用便盆排尿。可自行入睡,夜眠尚可。患者始终沉默不语,无论家人如何哀求,工作人员如何劝说,均不说话。偶尔无目的发出“唉唉”声。

(3)表情及情感反应:患者表情平淡,几乎无任何变化,偶尔出现短暂的皱眉。谈及孩子时,患者面无表情地听着,看见同学哭也无动于衷。

(4)动作和行为:患者终日卧床,双眼活动能看周围发生的事情。口中常含唾液不咽,唇上有唾液泡沫,有时可自行咽下。有外人碰触身体时身体便发僵,在被动活动患者肢体时,有与外加力的相反方向的抵抗。有时在工作人员协助下可坐起排尿,对输液和抽血检查合作。突然用手碰患者眼皮,可有眨眼等防御反应。有时有持续1~2秒的四肢不自主抖动,一天约1~2次,未见冲动伤人行为。

(二) 病例分析

1. 诊断和诊断依据

(1)患者刘某某,女性,23岁,初中文化,已婚。病前性格:外向,开朗,自幼受父母溺爱,依赖性强,以自我为中心,必须满足自身要求。平日喜欢游泳,打牌。

(2)病史5个月,与丈夫吵架为诱因,亚急性起病,为持续性病程,其间有不完全性缓解。

(3)精神症状

1)紧张性木僵:患者始终沉默不语,无论家人如何哀求,工作人员如何劝说,均不说话,偶尔无目的发出“唉唉”声,口中含唾液不下咽。检查者将患者下肢抬高后再松开手,则双下肢保持原抬高位置不动,在10~20秒内方自行缓慢放下,这是蜡样屈曲的表现。

2)违拗症:①主动性违拗:本病例在有别人碰触身体时身体便发僵,在被动活动患者肢体时,即有与外力方向相反的抵抗动作。肌张力增高。②被动性违拗:医生让其张口时,患者则咬紧牙关,让其闭口时,仍紧咬牙关不动。对任何要求均不服从。但呼其名字时,患者能将头朝向呼唤者,可见其意识是清楚的。

3)紧张性兴奋:患者在病史中有由木僵突然转为不协调性兴奋的表现,如起病2个月后突然从木僵状态兴奋起来,语乱,说父亲是小虫,地上有老鼠爬,自称要穿上红衣服出去,有人在外面等自己,夜间叫小妹妹和已经去世的男友名字,并反复自语“别再吓我,别刺激我,别抠我的眼睛。”自称“身上都是财神”等。

4)情感淡漠:患者表情平淡,几乎无任何变化,偶尔出现短暂的皱眉,周围人在

预措施,以预防疾病复发。

病例二

(一) 病历摘要

患者马某某,女性,35岁,初中文化,已婚,农民。病史由患者丈夫和母亲提供,可靠。

主诉:近6个月来少语少动,呆愣,疑心有人害父亲,伴阵阵语乱和无目的动作;于半月前加重,流口水,舔舌头,失眠。

现病史:在入院前6个月,患者无明显诱因逐渐出现少语少动,常一个人发呆,坐在家中不与家人主动说话,其丈夫和父母对患者说话时亦不理睬,睁大眼睛向前看,而前面并无可看之物。日常生活如吃饭和洗脸刷牙需经督促才能完成,动作明显迟缓。疑心别人谈话是针对她的,认为丈夫不回家是有外遇。并说有人要害其父亲,患者自诉看见有不认识的人在绑架父亲。整日呆坐,有时说自己压力大和浑身没劲,自诉心脏不好而不能照顾孩子等。患者怕见生人和不出门,不能上班及做家务。无发热、头痛、抽搐昏迷和大小便失禁等。起病约十几天后,患者突然出现兴奋话多,说自己什么都能干,做饭也不用别人帮忙,要求把周围闲置的二块地皮圈下来办养殖场和做买卖。但做事虎头蛇尾,刚开头便不干了。约1周后又转为少语、少动和呆愣。无自责、哭泣和悲观厌世,未见夸大、爱管闲事、易激惹和有冲动行为等。2月前因病情无明显缓解,家人送患者到某精神卫生防治所,诊断为“忧郁症”,用舒必利0.6 g/d治疗。住院1月后基本恢复正常出院,在家中说话和举止正常,能做家务和参加本职工作,坚持服用舒必利0.4 g/d。

半月前无明显诱因,患者又开始出现少语少动,流口水,舔舌头,有时自语,但听不清楚,对家人说自己没有病而拒服药。每日在家中不再干家务,常在院里走几步后就回屋躺在床上,吃饭、洗脸和刷牙等需督促,大、小便能自理。有时突然兴奋、话多,周围人不知所云。持续1~2天后,患者又表现为少语少动,有时去拿物品时转一圈后就回来,问家人“我该拿什么东西呢?”行为古怪,如走路时常停下来看周围人,说在某地方都见过这些人。睡眠差,主要为人睡困难,半夜醒来时常独自呆坐2~3个小时。今日由患者家人送至我院,门诊以“缄默状态”收住我院。

既往史:1976年确诊患有“风湿性心脏病”,具体治疗不详,平日能操持家务,能骑车到地里干活,无肝炎和伤寒等传染病史,无手术外伤和药物过敏史。

个人史:患者系家中独生女,母孕期正常,足月顺产,幼年生长发育正常。7岁

上学,成绩尚可,15年前因患“风心病”,学习成绩下降,初中毕业后居家无业,随母从事农村医疗服务。25岁时经人介绍与现夫结婚,26岁生育一子,夫妻感情一般。无烟酒嗜好和毒物接触史。月经史:13岁开始来月经,周期为28~30天,末次月经时间是入院前10天。无痛经和白带增多等。病前性格:内向、少语、脾气怪、不合群、小心眼、任性、不关心人、爱写日记。无特殊爱好。

家族史:其父亲年轻时曾患癫痫,以后治愈。父母两系三代中无精神疾病及其他遗传性疾病患者。

体格检查:

体温:36.5℃,脉搏:78次/分,呼吸:20次/分,血压:116/71 mmHg。发育正常,营养中等,全身皮肤黏膜弹性差,无皮疹、黄染和出血,浅表淋巴结未触及。头颅五官未见异常。颈部对称,气管居中,甲状腺无肿大。胸部无畸形,双侧乳房未触及肿块,双肺未闻及干、湿性啰音;心界不大,心率70次/分,各瓣膜区未闻及病理性杂音。腹部平坦,全腹软,肝脾未及。

神经系统检查:

头颅大小和形状正常,脊柱无畸形和叩压痛。颅神经检查未见异常,全身深、浅感觉和皮层感觉未见异常。全身肌力和肌张力增高,深反射和浅反射正常;巴宾斯基征(-)、踝阵挛和髌阵挛(-)。脑膜刺激征阴性。

实验室检查:

未见异常。

对不合作患者的精神检查:

(1)一般表现:仪表尚整,年貌相当,日常生活需协助料理,入院当日不主动进食,后在督促下能自饮牛奶、进食鸡蛋羹及面条。入院时虽卧于床不言不语,面部表情亦缺乏变化,但对体格检查能合作,能配合医师翻身作体检,输液时恳求护士别扎针了。夜间睡眠好。能在协助下起床和洗漱,在搀扶下自行入厕大小便,所以考虑患者意识清楚。

(2)姿态和言语:经协助步入病房,侧卧于床,姿势自然,能自行翻身。患者入院当日上午不言不语,无自言自语。但下午在医生询问下有言语反应,能回答医生提出的问题,言语反应略显迟钝,有时对问话不答,沉默不语,言语交谈欠深入。有时在询问下自称:“心情好多了,以前心情不好是因为在家中父母嫌自己不干活,老发脾气,所以才不说话。”患者认为在家里是有人给自己点了穴,所以说不出话、全身动不了,自诉在家觉得有人跟踪自己,心里很害怕。

(3)表情和情感反应:入院后面部表情缺乏变化,对言语刺激多无反应,或只是

冲面前的人眨眨眼,打针和输液时有痛苦表情。交谈中言语内容、面部表情及内心体验欠一致,例如当说到自己心情不好时曾想到过死,想用药麻醉自己后拿刀把自己杀死时,面带微笑。注意力欠集中,在交谈时易被周围人的活动所吸引,目光随之移动,不主动与医护人员及病友接近。

(4)动作和行为:入院后多卧于床,偶在病房内走动,有时一个人起床到窗前向窗外看。不主动进食,督促下可自行饮牛奶或食鸡蛋羹、面条。吞咽食物时,略显缓慢,拒绝别人喂食,早晨起床时需在他人协助下料理洗漱,在别人搀扶下可扶着墙走进厕所大小便。动作缓慢,全身有轻度对称性肌张力增高,无折刀样肌张力抵抗,未见肌震颤,无蜡样屈曲和空气枕头等。未见毁物和冲动行为。

(二) 病例分析

1. 诊断和诊断依据

(1)患者女性,35岁,初中文化,已婚,农民。病前性格:内向、少语、脾气怪、不合群、小心眼、任性、不关心人、爱写日记。无特殊爱好。

(2)病期6个月,无明显诱发因素而亚急性起病,为持续性病程,其间经外院住院治疗病情有不完全性缓解。

(3)精神症状

①紧张性木僵:为亚木僵状态,病史中和入院时的精神检查中,患者的主要表现是少语少动,家人和工作人员主动与其交谈时,患者多不回答;但护士来输液时,患者则恳求护士别扎针了。该患者在体检中全身肌张力增高,动作缓慢,未引出严重木僵常出现的蜡样屈曲和空气枕头等,以上表现不是典型的木僵状态,可称为亚木僵状态。

②紧张性兴奋:患者在病史中有由亚木僵状态转为突然兴奋的表现,如患者患病十几天后突然出现兴奋话多,说自己什么都能干,做饭也不用别人帮忙,要求把周围闲置的二块地皮圈下来办养殖和做买卖。但做事虎头蛇尾,刚开头便不干了。1~2天以后又逐渐转入少语少动和多卧床及两眼瞪视前方等。

③情感不协调:面部表情及内心体验欠一致,当说到自己心情不好时曾想到过死,想用药麻醉自己后拿刀把自己杀死时,面带微笑。

(4)对疾病无自知力,社会功能明显受损,不能与人交往、干家务和继续工作等。

根据以上临床特点,患者无明显诱因而亚急性起病,为持续性病程,病期已6个月,其间有不完全性缓解。病史和精神检查中主要症状有紧张性木僵、紧张性兴

奋、情感不协调、对病无自知力和社会功能明显受损等。所以诊断为：

20.3 紧张型分裂症[F20.2 紧张型精神分裂症]

2. 鉴别诊断

(1)心境障碍：患者病史中以少语少动、怕见人、少食、少眠为主，全身疲乏无力，不愿做事，间以兴奋、话多、言语夸大，想围地搞养殖，做生意，也可见于心境障碍。但患者在整个病程中情感以不协调和平淡为主，在紧张性木僵期间面部缺乏表情，无内心低落心境的表露，对环境中丈夫和父母等的劝解、鼓励和对儿子的呼唤等无动于衷。而在短暂的紧张性兴奋期间，其行为带有无目的性和冲动性，无喜悦的内心体验和高兴的外部表情。所以可以排除心境障碍诊断。

(2)躯体疾病所致精神障碍：患者患“风心病”的病史有24年，未发现心力衰竭临床征象。从整个病史中可以知道，患者心功能保持良好，既无发热、咳嗽、心悸、气喘和意识障碍等表现，也未见随“风心病”的病情波动而出现的阵发性精神障碍，患者6个月精神异常病程为持续性，皆不支持躯体疾病所致精神障碍。

3. 治疗方案

本例患者症状以紧张综合征表现为主，可以在对患者进行全身支持治疗的同时，用电抽搐缓解其紧张性木僵和舒必利抗精神病药物治疗。本例患者入院后经电抽搐治疗6次，第3天紧张性木僵状态消失，并对丈夫送她住院表示气愤，骂丈夫不该送其住院。合并舒必利平均800 mg/d治疗45天，所有精神症状消失；自知力部分恢复，社会功能恢复正常，愿回家继续工作。

4. 预后估计

有利因素为亚急性起病、家族史阴性、家庭结构完整和以紧张性综合征为主要临床表现；不利因素有性格内向和文化程度较低。因此经抗精神病药物治疗，其精神症状可完全消失，社会功能可恢复正常。但由于精神分裂症患者的复发率高，因此在药物治疗的同时，应主要进行社会独立生活技能训练和家庭干预等心理社会干预措施，以预防其病情复发的危险性和提高其社会功能，有利于患者回归社会。

病例三

(一) 病历摘要

患者程某，男，37岁，工人，已婚，汉族，初中文化。1960年1月26日首次住我院。由单位、家属提供病史，并参阅外院住院病历摘要。

主诉：精神失常3年余，少语少动或不语不动时轻时重；4天来病情加重。

现病史:患者于 1956 年 6 月(距入院前 3 年余)开始多疑,总觉得同事对自己有意见,因怕被单位辞退而埋头苦干。到 1956 年 10 月,言语、动作逐渐减少,经常独自发呆。从 1957 年 2 月 21 日开始,病情急性加重,躺卧于床,不洗漱,经常不说话,有时偶尔说 1~2 句话,大小便由家人扶着上厕所,进食须喂,如此半年之久,病情毫无进步,而于 1957 年 8 月 22 日住入某精神专科医院。入院后表现为:目光呆滞,常坐或卧于病床上,眼睛半闭着,长时间不改变姿势。表情呆板,对外界刺激无反应,与之谈话不回答。偶尔说:“我要小便”,“我要喝水”。饮食需督促,有时在督促下慢慢自己进食,有时则拒食,常需给予鼻饲以维持其营养。入院后经过系统的利血平治疗 132 天,最高日量 7 mg,利血平总量 605 mg,患者诉说自己感觉像从睡梦中醒来一样,只记得从 1956 年夏天开始头昏,“视力逐渐模糊”,以后的事就什么都记不起来了,患者对住院经过不能回忆。于 1958 年 1 月 7 日,以显著好转之疗效由该院出院。出院诊断:精神分裂症紧张型。患者出院后定期在该院门诊复查,曾服用小量利血平,病情尚稳定,但一直残留头痛、头昏、头晕、脑子发木,自诉有精力不足等脑衰弱综合征的表现。

1960 年 1 月 23 日(住我院前 3 天),精神症状急性加重。领导本来已经同意其当天下班后回原籍过春节,患者却把买好的火车票撕毁,过了下班时间还继续在车间干活。被同事强迫送回家中后,仍是一连几天到了下班时间不下班。1960 年 1 月 25 日深夜(1 月 26 日凌晨 2 点)车间还没有开门,患者就在车间门口等着,不到上班时间,就进车间开始干活,经劝说无效,仍在车间干活。被疑为精神病态表现,而于 1960 年 1 月 26 日经门诊首次住我院。

既往史:否认重大躯体疾患及药物过敏史。

个人史:患者为中药制药厂工人。病前性格:好静,知心朋友不多,胆小怕事,工作肯干。吸烟,量中等,不常饮酒。已婚,有一子,体健。

家族史:两系三代无类似精神失常患者。

体格检查:

未见异常。

神经系统检查:

未见异常。

实验室检查:

未见异常。

精神检查:

入院当天,患者意识清楚,定向力完整,自行步入病房。主动及被动接触均不

19日起,开始主动与人交谈,能正确说出自己的姓名、年龄等,但对得病经过完全不能回忆,甚至对其曾住过某精神专科医院也加以否认。氯丙嗪治疗共65天,500~800 mg/d约1月之久,患者虽然摆脱了木僵状态,能够与别人交谈,主动进食,生活能自理,但对自己为何被送来住院以及当时的病态表现等均以“不知道”、“不记得了”作为回答,自知力和批判力不佳。还有时表现呆呆愣愣,情感欠活跃,出院要求不迫切。经试出院观察于1962年10月4日以精神分裂症紧张型,经治疗显著好转之疗效出院。

出院后随访:患者由我院首次出院后,定期在我院门诊复查,不规律地服用小量氯丙嗪。多次诉说头昏、头晕、头胀,夜眠尚可。1963年8月下旬起,精神症状加重,说话不中肯,在工作时间来回踱达,唱小调,不能正常上班,患者否认有病,拒绝来院复查,夜眠欠佳,被单位送回原籍。在原籍,患者表现孤僻少语,疑心大,经常与邻居发生争吵,去他们家一个陌生人,患者就说对方是特务。自1964年年初开始,经常给国家领导人写信,称厂领导故意和其作对,明知其身体不好,还故意安排其从事重体力劳动。在群众集会场合,别人碰他一下,就质问对方为什么碰他。有时自语自笑,夜眠不佳。患者否认有病,拒绝服药而于1964年3月11日第2次住我院。入院及出院诊断均为精神分裂症。经氯丙嗪治疗103天,最高日量600 mg×33天,患者自知力部分恢复,批判欠深刻,能参加集体活动和轻体力劳动(工疗),乃以显著好转之疗效,于1964年6月29日由我院第2次出院。第2次由我院出院后,患者继续在我院定期门诊复查,但服药不规律。末次门诊复查时间为1966年5月25日,据患者单位及其儿子介绍,自从由我院第2次出院后,近两年来,患者的精神一直不正常,乱说乱闹,到处乱跑,打人骂人,夜眠不好。患者仍否认有病,拒绝服药及再次住院治疗。

(二) 病例分析

这是1例经2个精神专科医院门诊和住院长期、连续观察的精神分裂症紧张型患者,患者在长达10年的持续性病程中,有两次精神症状急性加重。第1次是1957年2月21日,木僵状态历时约1年,经系统的利血平治疗,获得显著好转之疗效。第2次是从1960年1月下旬开始,木僵状态经多种药物及物理治疗(例如电痉挛治疗),历时2年7个月,才获得显著好转之疗效。由于患者在出院后不久即服药不规律,自行减药、停药,以致于在1964年6月第2次住我院,以显著好转之疗效出院。经过长达10年的连续临床观察,患者的病情始终未达痊愈水平,这也验证了精神分裂症“病程多迁延”的临床特点。尽管精神分裂症紧张型远期疗效

“腋臭”而做手术,无外伤史。

个人史:出生于山东,独生子。母孕期正常,足月顺产,幼时生长发育正常,7岁开始上学,学习成绩好,顺利读至高中,读高中时因经常用电脑上网、玩游戏,而学习成绩下降,未考上大学。今年到成人业余大学学习,病前无重大的精神创伤史。在家和母亲的感情深,因父亲管教严而少与父亲接触,少量吸烟,每日1包以内,不饮酒,无毒物接触史,亦无婚姻恋爱史。病前性格:内向、少语,不喜结交朋友,好强,小心眼。

家族史:父母两系三代无阳性精神病家族史,无其他遗传性疾病和近亲婚配史,余无特殊。

体格检查:

体温:36.7℃,脉搏:74次/分,呼吸:18次/分,血压:120/78 mmHg。发育正常,营养中等,全身皮肤黏膜无皮疹、黄染和出血,浅表淋巴结未触及。头颅五官未见异常。颈部对称,气管居中,甲状腺无肿大。胸部无畸形,双肺未闻及干、湿啰音;心界不大,心率74次/分,各瓣膜区未闻及病理性杂音。腹部平坦,全腹软,肝脾未及。会阴部和脊柱四肢未见异常。

神经系统检查:

头颅大小和形状正常,脊柱无畸形和叩压痛。颅神经检查未见异常,全身深、浅感觉和皮层感觉未见异常。肌力和肌张力正常,深反射和浅反射正常;巴宾斯基征(-)、踝阵挛和髌阵挛(-)。脑膜刺激征阴性。

实验室检查:

未见异常。

精神检查:

经医院接诊被强迫送住入院,衣履欠整齐,年貌相符。病人意识清晰,对时间、地点、人物定向力完整。欠合作,主被动接触差,不与周围人交往;常一个人躺在床上,日常生活需督促。自诉凭空能听到有一群男女跟自己说话,有的说自己对,有的说自己不对;但看不见人,自己有时受说话内容的指使而四处走动。未引出幻视、幻味、幻嗅和内脏性幻觉和感知综合障碍等。患者回答问题时语量少,语速正常,语音低。有时对问话回答似有道理,但不合情理,如问:“为什么将擦大便的卫生纸扔在宿舍里?”答:“这怎么说呢?就像随地吐痰一样,你能解释为什么要随地吐痰,就这个样!”无刻板言语及持续言语。患者不愿谈及自己的想法,常吞吞吐吐,对各种问题不愿回答,经反复追问能引出关系妄想,认为周围同学说话及做事都是针对自己的,电视节目也在演自己以前的一些事情。认为学校食堂的饭菜中

有毒,所以到附近的小饭店去吃饭,周围人都想害自己,所以不愿和他们接触,认为父母也对他不好,未引出被控制及洞悉感。对病无自知力,要求出院,认为自己没有病。情感活动:患者说话过程中谈到高兴及不高兴的事情时,都哈哈痴笑,在父母探望时不与父母接触,有时无故痴笑,情感反应与环境联系少,周围病友中发生的高兴及不高兴的事,不会引起患者共鸣。患者对将来没有计划和打算,不参加病房的各种活动,亦不与病友交往,生活懒散,吃饭及洗漱需督促。在病房中无冲动行为,亦无怪异行为。但多待在床上,有时看窗子外面。

(二) 病例分析

1. 诊断和诊断依据

(1)患者男性,19岁,高中文化,学生。病前性格:内向、少语,不喜结交朋友,好强,小心眼。

(2)病史6个月,无明显诱因缓慢起病,为持续性病程。

(3)精神症状

①幻听:可引出言语性、带评论性质的幻听,自诉听到有一群男女跟自己说话,有的说自己对,有的说自己不对,但看不见人。

②逻辑倒错性思维,问:“为什么将擦大便的卫生纸扔在宿舍里?”答:“这怎么说呢?就像随地吐痰一样,你能解释为什么要随地吐痰,就这个样。”患者“将擦大便的卫生纸扔在宿舍里”解释为“随地吐痰”,“随地吐痰”是一种不良习惯,患者用其来推理“将擦大便的卫生纸扔在宿舍里”,不符合逻辑。

③关系妄想,认为周围同学说话及做事针对自己,电视上也说自己以前的一些事情。

④被害妄想,认为学校的饭菜中有毒,所以到附近的小饭店去吃饭,周围人都想害自己,所以不愿和他们接触,父母也对他不好。可见妄想内容已经影响了患者的行为。

⑤怪异行为,患者买小学生书包来背,突然一个人出去无目的地旅游和在学校阵发性乱跑等。

⑥情感不协调和平淡,患者说话过程中谈到高兴及不高兴的事情时,都哈哈痴笑,在父母探望时不与父母接触,有时痴笑,情感反应与环境联系少,周围病友中发生的高兴及不高兴的事,不会引起患者共鸣。

⑦意志缺乏:患者对将来没有计划和打算,不参加病房的各种活动,安于住院现状。

病例二

(一) 病历摘要

患者周某某,男性,34岁,高中文化,工人,未婚。病史由患者父母提供,可靠。

主诉:乱跑,反复背诵毛主席诗词,耳边总听见有人议论自己,怀疑同事害自己;平,近1周加重,出现痴笑、呆愣,持菜刀欲自杀。

现病史:患者于1994年随父亲来北京读高中,因未从老家转团组织关系,被同学说成是混入团组织的。以后逐渐出现情绪不好,乱跑,唱歌,反复背诵毛主席诗词和语录,有时骂人和夜间失眠等。不能再坚持正常学习。曾在某院诊断为精神分裂症,给以电痉挛治疗6次,奋乃静治疗143天,34 mg/d,治愈出院。

患者出院后能坚持服药,病情稳定,可正常工作。此次入院前2个月与一位女青年谈恋爱,不久即分手。自行停药1个月后,其病情复发。出现兴奋、话多、坐立不安、乱跑,给父母起外号,骂父母,言语混乱,夜间睡眠差。曾外跑3日不回家,被公安局收留。认为自己在工作上的差错是同事造成的,耳边总听见有人议论自己,并骂自己没脸没皮,但又见不到人。脾气暴躁,常无故找人吵架。1周前忽然对家人说:“外面有人吵我睡觉,批评我。”为躲避那些人,患者每日4~5点钟便起床去公园散步。坚信有人在迫害并要进屋打自己,表现为紧张恐惧。一天患者称头痛,到厨房拿菜刀欲自杀,被家人发现而未遂。称:“与其让他们害死,还不如自杀呢。”有时患者痴笑、呆愣,有时跪地叩头后就躺在地上不起来。家人无法护理,门诊以“精神分裂症”收住院。病后患者饮食不规律,体重无明显下降,大小便正常。

既往史:病前体健,无肝炎、结核等传染病史,无手术外伤史和药物过敏史,预防接种史不详,系统回顾余无特殊。

个人史:同胞3人,排行老二。母孕期体健,足月顺产,自幼发育正常。7岁入学,学习成绩好,顺利读至高中。因父亲工作变动而转至北京读高中。与父母和哥哥及妹妹感情好。第一次患病缓解后曾工作1年半,工作能力及人际关系可。无烟酒嗜好和毒物接触史、病前性格:内向,好强,心胸不开朗,不爱交朋友。无特殊爱好。

家族史:其姑姑有精神失常史,具体不详。否认父母两系三代中其他成员有类似病史。无近亲婚配和其他遗传性疾病。

体格检查:

体温:36.9℃,脉搏:87次/分,呼吸:22次/分,血压:120/75 mmHg。发育正

(二) 案例分析

1. 诊断和诊断依据

(1)患者男性,34岁,高中文化,工人,未婚。病前性格:内向、好强,心胸不开朗,不爱交朋友。无特殊爱好。

(2)病史4年多,以转学为诱因而亚急性起病,为持续性病程。

(3)精神症状

①真性言语性幻听:为评论性幻听,自诉:“大约从上周起,总有人在我耳边说话,议论我做的事是对还是错。说这小子怎么这样办事……那个人还骂我,说我,要杀我,我想让他们那么来害我,还不自己死了呢……”问:“那些声音是谁发出的呢?”答:“有男有女,有老有少,但听不清到底是哪个人的。”

②逻辑倒错性思维:问:“为什么给父母取外号?”答:“取外号好,有外号能辟邪,辟邪能当官,父母有了外号便可当官辟邪。”从这句话可以看出,患者认为:给父母起外号能够辟邪,然后就能当官。这个推理过程明显是荒谬的。

③被害妄想:患者述:“总有人在我门外敲门,咳嗽,感觉有人要踹门进来,打死我,我就想与其让他们害死,还不如我自己死呢。所以就用刀割腕了。”从中可知患者被害妄想继发于幻听。

④情感不协调:患者表情呆板,与医生谈话时低头看地,无目光交流,谈及被害体验时,无情感变化,情感与内心体验及周围环境不协调。

⑤怪异行为:患者常一一个人在病房内发呆,在病房时而跪拜时而躺在地上不起来。

⑥意志缺乏:对将来无打算,得过且过,经常独处,对吃饭都不主动。

(4)无自知力:认为自己没有病,要求出院。但是并不坚持自己的要求。

(5)社会功能明显受损:生活懒散,吃饭及洗漱皆需督促。不能继续工作。

据以上临床特点,患者病史4年多,以转学为诱因而亚急性起病,为持续性病程。有幻听、继发性被害妄想,存在逻辑倒错性思维、怪异行为,情感不协调。无自知力及社会功能明显受损,诊断精神分裂症成立,因其症状变异性大和多样化,既有幻觉、妄想、其行动受妄想支配等阳性症状,又有离奇、荒谬的思维逻辑障碍和明显的意志障碍。诊断:

20.5 未定型分裂症[F20.3 未分化型精神分裂症]

2. 鉴别诊断

(1)情感障碍:患者病程中有自杀和冲动行为,可见于情感障碍。但患者自杀

的原因是“与其让他们害死,还不如我自己死呢。所以就用刀割腕了。”可见是继发于被害妄想而非自责或有情绪低落背景,且患者的持续性病程和精神症状以思维障碍为主,主导情感不协调及进行性的社会功能严重受损皆不支持情感障碍诊断,所以可以排除。

(2)青春型分裂症:应以思维紊乱为主,并且多变。本病例既有幻觉妄想,又有荒谬、离奇的行为,虽然不系统,但是较为稳定,不太符合青春型分裂症。

(3)偏执型分裂症:应有系统的妄想,但是本病例并不具备此特征,不符合偏执型分裂症。

3. 治疗方案

本例患者症状以阳性症状为主,伴有少量阴性症状,因此可用典型或非典型抗精神病药物。本例患者入院后经电痉挛治疗6次,奋乃静平均30 mg/d治疗70天,其精神症状基本消失。自知力部分恢复,认为自己有病,认为幻听和自杀的想法都不正常,但对其他症状认识不足。日常生活能自理,社会功能有所改善,出院后计划继续上班。建议进一步进行心理社会干预,如社会独立生活技能训练和家庭干预等,以利于预防患者疾病复发,提高其社会功能和促进患者回归社会。

4. 预后估计

有利因素为亚急性起病,病程较短,文化程度较高,阳性症状为主,有工作。不利因素有家族史阳性,性格内向,家庭结构不完整。因此经抗精神病药物治疗,其精神症状可部分消失,社会功能会有所改善。出院后如果进行社会独立生活技能训练和家庭干预等心理社会干预措施,可降低其复发的危险性和恢复其社会功能。

病例三

(一) 病历摘要

患者文某,男,31岁,离异,售货员,高中文化。于2000年1月25日第2次住我院。由患者父亲提供病史,并参阅首次住院病历。

主诉:脑中反复出现与性有关的想法16年;孤僻、懒散伴冲动伤人毁物5年;1周来有自杀行为。

现病史:患者于1984年(15岁)暑假中某一天,偷看女性洗澡被发现,后虽协商解决纠纷,并无更多的人知道此事,但患者从此紧张恐惧,怕见人,同时脑中开始反复出现淫秽、下流、令患者难以启齿的与性有关的想法,患者对此感到痛苦并设法摆脱,但都无济于事。之后又出现头昏、头痛伴失眠心烦,家人带其到多家综

合医院诊治均未发现明显异常。患者于1984年下半年(16岁时)因学习成绩下降,无法完成学习任务而自己主动要求退学。退学后患者整日在家无所事事,脑中上述与性有关的想法有增无减,患者为此烦躁,发脾气,与父母吵架。同年,家人发现其总照镜子,问其原因,患者述自己的鼻子长得又大又歪,所以总照镜子。家人认为事实并非如此,但家人对此仍未予以足够的重视。

1985—1990年,患者仍然在脑中出现上述与性有关的想法,但对此感到痛苦的程度已明显减轻,有时还觉得挺好玩,也不再设法摆脱这些想法。在此期间,患者除了集邮和倒卖邮票外,还自修了高中课程并获得了高中毕业文凭。

1990年,患者开始结交女朋友后生活变得较前积极主动,情绪明显好转,脑中虽然还有许多上述与性有关的想法,但已不至于影响生活。1990年,在某单位招工,患者主动报名,应试并被录用当售货员。患者能按时上下班,工作也较认真,但多独处,极少与人交往。1992年与女友确定恋爱关系,1993年结婚。婚后仍有上述淫秽下流、难于启齿的想法,夫妻感情尚可。只是当妻子劝患者继续读书上进时,夫妻就会发生争吵,患者甚至动手打伤妻子。

1995年1月开始,患者又感到头脑发胀、难受伴严重失眠,头脑中上述淫秽下流的想法又明显增多,患者因无法摆脱且不能继续上班,遂来我院求治,但住院2天后患者就偷跑回家。由我院自动出院后,曾在某精神专科医院住院,出院诊断为强迫症。氯米帕明口服每日最高剂量200mg,治疗效果不佳,脑中病态想法仍存在,生活日益懒散,孤僻不出门,不见人,个人卫生差,不料理家务并多次冲动打伤妻子,知道妻子与其离婚,患者也表现无所谓。在家中闲居1年后,从1996年1月至1997年1月,患者勉强上班,但工作能力明显下降,迟到早退现象时有发生。1997年7月某一天,患者无端疑心同事说他偷了单位货款而将这位同事打伤,从此患者就不再去单位上班,并逼迫父亲给其找临时性工作。真的给其找了临时性工作,患者又不好好干。1997年1月起,患者经常不洗脸,不刷牙,不洗脚,有时两三个月洗一回澡。

1998年春季某一天,因买东西时与商店发生争执,患者冲动毁坏商店物品被警察送至我院门诊,门诊医生建议住院治疗,被患者家长拒绝。在家中患者脾气更加暴躁,生活懒散,身上有汗臭气味,很少出家门。对自己的女儿无感情,例如女儿每隔2个月才由其母亲带来看望亲人一次。但来了不到一天,患者就轰女儿走。

1999年底开始,患者情绪不稳,反复无常,行为幼稚,有时竟与自己的孩子争吃食品。患者的父亲批评他时,患者竟冲动打伤父亲头部,事后又下跪求父亲原谅。本次入院前1周,无明显原因突然吞服氯米帕明80片、氯硝安定100片自杀,

患者服药后立刻向父亲求助,要父亲救救他。经某院抢救,昏迷4天后才清醒。由该院转入我院继续治疗其精神病。

既往史:既往体健,否认重大躯体疾患史。否认药物过敏史。

个人史:同胞2人,排行第2,母孕期体健,足月顺产。适龄入学,学习成绩中下等,顺利读到初中毕业。自由恋爱结婚,婚后育一女。1996年协议离婚时女儿判归女方抚养。无不良嗜好。病前性格:内向,不善交往,胆小怕事,小时常受人欺负。

家族史:否认父母两系三代有类似精神失常者。

体格检查:

无异常发现。

神经系统检查:

无异常发现。

实验室检查:

未见异常。头颅MRI检查无异常发现。

精神检查:

意识清楚,定向力完整。年貌相符,入院时个人卫生差,头发较长,仪表不整洁。入院后仍好多天不洗漱,劝说下仍不洗澡。主动及被动接触均差。未引出感知觉障碍。患者谈话被动,不能切题回答问题。例如,医生问:“你为何要自杀?”患者答:“人死前都有生的欲望,针扎我时有一种疼痛的感觉,这就是一种本能。”医生第二次问患者为何要自杀,经抢救才脱险,患者答:“我也看过许多书,例如《癫狂梦醒》,书中谈到了许多药物毒副作用,如翻白眼等。”问患者刚吞下大量药片企图自杀,为什么又立刻向父亲求助,患者仍是答非所问,不能切题回答医生的问题。

患者注意力、记忆检查未见明显异常。智能检查开始时患者并不配合,经过医生多次鼓励,检查才能进行下去。例如,医生问他坐井观天的成语解释,第1、2次患者以“我小时候学过,忘了。”“病好了就能回答了。”避免直接回答医生的问题。第3~4次询问时,患者答:“坐井观天就是坐在井里往天上看。坐在井里静止不动了,抬头仰望天空。”在给予鼓励后,并第5次提同样问题时,患者才回答:“坐井观天就是看问题比较狭窄。”让其进行 $100-7$, $100-13$ 的连续运算,患者开始拒绝,说自己算不出来,后经鼓励可以顺利算出全部正确答案。患者认为自己在住院,并非出于自愿而是父母把他骗进来的,认为自己并没有精神病。

谈话过程中患者面部表情呆板,问及患者把父亲头部打伤,被送到医院缝了十针时,患者仍认为是父亲气他了,他才动手的,谈话时毫无愧疚之感。

患者对将来没有打算,对于自己目前靠父亲退休金生活,而自己没有收入时,表现得心安理得,反而认为这样挺舒服的。入院后经常在病房内手淫,食欲较亢进。诊断:

20.5 未定型分裂症[F20.3 未分化型精神分裂症]

(二) 病例分析

1. 病例特点

(1)男性青年,总病程已16年。发病之前曾因偷看女性洗澡被发现,不久以后即出现与性幻想有关的精神症状,并伴有恐惧、躲避人及怕见人的现象。

以强迫状态(脑中反复出现与性有关的想法)起病,如反复出现淫秽、下流、令患者难以启齿的与性有关的想法,患者对此感到痛苦并设法摆脱,但都无济于事。此病情虽曾一度好转,能够在患病以后完成学业,恋爱结婚。但在结婚后,上述与性幻想有关的精神症状仍未完全消失,可见该患者的病程具有波动的特点,与间歇性病程不同。

(2)患者虽然以“强迫状态”起病,但是随着病情进展,陆续出现一些与强迫症不符的精神症状。例如:脑中虽然仍反复出现淫秽下流、难以启齿的想法,但患者对此感到痛苦的程度已明显减轻,有时还觉得挺好玩,也不再设法摆脱这些想法,这种临床表现已经不符和强迫性神经症的基本特点。另外还出现自身躯体结构方面的感知综合障碍,患者称自己的鼻子长得又大又歪,所以总照镜子(“窥镜症”)。患者在意识清楚、定向力完整的情况下,有明显的联想松弛,思维散漫。出现与女儿抢吃抢喝,对女儿没有感情,冲动打伤父亲后毫无愧疚之心等情感淡漠的表现。本次住院前后有明显的生活懒散、意志缺乏的表现。患者主动及被动接触均不佳,记忆、智能虽无明显障碍,但是需要在医生的多次督促和鼓励下才能完成。患者无自知力。

(3)病前性格:内向,不善交往,胆小怕事,小时候常受人欺负。家族史无特殊。

(4)躯体及神经系统检查,入院常规化验及头颅MRI均正常。

2. 诊断依据和鉴别诊断

(1)神经症强迫症:患者以强迫状态起病,发病之初有心理因素,且曾被某精神专科医院诊断为强迫症,因此应该考虑此诊断。但随着病情进展,患者对所出现的与性有关的淫秽下流想法,不再焦虑和感到痛苦,不再设法摆脱这些想法,甚至还觉得挺好玩的,此点与神经症强迫症的定义和诊断标准不相符合。本次住院后检查发现有明显的精神分裂症的特征性症状,例如联想松弛、思维散漫等,因此可以

排除强迫症的诊断。

(2)精神分裂症,青春型:患者 16 岁起病,进入青春期后,脑中不断出现淫秽下流、难以启齿的想法,即使在结婚后,上述想法仍未完全消失。结合本次住院后又出现明显的联想松弛,思维散漫,经常在病房内手淫,食欲较亢进,提示患者的低级本能活动增强。患者在本次住院前的服药自杀带有明显的冲动性,事前缺乏预谋,服药后立即求父亲救救他,提示患者思维、情感、行为三者之间不协调,应该考虑此诊断。但精神分裂症青春型大多为急性或亚急性起病,本患者以强迫状态为首发症状,缓慢起病,逐渐进展,精神分裂症的阳性症状(例如幻觉、妄想、精神分裂症青春型兴奋等)在整个临床表现中不占主导地位,以上内容都不支持精神分裂症青春型的诊断。

(3)精神分裂症,未定型:患者缓慢起病,经过 16 年的病情逐渐进展,目前虽然还有联想松弛、思维散漫、冲动伤人、低级本能活动增强等精神分裂症的阳性症状,但是情感淡漠、意志缺乏等“精神衰退”的表现也非常明显,已经严重影响其劳动、社会交往和生活自理能力。患者无脑器质性精神障碍等其他精神疾病的诊断依据,符合精神分裂症的症状学标准、严重程度标准、病程标准和排除标准,精神分裂症的诊断成立。但不符合偏执型、青春型、紧张型、单纯型精神分裂症中任何一个精神分裂症亚型的诊断标准,因此可以确诊为精神分裂症未定型(又称混合型、未分型、未分化型)。

3. 治疗方案

患者既往只系统地服用过氯丙米嗪,本次住院后应给予抗精神病药物系统治疗,如传统的抗精神病药经过足量、足疗程的治疗后,疗效欠佳,方考虑选用非经典抗精神病药,如利培酮治疗,如果疗效不好最后再用氯氮平治疗。

4. 预后估计

患者发病年龄早,慢性起病,逐渐进展,既往未系统地应用过抗精神病药物,现在已错过了药物治疗的最佳时机,预后不容乐观,估计难以达到痊愈水平。但如果给予系统的药物治疗,估计精神症状会得到某种程度的控制和改善,取得好转或显著好转的疗效。

住院治疗经过:

住院后经过系统的利培酮治疗,患者能进一步叙述自己既往的病态表现。例如,患者说十几年来,从自己开始有病,头脑中就总是出现与性有关的想法,看到骑车的女同志,就想到她的会阴部。看到年轻的女孩,就想与她发生性关系。现在在病房内也经常想这些内容。严重时只要一醒,一天 24 小时,有十几个小时想男女

淫秽之事,觉得这些想法挺有意思,有时还要故意想得更淫秽一些,这样更过瘾。用利培酮最高日量 3 mg,维持 30 天,患者生活懒散情况明显改善,有关性的想法基本消失,对答已基本切题。情感反应和高级意向活动有所恢复,自知力大部分恢复。经试出院观察,以显著好转之疗效出院。出院诊断:精神分裂症,未定型。

评按:本例患者以精神分裂症未定型,第 2 次住我院后经利培酮治疗,显著好转出院。对于本例患者的精神分裂症临床类型诊断,不同专家至今仍有不同的意见和看法。有医生认为从本例患者的临床症状进行分析,患者在意识清楚的情况下,以思维形式障碍为主,结合拟诊讨论部分已经提及的其他理由,认为应该诊断为青春型。这和以思维内容障碍为主者诊断为偏执型,以木僵或紧张性兴奋症状(紧张综合征)表现突出者诊断为紧张型,以思维贫乏、情感淡漠、意志缺乏(精神分裂症的“阴性症状”)为主者诊断为单纯型有着明显的不同。如果只是对本例患者的精神症状进行分析,诊断为精神分裂症青春型,各位医生并无异议。不同专家、学者之所以对本例患者的临床分型提出异议,是在结合患者的病因、起病形式、临床表现和病情演变过程以后,不同学者才出现了“仁者见仁,智者见智”的局面。这时有些专家仍然诊断为青春型。而另外一些专家认为,应该诊断为未定型。理由是:①本例患者以“强迫状态”起病,在相当长的时间内,精神活动全面瓦解(认知、情感、意志行为活动三者不协调和不统一)的症状并不十分突出,这就不难理解患者曾被某知名精神专科医院诊断为“神经症强迫症”,患者的首发精神症状与精神分裂症青春型的典型表现不符。②青春型患者大多为急性或亚急性起病,与本例患者的慢性起病,逐渐进展不符。③一般说来,精神分裂症青春型患者,“青春型兴奋”的表现比较突出,与本例患者的临床表现不符。④本例患者的确有很多精神分裂症青春型的临床表现,但这些只能作为和强迫症鉴别诊断的依据。本例患者的临床表现不是典型的青春型,诊断为未定型更为相宜。

笔者认为,以上不同医生之间的学术争鸣,反映了当前精神分裂症的临床类型区分尚缺乏客观的生物学依据,需要我们今后在这方面做更多的科学研究工作。在现阶段,精神科临床医生在了解精神科临床诊治水平的现状后,应该更加注意多做临床观察,积累临床资料,倾听不同意见,不断提高自己的临床医疗水平。

本病例分析的方法是从病程和症状的发展开始进行纵的分析,从中找出精神分裂症的基本特点,以及进行鉴别诊断,最后将诊断及鉴别诊断进行总结。读者可以进行思考,在临床工作中参照使用。

(翁永振 江镇康 向应强 姜 涛)

精神障碍可能与中枢神经递质的功能低下有关,因为大多数抗抑郁药主要通过增高去甲肾上腺素系统和(或)5-羟色胺能系统的功能以治疗抑郁症,故至今抑郁症的病因学说或发病机制学说仍以上述两个系统功能低下为主。

二、临床症状

在了解情感性精神障碍的临床症状时,首先应明确躁狂发作和抑郁发作的特点。

1. 抑郁发作

抑郁心境、兴趣或愉快感丧失是抑郁症的核心症状。患者常诉说忧愁、绝望、沮丧或无用感。这种抑郁心境与正常人的悲伤和悲痛有显著的质的区别。患者常将其抑郁症状描述为一种十分痛苦的悲痛情绪,有时甚至诉说欲哭不能。约 2/3 的抑郁患者有自杀观念,10%~15% 有自杀行为。但有些抑郁患者有时对所患的抑郁症显得不在乎,并不抱怨心境的紊乱,即使他们早已表现出回避家庭、亲友和病前感兴趣的事物。

几乎所有抑郁患者诉说有精力减退而难以完成工作、学习任务,导致工作受损和执行任务动力低下。约 80% 患者诉说有睡眠障碍,特别是早醒和夜间易醒,并在此时反复思考种种自身问题。

许多患者伴有食欲下降和体重减轻,但也有患者表现食欲增高,体重增加,睡眠增多。焦虑实际上是抑郁症的普遍症状,大约殃及 90% 以上的抑郁患者。饮食和睡眠障碍可能加剧并存的躯体疾病,如糖尿病、高血压、慢性阻塞性肺部疾病和心脏病。其他自主神经症状包括心悸、便秘和性活动异常。临床医生如不能识别潜在的抑郁障碍,有时会导致对性活动异常等问题的处理不适当。

焦虑(包括惊恐发作)、酒精滥用和躯体不适主诉(如便秘和头痛)常使抑郁症的治疗复杂化。约 50% 抑郁患者的症状有日间波动现象,症状早上重,傍晚轻。认知症状包括注意力不能集中和思维损害,有研究报道,前者有 84% 抑郁患者受累,另一报道后者有 67% 之多。

(1)儿童和青少年的抑郁症:学校恐怖、过分纠缠双亲可能是儿童抑郁症的症状。空谈、物质滥用、反社会行为、性乱交、逃学和出走也可能是青少年抑郁症的早期症状。

(2)老年抑郁症:抑郁症在老年人中较一般人中更常见。据多项研究报道,其患病率达 25%~50%,不过这是否指的是重性抑郁障碍尚不能肯定,但确实显示

老年抑郁症普遍存在。众多研究资料显示,老年抑郁可能与社会经济状况、丧偶、合并躯体疾病和社会隔离有关。有些研究还显示,老年抑郁症漏诊,未得到治疗者较多,特别是在全科医生中更易发生。究其原因,可能是由于老年抑郁症的症状较年轻者更常表现有躯体主诉。同样,在内科医生中亦发现有较多忽视老年人的倾向,他们不太乐于接受老年患者的抑郁症状较年轻者繁杂的事实。

2. 躁狂发作

心境高涨,兴奋话多或易于激惹是躁狂发作的标志。高涨的心境常表现为欣快并具感染力,有时使缺乏经验的临床医生误认为没病。虽然非专科医生并没有认识到患者病态心境的异常本质,但凡熟识患者的人,都会认识到患者的表现是反常的。此外,患者的情绪常易于激惹,特别是当患者病态的雄心勃发计划受阻时更易发生。患者的病理性优势情感亦常发生迅速变化,往往从疾病早期的欣快向疾病后期的易激惹迅速发展。

住院时,由于受病房规章制度的限制,对躁狂患者的治疗可能变得复杂。病人常倾向于将责任推向他人,专找别人的弱点,离间工作人员的关系。院外躁狂病人常过度饮酒,或许以此作为自我治疗的尝试。病人难于自制的本质还反映在打电话多,特别是在清晨打长途电话,病理性赌博,在公共场合脱衣,以异常的搭配方式穿戴色彩鲜艳的服装、首饰以及不注意小节等表现均是躁狂患者的常见症状。许多患者行为的冲动性常与其坚信不移的意图与目的结合在一起。患者常倾注于宗教、政治、财经、性活动中,或具有源于复杂的妄想系统的猜疑观念。

青少年躁狂症:青少年躁狂症常被误诊为反社会人格或精神分裂症。青少年躁狂症的症状可能包括精神病性症状,酒精或其他物质滥用,自杀企图,高谈阔论,纠集团伙,强迫性情绪症状,各种躯体不适主诉,显著的激惹所致的斗殴和其他反社会行为。虽然许多这类表现可见于正常青少年,但是持续而严重的症状存在,应引起临床医生注意,在鉴别诊断中考虑双相Ⅰ型障碍的可能性。

3. 并存障碍

(1)焦虑:明显的焦虑症状可以与抑郁症状并存。具有明显的焦虑和抑郁症状的患者或者是受两种明显的疾病过程影响。

(2)酒依赖:酒依赖常与心境障碍并存。

(3)躯体疾病:抑郁症普遍与躯体疾病并存,特别是老年人。当抑郁症与躯体疾病并存时,临床医生必须试以断定这种潜在的躯体疾病是否在病理生理学方面与抑郁症有关,或判定患者用来治疗躯体疾病的药物是否引发抑郁症。许多研究结果显示,某种并存的重性抑郁障碍的治疗,能改善潜在的躯体障碍的病程,包括

癌症在内。

情感性精神障碍常为急性或亚急性起病。本病的病程多是发作性的,一次发作的症状持续时间可以数日至数月,短者可为3天,长者可达3年,平均为12个月,多数在6个月以内;抑郁发作时间长些,躁狂发作时间短些。少数病人呈慢性状态,可达数年或20年以上。间歇期间有的病人精神状况和病前完全一样,有一部分病人发作间期社会功能具有不同程度缺损。

第二节 情感性精神障碍的诊断标准

一、躁狂发作

躁狂发作以心境高涨为主,与处境不相称,可以从高兴愉快到欣喜若狂,某些病例仅以易激惹为主。病情轻者社会功能无损害,严重者可出现幻觉、妄想等精神病性症状。

(一) 症状标准

以情绪高涨或易激惹为主,并至少有下列8项中的3项(若仅为易激惹,至少需4项):

- (1) 注意力不集中或随境转移。
- (2) 语量显著增多。
- (3) 思维奔逸(语速增快、言语迫促等),有联想加快或意念飘忽的体验。
- (4) 自我评价过高,或夸大。
- (5) 精力充沛、不感疲乏、活动增多、难以安静,或不断改变计划和活动。
- (6) 鲁莽行为(如挥霍、不负责任,或不计后果的行为等)。
- (7) 睡眠需要减少。
- (8) 性欲亢进。

(二) 严重标准

严重损害社会功能,或给别人造成危险或不良后果。

(三) 病程标准

- (1) 符合症状标准和严重标准至少已持续 1 周。
- (2) 可存在分裂症性症状,但不符合分裂症诊断标准。若同时符合分裂症的诊断标准,在分裂症状缓解后,满足躁狂发作标准至少 1 周。

(四) 排除标准

排除器质性精神障碍,或精神活性物质和非成瘾物质所致躁狂。

二、抑郁发作

抑郁发作以心境低落为主,与处境不相称,可以从闷闷不乐到悲痛欲绝,甚至发生木僵。严重者可出现妄想、幻觉等精神病性症状,某些病例的焦虑与运动性激越很显著。

(一) 症状标准

以心境低落为主,并至少有下列 8 项中的 4 项:

- (1) 兴趣丧失、无愉快感。
- (2) 精力减退或疲乏感。
- (3) 精神运动性迟滞或激越。
- (4) 自我评价过低、自责,或有内疚感。
- (5) 联想困难或自觉思考能力下降。
- (6) 反复出现想死的念头或有自杀、自伤行为。
- (7) 睡眠障碍,如失眠、早醒,或睡眠过多。
- (8) 食欲降低或体重明显减轻,性欲减退。

(二) 严重标准

社会功能受损,给本人造成痛苦或不良后果。

(三) 病程标准

- (1) 符合症状标准和严重标准至少已持续 2 周。
- (2) 可存在某些分裂性症状,但不符合分裂症的诊断。若同时符合分裂症的诊

既往史:体健,无重大躯体疾病,否认手术、外伤及药物过敏史。

个人史:同胞4人,排行第1,幼年生长发育不详。8岁上学,学习成绩好,话少,与同学交往少,与同学关系一般。8岁时父亲去世,母亲改嫁,幼时跟其他亲属一起生活,生活条件艰苦,缺少家庭温暖。小学毕业后在农村务农,一年后来北京,与母亲及继父家人一同生活,做过临时工,卖过菜,后来在北京木材厂当工人。36岁左右调至一木材厂,做过班组长,女工委员。工作能干,与同事关系好,生活上省吃俭用,一心一意照顾孩子,对丈夫体贴。病前性格:内向,情绪不稳,爱发脾气,爱埋怨。婚育史:28岁结婚,婚后夫妻感情好,育两子,体健。月经史:初潮年龄15岁,3~5/30,末次月经1993年11月20日。月经规律,无痛经和经前期紧张。

家族史:父母两系三代无精神病人及性格古怪者。

体格检查:

未见异常。

精神检查:

意识清楚,定向力完整,头发蓬乱。患者被强迫送入病房,主被动接触差,语速中等,语音低,语量较多,主动叙述心中的不快。

否认有幻觉,未引出明显逻辑障碍和思维内容障碍。

患者明显表情忧愁,向医生吐露自己痛苦的心情:“搬家后觉一切事情都不方便,退休后挣钱少了,日子过得很紧张,有日子过不下去的感觉,在家干什么事情都觉得没有意思,如果继续再在医院呆下去,病会越来越重,我的脑袋现在像木头一样,什么都做不了啦!出门买菜也没有计划性,以前家务全由我管,现在什么也管不了啦!我确实不想活了,活着拖累大家。”患者认为现在活着只能给家人带来累赘,不如死了好。问患者:“你以前也做过错事吗?”答:“是!我从来没做过对的事,我谁都对不起。”问:“你有过自杀吗?”答:“有,上过吊。”问:“为什么?”答:“我是废人,什么都干不了,想跳楼,上过吊。”患者说话时愁眉苦脸,音调低沉。

入院后少动,多卧床,问患者为何少动多卧床,答:“我想好好生活,可是总是打不起精神,觉着累。”生活尚能自理,动作缓慢,能主动进食但食量少,午餐只能吃少半碗米饭,患者称:“没有胃口。”睡眠差,入睡困难,每日清晨4~5点钟就醒了。

(二) 病例分析

1. 诊断和诊断依据

(1)女性,48岁首次起病,总病程8个月。

(2)临床表现主要为抑郁状态:以心境低落为主,终日闷闷不乐,虽然患者对迁

居后的环境不满,生活有一定困难,但是不至于心境低落到无法正常生活的地步。主要症状有:对日常生活丧失兴趣,对迁居新房无愉快感,精力减退,自觉联想困难,自述:“脑子像木头一样”。有无用感,认为:“我什么也做不了啦!”自我评价过低,自责、内疚:“以前家务全由我管,现在什么也管不了啦!我确实不想活了,活着拖累大家。”反复出现想死的念头,并有自杀行为,失眠,食欲不振。心境低落为晨重晚轻,社会功能明显受损,患者理家功能丧失。患者的自责和负疚感向病前扩张。

(3)焦虑症状:病人在家中见什么都烦,并打自己。

(4)意志低下、运动迟缓:患者想把家管好,但是力不从心,因此患者不是没有动机或愿望。患者在入院后少动多卧床,说话也慢,是运动抑制症状。

根据以上临床所见已经满足抑郁发作的症状标准,社会功能受损,给本人造成明显痛苦,病程已经超过两周。根据 CCMD-3 诊断标准,诊断为

32.2 无精神病性症状的抑郁症[F32.1]

2. 鉴别诊断

由于患者对所迁人的新居很不满,可能成为患者的精神刺激,引起抑郁症状,应该排除适应障碍的可能性,但是适应障碍一般不超过 6 月,并且有一定的人格缺陷,本病例不符合此诊断。

3. 治疗计划

患者临床诊断较明确,治疗上应系统使用抗抑郁药,患者临床表现以抑郁和焦虑为主,故用药上宜选择有抗焦虑作用的抗抑郁药,如帕罗西汀及阿米替林等药物,治疗上应注意足量、足疗程,并在病情稳定后坚持巩固治疗,防止复发。

二、病例二

+++++

(一) 病历摘要

患者郝某,男性,17 岁,高中二年级,未婚,营业员。于 1999 年 3 月 9 日入院。由患者父亲报告病史,可靠。

主诉:5 个月来少语、少动、发愁及话多、兴奋交替;近 1 个月心情愉快,数日来加重而易激惹。

现病史:患者于 1998 年 9 月起无明显原因经常呆愣不语,家人与他说话,患者好像没听见一样,坐着发呆。父亲让他去扫地,他慢腾腾半天也扫不完。同年 10

月底开始变得胆子特别小,家里来了很熟的客人也躲着不见。自己一个人躲在储藏室里,家人怎么叫也不出来。有时父亲从外地回来也不敢见。整天愁眉苦脸,对什么都不感兴趣,院里的伙伴叫他去玩,他也不去,父母让他去看电影他说没意思,对精彩的电视节目也失去了以往的兴趣。对平时喜欢的饭菜也觉着没胃口,常说:“吃饭真没劲。”饭量持续下降,身体逐渐消瘦。学习成绩急剧下降。1998年10月后已不能继续上学。这些异常表现上午较重,晚上有所减轻。

1999年1月起,患者无原因突然转忧为喜。整天有说不完的话,从不在家待着,在外面乱跑,爬到3米多高的墙上往下跳,骑着自行车在马路上横冲直撞,见到汽车也不躲让,胆子特别大。自己说心情特别好,将来要干一番轰轰烈烈的大事业。夜里不睡觉,一会儿学外语,一会儿听音乐,一会儿又要帮家里洗衣服。觉得食欲特别好,吃得特多,身体一天比一天强壮。当姐姐们批评他学习不好时,他大发脾气,拿起罐头瓶将姐姐们打伤。总向父母要钱,常去饭馆吃饭。一次吃几十串羊肉串,并慷慨大方地请同伴一起吃,称自己有的是钱。当向他的奶奶要烟抽而被拒绝后,就掐奶奶的脖子,殴打奶奶。过后父亲问他为什么这样,他回答说是在开玩笑。喜欢找女孩玩,有时在一女孩家待着不走,被人家毫不客气地轰走,但是厚着脸皮还去找那个女孩。

1999年2月初家人带他到某院精神科就诊,诊断“精神分裂症”,予以氟哌啶醇癸酸酯、舒必利等药治疗,剂量不详。患者病情略有好转,服药十余天后自行停药。近几日患者彻夜不眠,暴跳如雷,打人摔东西,家人无法护理,遂送入院。

既往史:1岁时曾患“缺钙”,经治疗痊愈。平时体健,无重大躯体疾病史。

个人史:北京出生,同胞4人,排行第4,母妊娠期及生产过程无异常。足月顺产,牛奶喂养,出生后缺钙,2岁时才会走路,学说话正常。少儿期生长发育正常,8岁上学,学习成绩一般,与同学关系好。对父母较尊敬。1998年10月学校认为他“有病”,建议他休学治疗,以后一直未复学。病前性格:内向,不爱说话,不善交际,朋友较少,固执,脾气暴躁,任性。

家族史:父母两系三代无精神及神经病患者。

体格检查:

未见异常。

实验室检查:

未见异常。

精神检查:

自行步入病房,衣着整齐,年貌相符,入院后主动向医生与护士敬礼,表示听医

生的话,愿意帮助其他病友。在病房内四处走动,主动与其他病友聊天,边说边手舞足蹈,一会儿就招来一群人围着他,患者更显得高兴,说得更起劲。患者语量较多,滔滔不绝,声音高,语速快,难以打断。经常旁证博引,高谈阔论,内容连贯而切题,问他今年多大,他却回答说:“我今年 17 岁,明年 18 岁,你看我像不像二十几岁的小伙子,壮不壮,我能力举千斤,中国举重队要是收我,让我去比赛,准拿金牌,你知道金牌是真的还是假的?我知道,那金牌是镀金的,并不值钱。我家有真金的戒指、项链,可值钱了。你知道我有多少钱?我有 1 万块钱。”自诉:“我情绪可好了,觉得非常愉快,心里特高兴,无忧无虑。我能学各种知识,上大学。不,我不上大学,我要当运动员,你知道马拉多纳吗?他是足球明星,是踢球的。中国队太臭了,输给香港队,那场球我看了,气死我了,要是让我去,准输不了。我还可以做电影明星,去拍电影,我喜欢武打片,我要练武功,功夫不负有心人,拍成武打片后,去香港、台湾放映,我要拿奥斯卡奖。”问他以前有没有情绪不好的时候,回答说:“有,有时我心情不好,不高兴,胆小,不愿见人,总不想动,没力气,脑子不好使,什么都不想干。现在可不是了,自己全变了,就像变形金刚。”患者思维内容丰富,多幻想,不荒谬。有明显的夸大观念,过高评价自己,高傲自大,自命不凡,夸大自己的健康,觉自己有过人的才华,谈话过程中表现欢欣喜悦,轻松愉快,说话时眉飞色舞,喜笑颜开,自述内心十分愉快,没有什么忧愁和烦恼,思维与情感协调,有明显的感染力。在病房整天忙个不停,精力充沛。

(二) 病例分析

1. 诊断和诊断依据

(1) 患者男性,17 岁,5 个月,亚急性起病,逐渐加重。

(2) 临床表现

1) 躁狂发作

①语速快并有音联意联:当医生问他的年龄时,回答:“我今年 17 岁,明年 18 岁,你看我像不像二十几岁的小伙子,壮不壮,我能力举千斤,中国举重队要是收我,让我去比赛,准拿金牌,你知道金牌是真的还是假的?我知道,那金牌是镀金的,并不值钱。我家有真金的戒指、项链,可值钱了。你知道我有多少钱?我有 1 万块钱。”可见病人的回答切题,但是他加上“明年 18 岁”是意联症状,因为这两句话的意思关系很密切。以后的几句话都有意联的特点,并有夸大的内容。

②自我评价过高:病人自诩:“中国队太臭了,输给香港队,那场球我看了,气死我了,要是让我去,准输不了。我还可以做电影明星,去拍电影,我喜欢武打片,我

气。2月19日下班后在自家楼下的菜市场又唱又跳,摊主阻止她,她就躺在地上又哭又闹。家人发现后送患者到我院门诊就医,门诊以“躁狂状态”收患者入院。

既往史:体健,否认重大躯体病,无手术、外伤及药物过敏史。

个人史:同胞2人,本人行大。自幼生长发育良好,适龄入学,成绩中等。高中毕业后考入某大学计算机专业,1981年大专毕业后留校工作,工作表现和人际关系一般。1990年随丈夫调入北京,一直在现单位工作。病前性格:外向开朗,爱说笑,做事固执、不灵活,认真。月经史:初潮年龄15岁,5/28~30,末次月经2001年2月19日,不规律,经前爱发脾气。1983年经人介绍与现夫相识并结婚,婚后夫妻感情好,有一子发育良好。

家族史:否认两系三代中有严重精神、神经系统疾病和严重遗传疾病。

体格检查:

未见异常。

实验室检查:

未见异常。

精神检查:

患者意识清楚,定向力完整,接触主动,语量多,语速快,语调高,说话滔滔不绝,很难打断。见人热情,主动和其他病人打招呼并且把自己带来的食品分给大家吃。滔滔不绝地说:“最近这两个月感觉特好,什么愁事儿都没有。心情好,脑子也好使,老是不停地想事儿,想停也停不下来。我爱人说我最近好像变了一个人,爱管闲事儿,爱打扮,爱花钱。我觉得也是。这几天我脾气特大,遇着点儿事儿就管不住自己。其实我没病,住院是因为我和爱人打赌,我要是敢住院,他输给我500万,我一赌气就来了。”患者在说话时眉飞色舞,表情愉快。同时伴有较多的手势。患者对前途充满希望,认为要获得美好的将来毫无困难。

治疗经过:

住院后给予氟哌啶醇(20 mg/d,肌注)和碳酸锂治疗,兴奋症状略有好转。1周后出现被害妄想,诉:“我这次住院肯定是单位给我使的坏,有人看我不顺眼,用这种方法把我从单位挤走,现在他们可高兴了。你们(医生)和我们单位的人是什么关系,为什么说我有病,你们给我吃的到底是什么药。”氟哌啶醇加到每日24 mg,1周后疑心消失,情绪逐渐稳定,2001年4月9日痊愈出院。诊断:

30.3 伴有精神病性症状的躁狂症[F30.2]

(二) 案例分析

1. 诊断和诊断依据

(1) 患者女性, 41 岁, 起病较急, 病程 2 个月。

(2) 临床表现为躁狂综合征: 情感高涨, 主要表现为心情愉快, 自感精力充沛。

①随境转移, 患者在入院前看见同事们在打字就要帮忙, 但是没有干完, 见到别人在工作又去帮别人。②注意力不集中: 表现为工作出错, 在打印合同时将重要的内容打错, 在受批评后不以为然, 反而自我感觉良好。③自我评价过高: 患者工作出了错, 在受批评后, 不感到愧疚, 反而自诩: “谈合同我去, 这事儿没我不行”。④易激惹: 患者在买菜时和摊主发生争执, 患者情绪异常激动, 大声吵闹, 把摊主的菜扔到马路上。⑤精力充沛、活动增多: 在入院后发现患者精神头儿也特大, 每天老得找点儿事儿干, 自称: “精神头儿特大, 不睡觉也不觉得困。”⑥睡眠要求减少。⑦行为轻浮、鲁莽, 说话、做事不计后果, 如无计划乱花钱, 另外患者有与年龄及身份不相符的浓装艳抹行为, 有可能是一种性欲亢进的表现。

(3) 患者无自知力。治疗过程中又出现短暂的精神病性症状——被害妄想, 认为单位的同事肯定在给自己使坏。根据上述特点, 诊断为:

30.3 伴有精神病性症状的躁狂症[F30.2]

2. 鉴别诊断

精神分裂症。精神分裂症突出的表现是思维障碍和精神活动的不协调, 常常伴有社会功能的损害, 发病过程中始终以精神病性症状为主, 虽然也可出现情感方面的障碍, 但情感症状大多继发于精神病性症状, 持续时间相对短暂, 更常见的表现为情感倒错和情感淡漠。本病例临床以躁狂表现为主, 虽出现有精神病性症状, 但妄想出现晚, 持续时间相对较短, 消退早于情感症状。根据这些特点可除外精神分裂症的诊断。

3. 治疗原则

对症治疗, 心境稳定剂锂盐是主要的抗躁狂药物, 锂盐的用量应以血锂浓度作为重要参考指标, 适当血锂浓度为 $0.8 \sim 1.2 \text{ mmol/L}$, 如果超过 1.4 mmol/L 有中毒的危险。由于锂盐疗效的起效时间较晚, 和抗精神病药和(或)苯二氮草类药物合用可尽早控制运动兴奋症状。必要时可选用电痉挛治疗控制兴奋症状。

治疗程序:

(1) 前驱期: 出现心境障碍症状时, 及早用药。

(2) 急性期: 尽早应用抗躁狂药, 如用锂盐治疗应测血锂。锂盐治疗起效较慢,

有效率约为 40%，故常与抗精神病药合并治疗。或用抗精神病药合并其他情感稳定药(mood stabilizer)，其中有：卡马西平、丙戊酸钠、托吡酯(妥泰)等治疗。

(3)恢复期：症状消失后应将治疗剂量维持 6 个月左右，以后再考虑减药。

(4)康复期：目的在于增强病人内在抵御环境压力及疾病对自己造成不良影响的能力，预防疾病复发，提高生活质量。康复的基本策略为：用社会心理教育的方法使病人掌握用药的技能和早期发现复发征兆的能力，并把药物治疗和上述技能巧妙地结合，使药物治疗发挥最大的疗效。

附 1 锂盐的用法：

(1)增药期：1~2 周，服用碳酸锂将血锂水平逐渐达到 0.8~1.2 mmol/L，碳酸锂从小剂量开始，在两周内达到 1 500~2 500 mg/d，同时严密注意观察不良反应及进行血锂监测。

(2)治疗期：病情缓解后仍应按治疗有效剂量维持 6 个月以上。

(3)维持期：可将药物剂量减到维持量，如果为首次躁狂发作维持治疗应保持 1 年。

附 2 其他情感稳定剂治疗：包括卡马西平(carbamazepine)、丙戊酸钠(sodium valproate)、托吡酯(topiramate, topamax)等。

四、病例四

+++++

(一) 病历摘要

患者张某，女性，28 岁，高中文化，北京某商厦售货员，已婚。

主诉：10 年来间歇性兴奋，话多，好管闲事；近半年高兴、话多与沮丧自杀行为多次交替出现，近 1 个月来沮丧、自杀企图加重。

现病史：患者于 1989 年因学习紧张曾一度出现精神失常的表现，兴奋，话多，爱发脾气，好管闲事，睡眠少，每天在家人说服下 12 点以后才勉强上床，早晨 3~4 点钟就起床。未经诊治，一个月后恢复如常。1992 年底因工作不顺心再次出现反常的表现，兴奋话多，好吹嘘，觉得自己“能力比别人强，脑子特别好使，窍门特别多”。精力充沛，每天不停地找事做，睡觉少。在单位常为小事和同事争吵，要求别人都听她的，一不顺心就要求领导给她调换部门。勉强坚持工作，1993 年下半年自行缓解。

1999 年 5 月，临近工作合同期满，患者担心下岗，又出现睡眠减少、话多等症

状。当月到我院门诊就医,诊断“躁狂状态”,服用碳酸锂(最高剂量 750 mg/d)和氟哌啶醇(最高剂量 10 mg/d)治疗。2 周后,兴奋症状消失,但逐渐表现发呆、发愣,整天闷闷不乐,自称没有一件高兴的事,对什么事都没兴趣。换用多虑平治疗(最高剂量 75 mg/d)3 周后情绪低落等症状缓解,再次出现兴奋、话多、爱发脾气、乱花钱等表现,并拒绝服药,不能工作。此后,患者病情出现周期性的交替变化。1 周兴奋、话多,1 周悲观、少语、少动,没有明显的缓解期。自 1999 年 10 月起患者的病情波动变为 2 周一次,且有所加重,分别于 10 月 2 日和 11 月 5 日两次吞服“大量药物”(具体不详)自杀,经抢救脱险。近 1 个月来,患者仍表现沮丧、悲观、自责,认为自己是家里的负担,拖累家人,不如死了好,多次自杀未遂。进食少,入睡困难,早醒。于 2000 年 2 月门诊以“双相型情感障碍”诊断收患者入院。

既往史:既往体健,否认重大躯体疾病,无手术、外伤及药物过敏史。

个人史:同胞 2 人,本人行大。母孕期正常,足月顺产,幼时发育良好。适龄入学,学习成绩一般。高中毕业后分配到现单位工作,工作认真,肯吃苦,但能力一般。病前性格:内向,不善交际,固执,任性,小心眼。月经史:初潮年龄 13 岁,3~4/30,末次月经 2000 年 1 月 14 日。经期易烦躁,爱发脾气。婚育史:1995 年结婚,婚后感情好,有一子,体健。

家族史:患者二伯父患“精神分裂症”,长期住院治疗。

体格检查:

未见异常。

精神检查:

患者意识清楚,定向力完整,接触被动,谈话时紧皱眉头,表情痛苦。语调低,语速慢,语量适中。问患者为什么总是愁眉苦脸的,患者回答:“……心情不好,没意思,对什么事都没兴趣。什么都不愿意干,有时候想干也干不了;脑子不好使,想事儿特别慢,记性也不好。看别人活得都比我好,我活得太累,有时候想想真还不如死了好,活着没意思,太痛苦了……最近一点胃口都没有,比以前瘦了好多。睡觉也不好,睡不着,有时候醒得还特别早。”患者长时间独坐于床上,动作少,对今后的日子怎么过感到发愁,认为将来没有好日子,有自杀企图。

治疗经过:

入院后服用氯丙咪嗪(最高剂量 100 mg/d)和丙戊酸钠(最高剂量 600 mg/d)治疗。3 周后,患者出现兴奋症状,在病房里唱歌,跳舞。在精神检查时医生让她“唱一个!”病人很高兴地说:“行!”就高兴地高声歌唱。并且爱管闲事儿,患者见到护士在给病人分发药,她主动过来说:“护士姐我来帮你!”随手抓起一个药杯,递给

一个病人。在精神检查时主动表示：“最近可真想开了，心里特高兴，脑子也好使了，有好多想法，等出了院再去实现。我以前太糊涂，太自卑，其实我的能力比他们（同事）都强，要是我当了经理，商场效益准能提高。我现在精神头儿特大，有劲儿没地儿使，我每天都帮她们（其他病人和卫生员）干活儿，要不就闲得难受。”曾用电痉挛治疗4次、氟哌啶醇治疗（最高剂量20 mg/d，肌肉注射）10天后，再次出现少语，动作减少，自称不高兴。此后患者又如此7~10天反复多次，但程度均较轻。最后服用丙戊酸钠（1200 mg/d）和舒必利（200 mg/d），于住院治疗4个月后痊愈出院，其中有近一个月精神状况稳定。

（二）病例分析

1. 诊断和诊断依据

（1）患者女性，18岁起病，起病诱因不明显，呈间歇性病程，在间歇期间社会功能恢复如常。

（2）起病早期的数次发作以躁狂相为主，持续时间较短，抑郁症状不明显。

（3）自1999年5月以来发作频繁，半年内的发作次数已超过4次，每次发作均呈现典型的躁狂或者抑郁的临床表现，且两组症状交替出现多次，症状交替期间无明显的缓解期。

（4）据以上所见，每次发作都符合轻躁狂或躁狂发作，和抑郁发作。在过去12个月中发作超过4次，在入院后仍有类似发作。因此符合以下诊断：

31.91 双相障碍，目前为快速循环发作[F31.8]

2. 鉴别诊断

情感性精神障碍双相型，目前为混合性发作。混合性发作以躁狂和抑郁症状混合或迅速交替（即在数小时内）为特征。而本患者的临床表现始终以单一躁狂或抑郁症状为主，没有出现二者的混合现象；且这两组症状的交替大多以周为单位。根据这些特点，可除外混合性发作的诊断。

3. 治疗原则

电痉挛治疗和（或）心境稳定剂。有时抗抑郁药可诱发躁狂症，因此心境稳定剂和抗精神病药应作为首选治疗方案。抗精神病药的选择，目前可选用第二代药物，如氯氮平、利培酮、奎硫平等，加用心境稳定剂治疗。

五、病例五

(一) 病历摘要

患者翟某,女性,31岁,已婚,初中文化,农民。病史由患者其丈夫提供,可靠。

主诉:间歇性精神失常1年余,话多、急躁、自责、疑心交替出现,加重3个月,近半个月来不语少动。

现病史:患者于1999年11月无诱因出现精神失常,表现话多、愉快、高兴,总说自己有本事,有时自诩能承包商场,打算挣很多钱;不久又想去倒卖古币。自称羡慕有知识的人,经常拿着书到熟悉的老师家登门求教。患者认为父亲没本事,不能为自己找到工作,因此怒斥父亲把自己的前程耽误了。感觉自己比谁都强,说自己知识广,交际多,会说话,认为自己是个“超人”式的人物,什么都能干,应该在办公室当领导人。自称心情好,跑到街上唱歌,乱讲街坊:这个老太太有作风问题,那个老头快死了。到处乱走。有时好发脾气,自己认为不顺心的事就骂人,把人骂得一钱不值。高兴时又说又笑,上街乱花钱,见啥买啥,向别人要吃要穿,也不感到羞耻。夜不眠,白天仍精力充沛,曾在当地医院就诊,具体不详。两个半月后渐好转,即如常人,未再服药,在家做家务。

2000年9月起,患者病情出现变化,表现不爱出门,总唠叨说怕得罪人。10月份,家里的狗误服农药死了,患者表现伤心、流泪,说都是因为自己把人得罪了;家里请人帮忙买煤,没有很快送到,患者认为自己夏天收了人家一件衣服,把人得罪了。11月份出现明显沮丧和自责,因为自己不会给孩子做棉衣,就说自己没用,总给家人添乱,把邻居都得罪了,家里没法待了,要自杀,还要把孩子也杀死,以免自己的孩子活着受罪。患者病后很少出门,多坐在屋子里不动。2001年1月在当地服中药,未见明显好转,半个月后出现两眼发直、肢体发僵、走路不稳等症状且逐渐加重,整日卧床,不吃不喝,家人无法护理,遂送入我院。

既往史:1997年患“葡萄胎”已治愈。无其他重大疾病史。

个人史:同胞2人,排行第1,自幼生长发育正常,适龄读书,学习成绩一般,初中毕业后在家务农,与家人感情尚可,无特殊嗜好。1996年经人介绍与现夫结婚,婚后夫妻感情尚好,育一子,体健。病前性格:内向,不爱说话,稳重,较能干。

家族史:父母两系三代无精神及神经病患者。

体格检查:

未见明显异常。

精神检查：

意识清楚，定向力完整，由家人抬入病房，在别人的帮助下更衣，入院后即卧床不起，面无表情，双眼发直，目光呆滞，眼球活动少。对问话不答，周围发生的事情也不能引起患者的注意。不能排尿，有尿潴留，拒食、水，生活不能自理。

治疗经过：

电痉挛治疗 5 次，运动抑制症状缓解。患者可下床活动，主动进食，生活自理。但仍多独处，较少与周围人接触。精神检查：谈话过程中表情痛苦，反应迟钝；语量少，语速慢，语声低，有时对问话不回答。诉：“脑子不好使，什么都干不了；心情不好，高兴不起来。有时都不想活了，但担心孩子，怕自己死了以后孩子没人管，有时想把自己的孩子掐死，这样做死了以后也就没有牵挂的事了……觉得自己没用，连小孩的棉衣都不会做……不应该把邻居都得罪了，不该和邻居一起说婆婆的坏话”。经电痉挛治疗、阿米替林 150 mg/d 和奋乃静 20 mg/d 治疗 2 月余，痊愈出院。

（二）病例分析

1. 诊断和诊断依据

（1）患者女性，30 岁起病，起病较急，间歇病程，有明显的缓解期，缓解期间社会功能恢复至病前水平。

（2）临床表现：躁狂症状和抑郁症状两组症状交替出现。前者包括：在病史中有情绪高涨，自我感觉良好，自我评价过高，易激惹，精力充沛，语量增多，活动增多，注意力不能集中等症状。后者包括：情感低落伴自杀观念，患者多次表示想杀死自己的孩子，目的是在自己自杀死了以后别让孩子受罪，这可称为“利他性自杀”。这种症状经常是危险的，可能造成杀子的悲剧。另外还有思维迟缓，活动减少，自责，自我评价过低等症状。

（3）抑郁性木僵：抑郁性木僵是由抑郁发作逐渐演变而来的。表现为不语、不动、拒食等。患者有明显的抑郁性木僵症，经电痉挛治疗后有部分缓解，此时是自杀及杀人的最危险的时期，因为患者已经能够行动，但是抑郁症状尚未消除，有能力实施自杀的企图。另外，患者不止一次说过要杀死自己的孩子，以免自己死后孩子受罪，这是“利他性杀人”的表现，也是抑郁症常见的临床现象。在此期间，预防自伤、伤人是护理工作的头等任务。

根据上述特点，临床诊断：

31.6 双相障碍,目前为有精神病性症状(木僵症)的抑郁[31.5]

2. 治疗方案

患者以木僵状态入院,电痉挛治疗是缓解木僵状态的最有效的措施,争取患者尽早自己进食,有利于防止水、电解质紊乱及营养失衡,同时必须加强护理,预防自伤、伤人,由于在电痉挛治疗后木僵状态缓解或部分缓解,但是抑郁情绪依然存在,自伤、伤人的可能性比在木僵状态时要人的多。在此时预防自杀尤为重要。患者为双相性情感障碍,在1年内有2次发作,应选用心境稳定剂;必要时可加用抗抑郁剂。

六、病例六

+++++

(一) 病历摘要

患者许某,男性,22岁,浙江籍,某学院学生。

主诉:间断性愉快、兴奋话多、爱吹嘘1年;加重1个月伴语乱。

现病史:患者于1998年春节期间无明显诱因出现高兴、兴奋话多、爱吹嘘,说自己将来能当国家领导人;精力充沛,好管闲事儿,睡眠明显减少,晚睡,早醒。未经诊治,上述异常表现于十余天后自行缓解,工作、生活表现同前。1999年3月起患者病情复发,主要表现兴奋、话多;爱花钱,每天都给家里打长途电话,一聊就是一两个小时,讲话时滔滔不绝,不许家人插嘴;患者吹嘘说:“我们学校可不一般,由中央直接管理,将来我们毕业后都当国家领导人”。上课时不专心听讲,总想和同学聊天儿,别人要是不理他,他就故意骚扰别人,不让别人听课;有时老师讲着讲着课,他不经老师允许,突然就站起来提问。爱发脾气,在宿舍经常因为小事和别人发生争吵。精力非常充沛,睡眠明显减少。近3天来,同宿舍的人发现患者说话的内容特别离奇,一会儿说 he 自己是神,别的同学都是蛇妖转世,自称和他们斗法已经有很长时间了;一会儿又说 he 自己是秦始皇、又是林彪。有时候一个人躺在床上自言自语;有时候又突然冲动,大声喊叫、摔东西、打人。饮食、睡眠无规律,生活不能自理,不知洗漱。今日家属来京,和同学一起送患者到我院门诊就医,门诊以幻觉妄想状态收患者住院。

既往史:体健,否认重大躯体病,无手术、外伤及药物过敏史。

个人史:同胞2人,本人行2,幼时生长发育良好,适龄入学,成绩良好,上初中、高中时曾先后两次因贪玩、考试不及格而留级。高中毕业后考入北京政法干部

学院法律系,学习成绩一般,人际关系较好。病前性格:外向、开朗,好结交朋友,爱好较多。

家族史:否认两系三代中有严重精神、神经系统疾病和遗传疾病。

体格检查:

未见异常。

精神检查:

患者被家人送入病房。时间、地点定向力均较差,不认识家人,管他父亲叫舅舅。入院后即卧床,语乱,对答不切题,常自言自语。有时下床无目的乱走,分不清男女厕所,常找不到自己住的床,大小便不能自理。

入院当天下午和入院第二天早晨各电疗一次,意识恢复,对精神检查合作。患者对入院前三四天及入院当天的情况基本不能回忆,觉得自己“像在梦里一样,什么都想不起来了。”可引出躁狂综合征,诉:“最近特兴奋,脑子好使,自我感觉也好,什么事儿都特顺……将来没问题,我行,能混个一官半职的……我没病,让我回学校吧,在这儿闲得难受,有劲儿没地儿使。”谈话过程中注意力不集中,一会儿看电视,一会儿又和别的病人聊天儿。计算力正常,对成语的解释也正常。在病房内较兴奋,主动、热情,管闲事儿,如看见病友们在下象棋,他就乱插嘴。对护理欠合作,常对护士发脾气。睡眠少,有时半夜还在楼道里踱跬,找正在工作的值班护士聊天。

治疗经过:

经电痉挛治疗(9次)以及碳酸锂合并氯丙嗪治疗3周后痊愈出院。

(二) 病例分析

1. 诊断和诊断依据

(1)患者男性,22岁首次起病,为间歇性病程。

(2)既往曾有躁狂症发作,表现为无原因高兴、话多、兴奋愉快、精力充沛等症状,与本次发作相似,但症状较轻,持续时间只为十多天,未经治疗自行缓解,社会功能未受损害。

(3)此次发作较急,临床表现以躁狂综合征更为明显而且较以前严重:有情感高涨症状,表现为思维奔逸,患者说话滔滔不绝,可以连续说1~2个小时,还不让别人打断。说话的内容明显夸大,如称自己和同学们都将成为国家领导人。自我感觉良好,自我评价过高。还有随境转移,在上课时不注意听课,不断打扰同学,并和他们说话。行为鲁莽不计后果,不考虑是否需要及是否能够支付得起而乱买东西。

西,还伴有易激惹的症状,常因故与同学争吵。精力明显充沛,睡眠需求减少。

(4)患者病前性格外向,具有患情感性精神障碍的倾向性,但是只作为参考,诊断依据仍是以临床表现为准。

(5)在住院期间出现较为短暂的意识障碍,表现为定向力障碍,如患者不认识自己的父亲,有一段时间言语凌乱,不能认清男女厕所,找不到自己床位。经治疗后,意识恢复,但是不能回忆意识障碍期间自己的所作所为,上述表现都符合意识障碍的基本特征。

综上所述,患者有2次躁狂发作,本次发作出现意识障碍,诊断:

30.3 有精神病性症状(谵妄症)的躁狂症[F30.2]

2. 鉴别诊断

(1)脑器质性精神障碍:因为本患者有意识障碍症状,有脑器质性疾病引起精神障碍的可能性,但是,病人躯体感染、颅脑外伤或感染史、体格检查和神经系统检查、实验室检查所见没有该病的证据,经治疗后意识障碍很快恢复,在意识清楚的情况下,除在意识障碍时的经历不能回忆外,未见记忆障碍,智力也正常,因此可以排除脑器质性精神障碍。

(2)另外需要排除躯体疾病所致的精神障碍:但是本病例没有脑器质性疾病或损害的迹象和历史,亦无躯体疾病的依据,躯体检查、神经系统和实验室检查未发现异常。临床表现不具有躯体病的特点。本病例未发现引起躁狂的躯体疾病的迹象。

3. 治疗原则

因有意识障碍,应加强护理并给予支持治疗;针对躁狂症状,应以稳定情绪、控制兴奋为主,可首选电痉挛治疗,能够很快控制兴奋症状和意识障碍。意识障碍被控制后可用抗精神病药合并心境稳定剂治疗。本病例的躁狂由于发作的间隔只有1年左右,因此用药时间应该长一些。

七、病例七

+++++

(一)病历摘要

患者李某,女性,29岁,职高毕业,已婚,北京某商场售货员。

主诉:13年来间歇性出现沮丧、自卑,丧失兴趣,伴有被害感,1个月前复现。于2000年10月30日入院。

现病史:患者于1987年失恋后变得沉默寡言,总觉得心里不痛快,没有高兴的事。并且认为自己一切都不如人,觉得自己:“不如别人才让男朋友甩了”;悲观、绝望,认为自己“没希望了”。不久后吞服碘酒、红汞企图自杀,被及时发现送往附近医院,经抢救后脱险。

脱险出院后沮丧情绪无好转,整天闷闷不乐,食欲差,常失眠,主要为人睡困难。当时尚能勉强坚持上学,但上课时注意力不能集中,觉得脑子里有人和她说话,有的内容和自己想的事有关,就怀疑自己心里想的事情别人都知道了。家人送患者到我院门诊就医,门诊诊断为“精神分裂症偏执型”,即予以三氟拉嗪治疗(最高剂量20 mg/d),1个月后“说话声音”和“疑心”消失。患者能坚持服药,但是仍较悲观、失望,对什么事都不感兴趣,记性差,失眠,遂休学。在休学后约4~5个月情绪逐渐好转。半年后,自认为病已经痊愈而自行停药。于次年复学后顺利考入职业高中,而且学习成绩良好,多次被评为三好学生。毕业后分配到现单位工作,表现好。1994年结婚,夫妻感情好,并生育一女,能料理家务及照顾孩子。

2000年9月底无明显诱因疾病再次出现,主要表现为沮丧,觉得活着没意思;常说心烦,为小事和别人争吵;干什么事情都无精打采,经常对别人说:“活着没意思”。上班时注意力不集中,常发呆,有时算错账。同时有食欲下降、入睡困难。在上述症状出现后一两周开始出现疑心,怀疑别人对她不好,认为有人跟踪她,还要整死她。经常出现紧张、害怕的表情,常不敢出家门。在家人陪同下于2000年10月底送患者住院治疗,门诊以“精神分裂症”收入院。

既往史:体健,否认重大躯体病、手术、外伤及药物过敏史。

个人史:同胞2人,本人行大。幼时发育良好,适龄入学,顺利读至初三,因“精神不好”休学1年。复学后考入职业高中,曾任班干部,学习成绩好,多次被评为三好学生。毕业后分配到某商场当售货员,工作认真负责。病前性格:较内向,固执任性,脾气急躁。月经史:初潮年龄11岁,4~5/28~30,末次月经2000年9月25日,无痛经和经前期紧张综合征。

婚育史:1994年经人介绍与男友相识并于同年结婚,婚后夫妻感情好,生育一女,体健。

家族史:据说患者外祖母因患“精神分裂症”,后自杀身亡。否认家族中其他成员有重大精神神经疾病及遗传病史。

体格检查:

未见异常。

精神检查:

意识清楚,定向力完整,接触尚可,语速正常,未引出幻觉。患者表情忧愁,经医生询问,患者诉:上中学的时候因为失恋犯过一次病。那时候心情特别不好,特别自卑,觉得自己事事不如人,觉得活着没意思,想死,还自杀过一次。后来脑子变得特别乱,老胡思乱想。觉得男朋友在脑子里和自己说话,觉得自己的想法别人都知道,但说不清为什么会这么想。吃了1个月的药这些想法就没了,可心里仍不痛快,干什么事都觉得没意思,干脆就退学了。记得过了很长一段时间情绪才完全好转过来,接着上学、上班、结婚、生孩子都没受影响。最近1个月又犯病了,心情不好,和上次差不多,而且觉得脑子慢,反应也特别迟钝。这两个礼拜又开始胡思乱想了,心里老是不塌实,觉得好像有人老跟着她、要害死她。觉得真还不如死了算了,活着有什么意思,还拖累家里人。

患者在交谈时,注意力尚能集中,但认为自己的前途没有希望,不如一死了之,在住院期间尚无明显自杀企图及行为。患者不认为自己有病。

在谈话过程中,伴随动作如常人,患者认为前途渺茫,有自杀的愿望,但是不太强烈。

治疗经过:

住院后给予阿米替林(最高剂量150 mg/d)和奋乃静(最高剂量14 mg/d)合并治疗1个月后,上述症状消失,但逐渐出现兴奋、话多的表现。自觉心情非常好,脑子也比平时快;在病房里主动和别人打招呼,非常热情。把自己家属送来的食品送给其他病人吃。反复表示要给医务人员写表扬信,总是闲不住,爱管闲事;说起话来滔滔不绝,当有人想说话时总对别人说:“你们都听我说,别插话!”将阿米替林改为丙戊酸钠(最高剂量1200 mg/d)和氟哌啶醇(最高剂量20 mg/d),治疗6周后痊愈出院。

入院诊断为:

复发性抑郁,目前为有精神病性症状的抑郁。

(二) 病例分析

1. 诊断和诊断依据

(1)患者女性,16岁起病,间歇病程,缓解期社会功能恢复良好,能正常地工作、生活。

(2)抑郁综合征:首次发病就有抑郁综合征,表现为自责和自卑,如认为自己由于无能而失恋,认为一切都不如别人,以及自杀观念和行为。

(3)精神病性症状和情感症状之间的关系:精神病性症状,包括假性幻听,患者

可以不经过听觉器官而听到说话声,可能有内心被揭露感,患者怀疑别人能知道自己内心所想的事,还有过被害妄想,在病史中曾有无根据地怀疑别人对她不好,认为有人跟踪她目的是想整死她。经抗精神病药治疗后,精神病性症状很快消失。但是,抑郁症状仍然存在,可见抑郁是病人所患疾病过程中的主导症状,而且精神病性症状出现较晚,消失较早。

(4)疾病演变过程:在缓解期间,社会功能恢复良好,能承担一定的社会角色和家庭角色。此次发作无明显诱因,临床症状与上次发作相似,治疗过程中出现了明显的躁狂综合征的临床表现。

(5)在治疗过程中出现躁狂症状,在用抗抑郁药治疗过程中出现躁狂症状,各家有不同观点。有的学者认为抗抑郁药有引起躁狂症状的可能性,因此不将首发的抑郁症改为双相情感性精神障碍。但是,有不少学者认为用抗抑郁药后出现躁狂症状只是诱发因素,因此,他们认为在用抗抑郁药后所出现的躁狂症状应视为一次躁狂发作,因为有相当多的这类病人在不用抗抑郁药的情况下,也出现躁狂发作,故应将这类病例诊断为双相情感性精神障碍。笔者认同后者的见解。根据上述特点,考虑入院诊断为:

32.43 复发性抑郁,目前为有精神病性症状的抑郁[F33.3]

出院诊断:

31 双相障碍[F31]

2. 鉴别诊断

(1)精神分裂症:该病的突出表现是思维障碍和精神活动的不协调,常常伴有社会功能的损害。病程常为持续性,发病过程中始终以精神病性症状为主,虽然也可出现情感方面的障碍,但情感症状大多继发于精神病性症状,持续时间相对短暂,更常见的表现为情感倒错和情感淡漠。本病例不具备这些特点,故可除外。患者的精神病性症状出现在患病期的中间,在精神病性症状出现以前和消失以后都存在抑郁症状,可见抑郁情绪是本病例的主导症状,故不符合精神分裂症的基本特征。

(2)情感性精神障碍,复发性抑郁:住院时以伴有精神病性症状的抑郁状态为主,因为在入院前没有躁狂发作史,应诊断为:复发性抑郁,目前为有精神病性症状的抑郁。但是,在住院期间出现躁狂症,应考虑双相障碍。有的学者认为在用抗抑郁药期间出现躁狂应认为是药物性的。也有人认为用抗抑郁药出现躁狂只是诱发因素,应视为一次躁狂发作。另外,停用抗抑郁药,改用情感稳定药合并抗精神病药后精神症状消失,故应在出院后将诊断改为双相障碍。

3. 治疗原则

- (1)电痉挛治疗。
- (2)心境稳定剂。
- (3)抗精神病药物治疗精神病性症状和躁狂症状。
- (4)抑郁发作时加用抗抑郁剂,但治疗过程中需注意预防转相。
- (5)在出院后应长期用情感稳定药治疗,以防复发。

八、病例八

(一)病历摘要

患者吴某,女性,25岁,大学文化,公司职员,未婚。

主诉:3年来高兴、兴奋话多与沮丧、悲观、自责交替出现;悲观失望3个月,不语不动2周。

现病史:患者自1996年2月开始无诱因出现反常行为,上课时注意力不集中而和同学聊天,有时正上着课时突然站起来就往外走,老师质问她为什么中途离开教室,她却说:“心烦,我想听就听,不想听就不听。”一个月后,家人发现她变得特别爱说话,好吹嘘,自称:“我想干什么就能干成什么。”乱花钱,无计划买书及高档服装,说是“要追赶世界潮流”。情绪不稳定,急躁,常为小事和家人发脾气。

1996年4月,开始出现沮丧,整天闷闷不乐,尤其在上午特别明显。表现为自责,觉得自己对不起父母,认为自己能力比别人差。自称学什么都特别慢。对家人说“活着没意思”,不如死了好,同时表情忧愁或饮泣。食欲差,饭量明显减少。睡眠少,每天比平时要早醒3、4个小时。不愿出门,也不愿意见人。6月中旬患者情绪突然好转,觉得自己“精神头儿特大”,经常逛商店买衣服。6月底再次出现情绪低落,悲观、绝望,对父母说“我本来就不该来到这个世界上,人活着太累了,你们和我一起死吧。”家属为防止意外,送患者住院治疗。住院诊断:“情感性精神障碍,双相型,目前为抑郁相。”经电痉挛治疗(6次),阿米替林(最高175 mg/d)、麦普替林(最高150 mg/d)治疗3个月,痊愈出院。出院后坚持服药,病情稳定,学习、生活恢复如常。

1997年8月初因考试成绩不理想病情复发,又出现沮丧、紧张、害怕,认为自己能力不行,要求退学。8月11日第2次住院,诊断同前,经麦普替林治疗(最高150 mg/d)1个月痊愈出院。10月病情再次波动,表现同前,3周后开始出现兴奋、

此后用帕罗西汀(20 mg/d)治疗,但病情不稳定,严重时情绪忽高忽低;高兴时在病房里滔滔不绝地讲演,吹嘘自己英语学得好,有时用英语和别人说话,还大声朗诵她用英语写的“诗词”。有时又突然含着眼泪对医生说:“我心情不好,活着没意思,想跳楼摔死……可我脑子现在转得特快,能想到很多事,觉得有很多事情要做……我也说不清心情到底怎么样,一会儿高兴一会儿不高兴,控制不了。”后改用碳酸锂(500 mg/d)和甲硫哒嗪(200 mg/d)治疗 3 周后,情绪逐渐稳定。

(二) 病例分析

1. 诊断和诊断依据

(1)患者女性,22 岁起病,起病无明显诱因,间歇性病程,缓解期社会功能恢复良好,能完成大学学业,成绩优良。

(2)躁狂和抑郁交替发作:在整个病史中,精神症状以情感障碍为主,反复发作,发作具有躁狂和抑郁双相的特点。躁狂发作时,情绪高涨,语量增多,如在众人面前朗诵英文,自我评价过高如自诩英语水平很高。活动增多,好管闲事,表现为平白无故要帮助人。易激惹,因一点小事就争吵。

抑郁发作时,情绪低落,思考困难,患者自称自己的脑子不好使、反应慢,学习效率下降。兴趣丧失,自我评价低,自责,饮食、睡眠差。

(3)抑郁性木僵:第 4 次住院前后出现,卧床,目光呆滞,眼球运动少,常呆呆地望着天花板,周围发生的事情不能引起患者的注意,自主活动少,不语不动,对问话不答,卧床姿势也很少变化,肌张力正常;拒食、水,尿潴留。

(4)混合的状态:经治疗后出现了躁狂和抑郁混和状态,患者表现为心情不好,想跳楼摔死,这是明显的情绪低落症状;但同时具有躁狂症状,表现为感到脑子转得特快,还想做许多事,可持续 3 周左右。故患者第 4 次住院可诊断为情感性精神障碍。

根据 CCMD-3 的诊断标准,符合目前发作躁狂和抑郁症状混合为主的特点,同时有长于 2 周的躁狂和抑郁症状。诊断:

31.7 双相障碍,目前为混合性发作[F31.6]

2. 鉴别诊断

(1)情感性精神障碍双相型,目前为快速循环发作:混合状态和快速循环发作均为情感性精神障碍双相型的特殊诊断类型,两者没有本质上的区别。但根据 CCMD-3 诊断标准,快速循环发作的诊断要求患者在过去的 12 个月中至少有 4 次情感障碍发作,而本患者并不具备此特点,故可除外该诊断,但并不排除在以后的

发作中有可能出现快速循环发作的特点。

(2)精神分裂症:患者在住院前后出现明显的木僵状态,木僵常见于精神分裂症,但是此病例的病史以情感障碍为主,在木僵状态消失以后情感障碍更为突出,可以排除精神分裂症。

(3)其他疾患所致的木僵状态:没有病史及症状支持,可以不考虑。

3. 治疗原则

(1)电痉挛治疗用于治疗木僵状态非常有效。

(2)在木僵状态消失后可用抗精神病药和(或)心境稳定剂。

(3)对预防复发应给予足够重视,因为该病例3年来反复发作4次而住院,需给予心理社会干预,教会患者及其家属早期认识复发预兆、及早求治的技能。

(谢家康)

隐私,渴求获得赏识和赞誉,以及因为内心冲突和斗争而引起恐惧和罪恶感。潜意识的性欲矛盾可能在起病上有一定作用。偏执性精神障碍病人会带着一种强烈的期待性的情感,使他集中注意去寻找在事物之间事实上并不存在的联系,有时还会通过合理化心理机制把他的想法编成广泛的妄想系统。

以往人们习惯于把偏执性精神障碍分为偏执狂和偏执状态,而 CCMD-3 中偏执狂与偏执状态已合并为一个诊断,与 ICD-10 和 DSM-4 诊断标准一致。本病以系统而固定的妄想为主要症状,妄想内容有一定的现实性而并不荒谬,以被害内容为主,不经了解,难辨真伪。另外还有嫉妒、夸大、疑病或钟情等妄想,病程至少持续 3 个月。还需排除器质性精神障碍,应注意排除精神活性物质和非成瘾性物质所致的精神障碍、精神分裂症和情感性精神障碍。

二、分裂情感性精神病

+++++

指的是一组分裂症状和情感症状同时存在又同样突出的,常有反复发作的精神病。分裂症状为妄想、幻觉及思维障碍等阳性精神病性症状,情感性症状为躁狂发作或抑郁发作症状。首次被诊断为分裂情感性精神障碍病例,在多次发作以后可能发展为典型的精神分裂症、情感性精神障碍,或维持原诊断。

三、急性短暂性精神病

+++++

指一组起病急骤、以精神病性症状为主的短暂精神障碍,多数病人能缓解或基本缓解。临床症状主要表现为片断妄想或多种妄想,片断幻觉或多种幻觉,言语紊乱,行为紊乱或紧张症。在患病期间患者的社会功能明显受损,并且对个人或别人的安全有一定危害。病程特点为起病急骤,每次发作持续时间可为数小时到 1 个月,经治疗后很快能够缓解,缓解期间精神状况如病前,有的病例只发作 1 次,有的病例有反复发作的特点,但是多次发作并不产生精神功能的缺损。

四、感应性精神病

+++++

以系统妄想为突出症状的精神障碍,往往发生于同一环境或家庭中两个关系极为密切的亲属或挚友中(如母女、姐妹、夫妻、师生等),其妄想内容相似。

现突出提升为销售组长。后调到现单位工作,工作能力强,表现突出,为单位创造利润较多。病前性格:敏感多疑、固执、任性、自信。不太关心别人,希望别人处处都顺着他、听他的。婚育史:1980年经人介绍与现妻子相识并结婚,婚后夫妻感情一般。有一子,体健。

家族史:两系三代家庭成员中无精神神经系统疾病和严重遗传病。无类似精神病史及性格古怪者。

体格检查:

未见异常。

精神检查:

患者意识清楚,定向力完整,接触良好,言谈切题,可以引出思维内容障碍:反复询问患者为什么怀疑妻子,患者坚持说:“没什么可解释的,从一结婚我就知道了。”患者未能指出其妻子有任何不轨行为的证据,但坚信其妻子与她的前恋人至今有不轨行为。他的惟一把柄是其妻子有过恋爱史,未引出其他精神病性症状。在病房内可以和其他病人交往,待人接物正常。住院期间多次对患者进行详细的精神检查,均未发现其他症状,患者也未对其妄想内容做出更详细的解释。无自知力,否认有病,拒绝服药,经常要求出院,但劝说后能勉强继续住院。

治疗经过:

入院后经氟哌啶醇治疗3个月,病情无好转,家属接患者出院。患者出院后,妄想内容如故,经随访1年,仍有嫉妒妄想,如果无人提起妄想内容患者也不提,患者主要怕家人或同事说自己有病。

(二) 案例分析

1. 诊断和诊断依据

(1)患者男性,38岁,首次发病,慢性起病,起病有一定的现实基础(妻子在结婚前结交过其他男友),进行性加重,病程已达14年,期间无明显的缓解期。

(2)病前即敏感多疑,固执任性,且以自我为中心。临床表现为嫉妒妄想,病人毫无根据坚信自己的妻子不贞,而且不能用事实纠正自己错误的观念,可见患者具有嫉妒妄想。起病后患病十余年,也未经系统抗精神病药治疗,但是无明显的人格改变和社会功能损害,除妄想外,其他方面均表现正常。

(3)近2周出现对妻子的暴力攻击行为,并在愤怒情况下扬言要杀她,这是受妄想内容支配的继发行为及情绪障碍。诊断:

21 偏执性精神障碍[F22 妄想性精神障碍]

2. 鉴别诊断

精神分裂症:精神分裂症患者也可出现嫉妒妄想,但常伴有其他的精神病性症状,且精神分裂症患者随病程的延长往往出现社会功能的损害,情感缺损及意志贫乏。该患者临床表现单一,症状无变化,病程持续 14 年,没有出现明显的人格改变和社会功能损害,故可除外。

3. 治疗原则

抗精神病药物治疗。但偏执性精神障碍患者起病前常有偏执性人格特点,起病多有一定现实性的诱因,在人格障碍的基础上发展为偏执性精神障碍,因此,这类患者对药物不敏感。目前尚无有效的治疗方法,如果患者由于各种心理困扰有心理治疗要求者,心理治疗可能对行为障碍有一定疗效,但不能动摇其妄想内容。

二、病例二

(一) 病历摘要

患者曲某,女性,23 岁,大学毕业,未婚,无业。

主诉:沮丧、发愁、自责、失眠伴疑心、凭空听见说话声 2 个月,加重 5 天。

现病史:患者于 2001 年 4 月因大学毕业分配不顺利开始出现少语发愁,整天无精打采,闷闷不乐,老说:“头疼,浑身不舒服……心情不好,没意思。”上课时注意力不集中,学习成绩逐渐下降;对家人说她觉得自己“脑子越来越慢,记性也不如以前了”;自责,觉得自己:“太笨,无能,智力比别人差”。有时候隐隐约约听见父亲喊她的名字、在耳边和她说话;怀疑自己不用说出来别人就知道她的想法。进食少,体重明显下降;失眠,入睡困难。自同年 6 月开始,患者以“浑身不舒服”为由,整天卧床,不下地活动,拒食,家人和她说话她也不回答。6 月 5 日家人送患者到我院门诊就医,门诊诊断“抑郁症,缄默状态”,并在家属要求下给患者注射 10 mg 地西洋。患者却认为护士给她打的是“毒药、毒水”,说她的父母都是“披着人皮的狼”。家属当即送患者入院。

既往史:既往体健,否认重大躯体病史,无手术、外伤及药物过敏史。

个人史:独生女,母孕期体健,足月顺产。幼时生长发育良好,适龄入学,学习成绩好,顺利读至高中毕业。1997 年考入某大学法律系,学习成绩良好。现已毕业,正在联系工作。外向性格,为人随和,开朗,与人相处关系融洽。月经史:初潮年龄 13 岁,3~4/30,末次月经 2001 年 5 月 28 日。有痛经史。

后一组症状包括:片段的幻听及思维障碍。

①内心被揭露感:患者觉得自己想的事不说出来别人能够知道。

②破裂性思维:病人有一段谈话中句子和句子之间没有逻辑性联系,如:“‘海尔创新’是破坏性创新的意思,我现在一半是人一半是妖……把我劈开就好了,我不怕死,我死了爸爸妈妈就幸福了……这是个鬼的世界,我想做人,不想做鬼。”

可见患者有明显的思维逻辑障碍和大量离奇的思维内容。

③有人格统一性的破坏,如病人自称:“我现在一半是人一半是妖……把我劈开就好了,我不怕死”。

④无自知力。

从以上症状看来精神病性症状和抑郁症状几乎同时出现,表现均很典型,并且贯穿于整个病程。经抗抑郁药和抗精神病药物治疗后几乎同时缓解。根据上述特点,可诊断为:

24.2 分裂情感性精神病,抑郁型[F25.1 分裂情感性精神病,抑郁型]

2. 鉴别诊断

抑郁症伴有精神病性症状:该诊断是情感性精神障碍的一个特殊类型,临床表现以抑郁症状为主导,相对而言,精神病性症状出现较晚,在临床表现中不占有主导地位,多继发于抑郁症状且消散较早。而该患者两组症状同时出现,表现均很突出,并且贯穿于整个病程,治疗后几乎同时缓解,故可加以鉴别。值得注意的是,分裂情感性精神病只是一个临时性的诊断,该患者为首次起病,因此应密切随访,仔细观察预后和社会功能的恢复情况,一旦病情出现变化应对其临床症状进行认真的分析,并结合此次发作的情况做出明确的诊断。

3. 治疗原则

对症治疗,抗抑郁药和抗精神病药并用。在住院期间和出院后应给予家庭教育,使其家庭成员了解此病的性质及预防复发的知识。

4. 预后估计

分裂情感性精神病的预后较好,精神缺损的可能性较少,但是复发的可能性还是存在的。经过随访观察,有一部分患者发展为精神分裂症则预后较差。

三、病例三

(一) 病历摘要

患者秦某, 男性, 63岁, 工程师, 再婚, 汉族, 大学本科。入院日期 2000 年 1 月 11 日。由患者妻子报告病史, 详细可靠。

主诉: 32 年间歇性精神失常, 表现为凭空听见有人说话、被害感, 近 2 日来日夜不眠、兴奋话多、有冲动行为。

现病史: 患者于 1968 年(时年 32 岁), 正值“文化大革命”期间, 因遭迫害而失眠。后听到广播电台的播音内容和自己有关, 感到全国的人都知道自己的事情, 认为路过的解放军要抓自己。当时尚能劳动, 生活能够自理, 未见言语增多和冲动行为。曾在精神科门诊治疗, 服用奋乃静, 病人的睡眠情况逐渐改善。约 10 日后, 上述精神症状消失并能料理家务及上班工作。之后即停止用药, 精神状况如常人, 直至 1995 年。

患者于 1995 年 9 月, 经人介绍与其妻同练“沈昌功”, 当时未见精神异常。在 1996 年 2 月间, 自称“得了功”“功力大”, 凭空能听到有人说话的声音, 内容为: “你快逃跑, 你快离开北京。”患者即要求独自去南京及全国各地, 其妻不同意就用手抓她的脸。患者认为家中的物品有毒, 声称有人用毒药害自己。此时, 患者出现毁物行为, 无故将家中用品砸毁, 用新村衣来堵下水道。曾被诊断为“气功所致精神病”, 服用奋乃静 1 周后, 精神症状消失, 在家人劝说下服药约 1 个月即停药。不久, 上班工作如常人, 直至 1999 年, 并自行停止练气功。

1999 年 2 月间, 患者时年 62 岁, 同妻子一起参加“法轮功”修炼。该功法于同年 7 月被取缔, 患者想练又不敢练, 内心感到很矛盾, 而间断练功。直至 1999 年底才停止练功。此次发病前约 4~5 日患者出现失眠, 自称骂了沈昌(一气功师名), 认为沈某要找自己算账。同时认为自己功力强大, 可以通天, 入院前 1 天凌晨 1 时起床外出, 被其妻阻止, 即动手打其妻子, 但是很快就向妻子道歉。由于病人打人毁物被送入医院治疗。

既往史: 十余年前曾因心前区痛被诊断为“心肌供血不全”, 间断服用心痛定。否认酗酒、吸毒、中毒、颅脑外伤及过敏史, 否认抽搐史。

个人史: 同胞 3 人, 患者行大, 母孕期情况及幼年发育情况皆不详, 未闻幼年期间有被溺爱史。患者于 1953 年就读于农业中学, 1956 年考入某水利学院水利系,

从1961年毕业后在水利部工作,任技术员,与同事们相处关系融洽,工作努力,成绩突出,多次被评为先进工作者,在工作期间发表多篇论文,并获奖。1966年下放回乡务农,至1979年一直在一所中学任教师,能胜任工作,同事关系好。1979年恢复干部身份,在某化学工业公司工作,任工程师,工作期间多次发表论文,并获奖。1993年申请退休,获准后返京受聘于某公司任职,因为不满于工资太低而多次改变工作单位,本次患病前就职于某合资公司任职,同时在其他单位兼职。

患者于1963年与现妻相识,婚后夫妇关系良好,现有两个儿子,家庭经济状况中等。患者病前好交往,倔强,好强,乐于助人。

家族史:否认父母两系三代有精神病史者。家族无癫痫患者、精神发育迟滞者、酗酒者及自杀者。

体格检查:

体位自如,心、肺、腹物理检查未见异常,四肢活动自如,未见畸形。

实验室检查:

未见异常。

精神检查:

被动进入病房,步态平稳,对更衣合作。无主动言语,对医生的问话只能简单回答,而且在回答时双目闭合,有时称疲乏想睡觉。在更衣后,拒绝体格检查,对精神检查合作较差,有时对问话不回答,或回答简单,有时在回答后又予以否认,如问:“你有什么不舒服?”回答:“睡不着觉。我能睡得着!”否认有幻觉。当问到有关练气功的经过时,患者不回答或否认自己曾练过气功,过一会儿又承认自己练过气功。在与人接触时表情茫然。有时无目的向外冲,拒绝交谈。经注射氟哌啶醇后不久即入睡。

次日醒来,意识清晰,接触良好,对入院时的情况不能确切回忆。对精神检查合作,对人物、地点、时间定向正确,能自理生活,自行如厕。接触良好,思维条理清晰,能较清晰地回忆历次精神失常的情景,并认为1968年感到有人要抓自己的想法是因为有病闹的。能回忆1995年曾练过气功,凭空听到过气功师要抓捕自己的说话声。患者对1999年练“法轮功”之事深感后悔,并能回忆当时矛盾的心情。患者对入院前一天凌晨突然往外跑之经过不能回忆。在交谈时表情自然,动作适中,自知力良好,患者希望出院,并对因病中断工作面带焦急表情,恳请早日出院,继续去做没有完成的工作。

治疗经过:

入院第一天予以氟哌啶醇5mg肌肉注射治疗,次日精神症状消失。此后每日

口服氟哌啶醇 6 mg,共 18 天。以痊愈疗效出院。

随访:

出院后随访 3 个月。患者出院后 1 个月,又被某公司聘用负责较为困难的技术工作,能完成所交给的任务。在 3 个月后电话随访中,言谈状况如常人。

(二) 病例分析

1. 诊断与诊断依据

(1)患者男性,32 岁时受“文革”冲击后急性起病,为间歇性病程。

(2)患者共有 3 次精神病性发作,第一次在“文革”中受精神压力后急性发病,于受冲击后先出现失眠,2 天后出现精神病性症状。按 ICD-10 的标准,在 14 天内从正常精神状态发展为精神病性状态为急性发作。第 2 次发作与练气功有关,1999 年参加“法轮功”修炼,但是该功法于同年 7 月被取缔,患者想练又不敢练,内心感到很矛盾。其中包括患者对气功的心理需求,但是误入“法轮功”歧途而产生心理压力。可见患者每次精神病性发作,都可以发现有心理社会因素对患者的影响。

(3)主要精神症状有:

①命令性幻听:凭空能听到有人说话的声音,内容为:“你快逃跑,你快离开北京。”患者受幻听支配要去南京等地。

②关系妄想:听到广播电台的播音内容和自己有关,继而感到全国的人都知道自己的事情。

③被害妄想:患者认为家中的物品有毒,声称有人用毒药害自己。

④夸大妄想:在练气功后,认为自己功力强大,相信自己可以通天,这可能是受气功暗示继发的思维障碍,患者当时并不伴有情感高涨。

⑤行为障碍:患者出现毁物行为,无故将家中用品砸毁,用新衬衣来堵下水道。患者在精神症状消失后,对行为异常能回忆,但是不能解释其原因。

⑥意识障碍:患者在入院后接触被动,反应迟钝,次日精神状态正常的情况下,不能清晰回忆入院后与医生交谈的情景,可能患者当时处于意识朦胧状态。

(4)诊断分析:根据以上所见,病人的精神障碍系急性发作,其发作都与心理社会因素有关。并呈间歇性病程,间歇期间社交功能和智力是良好的,表现为在间歇期间不但能完成工作任务,而且能多次找到新的工作岗位,同时工作出色。精神症状具有精神分裂症的特征,精神症状持续时间只有数日,没有一次超过 14 天的。最后一次精神症状只持续 1 周左右。

按 CCMD-3 诊断标准:急性短暂性精神病指一组起病急骤、以精神病性症状为主的短暂精神障碍,多数病人能缓解或基本缓解。诊断:

22.9 其他或待分类的急性短暂性精神病[F23.8 其他;F23.9 待分类的急性短暂精神病性障碍]

附:其他或待分类的急性短暂性精神病的诊断标准

1)症状标准:精神病性症状,至少需符合下列 1 项:

①片断妄想,或多种妄想。

②片断幻觉,或多种幻觉。

③言语紊乱。

④行为紊乱或紧张症。

2)严重标准:日常生活、社会功能严重受损或给别人造成危险或不良后果。

3)病程标准:符合症状标准和严重标准至少已数小时到 1 个月,或另有规定。

可见本患者符合急性短暂性精神病的诊断标准。

2. 鉴别诊断

按 CCMD-3 排除标准,须排除:

(1)器质性精神障碍:患者智力正常,记忆力良好,也没有脑外伤和中枢神经感染史,可排除该诊断。

(2)精神活性物质和非成瘾物质所致精神障碍:该患者没有吸毒和物质滥用史,无物质依赖症状和体征。

(3)精神分裂症:患者虽有精神分裂症样临床表现,但是不符合精神分裂症的病程和严重性标准。

(4)情感性精神障碍:虽然患者有短时间的夸大妄想,但是没有明显的情感高涨症状,可以排除情感性精神障碍。

3. 治疗

氟哌啶醇注射是有效的治疗方法,可以短期口服氟哌啶醇。由于患者每次发病时间不超过 2 周,用药持续 2~3 周即可停止。

4. 预后估计

此诊断可能是多种难以归类、原因不明的精神障碍的总汇,有的病例以精神分裂症性症状为主,诊断为急性短暂性精神病以后,如果症状延续 1 个月或以上,就要改变为精神分裂症诊断;有的病例则以情感性精神障碍的症状为主,如果符合情感性精神障碍的标准,也应修改诊断;因此其预后各有不同。本病例不符合上述情况,目前不必修改诊断,至今已有 3 次发作,症状持续时间都不足 1 个月,并缓解完

全,其中有一次缓解达 27 年。由于本病发作和心理社会因素有关,因此给予心理干预,有利于预防复发,如有复发征兆,应及时用药,也能在数日内缓解。总的来说,本病例的预后良好。

四、病例四

+++++

(一) 病历摘要

患者李某,男性,34 岁,售货员,初中文化。

主诉:5 个月来认为有小鬼在喉内说话,近 1 个月来加重。于 2000 年 5 月由患者父亲陪伴来治疗。

现病史:于 1999 年 10 月间,患者的妻子认为自己说的话是小鬼的声音,其妻子有时用沙哑的声音说话,患者问她:“怎么了?”其妻子说:“这是小鬼说的话。”患者开始并不相信,有时她用正常的声音说话,即认为是她自己说的。并将其妻子的表现告诉自己的父亲等家人,家人认为其妻子可能有病,患者亲自带妻子到医院看病,虽然妻子不承认有病,但能在患者的督促下按时服药。患者的妻子每天重复沙哑和正常的声音说话,并给予同样的解释。患者逐渐怀疑妻子认为有小鬼说话是不是真的,他的妻子很认真的说:“这是真的!”患者也开始和妻子同样相信有小鬼在说话。有一次患者陪同其妻子来医院就诊,其妻子用沙哑声音回答医生的问题,回答内容切题,如医生问其妻:“现在还有小鬼替你说话吗?”,妻用沙哑声答:“有!”问:“刚才是谁说的?”答:“小鬼。”问:“你害怕吗?”答(正常声):“不怕!”问:“这话是谁说的?”答:“我说的。”患者认为其妻所言是真的,而且态度很认真。由于其妻患病后不能上班,患者有时陪伴,有时上班。

在本次就诊前 1 个月,患者夫妇一唱一和,有时两个人同时用沙哑声音对话,内容多为家务事。近 1 个月来整日陪伴妻子,不去上班。有时患者和妻子又说又舞,患者有时用手掐着妻子的脖子,两个人就能用正常的声音对话。由于两个人同时患病,无法过正常生活,患者由其父亲陪伴来就诊。

个人史:母孕期正常,足月顺产,发育正常,脾气温和,很听家长的话。从小不爱说话,也就不大合群,成年以后朋友也很少。学习努力,但是成绩常处于中下等,顺利初中毕业。于 25 岁经自由恋爱与现妻结婚。与妻子的感情非常好,其妻子有主见,自结婚后夫妇两人形影不离。现尚无子女。其妻子因出现被小鬼控制的症状,于 1999 年 11 月间,由患者伴同求治,诊断为“精神分裂症”。

既往史:一向体健,从小未患过重病。

家族史:父母两系三代成员中无精神病患者。

体格检查:

体位自如,营养中等,发育良好。心脏浊音界正常,两肺叩诊为清音。在心脏各瓣膜区未听到病理性杂音。腹部平坦,柔软,无压痛,未触及肝脾。四肢张力正常,未发现肌震颤,未见病理反射。

精神检查:

意识清楚,时间、地点、人物定向良好。接触好,交谈无困难,言语流畅,句子结构正常。患者可以听见有小鬼在自己的喉咙里说话,它的声音不能判断男女。患者确信有小鬼控制自己说话,认为现在和医生谈话是自己的声音,有时小鬼就能使自己的声音嘶哑。医生请他学一学,患者用哑声说:“小鬼快走!”患者自称不怕小鬼,但是讨厌它。患者能明确描述小鬼控制其妻子的情况,刚开始自己也不相信有小鬼控制她,患者说:“在去年(1999年)10月我爱人说有小鬼控制她说话,我不太相信,我看她挺难受的,她也讨厌被小鬼控制,我就把她带到医院来请您给看看,她希望用药把小鬼轰走,吃了几天也没管事,她就不吃了。”在询问下患者说:“小鬼控制我爱人说话越来越厉害,到1999年年底,我也感到有小鬼在控制自己。”问:“您所说的话是您要说的,还是小鬼说的?”答:“是我说的,但是只有它同意了我才能说。”问:“您的爱人也是这样吗?”答:“是。”

患者对小鬼很反感,希望医生帮忙把小鬼轰走,患者表情为明显无奈,并对目前的处境感到忧愁。患者在谈话中注意力集中,动作适中,希望医生帮助自己和他的妻子把小鬼“轰走”后两人能过上正常的生活。

治疗经过:

患者经用100~200 mg/d氯丙嗪治疗后精神症状逐渐好转,1个月后精神症状消失。

(二) 病例分析

1. 病例特点及诊断

(1)患者,男性,34岁。亚急性起病,患者的起病时间比较明确,可以判断在1999年底或2000年初起病,是在1~2周之间精神症状逐渐明朗化。

(2)患者的精神症状与其妻子的症状内容极为相似,其症状发生的时间是在其妻子出现精神症状之后2个月左右。

(3)真性幻听:患者凭空听到小鬼说话声,虽然病人幻听来自体内,但是已经指

4. 预后估计

感应性精神病一般预后较好,如果感应者患的是反复发作或迁延性的精神病,而且长期住在一起,由于受患者人格特点的影响有可能会复发。为预防复发应给予病人心理治疗,降低再被感应的可能性。

(翁永振)

应激相关障碍

应激相关障碍是指一组主要由心理、社会(环境)因素引起的异常心理反应导致的精神障碍也称反应性精神障碍。决定本组精神障碍的发生、发展、病程及临床表现的因素有:①生活事件和生活处境,如剧烈的超强精神创伤或生活事件或持续困难处境,均可成为直接病因。②社会文化背景。③人格特点、教育程度、智力水平及生活态度和信念等。④不包括癔症、神经症、心理因素所致生理障碍及各种非心因性精神病性障碍。

第一节 应激相关障碍的临床特点

应激相关障碍的临床表现与发病应激源密切相关,并伴有相应的情感体验,容易被人所理解。经过适当治疗,预后良好。病情恢复后,精神状态恢复正常,无人格方面的缺损。多急性或亚急性起病。

一、急性应激障碍

急性应激障碍,以急剧而严重的精神打击作为直接原因。在受刺激后立刻(1小时之内)发病,历时时间短,应激源消除后几天至1周内恢复,完全缓解。引起急

自我感觉和体验。气功所致精神障碍系指由于气功操练不当(如每日练习过多),处于气功态时间过长而不能收功的现象,表现为思维、情感及行为障碍,并失去自我控制能力,俗称“走火入魔”。

2. 临床表现

气功所致精神障碍的临床表现多种多样,在感知、思维、情感、行为和意识状态等方面都可能发生障碍。我国多数学者根据其临床表现主要分为3种综合征,即类神经症综合征、类癔症综合征和精神分裂样精神障碍。

值得注意的是,气功所致精神障碍为我国文化背景下产生的一种特殊疾病表现形式,其精神症状并无特异性。不同的人、不同的教育水平、不同的生活背景及性格特征以及疾病不同发展阶段等,其表现形式亦不相同。另外,有关“气功”及“气功所致精神障碍”的问题至今尚未取得一致的意见。所以在诊断“气功所致精神障碍”时必须慎重。

(二) 巫术所致精神障碍

患者具有明显的心理社会因素,其本人及家属多是迷信或宗教信仰很强的人。绝大多数患者有癔病发作史和突出的癔病性性格特征。发病多由神灵信念直接诱发。癔病性附体状态是该病的一个显著特点,附体物以鬼、神为最多,精灵较少。所有症状多突然产生和突然中止,持续时间短暂,症状的产生及其内容都有心因性疾病的特征。最主要症状是记忆障碍,主要表现是遗忘,可见对患者现实身份的短暂遗忘,代替以一个新的,即鬼或神等的非现实性身份。还可见到对周围人的双重定向。此外,还有情绪不稳、暴怒、恐惧性激情发作,哭笑无常,明显暗示性增高等某些癔病性症状。

第二节 应激相关障碍的诊断标准

国内按 CCMD-3 应激相关障碍进行诊断。

一、急性应激障碍

+++++

(一) 症状标准

以异乎寻常的和严重的精神刺激为原因,并至少有下列2项中的1项:

- (1)有强烈恐惧体验的精神运动性兴奋,行为有一定盲目性。
- (2)有情感迟钝的精神运动性抑制(如反应性木僵),可有轻度意识模糊。

(二)严重标准

社会功能严重受损。

(三)病程标准

在受刺激后若干分钟至若干小时发病,病程短暂,一般持续数小时至1周,通常在1个月内缓解。

(四)排除标准

排除癔病、器质性精神障碍、非成瘾物质所致精神障碍及抑郁症。

二、急性应激性精神病(急性反应性精神病)

(一)症状标准

- (1)病前遭受强烈精神刺激。
- (2)以妄想或严重情感障碍为主,症状内容与精神刺激因素明显相关,而与个体素质因素关系较小。

(二)严重标准

社会功能和自知力严重受损。

(三)病程标准

病程短暂,仅个别病例超过1个月。消除病因或改换环境(如解除拘禁)后症状迅速缓解。

(四)排除标准

排除癔病性精神病,以及其他非心因性精神病。

三、创伤后应激障碍

(一) 症状标准

(1) 遭受对个人来说异乎寻常的创伤性事件或处境(如天灾人祸)。

(2) 反复重现创伤性体验(病理性重现),并至少有下列 4 项中的 1 项:①不由自主地回想受打击的经历;②反复出现有创伤性内容的恶梦;③反复发生错觉、幻觉;④反复发生触景生情的精神痛苦,如目睹死者遗物、旧地重游,或周年日等情况下会感到异常痛苦和产生明显的生理反应,如心悸、出汗、面色苍白等。

(3) 持续的警觉性增高,至少有下列 4 项中的 1 项:①入睡困难或睡眠不深;②易激惹;③集中注意困难;④过分地担惊受怕。

(4) 对与刺激相似或有关的情境的回避,至少有下列 6 项中的 2 项:①极力不想有关创伤性经历的人与事;②避免参与能引起痛苦回忆的活动,或避免到会引起痛苦回忆的地方;③不愿与人交往,对亲人变得冷淡;④兴趣爱好范围变窄,但对与创伤经历无关的某些活动仍有兴趣;⑤选择性遗忘;⑥对未来失去希望和信心。

(二) 严重标准

社会功能受损。

(三) 病程标准

精神障碍延迟发生(即在遭受创伤后数日至数月后,罕见延迟半年以上才发生),符合症状标准至少已 3 个月。

(四) 排除标准

排除情感性精神障碍、其他应激障碍、神经症、躯体形式障碍等。

四、气功所致精神障碍的诊断标准

(一) 症状标准

(1) 由气功直接引起。

(2)症状与气功书刊或气功师所说的内容密切相关,通常只在做气功时出现,并在结束练功时迅即消失,而病人却持续出现或反复出现,无法自控。

(3)至少有下列3项中的1项:①精神病性症状,如幻听、妄想等;②癔病样综合征;③神经症样综合征。

(二)严重标准

社会功能受损。

(三)病程标准

病程短暂,经脱离现场,中断练功,给予适当处理后很快恢复。

(四)排除标准

(1)排除以类似表现作为治病手段,及获取财物或达到其他目的,或可随意自我诱发或自我终止者。

(2)排除其他精神障碍,尤其是癔症或严重应激障碍。

五、巫术所致精神障碍

诊断标准

(1)精神障碍由巫术诱发。

(2)症状与迷信、巫术密切相关,以神鬼附体的身份障碍,片断的幻觉、错觉、妄想,或行为紊乱等为主。

(3)排除:①以巫术作为获取财物或达到其他目的者;②可随意自我诱发或自我终止者;③其他精神障碍。

第三节 典型案例分析

一、病例一

(一) 病历摘要

患者杨某,男性,45岁,工人,初中文化,已婚。

主诉:因妻子有外遇而失眠、情绪不稳、呆愣3个月,阵阵紧张害怕。

现病史:患者于2001年春节前夕发现妻子有外遇后常失眠,呆愣,发脾气,不爱讲话。别人与其打招呼,患者也没反应。一日夜里2点多钟突然跑到一同事家敲门,同事开门后患者一句话也不说扭头就走,第二天对此坚决否认。在上班后患者表现为少语,呈凝思状,因此不能完成工作。以后病情逐渐加重,称无论白天晚上总能看到墙上有鬼影,多为李某(其妻的男友,同时也是患者的领导)的影子,手里拿着刀冲他乐,并说要杀了他。夜里不敢睡觉,总感到李某就站在门外,反复看门外是否有人,紧张,害怕。自语:“我曾经对他(李某)那么好,他为什么这样对待我呢?”一日患者突然到李某的宿舍用刀将李某右手小拇指砍伤。近日来常独自一人发呆发愣,反应慢,目光呆滞,不愿见人,不出门,对家人漠不关心。失眠,多噩梦,生活没规律。于2001年3月中旬住院治疗。

既往史:体健,无明确躯体病史。无药物过敏史。

个人史:同胞5人,行2,自幼生长发育良好。初中毕业后入现单位当建筑工人。1985年经人介绍与现妻结婚,婚后夫妻感情一般,凡事看妻子眼色行事。1995年生育一女,体健。其妻子无业。患者有吸烟史,20支/日,饮酒20余年,每日饮2两白酒。病前性格:为人老实,平素胆小怕事,没有主见,人际关系一般。

家族史:父母两系三代家族成员中无精神分裂症、痴呆、精神发育迟滞、人格障碍患者。

体格检查:

体温36.8℃,脉搏75次/分,呼吸19次/分,血压100/75 mmHg。发育正常,营养良好,周身皮肤无皮疹、黄染和出血,浅表淋巴结未触及。唇红、咽不赤、扁桃体无肿大,气管居中,甲状腺未及。心界不大,心肺听诊无异常,腹软,肝脾未触及,无压痛。四肢运动自如。神经系统检查未见明显阳性体征,未引出病理征。

实验室检查:

未见异常。

精神检查:

意识清楚,定向力完整。入院时衣着欠整洁,头发凌乱。面无表情,目光茫然,反应迟钝,能正确回答自己的姓名、性别、年龄及职业。能主动进食,需服安定类药物后才能入睡。可引出幻听、幻视。自述:“近 20 余天,我白天晚上经常能看到有许多小人儿围在自己身边,这些小人儿彼此都互相认识,都是平时与自己关系不太好的同事,主要是两个人,一个是李某,一个是马某。马某是项目部经理,这两个人都是我的领导,他们两人关系十分密切。这些小人什么时候出现,什么时候消失都由不得我。他们有时手里还拿着刀,说要杀了我。有时还能看到有大蜈蚣在地上爬。”

医生问:“您有什么话要说吗?”患者表情气愤,主动表达心中之不平:“我咽不下这口恶气,我的老婆和李某乱搞,我请领导马某出面调解,要求经济补偿和开介绍信去与我的老婆办离婚手续。姓马的那个项目经理与姓李的关系很好,他老是从中抹稀泥,他不主持公道反而向我施加压力,他说:‘你不要把事情弄大,李某还年轻,没结婚,又是单位的领导,你这样一闹让他在这儿不好做人。你要胡来,我就辞了你,让你下岗。’他既不调解又不给开离婚介绍信还威胁我。这口气一直憋在心里。”

患者常为此感到心烦、发愁,觉得没脸见人,阵阵紧张害怕,夜里经常被噩梦惊醒。晚上睡不着觉时脑子里琢磨的全都是这些事,不想想但又控制不住,还担心将来的工作生活问题。

情感反应与内心体验及环境协调。平日能与病友聊天并主动参与工娱疗活动。夜晚失眠,想心事。注意力、记忆力及智能均未见明显异常。

(二) 病例分析

1. 诊断和诊断依据

(1) 患者男性,45 岁,病程 3 个月,病前性格懦弱,无主见,人际关系一般。

(2) 在强烈的心因刺激下发病,即妻子有外遇,第三者是自己的好友兼领导,不能离婚同时又面临下岗的威胁。

(3) 精神症状

① 反复重现创伤性体验,如反复出现与李某有关的幻觉、噩梦。

② 持续的警觉性增高,如整夜不眠或易惊醒,过分地担惊受怕。

请教气功师,气功师说:“你自己慢慢去悟吧。”在回家的路上,患者突然对其母说:“我可能得到灵鸽了,您瞧,现在已收功了,怎么手还动呢。”并自觉耳边有人跟她讲话,患者就对天空边打手势边说:“灵鸽,你是上我这儿来了吗?”同时患者听见一声鸽子的“咕噜”叫声,非常高兴,认为自己不是一般人了,得到了气功“真谛”。此后患者又按书上说的,自行“辟谷”5天(即不吃谷物),并称能与气功大师对话。有时出洋相,比如学老太太、小孩吃饭的样子等。9月2日,病人开始不上班,增加练功时间,每天晚上11点半开始练功接气。9月8日,病人开始不进水,并对其母说:“妈妈,我现在是于某(患者以前的男友),我从现在起是您的儿子,开始孝敬您了。”一会儿又对其母说自己是杨玉环,气功师是自己的“三郎”。躺在床上唱歌,并对窗外说:“你说什么,我妈给我铺了。妈你出去吧,我们要做爱了……”有时将衣服脱光往外跑,有时又无故哭闹。说话不着边际,如说:“要当麒麟文化的传人,要入党,要当书记,要上天。”其母劝阻便下跪、叩头。拒绝进食进水。于1996年9月24日入院,给予奋乃静治疗,20 mg/d,1个月后痊愈出院。

既往史:体健,否认有严重躯体病史,无药物过敏史。

个人史:同胞2人,行2,母孕期正常,足月顺产,婴幼儿期发育正常。适龄上学,学习成绩一般。技术学校毕业后工作,与同事关系好。父母离异,家庭关系不和睦。婚恋史:未婚,曾先后交过3个男友,均不顺利,第一个男友曾与其同居,后与其中断关系。月经史:14岁月经初潮,平日月经规律,无痛经史,经期无特殊。病前性格:内向,心胸狭窄,不好交往,不爱说笑,缺少知心朋友。

家族史:其父曾因作风问题劳教2年。否认父母两系三代家庭成员中有精神病患者及性格怪异者。

体格检查:

体温 36.8℃,脉搏 75次/分,呼吸 19次/分,血压 100/75 mmHg。发育正常,营养良好,周身皮肤无皮疹、黄染和出血,浅表淋巴结未触及。唇红、咽不赤、扁桃体无肿大,甲状腺未及。心肺听诊无异常,腹软,肝脾未及。四肢运动自如。神经系统检查未见明显阳性体征,未引出病理征。

实验室检查:

未见明显异常。

精神检查:

意识清楚,环境定向力完整。自我定向障碍,如对医生讲:“我不叫吴某,我叫吴燕君,我是王昭君,杨贵妃……四大美人的结合体,我的躯壳是吴某,灵魂已经不是吴某了。”仪表整洁。对周围环境有戒备,说周围的人总是盯着她看,说:“我看她

们总想和我搞同性恋。”可引出幻听,如“听到灵鸽的叫声”“听到一个7岁的小男孩和我说话,他是一个小精灵,有时他让我学老太太吃饭,告诉我做这个,做那个,说我是杨贵妃……”可引出一过性关系妄想,如“周围的人对我怀有恶意,总盯着我看,好像要与我搞同性恋似的。”注意力不集中,记忆力和智能均未见明显异常。

(二) 病例分析

1. 诊断和诊断依据

(1)患者女性,24岁,发病由练气功直接引起,病程1个半月。

(2)精神症状

①可以引出真性言语性幻听,如“我耳边就有一个7岁的小男孩的声音和我说话,他是一个小精灵,有时她让我学老太太吃饭,告诉我做这个,做那个,说我是杨贵妃……”。

②可引出一过性妄想,如“周围的人对我怀有恶意,总盯着我看,好像要与我搞同性恋似的。”情绪及行为受幻听的影响。

③人格转换,如“我不叫吴某,我叫吴燕君,我是王昭君,杨贵妃……四大美人的结合体,我的躯壳是吴某,灵魂已经不是吴某了。”

(3)经治疗后很快缓解,间歇期末服药情况下精神状态完全正常。

综上所述,患者的症状表现与气功有关,练功后在气功的暗示下发病。根据CCMD-3诊断:

42.1 气功所致精神障碍[F43]

2. 鉴别诊断

(1)癔病性精神病:本病往往在心因刺激下当时起病,以分离型或转换型症状为主,患者往往具有癔病性人格特征。而该患者虽然有人格转换症状,但是在气功的暗示下起病,内容与气功有关,经治疗后很快缓解,且长期存在心理问题,即几次恋爱均不顺利。

(2)严重应激障碍:应激障碍是在严重精神刺激作用下起病,而该患者虽然长期存在持续性心因,但此次发病与其心因无直接关系,而存在长期难以解决的心理问题的人容易在气功的暗示下发病。

3. 治疗方案

有精神病性症状出现时可以给予小剂量抗精神病药治疗,该患者服奋乃静20 mg/d后很快缓解。同时稳定情绪,避免接触与气功有关的事物。解决其心理因素对预后十分关键的作用。

经上述治疗,患者出院后自行停药,1年后随访精神状态完全正常。未再练气功。

4. 预后估计

本患者几次恋爱都不顺利,已对其造成了一定的心理负担,而且患者的人格具有暗示性强的特点,这些特点均不利于患者的恢复。若其心理因素长期不能得到解决,则疾病有可能会反复发作。

三、病例三

(一) 病历摘要

患者李某,女性,47岁,已婚,中专文化,工人。

主诉:练气功后间断出现胡言乱语10年余,复发7天,自责,严重失眠。

现病史:患者于1988年4月开始练鹤翔桩气功,每天早晚各2次,每次持续时间不等。同年5月患者在一次练功中突然出现“自发功”,后不能“收功”,表现为手舞足蹈,称自己能看见死去的父亲从工厂里走了出来,来到她家并躺在床上乱扔床上的东西,说她父亲用过的东西都要扔掉。患者拉着丈夫的手不放,说要一起听她父亲讲话。不停地唠叨,自称能看见火球、金丹等。次日早晨不顾丈夫的劝阻,又去操场练功,再次突然“发功”,浑身扭动,喊叫,又哭又笑。气功师试着用发放“外气”的方法给其“纠偏”无效。患者无目的到处乱跑,不吃不喝,自言自语,不许别人打扰。患者称,她说出的话不是她自己说的而是父亲通过她的嘴说出来的;又称家里闹鬼,有人要害她,因此不在家住。上述情况持续约20天,经气功师反复“纠偏”无效。于1988年4月下旬入某医院住院治疗,诊治不详。3个月后痊愈出院。出院后即自动停药,精神恢复好,能正常工作生活。

1992年4月13日晨起后发现左侧嘴歪,曾到北京两个医院治疗,诊断为“面神经麻痹”,用激素、电针等治疗。4月17日请气功师“发功”治疗其“面神经麻痹”。患者在接受气功师“外气”治疗后,当天晚上,家属即发现其两上肢及躯干乱动,挤眉弄眼,面部表情神态与上次练功后精神失常时的表现相同,家属询问时患者称是在“接功”。次日白天呆愣,晚间睡眠极差,不停地自言自语,而于1992年4月20日首次住我院。诊断“气功偏差所致精神障碍”,经治疗很快痊愈。出院后未服药,精神状态正常。

1995年8月,与单位两位女同事聊天,其中一人说要给患者发“外气”,用气功

给患者治疗其右手的软组织挫伤。患者在接受“外气”治疗后当即表现不正常,由两位同事护送其回家。到家后患者愁眉苦脸、焦虑、紧张、自语、不睡觉,自诉又听见气功师与同事说她的坏话。家属担心患者病情会进一步加重,于1995年8月10日至9月4日第2次住院,诊断同前。奋乃静治疗27天,最高日量20 mg持续20天痊愈出院。出院后未服药,精神状态正常。

1998年10月底,患者回大连探亲,与亲友交谈时谈及气功,其中一人说自己在练气功时曾看见龙,患者说自己在练气功时也看见龙了。第二天起更表现情绪低、自责,说自己买菜时多拿了别人一棵菜等,说听见有人对自己讲话,整夜不眠,于1998年11月10日第3次住院,仍诊断“气功偏差所致精神障碍”。奋乃静治疗,最高日量34 mg持续34天痊愈出院。

既往史:患乳腺增生多年。1991年1月因早期癌变(左侧)而行左乳切除。术后经癌瘤多次复查,未复发;曾患“面神经麻痹”,已愈。否认有其他重大躯体病史。无药物过敏史。

个人史:同胞8人,行5。婴幼儿及青少年时期生长发育情况不详。中专毕业后分配入现单位,能胜任本职工作。婚育史:1971年与现夫结婚,婚后夫妻感情好,生育一女儿,体健。病前性格:内向少语,不愿与人交往,脾气易暴躁,但善于克制。为人善良。无特殊爱好,不嗜烟酒。

家族史:否认父母两系三代家族成员中有精神病患者及性格怪异者。

体格检查:

体温36.8℃,脉搏75次/分,呼吸19次/分,血压100/75 mmHg。发育正常,营养良好,周身皮肤无皮疹、黄染和出血,浅表淋巴结未触及。扁桃体无肿大,甲状腺未及。心肺听诊无异常,腹软,肝脾未及。四肢运动自如。神经系统检查未见阳性体征,未引出病理征。

实验室检查:

未见异常。

精神检查:

意识清楚,定向力完整。可引出真性言语性幻听:“第一次发功后听见死去的父亲说话,说了很多,内容记不清了。”自述能听到气功师及许多其他人议论自己,听见气功师和其他人议论自己的坏话,其中包括:不干活、老打麻将、爱占小便宜等,说的都是自己的缺点。有时自语,但是在问话时能中断自语并切题回答问题,未引出其他怪异的思维内容。情绪受幻听的内容影响而心情不好,觉得自己没用,对不起别人,认为自己有许多缺点,因此感到自己有罪。有时能回忆过去类似的经

历,记得曾数次住院,每次犯病时的表现都基本相同,但是患者否认自己有精神障碍,患者在入院后,无冲动怪异行为。经常在遇到医生时,要求出院。

(二) 病例分析

1. 诊断和诊断依据

(1)患者女性,47岁,间断病程10年余,患者每次发病均与气功有关。

(2)临床表现:

①患者起病与气功内容密切相关,例如每当接受“外气”治疗或接触到与气功有关的内容时便有病情反复,待精神症状缓解后即自动停药,精神状态如常人。

②出现真性言语性幻听,如“第一次发功后听见死去的父亲说话,说了很多,内容记不清了。还能听到气功师及许多其他人议论我,说我的坏话,说我:“不爱干活、打麻将,干了不少坏事,爱占小便宜……”情绪及行为受幻听和继发性妄想的影响,出现情绪低,自责等。

③精神症状缓解后,患者对气功与出现精神症状的关系能有一定的回忆和内心体验,并恢复了原有的本职工作。

根据 CCMD-3 诊断:

42.1 气功所致精神障碍[F43.8 其他严重应激反应和适应障碍]

2. 鉴别诊断

(1)与抑郁症相鉴别:该患者在每次发作中有不同程度的抑郁情绪,故需要与抑郁症相鉴别。后者应具有典型的抑郁综合征,而该患者每次起病都是在气功的暗示和自我暗示下发病,情绪受幻听和继发性妄想的影响,幻听消失,情绪好转。不符合抑郁症的基本诊断条件。

(2)与癔病性精神病相鉴别:此病往往在强烈的心因刺激下立即起病,以分离型或转换型症状为主,而且往往具有癔病性人格特征。本患者的起病和复发除与气功有关外,并无其他心理因素。每次发作都是在气功的暗示和自我暗示下起病,无分离型或转换型的症状特点,患者既往无癔病性人格特征和癔病样发作史,可资鉴别。

3. 治疗方案

(1)有精神病性症状出现时可以给予小剂量抗精神病药治疗,精神症状即很快缓解,但个别病例也有需要用较大剂量者。

(2)同时稳定情绪,避免接触与气功有关的内容。

4. 预后估计

本患者是一个比较拘谨的人,知识面较窄,生活内容局限,做事认真。患者对气功情有独钟,经治疗精神症状消失后又反复接受气功健身,而反复出现精神障碍,如果不改变对气功的追求和想法,还可能再发精神障碍。

四、病例四

(一) 病历摘要

患者安某,女性,37岁,已婚,农民,高中文化。

主诉:认为自己有神附体,兴奋,外跑半个月。

现病史:患者平日十分迷信鬼神,常因身体不舒服求助于神婆。平日在家中供奉观音塑像,每日上香,未见明显精神异常。

1999年2月28日因牙痛去当地医院输液,3天后无好转。3月3日请神婆看病,神婆说患者身上有神,患者自己也承认,并说自己是玉皇大帝的女儿(此话是5年前看病时一巫婆对她说的),回家后告诉家人说牙痛是神在点化她。患者认为自己是神仙附体,同时认为其他家庭成员的身上也附了神。3月7日,患者说玉皇大帝要给她传授武功,让她上天去办事,并将家人都赶出去,自己手舞足蹈不停地比画。为了表示心诚,不吃不睡,整日练功。3月9日,自称能听见观音菩萨说话,说赤脚大仙把她的武功偷走了,说康成(一个巫婆,5年前给她家看风水,要6000元钱,患者不同意,该巫婆说5年后患者要有难)要来害她了。3月10日患者兴奋、外跑,说家人也中邪了。在来北京的途中,患者一会儿糊涂一会儿明白,不认识家人,打人,要下车,说车会飞。小便失禁一次。3月11日于我院门诊肌注氟哌啶醇10mg,以后用氯丙嗪250mg口服,较前安静。后因拒服药,又出现兴奋语乱。于1999年3月15日住院治疗,1个月后痊愈出院。

既往史:体健。否认有严重躯体疾病。对青霉素、磺胺类药物过敏。

个人史:同胞6人,本人行大,幼年生长发育情况不详。高中毕业后在当地林业局当临时工,工作能力尚可。因农村户口未转正,后回家务农、料理家务,很能干。曾做过一段时间的个体布匹零售。婚育史:1984年结婚,生育3个孩子,2男1女。其丈夫在金矿工作,收入高。病前性格:外向,为人热情、开朗,能干、要强,关心人,但脾气暴躁。

家族史:否认父母两系三代家族成员中有精神病患者及性格怪异者。

体验及片断的幻觉,内容与巫术内容密切相关。

3. 治疗方案

小剂量抗精神病药治疗,该患者口服奋乃静 20 mg/d 后很快缓解。

4. 预后估计

该患者知识面窄,生活内容单调,同时迷信巫术,在生活中遇到困难、麻烦后很容易引起病情反复。

(谢家康 江镇康 于 靖)

阿尔茨海默病

阿尔茨海默病(Alzheimer's disease, AD)是发生在老年期及老年前期的以痴呆为主要临床表现的脑退行性疾病。AD 和血管性痴呆(vascular dementia, VD)是老年期痴呆中最常见的疾病,故已成为当前研究痴呆的重点课题。

早在 1907 年 Alzheimer 描述了 AD,即以其名字命名。传统上把大脑原发性病变所致的痴呆分为老年性痴呆(senile dementia)和早老性痴呆(presenile dementia),后者主要包括 AD 和 Pick 病。近年来的研究指出,老年性痴呆和 AD 除了在发病年龄上有差异外,在临床与神经病理学方面,两者并无本质上的差异。故 20 世纪 70 年代以来采用了老年性痴呆 Alzheimer 型(SDAT)或 Alzheimer 病一词,不再分为老年性痴呆和早老性痴呆,而将 AD 分为两个亚型,即老年期(65 岁以后)起病者称为 AD₁ 型;早老期(65 岁以前)起病者称为 AD₂ 型。

第一节 阿尔茨海默病的临床特点

AD 患者多发病于 50 岁前后,也有 30 岁发病的报道。本病多逐渐起病,病程进展缓慢。临床表现为持续进行性的记忆、智能障碍,伴有言语、视空间技能障碍及人格改变等。轻度的近事遗忘和性格改变是本病的早期症状,随后理解、判断、计算等智能活动全面下降,导致不能工作或操持家务,直至终日卧床不起,生活不

能自理,口齿不清,语言杂乱。一般经5~10年发展为严重痴呆,最后常因褥疮、骨折、肺炎等并发症引起脏器衰竭而死亡。

AD的临床过程大致可分为3个阶段。

第1阶段:表现为记忆减退,判断能力下降,病人不能对事件进行分析、思考、判断,工作或家务劳动漫不经心,时间、地点定向障碍,尽管仍能做些已熟悉的日常工作,但对新的事物却表现出茫然难解,情感淡漠,常有多疑。

第2阶段:表现为各种神经症状,可见失语、失用和失认及其他认知缺陷的神经系统症状。情感由淡漠变为急躁不安,常走动不停,可见尿失禁。

第3阶段:已进入晚期,为全面痴呆状态和运动系统障碍,包括肌强直和肢体屈曲。

人格改变和记忆障碍往往出现在疾病的早期。最初的人格改变是,病人变得主动性不足,活动减少,孤独,对新环境难以适应,自私,对周围环境兴趣减少,对人缺乏热情。以后兴趣越来越窄,对人冷淡,甚至对亲人漠不关心,情绪不稳,易激惹,因小事而暴怒,无故打骂家人等。进而缺乏羞耻及伦理感,不讲卫生,常常拾捡破烂,藏垢纳污以为奇世之宝,乱取他人之物据为己有,争吃抢喝恰似孩童。病情严重时,可表现本能活动亢进,当众裸体,甚至出现性行为异常等。记忆障碍也是首发症状之一,特别是近期记忆的减退尤为明显,例如,刚用过的东西随手即忘,日常用品丢三落四,严重者则如吃饭不久又要求进餐,不能记住新近接触的人名或地名,甚至遗忘贵重物品。随着病情的进一步发展,远期记忆也受损,不能回忆自己的工作经历、生活经历,甚至自己的年龄。为了弥补记忆方面的缺损,有的病人以虚构或错构来填充记忆的空白。

智能障碍,首先是计算困难,不能进行复杂运算,直至两位数以内的加减运算也不能完成。此后,逐渐发展为理解能力受损,判断力差,概括能力丧失。如看不懂小说、电影情节等,听不懂他人谈话。不能完成或胜任已熟悉的工作和技术,最后完全丧失生活能力。

视空间技能障碍表现为病人在已熟悉的环境中迷路,找不到自己的家门,甚至在自己家中也走错房间。在简单绘图试验时,病人不能精确临摹立方体图,也常不能临摹简单的图形。用韦氏成人智力测验,病人进行视空间技能测验时得分最低。

言语改变是大脑皮层功能障碍较敏感的指标,故言语障碍的特殊模式有助于本病的诊断。在AD患者,言语丧失不是所有言语功能同时受损,其言语障碍特点在疾病不同阶段而有所差异。最早的言语异常是自发言语空洞,用词困难、赘述,不能列出同类物品的名称;继之,命名不能,在命名测验中对少见物品的命名能力

首先丧失,随后对常见物品命名亦困难;之后出现感觉性失语,不能进行交谈,可有重复言语、模仿言语、刻板言语;最后病人仅能发出不可理解的声音,或者缄默不语。

AD的失认症状以面容认识不能最常见,患者不能从面容辨别人物,不认识自己的亲属和朋友,甚至丧失对自己的辨认能力而出现“镜综合征”(mirror syndrome),如对着镜子问:“你是谁?”曾有患者面对镜中的自己以为窃贼侵入,而一拳击碎镜子。

AD的失用表现为不能正确地以手势表达方法做出连续的复杂动作,如做刷牙动作等。

睡眠障碍也是常见症状之一。病人表现睡眠倒错。夜间不睡,到处乱走,或做些无目的动作,白天则精神萎靡、瞌睡。

部分病人在病程中可发生意识障碍,如意识模糊和谵妄状态,通常为躯体因素所诱发。如无症状性肺炎、前列腺肥大、泌尿系感染、外伤骨折、营养不良、镇静剂过量、电解质紊乱等。

抽搐发作可见于疾病的晚期。并有运动系统障碍,包括肌强直和肢体屈曲。

在AD的研究中,以往侧重于该病的认知功能障碍和智能减退。近年来,对精神病性症状给予相当大的重视。许多研究者认为AD病人有无精神病性症状,以及有哪些精神病性症状是至关重要的,因为这些症状可能反映了遗传方面的差异,也可能表明了AD的不同临床亚型。Rosen等(1985)指出,AD的特征性功能障碍可能有两种类型:其一为认知功能损害类型,其二为非认知的行为障碍类型,包括幻觉、妄想、焦虑、抑郁以及各种行为障碍和社会功能障碍。笔者等(1995)对76例AD病人的分析发现,半数以上的AD病人在表现认知功能障碍和智能障碍的同时伴有幻觉、妄想症状;另一部分AD患者在整个疾病过程中无幻觉、妄想症状,其认知功能障碍、智能障碍在临床表现中占主导地位。幻觉、妄想症状以幻听多于幻视,且多表现为言语性幻听;妄想则以被害妄想居首位,其次为被窃、嫉妒及夸大妄想。进一步发现AD无幻觉、妄想症状者较有幻觉、妄想症状者的认知及智能障碍程度重,病情恶化也更为迅速。

长期以来对痴呆伴发的精神症状缺乏统一的描述和定义,有些学者称此为“精神病性症状”,也有的学者称为“非认知的行为症状”。直到1996年,国际老年精神病学会(international psychogeriatric association, IPA)召集了一次专门讨论痴呆行为障碍的国际协商会议,制定了一个新的疾病现象学术用语即痴呆的行为和心理症状(the behavioral and psychological symptoms of dementia, BPSD)。会议将

年内。具体表现为持续的心烦,经常哭泣,没有精力,食欲减退,每月体重减轻超过1千克,活动减少特别是新近出现退缩、烦躁,睡眠变化为难以入睡和夜间早醒,自我评价低,但自杀观念和行爲少见。

焦虑、激越和坐卧不宁发生在许多 Alzheimer 疾病的后期,认知障碍越严重,病人越有可能出现这组症状。这组症状可以作为原发症状而单独出现,也可以继发于抑郁、妄想或幻觉。某些患者的这种焦虑、激越是继发于对丢失物品的关注,病人到处走动,无目的地在抽屉和壁橱内搜索。

4. 躁狂

痴呆的躁狂症状相对少见,Burns 等报道 AD 患者中 3.5% 有躁狂症状,这些躁狂症状与脑 CT 显示的半球间裂增宽相关,提示这类症状属于额叶病变所致。

5. 行为症状

行为症状对患者的照料者构成极大的负担和威胁。这组症状发生在 AD 病程的后期,随着痴呆程度的加重,行为障碍加重。痴呆病人常见的行为症状包括不停地徘徊,无目的地漫游,语言攻击,暴力行为,不适当的性行为,哭泣,喊叫,夜晚不眠,大小便失禁等。

研究发现,不停地哭喊症状与认知功能和自理能力损害的严重性有关。大声叫喊有时可能是未被人们发现的疼痛所致,因此要进行仔细全面的体格检查,包括关节、长骨等处的仔细的触诊,以明确是否由骨折所致,口腔及其他局灶部位也应做彻底检查。哭泣喊叫可能与病人难以进行语言表达及孤独感有关。

AD 的病程可以从 3 年到 20 年,病人平均存活时间为早期诊断后 8~10 年。

第二节 阿尔茨海默病的诊断标准

由于 AD 的病因未明,故其诊断手段还停留在临床指标的水平上,包括痴呆诊断的建立和排除其他特定原因所致痴呆两个步骤。目前有国际上几个公认的 AD 诊断标准,以及我国中华医学会制定的诊断标准,如下所述。

一、WHO 的 ICD-10(1992)

+++++

1. 存在痴呆。

2. 潜隐起病,缓慢退化,通常难以指明起病的时间,但他人会突然察觉到症状的存在。疾病进展过程中会出现一个相对稳定阶段。

3. 缺乏临床证据或特殊检查发现,提示其精神障碍可能是由于全身性疾病或脑部疾病所致的痴呆(例如甲状腺功能低下、高血钙症、维生素 B₁₂ 缺乏症、烟酸缺乏症、神经梅毒、正常压力脑积水或硬膜下血肿)。

4. 缺乏突然性、卒中样发作,在疾病早期无局灶性神经系统损害的体征,如轻瘫、感觉丧失、视野缺损及共济失调。

在某些病例中,AD 的特点和 VD(血管性痴呆)的特点会同时出现,这些病例应作双重诊断。如果 VD 先于 AD 发生时,临床上不可能作出 AD 诊断。

AD 分为 3 种亚型:

(1)早发型 AD:起病于 65 岁之前,症状进展迅速,病程早期可出现多种高级皮层功能紊乱,包括失语、失读、失写及失用症。可有 AD、Down 综合征或淋巴瘤家族史,但不是诊断所必须。

(2)晚发型 AD:起病于 65 岁之后,通常在 75 岁以上或更晚,病情进展缓慢,通常以记忆损害为其主要特点。

(3)非典型或混合型 AD:痴呆不符合上述早发与晚发型时归属此型;AD 与 VD 共存者属于此类。

二、APA 的 DSM-IV(1994)

Alzheimer 型痴呆

1. 发生多方面认知缺陷,表现为下列 2 项。

(1)记忆缺损(学习新信息的能力缺损或不能回忆以前所学到的信息)。

(2)至少有下列认知障碍之一。

①失语(语言障碍)。

②失用(虽然运动系统没有问题,但不能执行动作)。

③失认(虽然感觉功能没有问题,但不能认识或识别物体)。

④执行管理功能的障碍(即:计划、组织、安排次序、抽象)。

2. 符合上述认知缺陷导致社交或职业功能的缺损,并可发现这些功能明显不如以前。

3. 病程的特点是逐渐起病,进行性衰退。

4. 符合上述认知缺陷,并非由于下列原因所致。

(1)其他能导致记忆与认知进行性缺陷的中枢神经系统疾病(例如心血管疾病、帕金森病、亨廷顿病、硬膜下血肿、正常压力脑积水、脑瘤)。

(2) 已知能导致痴呆的系统性疾病(例如甲状腺功能减退、维生素 B₁₂ 或叶酸缺乏、烟酸缺乏、低血钙、神经梅毒、HIV 感染)。

(3) 物质所致情况。

5. 这些缺陷并非由于谵妄所致。

6. 此障碍并非由于其他疾病所致(例如重性抑郁、精神分裂症)。

三、NINCDS-ADRDA 标准(1984)

美国国立神经病学及语言障碍和卒中研究所(NINCDS)和 AD 及其有关疾病协会(ADRDA)联合 AD 研究小组制定的 AD 诊断标准(又称为 Mckhann 标准),提出了“可能性大的”(probable)、“可能的”(possible)及“肯定的”(definite)AD 分级诊断。

(一)可能性大的 AD

1. 必须符合以下 6 项。

(1) 根据临床检查建立痴呆诊断,用 MMSE、Blessed 的痴呆量表或其他类似工具收集资料,通过神经心理测验验证。

(2) 认知功能有两方面或更多的缺损。

(3) 记忆和其他认知功能进行性衰退。

(4) 无意识障碍。

(5) 在 40~90 岁之间发病,多在 65 岁以后。

(6) 不存在可导致记忆和认知进行性缺损的躯体疾病或其他脑部疾病。

2. 下列项目支持可能性大的 AD 的诊断

(1) 特定认知功能进行性衰退,如语言(失语)、运用技能(失用)和知觉(失认)。

(2) 日常生活活动受损和行为模式发生改变。

(3) 有类似障碍的家族史,尤其是经神经病理学证明的。

(4) 实验室检查结果,腰穿结果用标准技术测定为正常;EEG 正常,或有非特异性改变,如慢活动增加;CT 追踪证明有进行性脑萎缩。

3. 在排除了可能性大的 AD 以外的痴呆病因之后,与可能性大的 AD 诊断一致的其他临床特征。

(1) 疾病病程呈进行性平缓发展。

(2) 合并有抑郁症的症状、失眠、情感失禁、妄想、错觉、幻觉、奇特言语、情绪和

体力爆发性功能障碍及体重减轻。

(3)某些患者有神经系统异常,特别是在疾病进一步发展时,包括运动体征,如肌张力增高、肌阵挛或步态障碍。

(4)在疾病晚期有癫痫发作。

(5)CT 对其年龄来说是正常的。

4. 诊断可能性大的 AD 时不肯定或不大可能的特征。

(1)突然以卒中起病。

(2)在疾病早期出现局灶性神经系统体征,如轻瘫、感觉缺失、视野缺损、共济失调。

(3)在发病时或疾病的很早期出现癫痫发作或步态障碍。

(二)可能的 AD 的诊断

1. 可根据痴呆综合征标准作诊断,不存在足以引起痴呆的其他神经、精神或躯体障碍。其起病形式、临床表现或临床病程可有较大变异。

2. 在诊断时有足以导致痴呆的继发性躯体疾病或脑部疾病,但认为这些病不是痴呆的原因。

3. 当出现单纯的、进行性加重的认知缺陷,而且没有可证实的其他原因时,才能用于研究。

(三)明确的 AD 的诊断标准

符合可能性大的 AD 的临床诊断标准,并有活检或尸检的组织病理学证据。

四、中华医学会的 CCMD-2-R(1995)

+++++

中华医学会《中国精神疾病分类方案与诊断标准》第 2 版的修订版中,AD 的诊断标准基本上与上述 ICD-10 和 DSM-IV 相接近。

1. 符合脑器质性精神障碍的诊断标准。

2. 起病缓慢,以逐渐加重的痴呆为主要临床症状,病情发展虽可暂时停顿,但不可逆。

3. 需排除以下疾病。

(1)脑血管病等其他脑器质病变所致的痴呆。

(2)抑郁症等精神障碍所致的假性痴呆。

渐加重,近1年来,忘事更为严重,做事随做随忘,如刚洗完澡又要去洗,餐后回忆不起进餐的内容。已不能胜任讲课,被迫辞去客座教授的职务。不会进行复杂的操作,如不会使用照相机、计算机等。不能进行简单的计算,如6角钱一袋的牛奶,买两袋不知应付多少钱。理解问题困难,看不懂两年前写过的论著,与人交谈时不能理解对方的问话而茫然不知如何回答。日常生活必须老伴照料,如不知冷暖和饥饱,常用无助的眼光看着老伴。患者一反往日干净利索的性格,变得懒散,不讲卫生,甚至随地大小便。近半年来动作笨拙,反应迟钝,话少,常重复别人的言语,表现极为幼稚。近2天来昼夜不分,夜间不眠,到处走动,有时不穿衣服便欲外出,称要去超市,态度固执,不听老伴的劝阻。因家中难以护理故收住院治疗。

患者自发病以来无发热、抽搐情况。

既往史:患者既往无高血压、卒中病史。否认脑外伤、脑肿瘤、脑炎等病史。

个人史:患者自幼生长发育正常,适龄上学,成绩优异,顺利读至大学毕业。在高等院校从事教学和科研工作,在专业技术领域具有较深的造诣,曾多次获国家科技进步奖,多次出国访问。

家族史:家族中父亲于85岁时患老年性痴呆,88岁死亡。祖母有精神不正常史,具体表现不详。家族中其他成员无精神神经病史。

体格检查及神经系统检查:

均无阳性体征。

实验室检查:

血、尿、便检查正常。心电图示:不完全性右束支传导阻滞,ST改变。脑电图检查正常。头颅CT示:脑沟增宽,脑室扩大,脑萎缩。

精神检查:

入院后意识清晰,定向力欠完整。主要为时间定向欠准确,不知当天的年、月、日,尚能分清上、下午。地点及人物定向均正确。年貌相符,衣着欠整齐,接触被动,孤僻,不与周围病友交往。饮食不知饥饱。能自行洗漱。二便虽知入厕,但料理不干净。未引出感知觉障碍。简单回答提问,可见模仿言语。如问患者“住院几天了?”回答:“几天了”。问患者:“您感觉哪里不舒服?”回答:“您感觉哪里不舒服?”思维内容贫乏。记忆力减退主要为近期记忆力减退,不能回忆当日的饮食起居情况,记不住主管医生的姓氏,回忆不起住院的天数,但能够回忆自己早年的经历。智能障碍表现为一般常识及专业知识的减退,如患者不知当今国家主席是谁,不知道为什么“人们喜欢冬天穿深颜色的衣服,夏天穿浅颜色的衣服”。对其专业知识“大楼和吊车都很高,为什么大楼需避雷针,而吊车不需要?”患者回答不出。

计算力减退,如“ $100 - 7 = ?$ ”回答“93”(正确),“ $93 - 7 = ?$ ”回答“94”(错误),“ $94 - 7 = ?$ ”回答“94”(错误)。抽象概括能力减退,不能解释“雪中送炭”、“坐井观天”的含义。患者表情呆板,缺少变化。情感淡漠,对医护人员的关心麻木不仁,对周围环境漠不关心,不与任何病友交往。进食量多,饥饱无度。常在病房内无目的走动,或呆坐于桌前无所事事,不愿参加病房的娱乐活动,表现孤僻懒散。

神经心理测查:

MMSE:12分。Hachinski 缺血评分:0分。

(二) 病例讨论

1. 诊断与诊断依据

本例患者主要表现为痴呆综合征。具有如下特点:

(1)62岁缓慢起病,病情进行性加重。病程2年。

(2)记忆障碍表现为突出的近记忆损害。智能障碍表现为生活常识、专业知识受损,理解判断能力、抽象概括能力以及计算力障碍。病情严重地损害其工作能力和生活自理能力。

(3)其他认知缺陷,即高级皮层功能受损的其他症状:语言障碍(模仿言语),运用技能障碍(不会进行复杂操作,丧失以往使用照相机和计算机的能力。)

(4)表现突出的人格改变,行为幼稚,懒散,不讲卫生,情感淡漠,固执任性。

(5)非认知性症状:疾病早期出现的可疑的幻听、幻视,入院后表现的无目的的徘徊。

(6)痴呆家族史。

(7)无高血压病史,无卒中史,无感染、外伤史,无局灶的神经系统体征。头颅CT显示弥漫性脑萎缩。诊断:

00.1 阿尔茨海默病,老年前期型[F00.0 阿尔茨海默病痴呆,老年前期型]

2. 鉴别诊断

该患者系痴呆综合征,需与以下疾病相鉴别。

(1)有许多疾病可引起痴呆综合征,包括甲状腺功能减退、恶性贫血、麻痹性痴呆、额叶肿瘤、正常压力脑积水、硬膜下血肿等。本例患者无上述疾病的既往病史,除痴呆表现外缺乏其他相应的躯体和神经系统症状和体征,缺乏诊断上述疾病的实验室证据,故可进行鉴别。

(2)血管性痴呆是引起痴呆的第二种常见疾病,在诊断AD时必须与此病相鉴别。本例患者无高血压病史,无卒中病史,慢性潜隐性起病,进行性加重,无阶梯样

衰退,缺乏脑血管病引起的局灶的神经系统体征,Hachinski 缺血评分 0 分,头颅 CT 缺乏脑血管病的表现,故可资鉴别。

(3)本例患者除记忆、智能障碍,还具有语言障碍、运用技能障碍等高级皮层功能受损的症状,以及突出的人格改变,符合皮质型痴呆的特点,故需与 Pick 病相鉴别。Pick 病是一种在中年发生的大脑变性疾病,和 AD 一样,也是一种原发性退行性疾病。两者的临床表现常有相同之处,鉴别常有一定的困难。Pick 病临床上较为少见,多见于女性,表现为进行性痴呆,有额叶病变的特征,如:欣快、情绪反应不明显、淡漠或不安、社交能力差,在记忆障碍之前常先有行为表现,与 AD 不同,其额叶特征较颞、顶叶为明显。头颅 CT、MRI 显示双侧额叶对称性重度脑萎缩,萎缩也可累及颞叶。本例患者的人格改变和行为表现发生在记忆障碍之后,头颅 CT 显示弥漫性脑萎缩,非叶性萎缩,故可进行鉴别。

3. 治疗原则

(1)治疗 AD 认知症状的药物:可选择以下某一类治疗药物。

①乙酰胆碱酯酶抑制剂:如安理申(donepezil, aricept)、艾斯能(exelon)、石杉碱甲(哈伯因)、加兰他敏(galanthamine)等。

②脑细胞代谢激活剂:如吡拉西坦(piracetam, 脑复康)、阿尼西坦(aniracetam, 三乐喜)、萘非西坦(nefiracetam)等。

③脑循环促进剂:海得琴(hydergin, 喜德镇)、尼麦角林(nicergoline, 脑通)、都可喜(duxil)、银杏叶提取物(天保宁、银可乐、金纳多等)。

④钙离子拮抗剂:如尼莫地平、盐酸氟桂嗪。

(2)治疗非认知症状的药物:本例患者目前的非认知症状为无目的徘徊,故可选择少量抗焦虑药物。

(3)工娱疗治疗及康复训练。

二、病例二

+++++

(一)病历摘要

患者齐某,女性,83 岁,退休工人,文盲,丧偶,1997 年 8 月 12 日入院。

主诉:因进行性健忘,性格改变伴疑心被窃、被害感 2 年余,加重 2 周,哭闹、骂人入院。

现病史:患者约始于 2 年前,无明显原因渐起精神失常,表现为脾气越来越急

躁,常因一些琐事与家人吵架,多疑,爱唠叨。同时出现记忆力减退,好忘事,丢三落四。常把发生过的事记混淆,记错。经常张冠李戴,甚至说些无中生有的事,还说得活灵活现,有时分不清梦境与现实。近1年多来,症状明显加重,自己放的东西找不到了,便认为是被别人偷走了。开始怀疑自己的家人,后来怀疑周围的街坊,认为别人家放在街上的东西是她家的,常与街坊吵架,骂人,为此患者家属不得不经常向邻居道歉。患者变得越发固执、自私,将买的食物藏起来不让家人吃,越来越难与家人及周围人和睦相处。患者生活能力日渐减退,买东西不识钱币数值,炒菜做饭不知先做什么事情,于是干脆什么都不干。疑心也日益突出,怀疑别人串通起来害她,看到街坊在一起说话便认为是在说她的坏话,是要合伙算计她。1年前曾行头颅CT检查示:大脑皮层萎缩。近2周病情加重,说邻居家的东西是她的,认为街坊偷她家的木头,为此吵闹骂人,欲外出找邻居打架,家人劝阻便更为哭闹,故此住院治疗。患者生活无规律,夜眠尚可,进食不定时,饥饱无度,大小便尚可自理。

患者自发病以来无发热、抽搐情况。

既往史:患者既往无高血压、卒中病史。否认脑外伤、脑肿瘤、脑炎等病史。

个人史:患者为文盲,初为农民,劳动能力强,曾当选为区县的人大代表。后到工厂当工人,工作能力强。已退休多年。

家族史:无精神病及痴呆家族史。

体格检查及神经系统检查:

均无阳性体征。

精神检查:

入院时意识清楚。时间定向力差,不知当日是何月何日,辨别不出是上午还是下午。知自己目前身处医院,但有时找不到自己的床位及房间。知道周围医务人员的身份,能说出自己的姓名及年龄。年貌大致相符,衣着欠整洁。大小便能够自理。未引出感知觉障碍。言谈切题,可引出被窃及被害妄想。患者认为自己的东西总丢,是被自己身边的人或街坊偷走了,称近来街坊总偷她家的木头,但家里人总不给她“做主”,为此气愤。认为街坊合伙算计她,给她使坏。自述街坊总凑在一起,是在合伙算计她。远、近、瞬时记忆均明显减退。不能准确回忆自己的身世及重大经历,记不清住院前后的经历,记不住当日的饮食起居情况。记不住主管医生的姓氏。向病人出示3种检查物,片刻后均未回忆出。智能减退,一般生活常识差。计算力差,不能进行 $93 \div 7$, $79 \div 7$, $72 \div 7$ 等简单运算。理解力、抽象思维能力、分析综合能力、概括能力均减退。如不能指明两类物品的共同点和不同之处,

不理解常用成语。视空间技能减退,不能临摹平面图形,在病房内找不到自己的床位。能意识到自己的记性不好,但不认为是病态,将此归结为别人偷她的东西气得她记性不好了。自知力缺乏。情感缺损,对亲人的关怀和医护人员的关心均无相应的情感。无焦虑、激惹、情感失控、情感脆弱等表现。表现孤僻、懒散。不主动参加病区的工娱活动,不主动洗澡、更衣。未见冲动伤人、自伤自杀、违拗及怪异行为。

实验室检查:

头颅 CT 示弥漫性脑萎缩,脑沟增宽,脑室扩大。其他检查无异常。

神经心理测查:

MMSE:17,Hachinski 缺血评分:1 分。

(二) 病例分析

1. 诊断与诊断依据

患者为老年期(81 岁)起病,起病无明确病因,为慢性隐匿性起病,持续进行性加重。总病程 2 年余。临床表现为两组症状,其一为痴呆综合征,即:①记忆障碍,远、近、瞬时记忆均减退。病史中有可疑的错构与虚构。②智能障碍,理解力、抽象概括能力、分析综合能力、计算力均减退,视空间技能减退。③人格改变,与记忆障碍同时发生。表现为性情急躁易怒,固执、自私,与人难以相处。痴呆程度严重到丧失料理家务能力,生活自理能力减退。第二组症状为痴呆伴发的精神行为症状,即被窃妄想、被害妄想,以及在此基础上的攻击行为。查体无局灶的神经系统体征。神经心理评估 MMSE17 分。影像学的头颅 CT 检查为弥漫性脑萎缩。无感染、外伤史,无高血压及卒中发作史。本例患者无明显语言障碍及失用等症状,符合 AD 老年期起病的特点。诊断:

00.2 阿尔茨海默病,老年型[F00.1 阿尔茨海默病痴呆,老年型]

2. 鉴别诊断

(1)本例患者在疾病初期即有人格改变及行为症状,需与 Pick 病相鉴别。Pick 病的人格改变发生在记忆障碍之前,本例患者则同时发生。此外,Pick 病的视空间技能及智能障碍发生较晚,且头颅 CT 显示额、颞叶萎缩,故可资鉴别。

(2)本例患者有非认知性的精神病性症状,如被窃妄想、被害妄想,情感淡漠,以及在妄想基础上的攻击行为,应与精神分裂症相鉴别。精神分裂症在高龄老人中初次发病实属罕见,而且本例患者无明显思维联想形式障碍,有进行性加重的认知功能损害,即全面的记忆障碍、全面的智能障碍,以及脑损害的影像学证据。故

可进行鉴别。

3. 治疗原则

(1)治疗 AD 认知症状的药物:与例一患者的治疗相同。

(2)治疗非认知性症状的药物:鉴于患者的妄想症状和行为症状,可选择低剂量的利培酮(risperidone)、奥氮平(olanzepine)、氟哌啶醇(haloperidol)、奋乃静(silafon)等。

(3)工娱疗治疗及康复治疗。

第四节 思考与分析

在临床工作中,确定 AD 诊断首先在于确定痴呆综合征,即认知功能损害症状,其次依据神经系统解剖定位确定为皮质型痴呆而非皮质下型痴呆。皮质型痴呆的认知症状包括失语、失用、失认、失定向,视空间技能障碍,人格改变,无运动系统的症状和体征等。最后根据病史、实验室检查等,排除导致痴呆的其他疾病,方可临床确定 AD。由此可见,AD 的鉴别诊断是极其重要的。根据临床工作中经常遇到的问题,列举以下两方面问题供临床医生们思考。

我们已知 AD 可伴发精神行为症状,特别在疾病的早期可出现幻觉、妄想等症状。而随着对精神分裂症的深入研究,精神分裂症的认知功能损害症状已为人们所认识。因此,当老年人既有精神症状又有认知损害症状时,必须进行老年期晚发精神分裂症和 AD 的鉴别诊断,如何鉴别?

精神分裂症的认知损害涉及记忆、注意、执行过程及运动技能等方面,不累及计算力及一般生活常识,无失语、失用、失认、失定向、视空间技能障碍。精神分裂的的认知损害无进行性衰退的特点。MMSE 测查有助于痴呆的筛查。此外,影像学检查有助于两者的鉴别。最近有许多研究者发现 AD 患者尸检、头颅 CT 或 MRI 检查可见海马萎缩。海马萎缩与早期记忆损害有关。因此,CT 示海马萎缩可作为 AD 早期诊断的标志。同时,海马萎缩也有助于 AD 与正常脑老化的鉴别。

一般认为 AD 直到晚期才有运动障碍,但临床可见部分痴呆病人于疾病早期出现锥体外系体征,CT 显示弥漫性脑萎缩,无脑缺血的证据。此种情况诊断 AD 值得怀疑,必须除外 Lewy 体痴呆。有人认为 Lewy 体痴呆是老年性痴呆的变异,也有学者认为是一独立的痴呆类型。Lewy 体痴呆的主要特征是累及注意、记忆和较高级皮层功能的波动性认知损害,波动性意识错乱和谵妄为其突出表现。常伴有妄想的视幻觉或听幻觉,轻度锥体外系特征或对神经安定药敏感综合征,反复找

不到原因的跌倒或短暂的意识模糊或丧失。症状具有波动性,其临床特征持续较长的时期(以周或月计)。除外可引起波动性认知障碍的躯体性疾病。影像学检查无脑缺血或结构性损害的证据,无卒中史。

病例

(一) 病历摘要

患者蔡某,女性,66岁,本科文化程度,干部。

主诉:因全身不适,疑心被害伴健忘6个月,冲动毁物1周于2000年9月13日入院。

现病史:患者6个月前,听到邻里装修噪音后,表现得焦躁不安,紧张害怕,感全身难受,诉说心脏与噪音一起共振,曾到医院检查,经多次心电图检查和医生解释,仍感心脏难受。同时家人发现其办事经常丢三落四。一天指着存放在阳台上的电扇反复说“那是一个日本女人”,不容家人纠正。此后经常于夜间多梦,梦见有人打她和她的全家人,醒后则十分紧张。一次称丈夫以200元钱将她卖了,还买了一个小孩。一天清晨起床,不停地在衣缝中寻找打她的“小人”,后在屋中翻箱倒柜地寻找。入院前1周经常于夜间撕打丈夫,外出。白天则容易激惹,用锤子砸门,摔东西。故入院治疗。

既往史:否认脑血管及卒中病史。

体格检查:

入院后神经系统检查发现四肢肌张力偏高,腱反射活跃,步态迟缓,四肢轻微震颤。

精神检查:

患者存在持续短暂的幻视与幻听,凭空看到床单上有鲜花。称有时在家中无人的时候可以听到有人对她讲话,内容不清,持续时间不长。引出错视,自述一次在家中将床单上的印花看成是一个人头。患者诉说自己近日来经常回忆不起自己所做过的事情,如有一次自己在街上走了4个小时,丈夫在一旁陪着自己,事后丈夫告诉她时,她则一点印象都没有。丈夫让她看自己身上的伤痕,是她夜间打的,她则全然不知。患者否认曾翻箱倒柜寻找“小人”的情景。交谈中患者思维松弛,注意力尚集中,记忆减退,主要表现为瞬时记忆减退和近期记忆减退,远期记忆保存,计算力障碍,视空间技能障碍,情绪焦虑。

脑血管病所致精神障碍

脑血管病是一组脑部血管源性疾病的总称,是老年人的常见病、多发病,伴有不同程度的精神障碍。脑血管病所致精神障碍是指由于脑血管病变(包括出血性和缺血性)造成脑组织血流供应不正常所致的精神障碍,一般进展缓慢,病程波动,可因卒中而急性加剧,也可由于侧支循环获得代偿而有所好转,临床表现多样,最终常发展为痴呆。

第一节 脑血管病所致精神障碍的临床特点

一、血管性痴呆(VD)

+++++

凡由于脑血管疾病引起,以痴呆为主要临床表现的疾病均可统称为血管性痴呆。临床上大致可分为:多发梗死性痴呆、大面积脑梗死性痴呆、皮层下动脉硬化性脑病、丘脑性痴呆等几种类型。

(一)病因

以前将血管性痴呆归因于广泛的脑动脉硬化引起大脑弥漫性缺血缺氧所致。

算机扫描(SPECT)可以探测局部脑血流量,而正电子发射断层扫描(PET)和SPECT检查可见脑组织低代谢及低灌注,对早期诊断有一定的帮助。

(四)治疗

血管性痴呆的治疗,原则上以改善脑血流、预防脑梗死、促进大脑代谢治疗为主,同时辅以适当的促智药物,对于有精神症状的患者,可少量应用对症的精神药物,但不必长期维持。恢复期中,适当的生活能力训练是有益的。

(五)预防

防治高血压是预防血管性痴呆的重要措施。预防脑栓死也是预防血管性痴呆的重要措施,及时治疗各种心脏病均可减少脑栓死的机会。另外,对高脂血症、糖尿病的防治等有益于预防血管性痴呆。

二、急性脑血管病所致精神障碍

+++++

本病一般是指在卒中发生的急性期和恢复期所出现的精神障碍。

(一)病因

脑卒中的最常见原因是高血压及动脉粥样硬化,其他危险因素还包括:心脏病、糖尿病、肥胖、血小板聚集性增高、长期饮酒及吸烟、高脂血症等。

(二)临床表现

本病多起病急剧,多有明显的和较为严重的神经系统局灶体征,如偏瘫、偏盲、失语、感觉障碍等。其精神障碍常见的表现如下。

1. 意识障碍

急性期最常见的精神症状,以昏迷和谵妄为主,谵妄时可伴有大量的幻觉和杂乱无章的行为障碍。意识障碍可随卒中的恢复而逐渐恢复。

2. 抑郁

是卒中患者常见症状。可能是卒中所致躯体功能丧失后,所引起的抑郁情绪反应。卒中引起脑损伤的部位可能与抑郁的发生有关,左半球额叶卒中更易引起抑郁,皮质损害所致抑郁较皮质下所致者更难恢复。

3. 认知功能损害

也是卒中后较为常见的症状,多是一种严重的后遗症。常表现为局限性的认知损害,如失语、失用、体像障碍及视觉空间失认等,多次卒中则会导致痴呆。

4. 人格改变

患者于卒中后常出现易激惹、焦虑不安、多疑等人格方面的改变,对轻微挫折的情绪反应非常强烈,常因故而大发脾气,指责家人,对护理常不合作等,这种改变常是进行性痴呆的前兆。

5. 卒中后的精神病性障碍

部分患者在卒中恢复期会出现幻觉—妄想综合征,且往往同时伴有癫痫发作及失用等其他神经系统后遗症。

(三) 实验室检查

急性脑血管病所致精神障碍的实验室检查,与上述血管性痴呆的检查类似。

(四) 治疗与康复

1. 治疗原则

积极治疗原发脑血管疾病。

2. 对症治疗精神症状

选用适当的抗精神病药,目的在于控制精神病性症状或激越症状,必要时需维持治疗,预防复发。心理治疗也很重要,对患者的康复有重大帮助。针对抑郁、绝望、怨天尤人等心理症状进行干预,以帮助患者更早地面对现实,配合各项康复治疗,减轻患者的痛苦,也能减少照料者的负担。

三、高血压病伴发的精神障碍

(一) 病因

高血压病是老年人的常见病,血压增高可引起脑循环动力学改变、小动脉痉挛及硬化,最终都可导致脑供血不足,引起短暂和持久的精神障碍。

(二) 临床表现

1. 脑衰弱综合征

患者可有头部不适感,如头昏、眩晕、耳鸣等,可有阵发的头痛,严重程度与血压的高低变化明显相关。其睡眠障碍多为噩梦多、易惊醒、睡眠不实、入睡困难等。另外还有易疲劳、不能集中注意力、健忘等。

2. 高血压脑病的精神障碍

多在夜间突发意识障碍,表现为意识朦胧状态、谵妄状态和意识错乱状态。可能有冲动伤人或自伤的行为。意识障碍在出现前可有失眠、情绪不佳、烦躁不安等先兆表现,上述症状往往在一日内呈现时浅时深的波动性特点,可持续数日或数周,事后伴有遗忘。少数患者在出现意识障碍后可很快进入昏迷状态而死亡。

3. 其他精神障碍

疾病的早期,常因卒中可引发焦虑、抑郁症状,有时可出现疑病观念。中期的部分患者,可出现片断的幻觉和妄想。晚期的患者,可有头痛、呕吐、视乳头水肿等表现,精神萎靡、情感淡漠、思维贫乏、反应迟钝,严重者可出现意识混乱。

(三) 实验室检查

长期监测血压变化,眼底可见明显小动脉硬化,视网膜可有出血及渗出物。恶性高血压病人,血压可持续在 29.3/16 kPa(220/120 mmHg)以上;肾功能明显减退,血中非蛋白氮升高,尿中有大量蛋白及红细胞,眼底改变以视神经乳头水肿、视网膜出血及棉絮样渗出多见,也可出现心功能不全。

(四) 治疗和预防

药物控制高血压及心理治疗,让患者保持健康的心态,养成合理的日常生活习惯。精神症状的治疗原则是应用小剂量抗精神病药或抗焦虑药对症治疗,抗精神病药物不必维持治疗。合理选用抗高血压的药物,长期用药维持血压稳定,是预防高血压病伴发精神障碍的根本措施。

第二节 脑血管病所致精神障碍的诊断标准

国内 CCMD-3 标准中,按“脑血管病所致精神障碍”进行诊断。

CCMD-3 诊断标准:0.1 脑血管病所致精神障碍[F01 血管性痴呆]

入院后给予帕罗西汀 20 mg/d、维脑路通 0.4 g 加入 5% 的葡萄糖水静点,每日 1 次共 10 次,肠溶阿司匹林 80 mg/d 等治疗。约 1 个月后,患者病情逐渐改善,夜眠良好,情绪好转,可主动参加工娱活动,但近记忆力仍差,分析归纳能力无改善。

出院诊断为:

01.2 皮层性血管病所致精神障碍[F01.1 多发梗塞(脑皮层为主)血管性痴呆]

(二) 病例分析

患者在半年前已经出现易疲劳、入睡困难及早醒等症状,并且爱忘事。由于精力日渐衰减,与老友交往随之减少,自叹衰老而逐渐出现抑郁情绪。

本患者的精神障碍呈亚急性发展,入院前的 2 周,出现了阶梯样的恶化,其特点为以前的症状逐渐加重,如失眠、多梦、烦躁更加明显。

在患者的病史中可发现可疑幻听症状,如患者凭空听到有人告诉自己称自己的孩子被打伤,从而出现被害观念。

随病情发展出现继发性抑郁症状日趋严重:情绪低落,认为自己老了没有用了而自责,对原来爱下的象棋也感到毫无兴趣,悲观厌世,食欲及体重明显下降,上述表现是典型的抑郁症状。同时伴有焦虑症状,表现为心烦,坐也不是站也不是,无故怕出事。

近 2 周出现波动性意识障碍,为谵妄状态,如在夜间不认家人、无故冲动毁物、无目的行走、恐惧,有昼轻夜重波动,日间较轻时对夜间的精神症状不能回忆。

以后逐渐出现痴呆症状,如在意识清楚的状态下,记忆力减退、分析判断能力减退、地点定向力减退等。有神经系统局灶性体征,如双手震颤。有神经影像学证据,CT 示多发脑梗死。因此,综上所述,支持血管性痴呆的诊断。

根据以上所见,符合“皮层性血管病所致精神障碍的诊断”(按 CCMD-3, 01.2),在过去称为“动脉硬化性精神病”,按国际疾病分类与“多发性梗塞性血管性痴呆”是同一表达方式。在治疗过程中用抗抑郁药治疗,抑郁症状已消除,但是痴呆症状依然存在,可以排除老年性抑郁症。

二、病例二

(一) 病历摘要

患者王某,女性,66岁,已婚,大学文化,退休工程师。

主诉:因1个月来失眠、烦躁、易激惹,加重3天,出现动手伤人行为而入院。

现病史:患者自1个月前开始,因工作劳累,渐感全身不适,总觉得心慌气短,浑身乏力,脑袋总是昏沉沉的,觉得不清醒。常诉心烦意乱,总想发脾气,多次为一些家务琐事与丈夫争吵,当时控制不住,事后又觉得很后悔,自称一激动就一跳一跳地头痛,控制不住就发脾气。白天在单位里做研究工作时,越是想集中精力,就越是觉得头发胀、发沉。为此,患者请了假回家休息,但又放不下单位的工作,夜里睡觉总是不塌实,每晚总要到后半夜才能入睡,还常常做噩梦,而且旁边老伴儿稍有活动,患者马上便会惊醒,为此两人不得不临时分房而卧。近1周来,患者时常觉得恶心,但又吐不出什么东西,经常显得傻呆呆的。有时又十分紧张害怕,说看见房中有黑影,听见外面有要来抓她的警车声。3天前,患者正做着饭时,突然拿着菜刀回到房中,冲着老伴就砍,幸被及时夺下,未伤着人。但此后患者开始兴奋、烦躁吵闹,一会儿大喊大叫,一会儿又挣扎着要冲向门外,任意打周围的人,哭笑无常,且拒食、拒饮,为此家中难以护理,送来住院治疗。

既往史:患者既往有高血压史二十余年,最高达180/110 mmHg,平日间断服用降压药物,近日血压情况不详。有高血压性心脏病史5年,目前尚平稳,否认其他重大躯体疾患史,否认药物过敏史。

个人史:患者行2,足月顺产,母孕期及幼年生长发育情况不详,适龄上学,成绩优秀,大学毕业后在某研究单位担任工程师,工作能力强,是业务骨干,退休后单位返聘,工作至今。患者早年结婚,夫妻关系好,有一儿子,体健。患者平素不嗜烟酒,病前性格外向,脾气急,好交往,但知心朋友不多,无特殊业余爱好。

家族史:患者家族中两系三代所有成员均无精神疾患史,患者的父亲及哥哥均有高血压病史,其父死于“脑出血”。

体检及神经系统检查:

体温:36.8℃,脉搏:80次/分,呼吸:18次/分,血压:180/110 mmHg,对眼底检查不能合作,四肢肌力、肌张力正常,双下肢腱反射略亢进,未引出病理征。

实验室检查:

血常规检查及血沉、肌酐、肝功能、肾功能检查均正常,血糖正常,心电图及超声心动检查显示左室肥厚,符合高血压性心脏病的诊断。脑电图未见异常,头颅CT示:未见异常。

精神检查:

患者在入院前就有明显意识障碍,表现为明显恐怖性幻视(病人看到黑影而表情恐怖),凭空听到警车声,无目的用刀砍其丈夫,事后患者都不能回忆,入院后仍有兴奋吵闹,对检查不能配合,分不清白天还是夜晚,经常不能自理大小便,不能主动进餐。有时呆愣、茫然,有时又显得对周围十分警惕,对周围人带有某种敌意,一有人靠近,就做出防卫的姿态。以上各种表现为典型的谵妄状态。入院第2天夜间突然大喊大叫,胡乱踢打,当时测血压 200/100 mmHg。患者生活完全不能自理,进食需强制。

入院后,经应用缓释硝苯地平 20 mg 每日 2 次及小剂量奋乃静治疗,以及输液等躯体支持治疗,约 2 周后,精神症状随血压下降而逐渐改善。血压:120/80 mmHg,神志恢复清醒,但对近 2 周的表现不能清楚地回忆,查记忆力、智力均未见明显的减退,住院 1 个月后,患者痊愈出院。

出院诊断:01.9 高血压病所致精神障碍[F01.9 分类血管性痴呆]

(二) 病例分析

本病例由于高血压症未能被控制,引起明显脑功能衰减,继而出现意识障碍,可以是高血压危象,鉴别诊断应排除脑卒中。因为有较深的意识障碍,但是无局限性脑损害的神经系统症状及体征,因此不考虑脑卒中,意识障碍随血压下降而好转也是高血压病所致精神、障碍的临床特点。

(鲍 枫 项玉涛 翁永振)

癫痫所致精神障碍

第一节 概 述

癫痫所致精神障碍是一组反复发作的脑部疾病,由于病变累及脑部的部位和病理生理机制不同,导致临床表现各异。

癫痫所致精神障碍可分为急性发作性精神障碍和慢性持续性精神障碍。前者表现为在一定时间内出现意识、感知觉、记忆、思维障碍,心境恶劣,精神运动性发作或短暂分裂症样发作。发作的特点为:突然性、短暂性和反复发作。如果长期反复发作可导致慢性持续性精神障碍,如人格障碍或智能损害和精神分裂症样精神障碍。

第二节 病 因

癫痫的病因尚不清楚,可能和遗传有一定关系。有一部分病例可以查出发病原因,称为继发性癫痫或症状性癫痫。常见的原因有脑部的先天性疾病、脑外伤、脑感染、脑瘤、脑变性、脑缺氧、代谢障碍或中毒引起的脑损害。

癫痫发作的机制至今尚不明确,可能由于脑部的神经元过度放电所致。

第三节 临床表现

一、急性发作性癫痫所致精神障碍

1. 发作性精神障碍大多伴有癫痫大发作,部分病例则只有急性发作性精神障碍。常见的发作表现为:

(1)感知障碍:多为原始性幻觉(如各种颜色的光亮、闪电、难以形容的恶臭等)、错觉、感知综合障碍、体像障碍等。

(2)思维障碍:常有思维中断和一过性妄想。

(3)情感障碍:突然出现恐惧或心境恶劣,无故突然暴怒并伴有攻击行为。

2. 自主神经功能障碍:发作性腹痛、恶心、呕吐、心悸、呼吸急促或暂停、出汗、流涎、面色苍白或潮红。

3. 自动症:核心症状为意识障碍,在意识模糊的情况下,病人可做出一些令人不可理解的行为,并且和当时的环境不相适应。自动症发作可持续数分钟或数小时,少数病例可持续数日或更长。

4. 癫痫性意识障碍:可出现意识朦胧、谵妄。患者表现为目光呆滞,对自己的无目的行为不能回忆,如将偷窃的物品送人或乱扔。有时出现自我意识障碍,可出现交替人格,患者可以用其他完全不同的人格进行活动;也可见人格解体。

5. 病理性心境恶劣:无原因突发性心境恶劣,可持续数小时。

二、持续性精神障碍

1. 人格改变:由于长期和反复癫痫大发作或其他发作,引起脑部损害而导致人格改变。

2. 智能损害:由于长期和反复癫痫大发作或其他发作,尤其是癫痫持续发作,造成大脑不可逆的器质性损害,从而导致痴呆。

3. 精神分裂症样精神障碍:有一部分病人在出现癫痫发作后数年或数十年后,可能具有精神分裂症样精神症状。癫痫性精神分裂症样障碍发生在各种癫痫发作之后,常伴有易激惹和痴呆等症状。

第四节 诊断标准

癫痫所致精神障碍,指一组反复发作的脑异常放电导致的精神障碍。由于累及的部位和病理生理改变不同,导致的精神症状各异。可分为发作性和持续性精神障碍两类。前者为一定时间内的感觉、知觉、记忆、思维等障碍,心境恶劣,精神运动性发作,或短暂精神分裂症样发作,发作具有突然性、短暂性及反复发作的特点;后者为分裂症样障碍、人格改变,或智能损害等。

一、症状标准

+++++

- (1)符合器质性精神障碍的诊断标准。
- (2)有原发性癫痫的证据。
- (3)精神障碍的发生及其病程与癫痫相关。

二、严重标准

+++++

社会功能受损。

三、病程标准

+++++

分发作性和持续性两类病程。前者有突然性、短暂性及反复发作的特点;后者(如分裂症样障碍、人格改变,或智能损害等)为迁延性病程。

四、排除标准

+++++

- (1)排除感染或中毒所致精神障碍,需注意它们可产生继发性癫痫。
- (2)排除癔症、睡行症、精神分裂症、情感性精神障碍。

五、说明

+++++

如系继发性癫痫,应按原发疾病所致精神障碍下诊断。如能确定癫痫发作类

型者,还应按癫痫国际分类(见附表)。

附表 癫痫发作的国际分类(简化)

一、从局部开始的部分性发作

- (1)伴意识障碍的单纯部分性发作(局灶性癫痫):①运动性;②感觉性;③自主神经性;④精神性
- (2)有意识障碍的复杂部分性发作(相当于颞叶癫痫发作):①意识障碍起病;②单纯部分性发作起病进而意识障碍
- (3)部分性发作起病进而全身性发作:①单纯部分性发作起病进而全身性发作;②复杂部分性发作起病进而全身性发作

二、并非从部分性发作开始的全身性发作

- (1)失神发作(癫痫小发作);
- (2)肌阵挛性发作;
- (3)阵挛性发作;
- (4)强直性发作;
- (5)强直一阵挛性发作(癫痫大发作);
- (6)无张力性发作(癫痫迟缓性发作)

三、未分类发作

第五节 癫痫所致精神障碍的典型病例分析

一、病例一

+++++

(一)病历摘要

患者曹某,男,48岁,工人,已婚,初中文化,籍贯北京,入院日期,1998年9月8日。

主诉:阵发性抽搐29年;发作性害怕、打人、毁物24年;1周前突然说话乱、重复。

现病史:患者于29年前(1969年,患者19岁)因抽搐在某医院诊断为“病毒性脑炎”,经住院治疗1个月痊愈出院(具体用药不详)。患者出院后约3~4天又出现阵发性抽搐发作,表现为突然跌倒,四肢抽搐,嘴歪,双眼上翻,口吐白沫,大小便

失禁,偶有咬破舌头和头部摔伤,持续4~5分钟后自行缓解,事后不能回忆。

1974年(患者24岁),患者发作性凭空听见收音机声音,听到有人说他的坏话,因而感到恐惧,无故毁物、打人,并在马路上乱跑,事后不能回忆。首次住我院,诊断为癫痫 精神运动性发作,并给予苯妥英钠0.3 g/d、苯巴比妥0.09 g/d、氯丙嗪300 mg/d治疗,经治疗后未见抽搐发作,精神状况平稳,住院2个月后出院。

出院后门诊治疗并能坚持服药,每月约有2~3次抽搐发作,尚能在单位干些杂活。

1998年初(患者48岁)自行停药,停药后的次日即出现频繁癫痫大发作,1日内癫痫大发作20余次,阵挛发作间歇期间,在意识没有恢复的情况下又接着下一次强直阵挛发作。诊断为癫痫持续状态,给以地西泮20 mg 静脉滴注,癫痫持续状态缓解后,服用卡马西平0.6 g/d,丙戊酸钠0.6 g/d,治疗3个月病情平稳出院,未见明显精神病性症状。患者出院后不能按时服药,时停时服,常有抽搐发作。或突然发愣,呼之不应,数分钟后自行恢复,但是患者对发愣等发作的情形不能回忆。

患者于本次入院前1周,无明确诱因突然不认识人,言语内容凌乱,总重复一句话:“文婷0.15,文婷25%,文婷0.15”。于1998年9月8日又住院治疗。

既往史:1969年(患者19岁)时,因流涕、发热、咽痛、四肢酸痛,1周后突然出现抽搐、眼球上翻、嘴歪,持续4~5分钟后自行缓解,曾诊断为“病毒性脑炎”。无肺部疾病,无心脏和肝肾疾病,无脑外伤史,无中毒史,无药物过敏史。

个人史:同胞4人,患者排行第3。母孕期情况不详,婴幼儿期生长发育状况不详。7岁上学,学习成绩中等,1968年初中毕业,1970年参加工作表现一般,现不能工作。病前性格:内向,孤僻,与人交往少。

家族史:患者父母两系三代成员中无精神病患者,无癫痫、精神发育迟滞和其他遗传病史。无近亲婚配史。

体格检查和神经系统检查:

未见异常。

实验室检查:

血常规、血液生化系列检查和胸片、心电图、脑电图等检查均未见异常。

精神检查:

意识欠清晰,年貌相符,衣着整洁,对答不切题,不能说出入院是几月几日。患者将医生说成是“溜门撬锁的”,对自己所住的医院说是住在“榆树馆12号”,患者不认识自己的床,有时拿着饭盆要去洗澡,生活不能自理。未引出感觉障碍。可引出幻听幻视,患者自述:看见美国兵正在侵略中国,并听见枪炮声,未引出感知觉综

合障碍。思维活动:主动言语少,语速慢,声音含糊,无论问患者什么问题,总是回答:“榆树馆 12 号”,有时突然说:“大夫要把红旗偷出来送到我手上,象征着中国人民站起来了,我的任务是把国旗挂起来。”注意力:患者集中注意困难,与患者交谈中,需多次重复提问一个问题,才能得到简单的答案。记忆力:患者记不得住院日期,也记不得既往住院情况,主管医生多次重复地告诉患者自己的姓氏,但患者仍记不清。智能:因患者入院时意识障碍,无法进行有效交谈。入院第二天,在患者意识清晰时,做智能检查,做 $100-7$ 的连续运算时,仅能做出 $100-7=93$,再减 7 则计算不出来。解释不出成语“过河拆桥”、“画蛇添足”的意思。说不出 4 种水果的名称,对火车和飞机有什么异同点,解释为“火车和飞机有不同的速度”是不同点,都有一个目标是相同点,但患者能说出一年有 12 个月。患者对入院前的自语内容,如:“文婷 0.15,文婷 25%……”都不能回忆。情感活动:面部表情呆板迟钝。意向活动:多卧床不与他人来往,无主动要求,对命令性指令被动服从。

(二) 病例分析

1. 诊断和诊断依据

(1) 患者男性,48 岁,工人,初中文化,个人史和家族史等对诊断无参考意义。

(2) 起病缘于“病毒性脑炎”,后遗留癫痫,间歇性癫痫发作 29 年。

(3) 临床表现

① 癫痫大发作:29 年前病毒性脑炎后,遗留癫痫大发作,表现为突然跌倒,四肢抽搐,嘴歪,双眼上翻,口吐白沫,大小便失禁,偶有咬破舌头和头部摔伤,持续 4~5 分钟后自行缓解,事后不能回忆。每 3~4 天发作一次。未伴有明显精神症状,并能工作。

② 精神性发作:在出现大发作 5 年后,患者凭空听见收音机声音,听到有人说他的坏话,因而感到恐惧,无故毁物、打人,并在马路上乱跑,事后不能回忆,上述行为在明显意识障碍的背景上和环境不相适应,符合自动症的症状诊断。曾住院治疗,诊断为癫痫 精神运动性发作,给予苯妥英钠 0.3 g/d ,苯巴比妥 0.09 g/d ,氯丙嗪 300 mg/d 治疗,经治疗后抽搐发作被控制,精神状况平稳。

③ 癫痫连续发作:患者因突然停用抗癫痫药物而致频繁癫痫大发作,在 1 日内癫痫大发作 20 余次,在阵挛发作的间歇期,意识没有恢复的情况下又接着下一次强直阵挛发作,经抢救脱险。住院诊断为:癫痫持续状态。经抗癫痫药物合并氯丙嗪治疗,病情得以控制。

④ 癫痫大发作的顿挫型:患者从 1998 年上半年起时服时停抗癫痫药,以致抗

癫痫药的血浓度会随之波动,导致患者有时突然发愣,呼之不应,数分钟后自行恢复。这是抗癫痫药只能部分地制止,但不能完全制止大发作时的临床表现。

⑤癫痫性痴呆:在患者意识清晰后做精神检查存在智能障碍,如具有初中文化程度的成年人,简单的心算和成语解释任务也不能完成;也不能说出4种水果的名称。

依据患者的病史,其病因可能是病毒性肺炎,后遗癫痫间歇性发作历时29年,存在癫痫性强直阵挛发作,精神性发作和发作后的精神障碍,并存在智能障碍,社会功能减退。诊断:

02.6 癫痫所致精神障碍[F02.8 在他处分类特定疾病所致痴呆]

继发性癫痫(病毒性脑炎所致):

精神性发作

强直阵挛发作

癫痫性痴呆

2. 鉴别诊断

(1)精神分裂症:本病例有明显的精神病性症状,如患者凭空听见收音机声音,听到有人说他的坏话,因而感到恐惧,无故毁物、打人,并在马路上乱跑等,但是患者的精神症状都是在有意识障碍的情况下发生的,这和精神分裂症的基本特点不同,可以排除精神分裂症。

(2)其他脑疾病所致痴呆:患者有明确的脑炎病史,并继发癫痫发作。没有脑外伤、中毒、代谢障碍等病史,可以排除其他脑疾病所致痴呆。

3. 治疗

患者发作性病程29年,癫痫发作形式有强直阵挛发作、精神性发作、自动症,突然停药后曾发生过癫痫持续状态,而且继发性癫痫病因无法根除,故考虑:抗癫痫药物维持治疗,不能停药,在出现精神症状时可酌情给予抗精神病药物治疗。

4. 预后分析

该患者于19岁时因患病毒性脑炎,后遗癫痫,发作性病程29年。癫痫性精神障碍发作的形式:精神性发作、自动症,并存在智能障碍,据以上情况,预示预后不佳。

意识清晰,定向力完整,接触好,自述就怕犯病,每次犯病时,不分在工作时,还是在休息时,总是控制不住大声叫喊:“放开我,拿刀杀了我,让我去死。”患者能够较细致地描述自己的感受:“当时很难受,突然感到天旋地转,觉得自己的手在动,脚在动,感到周围的人都变成了鬼,感到自己的头发很乱,眼睛也陷了下去;感到自己的脸色不好看;天变了,地也变了,世界和原来不一样。在有一天的下午,自己看到屋内是白天,而看外边很黑,什么也看不见,只听见院子里乱哄哄的说话声,很刺耳。感到父母也变了,妈妈变成了黑人,她说话的声音也变粗了,爸爸变成了白人,有着黄头发和黄眼睛,连眉毛也是黄的,感觉自己也变得跟原来不一样,感到自己的身体变胖了,眼睛变小了,就像猪八戒一样。觉得在这个世界上自己就是赵某,而在另一个世界自己是神,这两个世界是连在一起的,在另一个世界上自己是天上的神,因为犯了错误被从天上打下来,感到自己吃的不是饭,而是大便。有时觉得自己是刚出生的婴儿,不会说话,只能用眼睛看周围的事物,因为自己是新出生的婴儿,就要像婴儿一样尿床。觉得电视上演的都是自己,电视演出的小品节目也是在演关于自己的事,并听见别人在议论自己,说自己的坏话,但是见不到人。有时突然想自己是中性人,男不男,女不女的;有时想水是从哪儿来的,土是从哪儿来的,为什么会有天,为什么会有地,这些想法突然大量地出现,一般持续4~5小时,不受自己控制,感到有种力量强加给自己。有时心里很烦,想不如死了好,死了就平平安安,不会这么烦了,每次都这样想着想着,最后终于睡着了,睡醒后就又恢复正常了……”

患者在谈话时语速适中,言语流畅,表情自然,未发现幻觉。未引出注意、记忆和智能障碍,自知力存在,认为上述表现是病态,迫切求治,在谈话时情感反应协调。患者动作自如,并希望在疾病被治好以后像正常人一样生活,自己有理发的手艺,出院后开一个美容店。

治疗经过:

入院后在2周内有多次发作,患者在发作时表情呆滞,反应迟钝,有时呈恐怖状。感到房间内是黑暗的,门外有光亮,能够问出在精神检查中所发现的体验。每次发作约4~5小时,在入睡醒来后,即如常人。曾用抗精神病药治疗,未能见效。后改用卡马西平0.6 g/d治疗,经1个月治疗后,发作间隔时间明显延长,症状持续时间缩短。出院后,经随访,患者在院外约4~5个月上述精神性发作1次,持续2小时左右,发作间期,精神状况如常人。

(二) 病例分析

1. 诊断和诊断依据

(1) 患者, 22 岁, 男性。

(2) 其家族中父母两系三代成员中无癫痫患者。

(3) 患者的母孕期体健, 未服用安眠药及酒类, 足月顺产, 婴幼儿期生长发育正常。

(4) 既往无脑外伤、脑炎、高热、惊厥史。

(5) 该患者起病无明确的诱因和病因, 为发作性病程, 每次发作可持续 4~5 小时, 在深睡数小时后, 精神状况如常人。发作时出现精神病性症状, 能自行缓解, 总病期 1 年 6 个月。

(6) 临床症状

①先兆症状: 首先感到天旋地转, 不久出现以下症状。

②意识障碍: 为朦胧状态, 发作时表情呆滞, 反应迟钝, 患者在疾病发作时对环境和自我的判断都有障碍, 认为自己吃的不是饭, 而是大便。有时觉得自己是刚出生的婴儿, 就要像婴儿一样尿床。突然感到无法形容的不舒服而紧张、恐惧, 控制不住要大声叫嚷。症状消失后, 对发作期间的精神症状能部分回忆。

③感觉过敏: 患者在发作时, 感到一般讲话声音很刺耳, 声音很强, 难以忍受。

④幻听: 患者在看电视时, 凭空听见别人在议论自己, 由于患者是在看电视时听到的声音, 有可能是机能性幻听, 但是, 患者对当时的情景不能详细描述, 所以不能予以肯定。

⑤视物变形: 有时觉得周围的人都变成了鬼, 感到自己头发很乱, 眼睛陷下去, 脸色不好, 感到父母也变了, 妈妈变成了黑人, 她说话的声音也变粗了, 爸爸变成了白人, 有着黄头发和黄眼睛, 连眉毛也是黄的。

⑥人格解体: 发作时感到周围的人都变成了神仙, 患者在发作期间觉得世界上只有自己一个人, 感到自己是另一个世界的神仙。有时觉得自己像是刚出生的婴儿, 同时感到天变了, 地也变了, 世界和原来不一样了。

⑦感知综合障碍: 感到自己变得跟原来不一样, 身体变胖了, 眼睛变小了, 就像猪八戒一样。

⑧关系妄想: 觉得电视上演的节目都是在说自己的事。

⑨强制性思维: 有时突然大量出现不由自己控制的想法, 如觉得自己男不男, 女不女的, 想水是从哪儿来的, 土是从哪儿来的, 为什么会有天, 为什么会有地。

⑩发作性焦虑抑郁情绪:在上述症状出现时感到焦躁不安和沮丧,有生不如死的念头。

根据患者起病无明确的诱因和病因,以突然方式起病,每次持续4~5小时后自行缓解,为发作性病程。每次发作均有先兆和发作时的精神障碍,每次发作时精神障碍的内容基本相同,并有意识障碍,在病中现实检验能力减退。经抗癫痫药物治疗,精神性发作的频率减少,发作持续时间缩短。

从病因上分析,该患者家族中父母两系三代成员中无癫痫患者,其母孕期体健,无服用安眠药及饮酒史,足月顺产,婴幼儿期生长发育正常,既往无脑外伤、脑炎、高热、惊厥史,入院后脑电图常规检查未见异常,因此,本病例所患癫痫的原因未明。当然,头颅CT或MRI检查,有助于癫痫的诊断,但是,临床观察和实验治疗也有助于诊断。本病例曾用抗精神病药物治疗未获疗效,而用抗癫痫药后获得满意的疗效,也有助于诊断。诊断:

02.6 癫痫所致精神障碍[F02.8 在他处分类特定疾病所致痴呆]

精神性发作

2. 鉴别诊断

(1)精神分裂症:本病例有许多精神病性症状,应考虑精神分裂症的诊断。但是本病例为发作性病程,在发作时多有意识障碍和人格解体,发作后精神正常,因此不符合精神分裂症的病程。另外,患者用抗精神病药物治疗不能控制其精神症状,但是对抗癫痫药有良好的疗效,也不符合精神分裂症的特点。

(2)短暂性精神病性障碍:短暂性精神病性障碍具有间歇性病程,并有明显的精神病性症状,和本患者有共同之处。但是,短暂性精神病性障碍对抗精神病药有良好的疗效,未见该病对抗癫痫药有效的报道。

3. 治疗

患者诊断为“癫痫性精神障碍,精神性发作”。入院后,首选卡马西平治疗。因精神性发作与边缘系统,尤其是杏仁核处的点燃效应有关,而卡马西平对点燃效应引起的边缘系统的电活动有选择性抑制作用,所以能有效地控制精神性发作。此患者经卡马西平0.6 g/d治疗,频率从每3天发作1次,每次发作持续4~5小时,减少为每4~5个月发作1次,每次持续2小时左右。可以追踪病人,将卡马西平加至1.2 g/d,通过血药浓度监测调整剂量。如癫痫症状控制后,继续服药巩固2~3年,可试行缓慢减药,如果在减药后症状加重,则要长期用药。用药期间经常进行躯体及神经系统检查,定期化验血常规、肝肾功能和血药浓度。

躯体感染所致精神障碍

一、躯体感染所致精神障碍的临床特点

躯体感染疾病所致精神障碍是躯体感染疾病症状的一部分,急性起病,在精神症状出现以前可有神经症样症状。精神障碍的主要特征是意识障碍,常常首先发现躯体感染症状,有时似乎是先出现精神症状,究其原因,最终还是躯体感染在先,精神症状出现在后。意识障碍的严重程度随躯体感染的严重程度而变化,精神症状随躯体感染被控制而消失。但是有一部分病人,在躯体感染被控制后,精神症状可延续一段时间。其他精神症状还有幻觉,妄想,精神运动性兴奋,思维不连贯,虚弱状态等。精神障碍的严重程度在1日内可有波动,如昼轻夜重。

二、躯体感染所致精神障碍的诊断标准

- (1)有躯体、神经系统及实验室检查异常的证据。
- (2)有意识障碍,精神病性症状,神经症样综合征,情感障碍综合征。
- (3)日常生活或社会功能明显受损。
- (4)应排除精神活性药物及其他原因所致的精神异常。

三、典型病例分析

病例一

(一) 病历摘要

患者徐某,男,23岁,大学三年级学生。

主诉:因失眠、注意力不集中1个月;头痛10余天;疑心5天,谈话内容重复,突然外跑,于1963年5月14日住院治疗。

现病史:患者于1963年4月15日无任何明显原因,出现失眠,无力,学习时注意力不集中。近10天来双侧顶枕部非持续性胀痛。入院前4天,明显精神失常,连简单的加法都算不对了。患者登记同学交给他的粮票时不是写错姓名,就是算错了斤数。次日凌晨天刚亮,患者看见一个同学就问:“我找了你一个早晨,都没有找到你,你到哪儿去了?”把那个同学问得茫然不知如何回答,因为患者没有任何理由在清晨找那位同学。随后病情不断加重,说话东一句西一句,使人很难理解,他对团支部书记说:“组织上在调查我,我全明白了,别瞒着我,他们要逮捕我了。”经团支部书记反复解释也不能改变他的想法。有时说话内容重复,例如:“给我一块小地方,由饭厅到小地方,由小地方到饭厅……”有时一边用耳机听广播一边自语:“放脑电波,放脑电波,你们拿我做实验,我听见了,我听见了。”经常夜不眠,有时夜间突然无目的外跑。入院前一天来院初诊,体温 37.7°C 。查体:咽后壁轻度充血,血常规检查白细胞为 $8\,500/\text{mm}^3$ 。门诊印象:精神分裂症?上呼吸道感染?给予APC及氯丙嗪口服。回校后精神仍不正常,昼轻夜重,白天尚能与同学正确交谈,能正确说出其小姑妈在京的居住地址,但在夜间又出现兴奋吵闹,如重复地说:“我要卧轨,我要卧轨”,或者说:“我老婆在南京,要回南京,要回南京”,整夜未眠,挣扎欲裸体外跑。于1963年5月14日住院治疗。

既往史:住院前数日有低烧、嗓子痛。

个人史、家族史均无特殊记录。

体格检查:

未见明显异常。入院时体温 36.4°C 。

精神检查:

意识欠清晰,表现为定向力差。患者称病房是旅馆,或是学校,到这里是学习

业务来了,有时也说这里可能是个医院。患者有时称穿白大衣的工作人员为和尚,并说:“我也要当和尚”,经反复提醒后才说:“你们可能是医生。”患者只知今年是1963年(正确),不知现在是几月、几日、星期几。主被动接触差,常独自卧床,对问话常不作答或自言自语。自语内容重复,如:将“这里是寺院,寺院,寺院……”重复8次;将“应该把我枪毙……”一句话重复17次;把“我要重新做人……”重复19次;把“我要回家……”重复20余次。对体格检查和护理都不合作。入院后不主动进餐,需经常鼻饲。晚间不眠,需用安眠药后方能入睡。可引出错视,如把某女护士误认为是其表姐,待这位护士走开后,患者说:“我的脑电波是加里哈波春天”,又指着病室内的灯泡说:“上面两个灯总是要把它合起来”,说完就起床走近窗口,边说边比划:“这上面(指窗玻璃)捂上一块红的布,这上面捂上一块白的布。”患者常常对问话不答或答非所问或回答非常简单。有时说有电波控制他,活不了啦。不吃工作人员端的饭菜,要别人先吃后他才吃。记忆力差,不能回忆住院日期及住院天数。告知其年月日及星期几后,第二天就忘了。患者凭空认为有人现在要枪毙自己,当他将此事告诉医生时,伴有表情紧张、恐惧,但大部分时间处于表情茫然状态。患者在自语时,有时对问话常不回答,且问话难以引起患者注意。入院后多次冲动打人,说打的是外国人,或裸体向门外跑,或重复地用两手画同心圆。当大夫追问时,患者答:“肯尼迪,我要去美国……”(内容令人费解,无法记录)。患者曾搂着病友在别人床上睡觉。患者否认自己有病。

入院印象:1. 感染中毒性精神病?

意识朦胧状态

2. 精神分裂症待除外

3. 发烧原因待查

住院经过:

患者于入院第3天体温达 38.3°C 。查体:咽后壁充血,白血球 $15\ 100/\text{mm}^3$,嗜中性细胞84%,淋巴细胞16%。应用青霉素后体温虽有下降,白细胞总数及分类也恢复正常,但意识障碍仍不见改善;定向力仍不完整,如问患者这是什么地方?则答:“你们这儿都是白的,是白区吧!”当患者看到在白大衣上印的“医院”二字后感到很奇怪。每当下午或晚间兴奋加重,把某护士当作是肯尼迪,自述:“在这里曾打过外国人”,凭空说自己能听到马约翰教授在广播,但不肯详谈广播的内容。入院后第21天,在其后颈部发现一充血性斑疹,2~3天后变为出血性皮疹,以后其颜色逐渐变浅,皮疹消退。住院第23天,右前颈部有2个针尖大的出血点;第27天,发现患者肝大肋下1厘米,质软,脾大,在深呼吸时刚可触及。结合血培养有甲

类链球菌生长,诊断为链球菌类败血症,感染中毒性精神障碍。经青霉素最高日量 240 万 U 10 天并链霉素 1 g/d 持续 41 天,氯丙嗪最高量 400 mg/d 持续 20 天,意识障碍渐好转,住院第 46、47 天,患者败血症虽已临床治愈,血培养呈阴性,但精神仍未完全恢复正常,仍有时突然冲动,踢人、打人,并主动给同学写信:“我现在病得相当重,有恶化的危险……”主动要求退学,要求同学接他出院,回原籍工作。经合并电痉挛治疗 6 次(每周 3 次),患者精神症状消失,治愈出院。

出院前,据患者回忆,刚入院时神志不清楚,对住院后的情况只能部分回忆,如能回忆病后看到人的脸形都变了,阵阵紧张恐惧,往床底下钻,有时打人等。住院前曾一连十几天睡不着觉,学习、工作效率很低,甚至连简单的加法都做不出来等。

出院后随访:

1981 年 5 月分别接到患者本人及家属的来信,都称出院后已停药,精神状况良好,并已工作。患者在来信中称出院后休息了 1 年半,复学后于 1967 年大学毕业,毕业后参加工作至来信时为止已经 13 年。

(二) 病例分析

1. 诊断及诊断依据

本例主要临床特点是:

(1)前驱症状:在 1 月以前曾有类似神经症样症状,如头痛、注意力不集中、失眠等。有可能患者已经患有感染性疾病,但是未能被发现。

(2)病程特点:入院前 4 天明显精神失常,为急性起病,逐渐加重。

(3)主要精神症状

①意识障碍:该患者入院后即有明显意识障碍,表现为定向力障碍,不能正确分辨人物、地点及时间,同时呈波动性,表现为昼轻夜重。

②注意减弱:患者难以在较长时间内集中做一件事,例如在登记同学们交来的粮票时经常出错,计算粮票的数量也有错。

③思维不连贯:患者说话内容与环境脱节(可能和意识障碍有关,因为病人不能正确理解周围环境的变化),如遇见同学和团支部书记时所说的话使人费解,经劝说不能理解别人的意思(见病史中患者和团支部书记的谈话内容,以及自语的内容,可发现句子间的联系很松散),在住院前可能已经存在此症状。

④精神运动性兴奋:在入院前曾有夜间不眠、无故裸体外跑、自语,其内容与环境脱节,和自己的经历无关(如“我老婆在南京……”)。入院后精神运动性兴奋症状更加明显,如夜间兴奋不眠,无故冲动打人,说是要打外国人,将裸体向门外冲解

(4)护理要点:防止自伤、伤人行为。

病例二

(一)病历摘要

患者李某,女性,20岁。为某大学三年级学生,平时住校,周末回家,学习成绩好。病史由患者同学、老师、姐姐提供,可靠。

主诉:低热后精神失常1周余,注意力不集中,记忆力减退,说话糊涂,加重2天。

现病史:1993年5月10日,患者无明显诱因自觉低热、无力,口腔内有数个散在溃疡,于校医务室就诊,具体不详。给予维生素B₁、维生素B₂及栀子金花丸等中药口服,未见明显疗效。同时患者自觉记忆力明显减退,上课时注意力不集中。患者自觉:“怎么上课跟没上一样?”“刚复习完的功课怎么就忘了?”“什么都记不住了!”“我怎么挺忧郁的?”夜不眠,饮食差。5月14日考试的前一天复习功课时,患者无论如何也记不住复习的内容,刚看完一转眼就忘了。次日在同学的“帮助”下勉强答完了卷子。上午刚考完,下午就问同学什么时候考试。15日晨起吃过早餐后患者站在宿舍里不知该做些什么,问同学:“我平时吃完饭后都干什么呀?”经同学提醒后才知该去上课。晚上从男朋友处回来后说:“我怎么好像都不知道该在哪儿下车了,也不知道买没买票。”“我也不知道怎么这么高兴,栀子金花丸的药效真不错。”有时兴奋,用脚踢门。夜里,同宿舍同学发现患者起来二三次取药吃。晨起患者对同学说:“我夜里好像做梦起来过二三次,又觉得好像是真的起来了”,说话东一句西一句,“我怎么看东西都变样了,我自己怎么翻过来了……你们怎么都不一样了……这是咱们宿舍吗,怎么像一个同学家呢?”5月16日其男友也发现患者说话糊里糊涂的,便找其一好友一起送患者回家,患者问:“他是谁,找她干什么?”晚上同学告诉她:“你男朋友陪你玩儿了一天。”患者好像什么都不知道似地问:“我怎么不知道他来了?”不能回忆与大家一起交谈的情况。

5月17日,其姐姐带其到某医院就诊,在去医院的路上患者觉得疲乏无力不能行走,便叫了一辆出租车,在车上患者反复说:“真奇怪,真奇怪……”,看见行驶的车便问:“那是什么呀,怎么还会动呀?”,并向姐姐要刀片说要自杀。到医院后患者对医生说:“我是不是得神经病了……你给我打一针算了……我怎么觉得自己的行动像计算机一样编入程序了呢?”当时测体温37.9℃,未予以特殊处理。回家后常问一些毫无意义的问题,如:“杯子为什么听不懂人说话?”语乱,糊涂,分不清时

里糊涂的?”

患者表情呆滞,反应平淡,周围发生的任何事情均不能引起患者的注意,有时无故表现高兴,但是和周围环境不协调,对别人没有感染力。患者多卧床,在稍稍活动后极易疲劳,熟睡一段时间后精神状态可稍有好转。多有无目的性行为,如在病房里到处走来走去、徘徊,目光茫然,拿起病人包的生饺子就吃。患者有时平卧于床上,将左足跟置于右腿膝部反复乱动。

实验室检查:血常规示白细胞 $12\ 500/\text{mm}^3$,中性粒细胞 73%,淋巴细胞 27%。脑脊液常规及生化检查正常。脑脊液细胞学检查小淋巴细胞 87%(60%~70%),浆细胞 2%(0%),异形淋巴细胞 3%。脑电图及脑地形图正常。

(二) 病例分析

1. 诊断及诊断依据

本例主要临床特点是:①精神症状出现之前约 1 周有低热史及口唇疱疹。②意识障碍于一天当中持续存在且有波动。③有虚弱的表现。④精神症状。⑤脑脊液细胞学检查示小淋巴细胞 87%,为淋巴细胞反应伴有浆细胞,提示中枢神经系统病毒性感染。

诊断:(1)单纯疱疹病毒性脑炎

(2)感染中毒性精神障碍

2. 治疗

(1)抗病毒治疗。

(2)激素减轻脑水肿,抑制炎症反应。

(3)抗精神病药控制兴奋及精神病性症状。

(4)营养支持治疗。

3. 思考与分析

(1)该患者有哪些精神症状?

(2)该患者是否有意识障碍?为什么?

(3)该患者哪些动作属于刻板动作?

(4)患者在睡眠后精神症状就减轻,稍稍活动或多说几句话后精神症状就加重,这是什么原因?

(5)本病例是否有精神运动性兴奋,是瓦解性的还是协调性的?为什么?

(6)本病例的治疗方案应如何考虑?与前一病例有哪些区别?

(于靖)

颅脑损伤所致精神障碍

颅脑损伤所致精神障碍指由各种脑外伤导致的精神障碍和后遗症。

第一节 颅脑损伤所致精神障碍临床特点

一、病因

头部遭受直接或间接的外力作用造成脑组织损伤,从而产生精神障碍。头部外伤的后果可以是脑震荡、脑挫裂伤、颅骨骨折、颅内血肿等。脑组织的损伤因其部位、性质、程度不同,产生各种不同形式的精神障碍。

二、临床表现

(一)脑损伤引起或伴发的急性精神障碍

1. 脑震荡综合征

脑震荡后出现短暂意识丧失,但很快恢复。醒后患者对受伤时的情景和受伤

前的片刻不能回忆。可伴有头痛、呕吐、易激惹、缺乏自信、注意力不集中和自主神经症状(如皮肤苍白、血压下降)等表现。

2. 外伤后昏迷

未引起脑挫裂伤的严重脑震荡以及脑挫裂伤均可发生较为持久的昏迷,患者对刺激的反应丧失。昏迷后可出现一段时间的昏睡、不安、意识模糊等表现,以后有两种转归,或完全恢复或转入外伤性谵妄。

3. 外伤性遗忘—虚构综合征

最显著的表现是虚构,同时也存在记忆障碍。虚构可以是真实和杜撰的混合或完全是新的虚构。此类表现的持续时间较酒精中毒性病例要短。

4. 外伤性谵妄

谵妄一般由昏迷或昏睡演变而来,其内在脑损伤可为脑震荡或挫裂伤等。大多数病例,谵妄是轻微的,表现为意识模糊,易激惹,不安,定向障碍,困惑,恐惧等。严重的病例可处于混乱性兴奋状态,对自己和周围均具有危险性。有时谵妄被朦胧状态或梦样状态所取代。

(二) 脑损伤引起或伴发的慢性精神障碍

1. 颅脑损伤后综合征

发生在脑损伤以后的一般性脑衰弱症状,故又称之为外伤后脑衰弱状态。其临床表现与神经衰弱有许多类似之处,主要症状有如下几方面:

(1)头痛:最多见也最突出,部位多不固定,也可在受伤部位的局部、对侧或周围,或者在全头部。疼痛的性质为胀痛、钝痛或跳动痛。转动头部、变换体位、受到精神刺激、进行体力劳动或身体不适时,头痛均会加重,而在安静或平静时可减轻。

(2)头晕:多见。在突然转头、改变体位、乘车或乘船时容易发生。发作时伴有短暂的视物模糊,严重者可伴有恶心和眩晕。可为阵发性或持续性。

(3)睡眠障碍:常见。多表现为入睡困难、易醒、多梦和早醒。有的病人缺乏睡眠感,即使曾入睡也总感到彻夜未眠。

(4)激惹性增高:病人对于环境中的声音、光线、冷热等感觉刺激过分敏感,微弱的声光刺激,病人也会感到十分强烈和难以忍受。

(5)注意力不集中、记忆力减退、思维迟缓、易疲劳和厌倦、周身不适、疲倦无力,且易产生疑病观念。对学习和工作缺乏主动性和进取心。

(6)情感障碍。情绪不稳、易激惹、易伤感、不能控制感情。有的患者情绪低沉、抑郁,对周围事物缺乏兴趣。微弱刺激往往引起强烈的反应,如紧张、恐惧、惊

药有减轻紧张、烦躁不安情绪和改善睡眠的作用。有癫痫发作者进行抗癫痫治疗。人格改变和外伤后痴呆病人,可给予训练、教育和工娱治疗。至于有幻觉妄想的颅脑损伤伴发精神障碍的病人,可给予抗精神病药物治疗,如氯丙嗪、奋乃静。

(三) 心理治疗

对于急、重型脑外伤经手术或保守治疗病情稳定后或轻型脑外伤者康复期,其表现的头痛、头晕、记忆力下降、睡眠障碍等多种多样的自觉症状经单纯药物治疗效果欠佳,造成病程迁延者,主要是因为心理素质缺陷,因此,迫切需要辅以心理治疗。医护人员在处理和照顾病人时应耐心、细致,主动深入地了解病人的心态,取得患者的信任,并鼓励患者,培养其自信乐观的态度,帮助患者完成其力所能及的日常活动,克服他们不健康的、不现实的观念,将对病人的病情恢复具有积极的作用。

第二节 颅脑损伤所致精神障碍诊断标准

国内 CCMD-3 标准中,按“脑外伤所致精神障碍”进行诊断。

一、02.4 脑外伤所致精神障碍诊断标准

1. 符合器质性精神障碍的诊断标准。
2. 脑外伤导致不同程度的意识障碍。
3. 精神障碍的发生、发展及病程与脑外伤相关。

二、02.41 脑震荡后综合征诊断标准

(一) 症状标准

1. 符合脑外伤所致精神障碍的诊断标准。
2. 有脑外伤导致不同程度的意识障碍病史。
3. 目前的症状与脑外伤相关,并至少有下列 6 项中的 3 项:①头痛、眩晕、内感性不适或疲乏。②情绪改变,如易激惹、抑郁或焦虑。③主诉集中注意困难、思考效率低或记忆损害,但是缺乏客观证据(如心理测验正常)。④失眠。⑤对酒的

耐受性降低。⑥过分担心上述症状,一著程度的疑病性超价观念和采取病人角色。

4. 中枢神经系统和脑 CT 检查,不能发现弥漫性或局灶性损害征象。

(二) 严重标准

社会功能受损。

(三) 病程标准

符合症状标准和严重标准至少已 3 个月。

(四)排除标准

排除脑挫裂伤后综合征、分裂症、情感性精神障碍或创伤后应激障碍。

三、02.42 脑挫裂伤后综合征诊断标准

脑挫裂伤是头颅受外力直接作用产生的器质性损伤,其特征为严重持久的意识障碍,历时 30 分钟以上。以全脑损伤症状为主,可并有局灶性症状、继发蛛网膜下腔出血或颅内血肿。由脑挫裂伤导致的后遗神经症性症状称脑挫裂伤后综合征。

(一) 症状标准

1. 符合脑外伤所致精神障碍的诊断标准。
2. 脑挫裂伤导致严重持久的意识障碍历时 30 分钟以上。
3. 目前症状与脑挫裂伤相关,并符合“02.41 脑震荡后综合征的症状标准 3”。
4. 中枢神经系统和脑 CT 检查发现弥漫性或局灶性损害征象、继发蛛网膜下腔出血或颅内血肿。

(二) 严重标准

社会功能受损。

(三) 病程标准

符合症状标准和严重标准至少已 3 个月。

(四) 排除标准

排除脑震荡后综合征、分裂症、情感性精神障碍或创伤后应激障碍。

第三节 典型病例分析

一、病例一

+++++

(一) 病历摘要

患者聂某某,男,36岁,高中文化,汉族,技术工人,再婚。

主诉:因头部受伤,昏迷2个月后入睡困难、头痛、行为幼稚、无故发脾气、骂人、砸东西4年而入院。

现病史:1994年春,患者回家上楼时,不小心从楼梯上摔下(约12级台阶),当时昏迷,耳道流血,急送某医院抢救,诊断为“①颅内血肿;②脑挫裂伤。”行开颅手术,手术顺利,术后昏迷约2个月。患者醒后记忆力丧失,说不出自己的姓名,不知道自己的年龄,不认识家人,不能回忆自己以前的经历,后逐渐恢复,但仍不能回忆自己受伤时的场景。患者常诉头痛,睡不着。同时,患者出现性格改变,表现为行为幼稚,与邻居小孩争东西吃,抢过来后喜形于色,抢不过来则怒气冲天;好发脾气,常无故骂人,家中无人招惹患者,患者常突然骂家人;平时听见汽车鸣笛便指着汽车破口大骂,有时指着司机大骂;走在街上与路人目光相触时,也常常指着对方大骂,为此数次险些被打,但患者转眼就对此矢口否认。患者常常到街上捡废旧物品和垃圾,如破布、碎纸、烂水果等回家,家人劝说无效,而且患者对此并不作解释。常常到农田里跑来跑去,大跳大叫,喜形于色,把庄稼都毁掉,对其劝说无效。工作能力下降,明显不能胜任以前的工作,不得不病休在家。因家属护理困难,送入精神病医院,于1998年6月2日首次住院。

入院前半月二便正常,进食好,无腹泻及上呼吸道感染史。

既往史:平素体健,否认药物过敏史。

个人史:胞2行2,其母孕期体健,足月顺产,患者幼年发育正常,适龄上学,成绩一般,高中毕业后参加工作,能力尚可。1994年受伤后一直在家休息。患者1986年首次结婚,婚后夫妻感情欠佳,1995年离婚。1996年患者与现妻结婚,育

一子,体健。患者平时性格内向,乐于助人,有修养,偶饮酒,无不良嗜好。

家族史:阴性。

体格检查:

体温 36.4℃,脉搏 84 次/分,呼吸 18 次/分,血压 130/70 mmHg。发育正常,营养良好,自主体位,全身皮肤无黄染,浅表淋巴结无肿大,左前额部可见一 4 厘米×4 厘米大小凹陷,质软。五官端正,颈部对称,气管居中,甲状腺无肿大,胸部无畸形,双肺未闻及干、湿啰音。心界不大,各瓣膜区未闻及病理性杂音。腹部平软,肝脾未及,无压痛。

神经系统检查:

头颅大小、形态正常,脊柱无畸形,颅神经检查未见异常,全身深、浅感觉和皮层感觉未见异常;肌力、肌张力正常,深、浅反射正常,未见病理征。

精神检查:

患者入院后意识清晰,定向力完整,接触被动,对答切题,未引出明显感知觉障碍。交谈中,患者否认自己平时的异常行为,当谈到患者平时无故骂人、捡垃圾等行为时,患者连连摇头,坚决否认,认为自己是因为头部摔伤、失眠、头痛等才住院的。注意力欠集中,与其进行交谈时,患者常常走神,需提醒,但坚持十几秒后又走神。智力检查时,患者欠合作,拒绝进行 100 递减 7 的测验,拒绝解释成语,说“用脑子就头痛”。近记忆力、瞬时记忆正常,患者对自己受伤时的情景记不清。无自知力。平时情绪易波动,易激惹,常无故大骂其他病友,对医护人员的劝说能勉强听从。多独自活动,少与病友来往,对将来无明确打算。

(二) 病例分析

1. 诊断及诊断依据

(1)患者男性,36 岁,病前性格偏内向,有修养。

(2)头部外伤后耳道流血、昏迷约 2 个月,送医院诊断为“①颅内血肿;②脑挫裂伤”。抢救清醒后,出现精神障碍。

(3)精神症状

①失眠:表现为入睡困难,此症状在受伤后出现,为颅脑损伤后综合征表现之一;

②头痛:尤其在思考问题时加重,为颅脑损伤后综合征表现之一。

③注意力涣散:与其进行交谈时,患者常常走神,需提醒,但坚持十几秒后又走神,为颅脑损伤所致精神障碍的症状之一,也为颅脑损伤后综合征表现之一。

④工作能力下降:此现象可能为颅脑损伤后出现的失眠、头痛、注意力涣散、性格改变等诸多因素共同导致。

⑤情绪改变:好发脾气,常无故骂人,家中无人招惹患者,患者常突然骂家人;平时听见汽车鸣笛便指着汽车破口大骂,有时指着司机大骂;走在街上与路人目光相触时,也常常指着对方大骂,为此数次险些被打。

⑥人格改变:本例人格障碍是在脑外伤后出现的,属继发性,医学上叫人格改变。表现为行为幼稚,与邻居小孩争东西吃,抢过来后喜形于色,抢不过来则怒气冲天;到街上捡废旧物品和垃圾,如破布、碎纸、烂水果等回家,家人劝说无效,而且患者对此并不作解释;常常到农田里跑来跑去,大跳大叫,喜形于色,把庄稼都毁掉,对其劝说无效。属于脑损伤引起的慢性精神障碍。

⑦曾有过脑挫裂伤综合征、外伤性昏迷等表现。

(4)查体:左前额部可见一4厘米×4厘米大小凹陷,为脑组织大面积缺损所致。

综上所述,患者脑外伤后严重持久的意识障碍持续近2个月,此后出现失眠、头痛、注意力涣散、情绪和人格改变等精神症状,其工作生活能力严重受损,以上症状已持续近4年,故根据CCMD-3入院诊断为:

02.42 脑挫裂伤后综合征[F07.8]其他脑器质性人格障碍和行为障碍

2. 鉴别诊断

神经症:二者皆有自主神经系统症状,易混淆;但脑外伤所致精神障碍有明确的脑外伤史,且其自主神经系统症状比神经症重。部分脑外伤所致精神障碍患者的实验室检查异常,而神经症没有。故不考虑该诊断。

3. 诊治方案

(1)入院后完善各项检查。

(2)患者目前情绪不稳,易激惹,予其氯丙嗪200 mg/d对症处理;合并心境稳定剂丙戊酸钠0.8 mg/d处理。

(3)予以疏导性心理治疗。

(4)鼓励患者参加回归社会技能训练的康复活动,能够有效地减轻其精神残损的程度。

患者住院后接受以上治疗,约1个月后症状渐缓解,但偶尔还无故骂人,4个月后显著好转出院。

4. 预后估计

患者外伤后出现精神障碍,其病前性格偏内向、有修养;病程较长,近4年,此次住院接受系统抗精神病药物治疗,估计近期效果较好,如果其能继续参加其他的

心理社会康复措施,估计远期效果可能较好。

二、病例二

+++++

(一) 病历摘要

患者张某某,男,43岁,已婚,汉族,工人。

主诉:脑外伤后出现入睡困难、自言自语、疑心、凭空听见声音近2个月;加重半个月。

现病史:患者于2000年2月中旬头部被汽车撞伤后昏迷,半小时后清醒,不能回忆以前的事情,情绪不稳。被送至当地医院,诊为“①头皮裂伤;②脑震荡”。CT显示:硬膜下积液。予抗炎、营养神经治疗,不见好转,并出现不认识家人,在病房内彻夜徘徊,自语,反复说“我修炼许多年了,我是玉皇大帝。”认为病房里有窃听器、摄像机,总说:“老窃听我干啥?你老说我干啥?我还有4天的寿命,4天后我就死了……”听到外面的脚步声,便认为是送检举材料的来了。别人打电话,他认为在说他。家人买来蛋糕,便认为里面有迷魂药,历时约1周。以后又出现不吃、不动、不语,对治疗不合作约1周,以后虽逐渐好转,但患者对当时的情况不能完全回忆,而且失眠严重,表现为入睡困难。家人护理困难,送至北京治疗,于外院行CT检查,未见异常。被送至我院门诊,门诊诊为“①脑外伤后精神障碍;②轻度脱水。”予舒必利0.1g/d;佳静安定1.2mg/d处理,此后患者间断服药,病情有所好转,认识家人,可与他人交谈,入睡也有所好转,但仍有时自语。

2000年3月29日无明显诱因,患者病情加重,反复诉外面有人说他装病,觉得外面的声音特别大,刺耳。感到胸闷、生气,为进一步诊治,经门诊首次收住院。发病以来,患者饮食、睡眠差,二便基本正常。

既往史:平素体健,否认食物、药物过敏史。

个人史:胞4行2,其母孕期体健,患者幼年发育正常,适龄上学,成绩一般,初中毕业后在家务农。结婚19年,夫妻感情好,育一女,体健。患者吸烟史10余年,每日20余支。病前性格:内向,不善交往。

家族史:阴性。

体格检查:

体温36.4℃,脉搏78次/分,呼吸18次/分,血压120/80mmHg。发育正常,营养中等,全身皮肤黏膜未见黄染、出血,全身未及肿大的浅表淋巴结。五官端正,

颈部对称,气管居中,甲状腺无肿大。胸部无畸形,双肺未闻及干、湿啰音。心界不大,各瓣膜区未闻及病理性杂音。腹部平软,无压痛,肝脾未及。

神经系统检查:

头颅大小、形态正常,脊柱无畸形,颅神经检查未见异常,全身深、浅感觉和皮层感觉未见异常,肌力、肌张力正常,深、浅反射正常,未见病理征。

辅助检查:

未见异常。

精神检查:

入院后意识尚清晰,人物、地点定向力好,时间定向欠佳。接触被动。存在听觉过敏,患者觉得楼道里的声音特别大,震得自己心里难受。可引出假性幻视,诉脑子里能凭空看到电视台爆炸,电视机爆炸。可引出真性幻听,听到外面有人说自己有病。回答问题慢,语量少,声音低,反复诉:“我的脑子不好使了,一用脑子就头痛。”对答基本切题,交谈中可引出关系妄想,认为外面的病人说话是在故意打扰自己休息。

注意力涣散,交谈中病人总是说着说着就看外面,不能持久地保持注意力。记忆力差,以近记忆为著,记不清自己的住院日期。存在顺行性、逆行性遗忘,记不清车祸前后发生的事情。计算力差,不能做 100 递减 7 的测验。无自知力,只承认自己失眠,希望治疗自己的外伤,否认有精神病。情绪不稳,常出现焦虑、紧张,自述心烦、痛苦,想摆脱目前这种情况。多独处,少与病友交往,未见冲动行为。

(二) 病例分析

1. 临床特点

(1) 患者为 43 岁中年男性,病前性格内向。

(2) 脑外伤后(诊断为“①头皮裂伤,②脑震荡”)昏迷半小时,清醒后出现精神障碍,连续病程近 2 个月。

(3) 精神症状

①谵妄状态:表现为不认识家人,在房间内彻夜徘徊,自语,反复说“我修炼许多年了,我是玉皇大帝。”认为病房里有窃听器、摄像机,总说:“老窃听我干啥?你老说我干啥?我还有 4 天的寿命,4 天后我就死了……”听到外面的脚步声,便认为是送检举材料的来了。别人打电话,患者认为在说他。家人买来蛋糕,便认为里面有迷魂药等。

②木僵状态:在谵妄状态后接着出现,表现为不吃、不动、不语,对治疗不合作

约 1 周,缓解后对当时的情况也不能完全回忆,不能排除当时也有意识障碍。

③感知觉障碍:在患者意识清晰后出现,包括听觉过敏,患者觉得楼道里的声音特别大,震得自己心里难受。幻听,听到外面有人说自己有病。幻视,诉脑子里能凭空看到电视台爆炸,电视机爆炸。

④思维障碍:思维迟缓,有牵连观念,认为外面的病人说话是在故意打扰自己休息。

⑤情感障碍:包括情绪紧张、焦虑。

⑥失眠:表现为入睡困难。

⑦曾有过脑震荡综合征、外伤性昏迷等表现。

⑧其他:包括注意力不集中,记忆力减退,无自知力等。

综上所述,患者脑外伤后存在意识障碍,此后出现一系列精神症状,经治疗后行 CT 检查未见弥漫性、局灶性损害,故根据 CCMD 3 入院诊断考虑为:

02.41 脑震荡后综合征[F07.2]

2. 鉴别诊断

反应性精神病。支持点有:患者车祸后出现精神障碍,且有紧张、焦虑情绪。

不支持点有:①有明确脑外伤史,头颅 CT 显示硬膜下积液。②曾出现谵妄。一般说来反应性精神病时所出现的意识障碍较谵妄为轻。③存在大量幻听、幻视、牵连观念等与心因内容无关的精神病性症状。④其紧张、焦虑缘于幻听、幻视。故目前暂时不考虑该诊断。

3. 诊治方案

(1)完善各项常规检查。

(2)选择中枢抗胆碱能作用小、锥外反应轻的抗精神病药物,予此患者奋乃静 12 mg/d 处理。

(3)予疏导性心理治疗。

(4)患者住院接受上述治疗约 2 周后,症状渐好转,住院约 5 个月后显著好转出院。

4. 预后估计

患者为中年男性,病前性格内向。脑外伤后出现精神障碍,在外院经治疗只是躯体状况改善明显。此次住我院前行 CT 显示颅内无异常。此次为首次住我院接受系统抗精神病药物治疗,辅以心理治疗,估计效果较好。

(项玉涛)

内肿瘤中,以胶质细胞瘤发生精神症状最多。生长在额叶、颞叶、胼胝体及第3脑室附近的肿瘤最常发生精神症状,且症状出现较早也较重。累及两侧半球的脑肿瘤(如转移瘤)也常出现明显的精神症状。而位于顶叶、枕叶的肿瘤则较少出现精神症状。

1. 一般性症状

即颅内肿瘤本身所引起的一般共性症状。

(1)意识障碍:是脑肿瘤的一般性症状,可见于任何部位快速发展的肿瘤。病人可表现为意识模糊、注意力不集中、反应迟钝和理解困难,嗜睡、谵妄乃至昏迷。

(2)记忆障碍:常见于缓慢生长的颅内肿瘤,但邻近脑底部和第3脑室的局限性损害也可引起。开始表现为远近记忆减退,一般即刻记忆可相对保持完好。随病程发展,常可出现识记能力障碍、时间定向力障碍、虚构症和顺行性遗忘症,即遗忘综合征。

(3)智能障碍:缓慢生长且病程较久的脑肿瘤病人及快速浸润生长的脑肿瘤病人均可出现智能障碍,表现为计算、理解、判断能力的缺损,多数病人常因此不能工作,严重者发展为痴呆。

(4)人格改变和行为异常:常与智能障碍同时出现。病人变得懒散、退缩、兴趣减少、不讲礼貌、不讲卫生、不知羞耻。有的病人可出现离奇和怪异行为。

(5)情感障碍:亦多与智能障碍同时存在。主要表现为情感淡漠,部分病人可有无故哭笑、情绪不稳、烦躁不安、焦虑、抑郁、易怒,偶尔可出现欣快。

(6)幻觉妄想症状:发展缓慢的颅内肿瘤病人中,幻觉也是较为常见的症状之一。常见为幻听,其次有幻视、幻嗅、幻触等,多见于颞叶和顶叶肿瘤患者。有的病人还可出现被害妄想、夸大妄想、疑病妄想及影响妄想。妄想结构松弛不固定,具有器质性特点。

2. 局限性症状

即颅内肿瘤由于生长于不同的部位所产生的症状。

(1)额叶肿瘤:精神症状较其他部位的肿瘤多见,出现时间也较早,常见为人格改变。初期表现为精神萎靡、情感淡漠、反应迟钝,逐渐病人变得幼稚、诙谐、愚蠢、说话夸张、态度傲慢,有时又过分亲热、表情欣快、行为放纵。病人的抽象思维能力、主动性减退,对工作的兴趣和工作能力明显下降,不负责任,玩忽职守。严重者表现呆板、迟钝、嗜睡或低级意向增强,可有不知羞耻或不道德行为。若肿瘤侵及扣带回,可产生运动不能性缄默症。少数病人有重复言语、重复动作、模仿动作。有的病人可表现为类似精神分裂症和类躁狂状态。此外还可有记忆减退和智能

障碍。

(2) 颞叶肿瘤: 大约 70% 的颞叶肿瘤出现精神症状。尤其生长于优势半球侧的肿瘤, 精神症状更为多见。主要表现为情感淡漠、反应迟钝及智能损害, 并伴有明显的记忆减退。情感障碍可表现为焦虑、抑郁或躁狂、欣快。有的类似精神分裂症、疑病症。人格改变常表现为幼稚愚蠢。早期发生和迅速进展的痴呆是颞叶肿瘤的特征性症状。沟回发作也是颞叶肿瘤具有诊断价值的症状, 表现为发作性幻嗅、幻味, 伴有轻度眩晕, 随之出现短暂的意识障碍, 病人如在梦中, 突然面无表情, 中断谈话, 凝视不动, 并可出现旧事如新症或似曾相识症, 也可产生非真实感和感知综合障碍。在意识障碍基础上, 病人表现出焦虑不安和无名恐惧。同时伴有吐舌、舔唇、咂嘴、咀嚼等不自主运动。约半数颞叶肿瘤患者有癫痫样发作, 以精神运动性发作最为常见。也可见大发作、小发作及局限性发作。

(3) 顶叶肿瘤: 出现精神症状较少。主要表现为精神活动迟钝、思维迟缓、主动性降低、精神萎靡、理解力下降。对环境兴趣减少, 记忆力减退, 情感淡漠、迟钝, 也可有焦虑、抑郁、恐惧或欣快, 也可见人格改变。

(4) 枕叶肿瘤: 以幻视最为常见, 多为原始性幻视。病人看到闪光、火球。幻视多在病灶对侧的视野中出现。部分病人有明显的注意和记忆障碍, 偶尔可见遗忘症与痴呆。此外还可见到情感障碍和人格改变。

(5) 胼胝体肿瘤: 多见严重的精神障碍, 且经常发生于肿瘤的早期。由于受损部位不同, 表现各异。生长在胼胝体前部的肿瘤表现为始动性缺乏, 言语贫乏, 模仿言语, 理解力下降及人格改变。胼胝体后部肿瘤则常出现记忆及定向障碍。

(6) 间脑肿瘤: 肿瘤可损及丘脑、丘脑下部及临近的第 3 脑室。间脑肿瘤常有嗜睡或短暂的嗜睡发作, 也可以出现痴呆。间脑肿瘤的情感障碍很明显, 且变化急剧。可从情绪严重抑郁转为极度欣快, 或在情感控制有缺乏的背景上出现突然地情感暴发。间脑后部和中脑上部的肿瘤可引起运动不能性缄默症, 病人睁眼但无自主言语及运动, 对周围事物不理解。丘脑下部肿瘤可引起人格改变, 病人冲动兴奋, 对工作不负责任或主动性降低, 行为幼稚愚蠢。第 3 脑室肿瘤常引起显著的近记忆障碍, 病人远记忆保持良好, 少数病人表现为柯萨可夫综合征。

(7) 垂体肿瘤: 精神症状多种多样, 主要为嗜睡、局限性遗忘、人格改变。病人精神迟钝、情感淡漠、行为被动、情绪不稳, 易激惹或暴怒, 对自身的健康漠不关心。肿瘤向上扩展到第 3 脑室, 可引起间脑肿瘤的特殊症状。若向前扩展到额叶, 或向两侧扩展侵及颞叶, 则引起相当复杂的症状, 如颞叶的沟回发作症状。若肿瘤影响到脑脊液循环障碍, 则可出现颅压增高的精神症状。

第二节 颅内肿瘤所致精神障碍的诊断标准

国内 CCMD-3 标准中,按“脑瘤所致精神障碍”进行诊断。

02.5 脑瘤所致精神障碍[F02.8 在它处分类的其他特定疾病所致痴呆]诊断标准:

- (1)符合器质性精神障碍的诊断标准。
- (2)有脑瘤的证据,且精神障碍的发生、发展及病程与脑瘤相关。

第三节 典型病例分析

一、病例一

+++++

(一) 病历摘要

患者郑某某,男,51岁,中专文化,干部,已婚。

主诉:不自主动作增多、性格改变、记忆减退、语乱1年。

现病史:患者于1966年5月开始出现手脚、面部肌肉不自主乱动,于同年10月住当地医院诊断为“舞蹈症”,经治疗动作减少(治疗情况不详)。住院期间发现病人有性格改变,如贪吃,随便拿其他病人的食物吃,抱着男同志就亲,随便在病室内及床上大小便,有时玩尿,还表现得若无其事。记忆力也逐渐减退,刚发生的事就忘了。语无伦次,常常答非所问。近来,进食被动,不督促就不知道吃饭,生活不能自理。为进一步诊断和治疗于1967年1月9日送来我院。门诊以痴呆状态收入院。

既往史:体健,否认传染病史。否认躯体疾病史和手术外伤史。否认药敏史。

个人史:幼时生长情况不详,毕业于某师范学校,1938年参军,1947年转业参加工作,1957年在某省任水利工程局副局长,1963年任农机学院院长,1965年任农业厅厅长,做事稳重,工作认真负责。抽烟20年,每天1盒。不嗜酒。婚育史:结婚30年,夫妻感情好,育二子三女,均体健。病前性格:个性较孤僻,脾气急躁。

家族史:父母两系三代家族成员中无精神分裂症、痴呆、精神发育迟滞及人格障碍患者。否认近亲婚配。

性极大,胃出血可能为脑肿瘤影响到下视丘所致,建议手术治疗。转院后行右额部开颅术,切开额叶皮层,直达右侧脑室前角,见有大囊性肿物占据,壁薄,手术过程中壁破,囊液流出后则右侧脑室空空,清楚见到扩大的室间孔和第3脑室,继而切除囊壁向深部追踪,发现实质部分瘤组织直径约3厘米,由于边界不清,仅部分切除。病理报告为多形性胶质母细胞瘤。术后行放射治疗。

诊断:

02.5 脑瘤所致精神障碍[F02.8]

(二) 病例分析

1. 诊断及诊断依据

(1)患者男性,51岁,干部,病前性格较孤僻,脾气急躁,做事稳重,工作认真负责,既往无特殊躯体疾病史,家族史阴性。

(2)病史1年余,以动作增多为首发症状,以后出现精神症状。

(3)精神症状

①人格改变:患者病后有明显的性格改变,如贪吃,抱着男同志就亲,随地大小便,玩尿,也不以为耻,与其既往生活经历及目前社会地位均不相称。

②痴呆:记忆、智能全面减退,对于何时毕业、参加革命、入党,到过什么地方及儿女的名字等均记忆不起,对于早上吃什么东西了也记不住,不能正确运算简单减法,理解力也下降,如问一张桌子4个角,砍掉1个还有几个,答3个。时间、地点、人物定向力均差。

③情感欣快:情绪欣快,面带笑容,有时嘴里哼着小曲。

(4)躯体症状和体征:脸部、四肢不自主运动,挤眉弄眼作怪样,四肢不自主舞动。有颅内压增高的症状:反复呕吐,查体发现双视乳头边缘欠清楚,双跟腱反射低。

(5)辅助检查:脑脊液显示蛋白含量增加,气脑造影和脑血管造影显示第3脑室前部、额叶底部鞍上占位病变。

综上所述,患者以不自主运动增多为首发症状,曾诊断为“舞蹈症”,入院检查精神症状主要为一典型的痴呆综合征,伴有颅内压增高的症状和体征,进一步进行影像学检查显示颅内占位性病变,神经科会诊意见为颅内肿瘤可能性大,经手术及病理检查结果证实为多形性胶质母细胞瘤,从而确诊为:脑瘤所致精神障碍。

2. 鉴别诊断

(1)亨廷顿病:患者以不自主运动增多为首发症状,曾诊断为“舞蹈症”,精神症

状为一典型的痴呆综合征,应与之鉴别。亨廷顿病临床表现也为痴呆和舞蹈样动作,但痴呆发生缓慢,情绪障碍突出,影像学检查可显示脑室扩大,脑萎缩尤以额叶为主;而本患者痴呆进展快,影像学检查显示占位性病变,故可排除。

(2)人格障碍:患者人格改变突出,应与之鉴别。但人格障碍通常开始于童年时期或青少年时期,并长期持续发展至成年;本患者起病于50岁,其人格改变是继发于脑器质性疾病的,是属于假性病态人格,故可排除。

3. 治疗方案

患者已出现明显的颅内压增高症状,住院后不久影像学检查显示占位性病变,经神经外科会诊建议手术治疗。患者转外院手术治疗后进一步确诊,症状也有所好转。术后多动减少,左上下肢肌力稍弱,可以自由活动,定向力、智力、记忆力都有所改进。

4. 预后估计

颅内肿瘤所致精神障碍的预后最终取决于原发疾病的转归。患者手术后病理报告为多形性胶质母细胞瘤,为胶质瘤中恶性程度最高的肿瘤。肿瘤呈浸润性生长,增长迅速,病程发展快,治疗较为棘手,手术常无法彻底切除且复发迅速,对放射治疗及化学治疗均不敏感。不少医师认为手术与否差别不大,平均生存时间只10个月左右。估计此病人复发可能性很大,长期预后欠佳。

二、病例二

(一) 病历摘要

患者杨某某,男性,41岁,小学文化,干部,已婚。

主诉:癫痫大发作6年;疑心有人害他、疑心爱人有外遇2年;近半个月加重,冲动伤人外跑。

现病史:患者曾于1966年某日在工作中突然摔倒,四肢抽动,口吐白沫,当时送至某医院诊断为癫痫症,给予抗癫痫药物治疗。此后一直服用苯巴比妥和苯妥英钠,但仍有癫痫大发作的现象,每隔几个月发作1次,每次发作均是发作前大叫一声,突然摔倒,四肢挺直然后抽动,口吐白沫,每次持续1~2分钟,有时伴有大小便失禁,舌头咬破及头部和四肢外伤。

1970年7月份开始病情加重,每月发作2~3次,甚至更多,有时一天发作几次,每次发作同前,并开始出现精神失常,总疑心有人骂他。于1970年10月18日

首次来我院门诊,诊断为癫痫,予苯妥英钠、苯巴比妥、安眠酮治疗后发作停止,但精神症状加重,总认为别人要害他,紧张害怕,觉得不如一死,曾吞服大量安眠药企图自杀,经抢救未造成恶果。1971年仍常说有人背地里陷害他,要逮他,怀疑自己的爱人与其他男子勾搭,并一起整他,常破口大骂爱人是破货,骂孩子是反革命,动手打爱人和孩子。有时讲话南腔北调,有时大声说外国话,实际病人并不懂外语。来我院门诊给予氯丙嗪治疗后无明显好转。近半月来病情加重,自言自语,常无故对着墙发笑,冲动打骂家人,夜间不眠,到处乱跑,故于1972年4月10日送入院治疗。

既往史:否认传染病史。否认重大躯体疾病史。否认颅脑外伤、感染及高热抽搐史。否认外伤史。曾于1958年行阑尾切除术。否认药敏史。

个人史:幼年情况不详,高小毕业后到某工厂当学徒,现为某税务局干部,工作表现较好,为中共党员。婚育史:结婚近20年,夫妻感情尚好,育一子一女,均体健。病前性格:性子急,好说,好交际,心胸较开朗,遇事果断。

家族史:父亲既往有精神失常史,具体不详,于1962年因病故去。否认父母两系三代其他人有类似精神疾病、癫痫及人格异常者。否认家族中有近亲婚配者。

体格检查:

体温 36.2°C ,脉搏72次/分,呼吸20次/分,血压120/90 mmHg。发育正常,营养中等,全身皮肤黏膜未见黄染、皮疹,全身浅表淋巴结无肿大。五官端正,颈部对称,气管居中,甲状腺不大。胸部无畸形,双肺呼吸音清,听诊无干、湿啰音。心界不大,心率80次/分,心律整齐,各瓣膜区未闻及杂音。腹平软,无压痛,右下腹有手术瘢痕,肝脾肋下未触及。

神经系统检查:

头颅大小正常,双侧瞳孔等大等圆,对光反射灵敏,眼球运动各方向自如,伸舌居中,口角稍向左歪。无感觉障碍。四肢肌力、肌张力正常,深浅反射正常,病理反射未引出,指鼻跟膝胫试验能完成。脑膜刺激征阴性。

实验室检查:

未见异常。

精神检查:

年貌大致相符,衣着尚整洁,意识清楚,定向力完整,接触尚好,护理合作,生活能自理。常自言自语,可引出幻听,称常听见有人骂他,但看不见人。说话有时用湖南口音,有时用湖北口音,一会又用“外语”说话,常令人难以听懂。思维内容较凌乱,无固定的主题,存在嫉妒妄想和被害妄想:对爱人与别人勾搭坚信不移,并称

有一帮人要陷害他,逮他,并表示气愤。远近记忆力尚好,能回忆既往之事和最近发生的事。能回答一般的问题如重大节日,计算力因不合作未作详细检查。无自知力。情感不协调,常无故发笑。多独自在楼道里徘徊,有时蹲在墙角发呆,未见冲动伤人行为。

辅助检查:

超声波显示中线平均右移 0.2 厘米。脑电图广泛中度异常。左颈动脉造影:左侧中央区占位性病变。

住院经过和随访结果:

入院后给予苯妥英钠、苯巴比妥、氯丙嗪 450 mg/d 治疗,大发作基本控制,但约 1 个月后逐渐出现构音不清,以及右侧轻瘫体征:吃饭时右手常掉筷子,右下肢无力,走路时步态不稳。此后症状逐渐加重,右手不能写字,不能持物,一拿就掉,不能自己进食,生活不能自理。外院神经科就诊考虑脑肿瘤,故于 1973 年 6 月 11 日出院。外院手术切开额中回中部皮质 1 厘米,见肿瘤在左额顶部,边界不清,向言语中枢及额回深部发展。手术将额极、额中上回肿瘤部分切除,深部及言语中枢下残留部分肿瘤。病理诊断:左额顶生长活跃的星形细胞瘤部分胶母变(相当于星形细胞瘤Ⅱ—Ⅲ级)。诊断:

02.5 脑瘤所致精神障碍[F02.8]

(二) 案例分析

1. 诊断及诊断依据

(1)患者男性,41 岁,干部,病前性格:性子急,好说,好交际,心胸较开朗,遇事果断,既往无特殊躯体疾病史,父亲有精神失常,具体不详。

(2)癫痫发作史 6 年,近 2 年出现精神症状,并逐渐加重。

(3)精神症状

①幻听:患者称常听见有人骂他,但看不见人。

②嫉妒妄想:患者坚信自己的爱人与其他男子勾搭,并一起整他,常破口大骂爱人是破货,骂孩子是反革命,并受妄想支配动手打爱人和孩子。

③被害妄想:患者总认为别人要害他,紧张害怕,觉得不如一死,受妄想支配曾吞服大量安眠药企图自杀。

④冲动行为:受妄想支配有冲动伤害家人和自杀行为。

(4)躯体症状和体征:入院前反复出现癫痫大发作,入院后逐渐出现较明显的神经系统局灶性体征:构音不清,右侧偏瘫进行性加重。

(5)辅助检查:超声波检查中线平均右移0.2厘米。脑电图广泛中度异常。左颈动脉造影:左侧中央区占位性病变。

综上所述,患者以癫痫大发作为首发症状,曾诊断为“癫痫症”,入院检查精神症状主要为幻觉妄想综合征,入院诊断首先考虑癫痫性精神障碍,精神分裂症待除外。随后出现了较明显的局灶性神经系统定位体征,结合辅助检查,神经科会诊意见为颅内肿瘤可能性大,经手术及病理检查结果证实为星形细胞瘤部分胶母变,确诊为脑瘤所致精神障碍。

2. 鉴别诊断

(1)癫痫所致精神障碍:患者以癫痫大发作为首发症状,随后出现精神症状,应与癫痫所致精神障碍鉴别。患者为中年以后出现癫痫发作,故首先考虑为症状性癫痫,辅助检查显示占位性病变,故可以进一步排除。

(2)精神分裂症:患者精神症状为幻觉妄想综合征,应与精神分裂症鉴别。精神分裂症患者常见幻觉妄想综合征,但确诊前应排除器质性疾病,本患者的精神症状是在器质性疾病之后出现的,应尽量用一元论解释,脑器质性疾病在先,不应再诊断功能性疾病。

3. 治疗方案

入院后给予苯妥英钠、苯巴比妥治疗后大发作基本控制,并给予氯丙嗪治疗其精神症状,均为对症治疗。但住院后不久逐渐出现神经系统局灶体征,辅助检查显示占位性病变,经神经外科会诊建议手术治疗。患者转外院经手术治疗进一步明确诊断。

4. 预后估计

颅内肿瘤所致精神障碍可给予精神科药物对症处理,预后最终取决于原发疾病的转归。患者术后病理报告为生长活跃的星形细胞瘤部分胶母变(相当于星形细胞瘤Ⅱ—Ⅲ级)。星形细胞瘤恶性程度较低,生长缓慢,但边界不清的实质性星形细胞瘤不能彻底切除,术后仍要复发,需加用放射治疗及化学治疗,5年生存率可达30%。本患者手术中发现肿瘤边界不清,仅部分切除,估计复发可能性大,预后不佳。

(李 樱 江镇康)

脑变性疾病所致精神障碍

第一节 肝豆状核变性所致精神障碍

一、肝豆状核变性所致精神障碍的临床特点

肝豆状核变性为铜代谢障碍而导致肝、脑、角膜等组织有铜沉积而发生的病变。由 Wilson(1912)首次报道,故又称 Wilson 病。本病具有不断进展的病程,大多预后不良。

(一) 病因

肝豆状核变性为常染色体隐性单基因遗传病,由于患者体内缺乏血浆铜蓝蛋白,不能和铜结合,以致大量铜沉积在组织中,造成铜代谢障碍并引起一系列内脏功能和组织上的损害,最常见的部位是脑基底节、小脑、大脑皮层、角膜、肝、肾等处。

(二) 临床表现

铜在各个脏器和组织沉积从而产生一系列症状和体征。

1. 精神症状

大脑皮质由于铜的沉积从而产生精神症状。早期即有情绪异常或个性特点的变化,以强制性哭笑、情绪不稳易激动、欣快、情感淡漠、焦虑等常见。在疾病过程中可出现类似情感性精神障碍或类精神分裂症样表现。晚期则以智能减退为明显表现,严重者达痴呆状态,日常生活也不能自理。

2. 躯体症状和体征

锥体外系症状、肝硬化、角膜色素环为三大主要症状和体征。以豆状核为主的基底节神经元对铜的毒性特别敏感,从而产生震颤、肌张力增高等锥体外系症状。铜在角膜弹力层的沉积产生 K-F 环(Kayser-Fleischer 环),呈棕色或灰绿色,位于角膜边缘,在裂隙灯下较易看到,检出率高达 90% 以上,具有诊断价值。铜在肝脏的沉积造成肝硬化,产生门脉高压的一系列症状。

(三) 实验室检查

血清铜蓝蛋白和血清铜量降低,尿铜和肝铜含量增高为主要生化异常。血清铜氧化酶吸光度检查有 90% 的病人低于正常值。肝功能检查包括 SGPT、TTT 和 ZnTT 均增高。

(四) 治疗

肝豆状核变性的治疗包括减少铜摄入和增加铜排除。前者应避免食用高铜食物如坚果类、贝类、螺类、虾、蟹和动物肝脏等。驱铜治疗可采用二巯基丙醇(BAL)和 D-青霉胺等,同时合并保肝治疗。近年来有采用肝移植术的病例,但仅限于极少数病人。精神症状可对症处理,但应注意选用锥体外系毒副作用小的抗精神病药物如甲硫哒嗪,剂量不宜过大,时间不宜过长。

二、肝豆状核变性所致精神障碍的诊断标准

+++++

国内 CCMD-3 诊断标准中,按“肝豆状核变性所致精神障碍”进行诊断。

02.14 肝豆状核变性(Wilson 病)所致精神障碍[F02.8 在它处分类的其他特定疾病所致痴呆]诊断标准:

- (1)符合脑变性病所致精神障碍的诊断标准。
- (2)有肝硬化、肌张力增加、震颤、角膜 K-F 环等症状、体征。
- (3)有进行性智能减退、情感障碍、幻觉、妄想或人格改变等精神症状。
- (4)实验室检查有铜代谢障碍的证据。

三、典型案例分析

(一) 病历摘要

患者田某某,男,33岁,军人,已婚。于1963年12月20日入院。

主诉:发现肝脏病7年;性格改变、情感不稳6年;四肢震颤4年;打人毁物3天。

现病史:患者于1952年起常流鼻血、乏力,未引起重视。1956年发现腹水、黑便,肝功能不正常,诊断为肝硬化。1956年因呕血在某医院作脾切除及脾肾静脉吻合术,病理诊断为结节性肝硬化。

1957年后性格变得自私小气,斤斤计较,以自我为中心。妹妹由外地来探望,为要一点东西就大吵大骂,叫妹妹滚回去。为了吃家乡菜,打电报将父亲从外地叫来,并让父亲早起做饭,骂父亲。住在哥哥家里,饭菜都要最好的,甚至对几岁的侄儿也不谦让,稍不如意就大吵大闹。情绪不稳,易急躁、激动,常为小事发脾气。一次因小事生气要自杀,割手腕血管,未成功,又切断股静脉致大出血,被及时抢救。1959年以后四肢震颤,说话含糊,流口水,喝水呛咳,走路不稳,1960年9月住某医院诊断为肝豆状核变性,经二巯基丙醇(BAL)治疗有好转。1962年起四肢震颤明显加重,言语不清,共济失调,再用BAL治疗后因出现皮疹而停用。1963年11月出现兴奋,自述常听到院长叫自己名字,说要见毛主席,入院前3天哭笑无常、打人毁物。

既往史:1956年诊断为肝硬化,在某医院作脾切除,脾肾静脉吻合术。1960年住另一医院诊断为肝豆状核变性。否认传染病史。否认颅脑外伤、感染及高热抽搐史。否认外伤史。否认药物过敏史。

个人史:足月顺产,幼年时很挑食,不正经吃饭,好吃水果,身体较瘦弱,听父母话,聪明活泼,学习成绩很好。1946年参军并入党,工作能力很强,经常受表扬。婚育史:结婚10余年,夫妻感情好,领工资后除留饭费外,全部交给家庭。育一子,体健。病前性格:活泼开朗大方,对自己要求严格,常主动帮助别人,对人體贴,有

不少知心朋友。

家族史：有一姐姐，死于脑炎。否认父母两系三代有类似精神疾病、癫痫及人格异常者。家族中否认有近亲婚配者。

体格检查：

体温 36.2℃，脉搏 90 次/分，呼吸 20 次/分，血压 (120 ~ 160)/(70 ~ 110) mmHg。发育正常，营养中等。全身皮肤黏膜无黄染及皮疹，浅表淋巴结无肿大。五官端正，双角膜上缘可疑 K-F 环。颈部对称，气管居中，甲状腺不大。心律整齐，未闻及杂音。双肺呼吸音清，听诊无啰音。腹平软，无压痛，左侧有手术瘢痕，肝肋下未触及。腹水征阴性。

神经系统检查：头颅大小正常，双侧瞳孔等大等圆，对光反射灵敏，眼球运动各方向自如，伸舌居中。无感觉障碍。四肢肌力正常，肌张力高，腱反射亢进，指鼻跟膝胫试验不稳，四肢有大幅度的手舞足蹈样不自主运动，四肢粗大震颤，双踝阵挛、双霍夫曼征(+)。有尿失禁。脑膜刺激征阴性。

实验室检查：

血常规正常，尿蛋白(++++)，尿 WBC 19~29/HP，尿 RBC 2~5/HP，肝功能正常，白蛋白 3.0 g/dl，球蛋白 2.7 g/dl，血钙 8.5 mg%，血磷 4 mg%，血铜氧化酶为 50 μg/dl(正常值 90~140 μg/dl，血中的铜 95% 与球蛋白结合为铜蓝蛋白，具有氧化酶的作用，又称铜氧化酶)，尿铜 225.7 μg/24 h(正常值 15~35 μg/24 h)，EKG：肢导低电压。脑脊液正常。

精神检查：

不能行走，被抬入病房。意识清楚，定向力完整，答话切题，否认幻觉和妄想，知道自己是肝豆状核变性病，要求治疗。有时自言自语，内容含糊不清，或高声喊叫。近记忆力差，记不住主管医生的名字，对智能检查不合作。表情呆板，有强制性笑容，挤眉弄眼，做鬼脸，情绪波动大，易激惹，手舞足蹈，不自主动作增多。

住院经过和随访结果：

患者在入院后经眼科会诊，裂隙灯检查双角膜上缘有早期 K-F 环。开始使用 5% 二巯基丙磺酸钠驱铜治疗，根据 24 小时尿铜检查尿铜逐渐下降，四肢震颤逐步减轻，行走较稳，说话口齿较清，四肢不自主运动减少。兴奋躁动不安逐步控制，但精神症状时有波动：以情感不稳定为主，常因小事发脾气；出现过轻躁狂的表现如爱开玩笑，诙谐；还曾出现过情绪低落，终日闷闷不乐，哭泣，想死，经 ECT 治疗后缓解；有过片段的幻听、妄想，凭空听见有人和他说话，认为有人要害他，并要写控告信等，但均片断不固定，持续 2~3 天即愈。同时，入院不久后颜面部及双下肢凹

陷性水肿,尿蛋白(++)~(+++),有红白细胞,血白蛋白/球蛋白倒置,经内科会诊为肝豆状核变性所致的肾病,用利尿剂治疗有效。1965年2月25日以显著好转出院。

出院后用二羟基丁二酸钠,约40g(1疗程总剂量),症状尚平稳,曾因情绪低合并用过丙咪嗪75~100mg/d。1965年8月起震颤加重,举步困难,情感易激惹,常因小事生气哭泣,有时对空谩骂,或对空怒目横瞪,拒食,入院前1天突然向右晕倒,而于1965年11月10日第2次入院。入院时神经系统体征同上次入院时,精神状态主要为违拗拒食,情绪不稳,大哭大笑,生活懒散,经ECT治疗能暂时缓解。但躯体情况逐渐恶化,肾功能差,钙磷缺失,血钙7.6mg%,血磷2.5mg%,尿蛋白大量漏出,持续尿蛋白(+++),白蛋白1.8g/dl,球蛋白2.5g/dl,出现腹水、胸水、心衰、尿毒症昏迷、上消化道出血,最后于1966年6月4日死于呼吸循环衰竭。

死亡诊断:①肝豆状核变性;②肝豆状核变性所致精神障碍;③肝豆状核变性合并肾病;④结节性肝硬化;⑤脾切除术后,肝肾静脉吻合术后;⑥充血性心力衰竭,贫血所致?⑦低蛋白血症,全身浮肿;⑧右胸腔积液;⑨腹水;⑩尿毒症;⑪上消化道出血,食管静脉曲张破裂?

死亡原因:呼吸循环衰竭,全身衰竭。

尸体病理解剖结果:结节性肝硬变;脑萎缩及蛛网膜下腔积液;肾病(?);高血压性心脏病;左心肥大;腹腔、心包腔及右侧胸腔积液,右肺萎缩及纵隔左移;两肺水肿;脾缺如;左侧脾肾静脉吻合;慢性胃溃疡;主动脉轻度粥样硬化;两下肢静脉切口溃疡;左侧胸腹壁联合切口瘢痕;脏器充血。

(二) 案例分析

1. 诊断和诊断依据

(1)患者男性,病前性格:活泼开朗,对人体贴;诊断为“肝豆状核变性”病3年,家族中姐姐死于脑炎。

(2)肝脏损害病史7年,随后缓慢出现精神症状以及锥体外系症状。

(3)精神症状

①人格改变:病前性格活泼开朗,对人体贴,病后性格变得自私小气,以自我为中心。如为要一点东西就大吵大骂,叫妹妹滚回去。让父亲早起做饭,骂父亲,吃饭时对几岁的侄儿也不谦让,稍不如意就大吵大闹。

②幻觉妄想:住院过程中出现过凭空听见有人和他说话,认为有人要害他,并

要写控告信等,但均片断不固定。

③记忆力减退:近记忆力差,记不住主管医生的名字。

④情感高涨:住院过程中也出现过类似轻躁狂的表现,如爱开玩笑,诙谐。

⑤情感低落:住院过程中也出现过抑郁表现,如终日闷闷不乐、哭泣、想死,院外也有过情绪低的表现并曾合用过抗抑郁药丙咪嗪。

(4)躯体症状和体征:有肝、肾、脑多个脏器损害的表现,腹水、呕血、黑便等肝硬化表现,四肢震颤等锥体外系反应,高血压、水肿等肾病表现;查体可发现角膜 K-F 环,血压(120~160)/(70~110) mmHg,颜面部及双下肢凹陷性水肿,四肢震颤,肌张力增高,腱反射亢进。

(5)辅助检查:血铜氧化酶 50 $\mu\text{g}/\text{dl}$ (正常值 90~140 $\mu\text{g}/\text{dl}$)。尿铜 225.7 $\mu\text{g}/24\text{h}$ (正常 15~35 $\mu\text{g}/24\text{h}$)。血白蛋白/球蛋白倒置。尿蛋白(+++)~(+++),有红白细胞。血钙 7.6 mg%,血磷 2.5 mg%。

综上所述,本病例以肝脏损害为首发症状,随后缓慢出现精神症状以及锥体外系症状,肝、脑、角膜及肾损害均十分典型,尿铜增高,血铜氧化酶吸光度下降,尸检发现结节性肝硬化及脑萎缩,肝豆状核变性所致精神障碍可确定。

2. 鉴别诊断

(1)精神分裂症:本例在病程中,出现过片段的幻觉妄想,应注意和精神分裂症鉴别。由于本病例同时存在肝损害、神经症状、角膜 K-F 环和实验室数据,可排除精神分裂症。

(2)情感性精神障碍:出现过轻躁狂和严重的情绪低落、自杀观念,经 ECT 治疗缓解,应注意和情感性精神障碍鉴别。如上所述,本病例同时存在肝损害、神经症状、角膜 K-F 环和实验室数据,可排除情感性精神障碍。

3. 治疗方案

(1)降铜治疗:减少铜摄入应避免食高铜食物如坚果类、贝类、螺类、虾、蟹和动物肝脏等;驱铜治疗可采用二巯基丙醇(BAL)和 D-青霉胺等,本患者因对二巯基丙醇过敏,采用二羟基丙磺酸钠及二羟基丁二酸钠治疗。

(2)精神症状对症处理,因其幻觉妄想均片断不固定,未用抗精神病药物,针对其类躁狂样表现和抑郁表现,采用 ECT 治疗有一定缓解,还合用过抗抑郁药丙咪嗪。

(3)保肝治疗。

4. 预后估计

本病为持续性进展过程,即使有少数可部分缓解,最终结局是不良的,从出现

症状到死亡时间为 7~15 年,多因肝衰竭或并发感染死亡。本病例死于呼吸循环衰竭。

第二节 帕金森病所致精神障碍

一、帕金森病所致精神障碍的临床特点

帕金森病的原因尚不明确,主要表现为运动减少、肌强直、震颤、面具脸及姿势障碍等,重者可导致痴呆。多见于中老年人,平均发病年龄在 60 岁左右,男性较多。

(一) 病因

本病的原因目前尚不明确,虽有家族遗传史的报道,但无研究方面的支持,也有学者提出环境中的农业和工业毒素致病因素,但均缺乏证据。研究表明患者纹状体中的多巴胺含量明显减少,引起多巴胺和乙酰胆碱两种神经递质间平衡失调而出现症状。

(二) 临床表现

1. 精神症状

(1) 急性器质性综合征:表现为意识障碍,定向力障碍,思维不连贯,幻觉,情绪不稳等。

(2) 痴呆状态:随病程进展,智能逐渐减退,呈现痴呆状态,韦氏智力量表测验可显示皮质下痴呆特点。并有人格改变,表现欣快、幼稚行为。

(3) 幻觉妄想状态:可出现幻听、被害或疑病妄想。

(4) 类抑郁状态:表现为情绪低落、焦虑,严重者可有自杀企图。

2. 躯体症状和体征

(1) 震颤:为静止性震颤,可累及上肢、下颌、口唇、舌及头部。

(2) 肌强直:累及全身肌肉,病人可呈现“面具脸”、头部前倾、屈曲体态和慌张步态,查体可见铅管样肌张力增高。

(3) 运动减少:随意动作减少,动作缓慢。

(4) 其他:还可有流涎过多、皮脂溢出等自主神经紊乱症状。

(三) 实验室检查

无特异性指标,脑电图、脑CT等异常均无特点,可作为参考。

(四) 治疗

帕金森病的治疗可采用抗胆碱能药物如安坦、苯甲托品等,抗组胺类药物如苯拉明,多巴胺释放促进剂如金刚烷胺,多巴类药物如左旋多巴等。对于精神症状,可采用适当的抗抑郁药或抗精神病药对症治疗,但应注意选用锥体外系反应小的药物以免加重躯体症状和体征。氯氮平由于不引起锥体外系反应,近年来在帕金森病所致精神障碍的治疗中应用较多。

二、帕金森病所致精神障碍的诊断标准

国内 CCMD-3 诊断标准中,按“帕金森病所致精神障碍”进行诊断。

02.13 帕金森病所致精神障碍[F02.3 帕金森病痴呆]

(一) 诊断标准

1. 符合脑变性病所致精神障碍的诊断标准。
2. 先有肌张力亢进、震颤、面具脸等帕金森病表现,然后发生精神障碍,严重时导致痴呆。
3. 慢性进行性病程。
4. 排除抗帕金森病治疗导致的认知损害和其他原发性脑部疾病所致精神障碍。

(二) 说明

帕金森病所致痴呆可能与阿尔茨海默病痴呆或脑血管病所致痴呆同时存在。

三、典型病例分析

(一) 病历摘要

患者何某某,男性,66岁,司机,小学文化,已婚。

主诉:不自主震颤4年;凭空看见东西、疑心被害3年;记忆力下降2年;兴奋冲动1天。

现病史:患者于1996年开始出现四肢不自主震颤,动作缓慢,走路不稳,在某医院诊断为“帕金森病”,给予安坦4 mg/d治疗后略有好转。自1997年无明显诱因出现凭空看见东西,总说看到很多小飞虫并用手到处抓,还说饭里有小黑虫子并往外抠,从窗户上能看见妖魔鬼怪的影子,说能看见有人进来,要打他杀他等,说老伴是小偷,偷他东西,夜眠差。1998年初来我院就诊,诊断为“脑器质性精神障碍,帕金森病”,服用奋乃静8 mg/d,上述症状有所控制,患者未能坚持服药,病情时好时坏。1999年逐渐出现记忆力下降,东西放起来后常找不到,刚发生的事情就想不起来了,也不会算账了,说话有时颠三倒四。入院前1天夜里突然兴奋冲动,认为家人要害他,打家人,砸酒瓶子,砸门,家人护理困难于2000年10月18日第1次入院。

既往史:1996年在某医院诊断为“帕金森病”,四肢有静止性震颤,现服用安坦4 mg/d治疗。冠心病史3年,近2年较稳定,未服药。否认传染病史。否认颅脑外伤、感染及高热抽搐史。否认外伤史。否认药敏史。

个人史:母孕期体健,足月顺产。幼年生长发育正常,小学文化,后当卡车司机,工作情况好,60岁退休。无烟酒等嗜好。婚育史:结婚四十多年,夫妻感情一般,育4个孩子,体健。病前性格:外向,直爽,人际关系一般。

家族史:父母两系三代无类似精神疾病、癫痫及人格异常患者。家族中否认有近亲婚配者。

体格检查:

体温36.2℃,脉搏80次/分,呼吸20次/分,血压120/90 mmHg。发育正常,营养中等,全身皮肤黏膜未见黄染、皮疹,全身浅表淋巴结无肿大。五官端正,颈部对称,气管居中,甲状腺不大。胸部无畸形,双肺呼吸音清,听诊无干、湿啰音。心界不大,心率80次/分,心律整齐,各瓣膜区未闻及杂音。腹平软,无压痛,肝脾肋下未触及。

神经系统检查:

头颅大小正常,面具脸,双侧瞳孔等大等圆,对光反射灵敏,眼球运动各方向自如,伸舌居中,舌颤。无感觉障碍。慌张步态,四肢肌力正常,肌张力增高,深浅反射正常,指鼻跟膝胫试验不稳,四肢静止性震颤。病理征阴性。脑膜刺激征阴性。

实验室检查:

未见异常。

会解释。

(4)躯体症状和体征:四肢震颤,动作缓慢,走路不稳,查体可发现面具脸,舌及四肢震颤,肌张力增高,慌张步态。

(5)辅助检查:无异常。

综合上述情况,患者在患帕金森病后逐渐出现幻觉、妄想及痴呆的表现,查体可发现帕金森病的体征,病情已严重影响其日常生活,故诊断考虑帕金森病所致精神障碍。

2. 鉴别诊断

(1)继发性帕金森综合征:首先应排除继发性帕金森综合征才可诊断为帕金森病,如脑炎、中毒、颅脑外伤等均可产生类似的症状。因无以上疾病的病史和相应表现,故可排除。

(2)精神分裂症:本例存在幻觉妄想,应注意与之鉴别。由于精神症状均是继发于帕金森病的症状和体征出现的,所以鉴别诊断并不困难。

(3)其他疾病导致的痴呆:本例已发展为痴呆,应与其他导致痴呆的常见疾病如阿尔茨海默痴呆、血管性痴呆鉴别,同样由于精神症状均是继发于帕金森病的症状和体征出现的,辅助检查也无任何异常,所以可排除。

3. 治疗

(1)帕金森病的治疗:安坦 6 mg/d,金刚烷胺 2 粒/d。

(2)精神症状的治疗:入院后给予氯氮平 25 mg/d 治疗,因出现频发室性期前收缩和变异型心绞痛发作,停用氯氮平,改为氟哌啶醇 6 mg/d,但加重了锥体外系症状和体征,并影响吞咽,故换用维思通治疗 1 mg/d。

(3)促智治疗:喜得镇 6 mg/d。

患者接受以上治疗后,幻觉妄想基本消除。但智能记忆无明显改善。住院约 2 个月后好转出院。

4. 预后估计

本病进展缓慢,病程持续并逐年加剧,影响整个社会功能,最后导致痴呆。死亡多由于躯体疾病或并发感染所致。本病例已进展至痴呆,预后不佳。

第三节 其他脑变性疾病所致精神障碍 (皮克病所致精神障碍)

一、皮克病所致精神障碍的临床特点

本病由 Pick(1892)首次描述,病因不清,临床表现为痴呆综合征,伴有额、颞叶局限性萎缩,和阿尔茨海默病同属于原发性退行性痴呆,但发病率比后者低得多。

(一) 病因

病因尚不清,虽有家族遗传史的报道,但多数为散发性。

(二) 临床表现

最显著临床表现为早期即有额叶损害的某些症状,明显的性格和社交行为改变,如行为幼稚、说谎、无礼貌、懒惰等,而不是记忆力下降。常在早期即丧失自知力。幻觉妄想少见。言语困难、失用、失认等顶叶症状少见。随疾病进展,记忆、智力障碍越来越明显,晚期和其他痴呆难区别。

(三) 实验室检查

脑电图异常少见,CT 和 MRI 可显示脑叶萎缩,典型病例额角扩大,额、颞叶前部明显萎缩,侧脑室体即顶、枕叶较少受累。

(四) 治疗

尚无特殊治疗,主要为对症治疗和一般护理。

二、皮克病所致精神障碍的诊断标准

国内 CCMD-3 诊断标准中,按“皮克病所致精神障碍”进行诊断。

02.11 皮克病所致精神障碍[F02.0 皮克病痴呆]诊断标准:

(1)符合脑变性病所致精神障碍的诊断标准,在疾病早期记忆和顶叶功能相对完整。

(2)以额叶受损为主,至少有下列3项中的2项:①情感迟钝或欣快;②社交行为粗鲁,不能安静,或自控能力差;③失语。

(3)缓慢起病,逐步衰退。

(4)排除阿尔茨海默病、脑血管病所致精神障碍,或继发于其他脑部疾病所致的智能损害。

三、典型病例分析

(一)病历摘要

患者郑某某,男性,68岁,医生。

主诉:性格改变8年;记忆力下降3年;近半年加重,生活不能自理。

现病史:患者于1986年退休后性格逐渐出现改变,变得爱唠叨,脾气急躁,常为一些小事发火。自私小气,儿女来看望他,骂儿女生活比他好,女儿从其家中拿走一瓶香油,就整日大骂。行为幼稚,有时为了争东西吃和几岁的小孙子打架。不讲卫生,有时在屋里随地吐痰。近3年来记忆力明显下降,东西放起来后常找不到,总认为是被儿女拿走了,外出经常迷路,几次被别人送回家。近半年病情进一步加重,说话含糊不清,不能领会别人的话,有时看见熟人叫不出名字。生活不能自理,二便不知,有时甚至用手抓大便,吃东西不分生熟,情绪不稳,有时烦躁,在屋里不停地乱走或翻箱倒柜,夜晚入睡困难,入院前曾服过奋乃静4mg/d,因耐受不了而停用。因家人无法护理于1994年1月12日送入院,门诊以痴呆状态收住院治疗。

既往史:1958年患乙肝,1976年因胆结石行胆囊切除术,1987年因股骨颈骨折而换人工股骨头(右侧)。曾作过两次CT,末次是在1992年,结果无明显脑萎缩。否认传染病史。否认颅脑外伤、感染及高热抽搐史。否认外伤史。否认药敏史。

个人史:母孕期及幼年生长情况不详,适龄入学,1946年毕业于某医科大学医疗系。毕业后在某医院外科工作,1980年担任医院外科主任,1986年退休。婚育史:结婚四十余年,婚后感情好,有两儿一女,均体健。病前性格:争强好胜,急脾气,愿意帮助人,与周围人关系融洽。

家族史:其一姐姐据说患老年精神病,具体不详。其余父母两系三代无类似精神疾病、癫痫及人格异常患者。家族中否认有近亲婚配者。

体格检查:

体温 36.2℃,脉搏 72 次/分,呼吸 20 次/分,血压 120/90 mmHg。发育正常,营养中等,全身皮肤黏膜未见黄染、皮疹,全身浅表淋巴结无肿大。五官端正,颈部对称,气管居中,甲状腺不大。胸部无畸形,双肺呼吸音清,听诊无干、湿啰音。心界不大,心率 72 次/分,心律整齐,各瓣膜区未闻及杂音。腹平软,无压痛,右上腹一长约 10 厘米手术瘢痕,肝脾肋下未触及。

神经系统检查:

头颅大小正常,双侧瞳孔等大等圆,对光反射灵敏,眼球运动各方向自如,伸舌居中。无感觉障碍。四肢肌力、肌张力正常,深浅反射正常,病理反射未引出,指鼻跟膝胫试验能完成。脑膜刺激征阴性。

辅助检查:

CT 示无脑室扩大,无梗塞灶,左侧颞叶局限性脑萎缩与右侧不对称。其他辅助检查无异常。

精神检查:

意识清楚,定向力差,被动接触差,言语不清,答非所问,表情呆滞,进食需督促,生活不能自理。语量少,发音不清,且有重复言语,如病人不时地说“开会,开会”。有感觉性失语,不能理解问话,无法交谈和了解其思维内容,不让小保姆喂饭但儿子喂饭却可以,问其何故,只能听见其嘟嘟囔囔,不知所云。不能复述数字,不能执行口头指令,甚至说不出自己的姓名,无法评定其记忆力及计算力,但推测其智能衰退,记忆力已完全下降。表情呆滞,情绪不稳,经常冲小保姆发脾气,大声喊叫,有时不停地来回走动,有焦虑表现。意向活动明显减少,独处,有时在房间来回走动,有冲动行为,打小保姆,不让其给他拿饭,有时抱着被子站在门口。治疗护理不合作,服药需反复劝说,生活不能自理,有时在屋里小便。

(二) 病例分析**1. 诊断和诊断依据**

(1)患者男性,68 岁,病前性格争强好胜,急脾气,愿意帮助人,与周围人关系融洽,既往无特殊躯体疾病史,家族史阳性。

(2)无诱因起病,总病程 8 年,首先出现人格改变,随后缓慢出现智能记忆下降,逐渐加重。

(3)精神症状

①人格改变:患者无明显原因性格逐渐改变,变得爱唠叨,脾气急躁,自私小

(二) 脑血流量减少

可以直接影响脑功能而产生精神障碍,如休克、心力衰竭以及多种原因引起的脑水肿,均能使脑血流量减少。

(三) 水、电解质代谢异常

血液中钾、钠、氯、钙、镁等含量的增高或降低,内分泌疾病、大失血、手术后、激素治疗以及摄入量减少,发热、大汗及脱水等,均能引起脑功能紊乱,从而出现精神症状。

(四) 酸碱平衡失调

呼吸系统疾病引起的呼吸性酸中毒或碱中毒,糖尿病引起的代谢性酸中毒,肝脏疾病引起的代谢性碱中毒,以及慢性肾功能衰竭导致的尿毒症,均可因酸碱平衡失调而出现精神症状,尤以意识障碍多见。

(五) 中间代谢产物蓄积

肝脏疾病时血氨的升高,肾功能不全时所致的尿素、尿酸等的增高,糖尿病时酮体的增多等,这些中间代谢产物都构成毒性物质,致使脑功能受损害而产生精神症状。

(六) 内分泌功能障碍

甲状腺功能的增高(甲亢)或减低(甲低),肾上腺皮质功能亢进(Cushing 病)和减退(Addison 病)、垂体功能亢进(肢端肥大症)和产后垂体前叶功能减退症(Shehan 病),以及性腺、甲状旁腺等内分泌腺的功能紊乱,均能导致精神障碍。

(七) 维生素缺乏

长期营养不良、多种消耗性疾病(溃疡病、癌症)及代谢障碍等可引起维生素缺乏而出现精神症状,尤以烟酸、硫胺、叶酸及维生素 B₁ 缺乏等容易导致精神异常。

(八) 结缔组织疾病

系统性红斑狼疮、多发性肌炎、皮肌炎等均能直接或间接影响脑功能而引起精神障碍。

(九) 微生物毒素

由细菌、病毒等病原微生物侵入人体,产生内毒素或外毒素,均可使中枢神经系统受毒性损害,影响正常的脑功能活动致精神异常。

(十) 神经介质改变

各种神经介质如多巴胺、去甲肾上腺素,5-羟色胺、乙酰胆碱、某些氨基酸及肽类的改变,与人的意识、睡眠、情绪、意志和行为等有密切关系,常常引起精神功能改变而致精神异常。

二、临床表现

+++++

躯体疾病伴发的精神障碍虽因其原发的疾病或病因不同,精神症状也有差异,但仍具有以下共同特点。

1. 躯体疾病伴发的精神障碍具有所谓的特征性症状,即不同的病因可引起相似的精神症状;而相同病因也可出现不同的精神症状,即所谓非特异性症状。
2. 精神症状与原发躯体疾病的病情在程度上常有平行的关系。
3. 不论原发病属于何种躯体疾病,其精神症状一般起病较急,急性期大都以意识障碍为主要症状;恢复期偶有人格改变或智力障碍;从急性期过渡到恢复期可表现出过渡症状群,如抑郁、躁狂、妄想、幻觉、兴奋或木僵等。
4. 精神障碍在躯体疾病的整个病程中,多易转变、波动、发展或逆转,常反复多次,且往往交织出现、错综复杂。
5. 病程和预后取决于原发躯体疾病的病程长短和轻重程度。预后一般来说是可逆的,恢复后不留精神缺陷。但少数患者特别是长期陷入昏迷者,偶尔可遗留人格改变或智力缺陷。

三、实验室检查

+++++

根据不同疾病的诊断需要,进行必要的物理和生化检查,如血、尿、电解质、尿素氮、血气分析、转氨酶、脑脊液、内分泌机能、心电图、脑电图、超声波、CT、MRI等检查。

四、治疗

精神障碍的治疗原则以针对病因及对症治疗并重。由于精神障碍多影响或加重躯体疾病的病情,有时要先对症治疗。对症治疗时要慎用催眠药、镇静药等,避免加深意识障碍。

第二节 躯体疾病所致精神障碍诊断标准

国内 CCMD-3 标准中,按“躯体疾病所致精神障碍”进行诊断。

03 躯体疾病所致精神障碍诊断标准

指由各种躯体疾病,如躯体感染、内脏器官疾病、内分泌障碍、营养代谢疾病等影响脑功能所致的精神障碍。急性躯体疾病常引起急性脑病综合征(如谵妄),慢性躯体疾病则引起慢性脑病综合征(如智能损害、人格改变等)。从急性过渡到慢性期间,可有抑郁、躁狂、幻觉、妄想、兴奋、木僵等精神症状,并在躯体疾病的整个病程中,具有多变和错综复杂的特点。

(一) 症状标准

- (1)通过病史、躯体及神经系统检查、实验室检查发现躯体疾病的证据。
- (2)精神障碍的发生、发展及病程与原发躯体疾病相关,并至少有下列 8 项中的 1 项:①智能损害;②遗忘综合征;③人格改变;④意识障碍(如谵妄);⑤精神病性症状(如幻觉、妄想或紧张综合征等);⑥情感障碍(如抑郁或躁狂综合征等);⑦神经症样症状;⑧以上症状的混合状态或不典型表现。
- (3)无精神障碍由其他原因导致的足够证据(如酒精或药物滥用、应激因素)。

(二) 严重标准

社会功能受损。

(三) 病程标准

精神障碍的发生、发展及病程与原发躯体疾病相关。

(四) 排除标准

排除精神分裂症、情感性精神障碍的严重躁狂发作或抑郁发作。

第三节 典型病例分析

一、病例一

+++++

(一) 病历摘要

患者郭某,女,45岁,初中文化,工人,已婚。

主诉:患系统性红斑狼疮8个月后出现话多、多疑、脾气大;近2周来加重,多疑,入睡困难。

现病史:1999年9月中旬,患者感到手指尖针刺样疼痛,不能摸东西。半月后,脚趾尖亦出现疼痛,不能碰,走路或受压时,疼痛加剧。当时于外院诊为“系统性红斑狼疮”并入院,具体治疗不详。住院约1月后,由于患者怀疑邻床病友说自己坏话(可能确有此事),便坚持出院。患者平时间断治疗,口服氢化可的松10 mg/d,环磷酰胺每周肌注1次,剂量不详。后因为白细胞降至 $1\,700/\text{mm}^3$,故改为口服氢化可的松10 mg/d,疗效尚可。

2000年5月25日(本次入院前2周),患者感到半身麻木,右眼视力模糊,并反复说是以前打针打坏的,表示以后不再打针了。还出现烦躁,“爱翻旧账”,把多年前的家事说个不停,无端向家里人发脾气等。同年6月3日,到我院门诊,诊为“红斑狼疮所致精神障碍”,予奋乃静6 mg/d。患者回家后不规律服药,效果欠佳,其精神症状渐加重,出现多疑,认为有人故意和自己过不去,认为邻居都在议论自己,认为他们串通起来害自己,无端怀疑邻居向自己家扔脏东西,推开窗户骂邻居。一次到邻居家,大叫“求你们了,饶了我吧。”反复说单位领导挤兑她,扣了她50块钱,愤愤不平。看到丈夫,就骂婆家人,说没一个好人。看到自己的弟妹,就说都是傻子,让人欺负。能喝水,有时一天能喝几暖瓶水。入睡困难,常常凌晨三四点才能睡着。家人护理困难,送至精神病院治疗,门诊以“红斑狼疮所致精神障碍”首次收住院。

既往史:25岁曾患“肺结核”,已痊愈。1999年患“系统性红斑狼疮”。

个人史:胞3行大,其母孕期健康,患者幼年发育正常,适龄上学,初中毕业,从事

商业活动,结婚 20 年,夫妻感情好,有一子,体健。病前性格:外向,急性子,好胜。

家族史:否认父母两系三代中有精神病患者。

体格检查:

体温 36.4℃,脉搏 78 次/分,呼吸 18 次/分,血压 120/80 mmHg。发育正常,营养中等,全身皮肤黏膜未见黄染、出血,全身未及肿大的浅表淋巴结。五官端正,颈部对称,气管居中,甲状腺无肿大。胸部无畸形,双肺未闻及干、湿啰音。心界不大,各瓣膜区未闻及病理性杂音。腹部平软,无压痛,肝脾未及。

神经系统检查:

左侧鼻唇沟浅,不能吹口哨,腱反射不对称,右侧较活跃。

辅助检查:

未见明显异常。

精神检查:

意识清晰,时间、地点、人物定向及自我定向力均完整,接触被动。可引出感觉过敏,患者畏光、怕冷,觉得光线和冷气刺激得她全身难受。可引出真性幻听,诉凭空能听到邻居骂自己,骂自己不是人,骂自己偷电,患者对此感到非常气愤。交谈不切题,有时答非所问。可引出关系妄想、被害妄想,患者认为邻居经常向自己扔东西,经常背后议论自己。注意力不集中,谈话时经常走神。智力、记忆力基本正常。无自知力,否认有精神病。情感基本协调,情绪欠平稳,经常感到无原因的心烦、焦虑,谈话时,患者一会儿坐着,一会儿又躺在床上,一会儿又收拾衣服、鞋子,并自述心烦。住院后患者怕冷、怕光,不停地换衣服,活动较多。

(二) 病例分析

1. 诊断及诊断依据

(1)患者女性,45 岁,病前性格:外向,暴躁,好胜。

(2)本病例有以下特点

1)躯体疾病在前,精神症状在后。

2)在“红斑性狼疮”诊断后半个月出现明显的感觉障碍如脚趾等处疼痛,1 个月后又出现精神症状,故难以排除精神症状与该病的因果关系。但有明显的感觉障碍,可能系统性红斑狼疮病变仍未平复。

3)此次患者是急性或亚急性加重。

4)精神症状

①真性幻听:诉凭空能听到邻居骂自己,骂自己不是人,患者对此感到非常气

愤。此为躯体疾病所致精神障碍常见表现之一。

②关系妄想、被害妄想：患者认为邻居经常向自己家扔脏东西，经常背后议论自己，到邻居家大叫“求你们了，饶了我吧。”反复说单位领导挤兑她，扣了她 50 块钱，愤愤不平。此为躯体疾病所致精神障碍常见表现。

③注意力涣散：谈话时经常走神。

④情绪不稳，经常感到无原因的心烦、焦虑，谈话时，患者一会儿坐着，一会儿又躺在床上，一会儿又收拾衣服、鞋子，并自述心烦。活动多，坐立不安。

综上所述，患者目前精神症状丰富，错综复杂，故根据 CCMD-3 可诊断为：
系统性红斑狼疮所致精神障碍

2. 鉴别诊断

激素诱发精神障碍：从时间上来看，患者不是在大量、长期应用激素过程中出现的精神障碍；另外，此病一般表现为表情欣快、心情愉快，而患者无以上表现，相反，在用皮质激素治疗后精神症状有所好转，故目前不考虑此病。

3. 治疗

- (1)防止感染，密切注意血常规、血沉变化，防止出现肾功能异常。
- (2)注意意识状态的改变，防止出现谵妄。
- (3)患者目前存在关系妄想、被害妄想等精神病性症状，予氟哌啶醇 6 mg/d。
- (4)在住院期间继续用氢化可的松治疗。

患者住院期间接受上述治疗，约 1 月后治愈出院。

4. 预后估计

患者患系统性红斑狼疮后出现精神障碍，且至今系统性红斑狼疮未愈，此次住院接受治疗，近期疗效较好，在治疗精神症状的同时治疗躯体病，用适当剂量的皮质激素治疗，估计预后较好。有文献报道吩噻嗪类、抗精神病药可诱发本病，应慎用。本例用小量氟哌啶醇治疗，疗效尚好，但不宜长期服用。为安全起见可选用第二代抗精神病药，如利培酮或奥氮平等。

二、病例二

+++++

(一) 病历摘要

患者邵某某，男，57 岁，丧偶，农民，初中文化。

主诉：食不洁食品后发热、胡言乱语 1 周余。

现病史:患者于1999年4月13日食不洁物后腹泻1天,大便7次,并出现尿急、尿频、尿痛,自服“牛黄上清丸”,症状渐好转,其体温始终不高。

1999年4月23日出现双脚浮肿,4月24日晚发热38.5℃,因当晚患者值夜班在外,未能服药治疗。4月25日起床后突然出现精神异常,说昨晚值班时没水、没电,是有人要害自己。经常呆愣、自语,言语凌乱,如“到7点我该练功了,别碰我,12点你妈来接我去天堂……我是世界美人,我漂亮。”行为怪异,两手作揖,经常不认识家人,兴奋躁动,反复问“你是谁?滚开,哪是北方?哪是中轴线?我死也要死在北方。”近2天曾到多家医院就诊,未明确诊断。为明确诊断,送我院治疗。近2周否认头晕、头痛、肢体乏力史。

既往史:平素体健,否认食物、药物过敏史。

个人史:胞6行大,母孕期无异常,幼年发育正常,适龄上学,成绩一般,初中毕业后参加工作,能力尚可。1968年结婚,夫妻感情非常好,3年前丧妻。病前性格:内向,性急,对家人要求严格。患者从小喜欢唠叨,说话啰嗦,凡事经常说不到点上。

家族史:患者父亲及堂兄有精神病史,具体不详。

体格检查:

体温36.4℃,脉搏78次/分,呼吸18次/分,血压120/80 mmHg。发育正常,营养中等,全身皮肤黏膜未见黄染、出血,全身未及肿大的浅表淋巴结。手的十指甲床苍白。五官端正,咽略红,颈部对称,气管居中,甲状腺无肿大。胸部无畸形,左肺少许湿啰音。心界不大,各瓣膜区未闻及病理性杂音。腹部平软,无压痛,肝脾未及。

神经系统检查:

头颅大小、形态正常,脊柱无畸形,颅神经检查未见异常,全身深、浅感觉和皮层感觉未见异常,肌力、肌张力正常,深、浅反射正常,未见病理征。

实验室检查:

血常规:红细胞 $2.8 \times 10^{12}/L$,血红蛋白6.4 g/dl,白细胞 $10\ 900/mm^3$,嗜中性细胞82%,淋巴细胞15%。尿常规:潜血(++),蛋白(++),白细胞(+++)。血生化系列:AST 116 U/L,ALT 35 U/L;LDH 369 U/L;CPK 304 U/L。胸正位片:双肺纹理增重。头颅CT:未见异常。

精神检查:

意识清晰,定向力完整,年貌相符,住院合作。能引出可疑赘述,患者谈话时过于强调细枝末节,如谈到发病前一天值班时,患者反复讲:“单位有个傻子,傻子每

天5点起床,然后在院子里跑步……”但经提醒后能回到正题上来。语量稍多,问其为何住院时,患者说:“4月13日值班时,发现没有水,也没有电……”讲述如何与单位的人有矛盾,迂回一会儿也能讲到自己的病上,一会儿又说到自己的老伴,说的时候眼中含泪。未引出幻觉、妄想,对自己病后的异常表现不能回忆。情感协调,有礼貌,未见异常行为。

(二) 病例分析

1. 诊断及诊断依据

(1) 患者男性,57岁,丧偶,病前性格内向。

(2) 食不洁食物后发热,并出现胡言乱语等精神症状。

(3) 疾病特点

①泌尿系感染:1999年4月13日食不洁物后出现尿急、尿频、尿痛。尿常规:潜血(++),蛋白(++),白细胞(+++)。提示患者有泌尿系感染。

②呼吸系统感染:左肺少许湿啰音,血常规:白细胞 $10\ 900/\text{mm}^3$,嗜中性细胞82%。有较严重的贫血,手的十指甲床苍白,血红蛋白 6.4 mg/dl 。提示患者有呼吸系感染和导致贫血的躯体疾病。

③精神症状:患者曾出现行为紊乱,如突然说值班时没水、没电,是有人要害自己。经常呆愣、自语,言语凌乱,如“到7点我该练功了,别碰我,12点你妈来接我去天堂……我是世界美人,我漂亮。”行为怪异,两手作揖,经常不认识家人,兴奋躁动,反复问“你是谁?滚开,哪是北方?哪是中轴线?我死也要死在北方。”从表现上看,以上症状是在意识障碍的基础上产生的,如当时患者不认识家人,而且事后对当时情景不能回忆均支持此点;且精神症状与躯体症状共消长。

目前患者没有意识障碍,也没有引出特征性的精神症状。

综上所述,根据CCMD-3入院诊断为:

躯体病伴发精神障碍

泌尿系统感染

呼吸道感染

贫血原因待查

2. 鉴别诊断

脑器质性精神障碍:患者存在可疑病理性赘述,当提到老伴时,伤心落泪,为可疑情感脆弱,应与此病相鉴别。但据家属介绍,患者平时一直如此,喜欢唠叨,说话啰嗦,凡事经常说不到点上,而患者平时和妻子感情较好,丧妻后提到妻子容易悲

伤也可以理解。头颅 CT 示正常。故目前考虑脑器质性精神障碍的诊断依据不充分。

3. 诊疗计划

- (1)完善各项相关检查。
 - (2)病因治疗:予奥复星 200 ml/d 静点抗炎治疗。
 - (3)对症治疗:予硫酸亚铁、叶酸等药物改善贫血。
 - (4)促大脑代谢治疗:予 B 族维生素和维生素 C 等补充营养。
- 住院治疗 1 周后,精神症状消失,就精神症状而言,患者治愈出院。

4. 预后估计

患者为 57 岁男性,虽然有精神病阳性家族史,但考虑患者的行为紊乱是在急性感染后出现意识障碍的基础上产生的,且精神症状与躯体症状共消长。目前患者没有意识障碍,也没有引出特征性的精神症状,故可判断其预后较好。

(项玉涛)

神经症及心理因素相关生理障碍

第一节 神经症

一、概述

神经症是一组有一定人格基础,起病常受心理社会因素影响的精神障碍。主要表现为焦虑、抑郁、恐惧、强迫、疑病、躯体化症状,或神经衰弱症状。症状没有可证实的器质性病变基础,并与病人的现实处境不相称,但病人对存在的症状感到痛苦和无能为力。自知力完整或基本完整,病程多迁延。有人指出在疾病分类学中,神经症这一概念模糊的名词无重要意义。ICD-10 尽量避免使用,DSM-4 不用这一名词,CCMD-3 鉴于这一名词便于归纳,故仍作保留。各种神经症性症状或其组合可见于感染、中毒、内脏、内分泌、代谢或脑部器质性疾病,称为神经症综合征,不能称为神经症。CCMD-3 的编码 43 神经症的亚型分类如下:43.1 恐惧症;43.2 焦虑症;43.3 强迫症;43.4 躯体形式障碍;43.5 神经衰弱。

“看得出来,这个女领导发脾气样子使你非常地不愉快,是吗?”刘先生嗫嚅地说了句什么表示认可。“你再认真地想一想,她的这种表现使你很容易地联想到什么人或什么事吗?”他沉默了一会,才慢吞吞地说:“每当她发脾气时,我就不由自主地感到紧张,因为小时候母亲常常吼我们。”在笔者的要求下,他虽然有些犹豫,但还是给笔者讲了他小时候的故事。

“我出生在一个中小城镇的普通居民家庭里,排行老大,下有弟妹4人。父母亲虽说文化程度不高,但还算是吃苦耐劳、精明能干吧。特别是母亲,更是家里家外一把好手,是全家人的主心骨。也许是生活的忙碌艰辛和儿女们的拖累,母亲很少有笑容面对我们。父母崇尚教子严厉、日后才能有出息的古训,并把这种信念一丝不苟地‘贯彻’在对我们兄妹几人的教育中。在所有孩子的心目中,母亲是最可敬的人,但我的母亲对我们却极少有温存、爱抚的表示,更不要说那些夸奖、表扬的话了。母亲说话的声音很洪亮,每当她的声音达到一定的强度在家门内外响起时,差不多就是我们几个孩子挨骂挨打的时候到了。”“作为家中长子,我领教的巴掌最多,尽管我经常弄不明白自己错在哪里。母亲不曾抚摸过我们,肌肤上的接触就是母亲的巴掌,不知何时就会伴随着她的叫喊声落下来,至于落在身体的什么部位上,她似乎也不加以考虑。后来我上学了,学习成绩一直名列前茅,但即使我取得非常好的成绩,也不能换得母亲的表扬,父亲只是点点头,就算是鼓励了。无论是学业还是家务,年幼的我都力图做得好些、再好些,成为弟妹的楷模。这样要求自己不为别的,仅仅是为了避免惩罚而已。那时,我还不很懂事,说不清心中是啥滋味,只是终日内心苦闷,惟恐听到母亲的叫喊声,那声音会令我颤栗很久。我曾经发誓长大后远离母亲,逃出那个可怕的家庭。”“当我渐渐地长得高于母亲而对她不那么恐惧时,我发现自己开始畏惧那些与母亲脾气相似的女人了。我很不喜欢身材高大、性情爽直、说话声音洪亮的女人,甚至不敢正视她们。我自问心中无愧,凭什么怕她们,但就是克制不住这种感觉。在这些人面前,我变得谨慎、胆怯、做事前思后虑,与她们交往时唯唯诺诺的,很小的一件事就能使我心里很久不踏实……”

(二) 病例分析

刘先生的故事讲述完后,问题发生的原因也就随之暴露出来了。他恐惧女领导的种种表现,是由当年畏惧母亲演变而来的。这是一个泛化的过程,是幼年记忆中特定的恐怖对象留在心中的痕迹,在一定条件下的再现和扩大化。

一个人幼年的生活经历和体验,将对其个性发展产生深刻的影响。也许,刘先生的父母双亲在几十年前尚且不知,仅是按照自己所信奉的教子方式去付出种种

努力,可谓是一种严厉的爱吧。然而,不论是无意塑造还是苦心雕琢,孩子的个性发展却是在压抑和惊悸中走向畸形。对于孩子来说,父母亲不仅是其生命的赠予者、生活上的依靠者,还意味着在精神上有榜样、权威与约束作用。俗话说“润物细无声”,父母的言行举止对儿女们的作用是潜移默化的。

一个人早年生活中所发生过的事情,保留在头脑中的更多的是感觉记忆。虽说感觉记忆不一定像言语表达得那么清晰、明确,但却是深刻、难以忘怀的。或许幼年时的混沌不知,在某种程度上可以保护自己的心灵上少受些刺激,但这些刺激作为一种不愉快的体验,却会悄悄地“渗透”,被“镌刻”在心里,以感觉记忆的形式保存下来。总而言之,人生经历的坎坷,感情方面经受的创痛,凡是能在人们心灵上留下“磨痕”的东西,都不会自然而然地消失殆尽。时间不可能磨去所有的记忆痕迹,这些残存的东西有可能在其日后成长的过程中,被一个个相应的事件或人物“唤醒”,刘先生的症状正是这种不良痕迹的再现。在此,女领导的某些特征和表现,唤起了他早年对母亲的畏惧感,就像心灵上的一个敏感痛区,经不得敲击和碰撞。

在与刘先生的交谈中,笔者着重和他谈了两个问题,明确分析了其现实症状源于幼时创伤,女领导因与其母某些特点相似,无意间成为其身份的替代者,怕女领导实则是惧怕母亲心态的再现。刘先生对这个问题的领悟对心理治疗将起关键作用,假如刘先生能够将两者区别开来,不再“混淆”对母亲和女领导两人的感受,便能在情绪和行为上保持相对的稳定状态,以便于单独处理早年生活史留给自己的那些不良的痕迹。另一个方法是在理解自我的前提下,帮助刘先生找出自己观念上的谬误之处,将幼年时与成年后的感觉分别置之。比如:“你是否会因此而怨恨母亲?”他先点点头,继而又摇摇头,说不敢恨母亲,因为母亲给了自己生命(而承认有所怨恨才是真实的感受)。讨论这个问题,医生指导其先承认感受,接受幼儿期曾有过的感受的真实性;然后才是站在成人的角度去理解母亲,而不是像小孩子那样单纯地畏惧母亲。在这个案例中,以对母子感情的再理解、再认识,来帮助来访者改变对母亲的体验,降低畏惧心理,进而使之不再泛化到其他人的身上。

接手这个案例,笔者个人的感触颇深,就此多说两句:作为父母亲,你们拥有教育儿女的权利。对孩子的教育方式可以因人而异,但成功的教育离不开两个方面:理性和适度。理性使我们在教育上有“目标”,减少单凭感情色彩、盲目的、随心所欲的爱。适度让我们在教育子女的过程中把握住“火候”,爱得恰如其分,并能使爱的付出得到预期的效果。对孩子不是不可施以惩戒,但一定要做到惩罚之因清楚,训诫之后明理,千万不能越打越糊涂,甚至造成终生“内伤”,影响他们的身心发展

精神检查:

意识清楚,年貌相符,衣着整洁,接触好,表情焦虑,双眉紧锁,言谈切题,能主动完整地叙述病情。患者称这8个月来他太痛苦了,身体总感觉不舒服,反复去医院做了很多检查,却总查不出什么问题。每当症状出现时,自己非常恐惧,有时感到自己要失去控制,有病不怕,就怕查不出什么病,吃了很多药都没有效果,有时真想死。在询问下,患者谈及了自己的工作和生活情况。患者担任了厂长职务后,大量的工作要去做,可是领导班子不团结,使一些工作无法顺利进行,有时真想辞去厂长的职务去干自己的技术工作,可又不甘心就这样放弃,心里很矛盾。爱人对他的所作所为并不十分理解,有时抱怨他受苦受累,照顾不了家和孩子,又挣不了什么钱,自己真是有苦难言。患者反复问医生是否见过像他这样的病人,他的病能否治好,求治心情极为迫切。

(二) 病例讨论

1. 本病例有以下特点

(1)发病诱因:临床观察研究认为,焦虑症的发生与生理遗传因素、早年的经历(失去与分离的体验)、家庭环境、性格特点以及生活中的压力有关。本例患者发病有着明显的社会心理因素。由于生活所迫,患者过早地挑起了家庭生活重担,不能从父母和家庭中获得依靠和安全感,被剥夺了做孩子的权利,造成了患者对自己行为能力缺乏自信、谨小慎微、怕出事、容易紧张的性格。这使得患者在今后的工作和生活中,遇到问题、困难和烦恼时,不善于寻求帮助及与人沟通,而习惯于自我压抑。同时,这种焦虑素质也削弱了患者对挫折和压力的承受能力,增加了今后焦虑症的患病风险。厂长的责任和人际关系的压力使患者感到精神紧张,内心冲突加剧。此外,患者在童年期,因母亲多病,经常担心失去母亲,这种体验使患者对丧失和分离十分敏感,对自身健康比较关注,一旦遇到应激,如爱人外伤便出现焦虑。

(2)病程特点:急性起病,初期为发作性病程,随着病情发展,症状持续存在,病程8个月。

(3)临床表现

- ①无明显原因突然出现极度恐惧、濒死感、失控感。
- ②自主神经功能障碍:头晕、心脏剧烈跳动、窒息感、出汗等。
- ③发作频率:每周发作3~4次,每次发作持续30~60分钟不等。
- ④发作间歇期,因预期恐怖,即担心再次发作而不敢单独外出。随着病情进展,精神紧张及躯体不适感持续存在,工作和生活均受到影响。

后相信医生的解释和检查的结果。因此可以除外疑病症的诊断。

4. 治疗

首先给予药物治疗,以较快地改善和减轻患者的精神紧张和各种躯体不适感。选择抗抑郁剂与抗焦虑剂,给予多虑平 50~150 mg/d,罗拉西洋 3 mg/d。同时给予心理治疗,以支持性心理治疗和行为治疗为主,向患者解释所患疾病的性质,减轻患者的思想顾虑,增加对治疗的信心。在患者表示理解之后,要求患者快速呼吸 30 秒钟。事后,患者感到头晕、心慌、出汗等不适。这时,让患者体会身体感觉与紧张害怕时的感觉是否相同,患者回答在两种不同情况下,出现的躯体不适症状差不多。通过这个练习,使患者明白了自己的躯体不适感并不是什么疾病,在快速呼吸后也可以出现头晕、心慌等躯体不适感。要求患者回家后每天做一次快速呼吸练习,并且记录身体的感觉(暴露症状)。经过几次体验后,症状减轻。通过快速呼吸练习,使患者明白一个道理:自己可以控制自己的症状。2 周后患者的焦虑情绪有所改善,在上述治疗的基础上,每周进行一次门诊心理治疗,以森田疗法、认知行为疗法治疗为主,逐步帮助患者分析和认识自己的性格特点,对待事物的态度、看法和行为方式,以及上述因素与疾病的关系和对症状发生、发展的影响。帮助患者树立顺应自然的生活态度,忍受疾病的痛苦,积极行动,在这个过程中逐步将对自身的过度关注转移到外界事物上,同时也提高了自身对焦虑的承受能力。最后,在疾病的恢复阶段,进一步指导患者将顺应自然的生活态度扩展到生活和工作中去,面对各种不安,积极努力奋斗,不作完善欲的俘虏,使其心理健康的水平不断提高。

病例三 强迫症

(一) 病历摘要

患者男性,25 岁,未婚,高中毕业,专业技术人员。

主诉:因怕得传染病而反复检查及重复动作 6 年,担心自己做出罪恶的行为 2 年。

现病史:患者反复检查及重复动作出现于高中二年级(17 岁)一次体检之后,在这次体检中,患者被检查出乙肝病毒表面抗原为阳性。患者对此感到非常不安,既担心自己的健康状况,又担心一旦被别人知道后,会被人歧视。患者开始有意回避一些脏的物体,如垃圾堆、垃圾箱等,患者当时认为这些行为是必要的,未加以克制。高三下半学年(18 岁),患者因“乙肝”住院治疗,未能参加高考,半年后“治愈”出院。此后,患者对“脏”越来越敏感,回避一切自认为是脏的物体,患者认为如果

不小心碰到这些物体,会使自己旧病复发甚至会危及生命。逐渐出现了反复检查及重复动作。路过“脏”东西时,患者时常会担心“刚才碰到了它们”,于是要回去检查,以减轻这种焦虑。检查的方法起初是从原路再走一次,以确定碰到与否。渐渐地重走一次并不能克服担心,患者遂采取新的措施,即向“脏”东西靠近一段距离后再仔细检查,通过空间上更接近却仍然没有碰到“脏”东西,来证明刚才确实没有碰到。得到验证之后,患者可安心。然而好景不长,新的担心随之而来——“比刚才还近,不是更可能碰上吗?”于是,患者就再向“脏东西”更靠近一些,更加细致地检查。久而久之,患者形成了一套相对固定的行为模式,即在其出现担心时,不断地重复检查—靠近—再检查—再靠近的循环。患者为此深感苦恼,知道这样的重复检查是徒劳的,反而会给自己带来真正的伤害——在不断地靠近“脏”东西时,最终真正地接触到了它们。但患者不能克制,每当担心出现时,只能以这种方式来降低焦虑。

患者在高中毕业后,断续做过推销员等几项工作,4年前进入现在的工作单位做技术员。由于工作环境特殊,压力非常大,故患者在做一些比较重要的事情时都会有很强烈的担心,比如在关电闸时怕关错了,在操作前要花费几分钟的时间先认定所要关的电闸,在关完电闸之后仍不放心,要反复检查多次,确信自己没有关错之后方可继续做其他的工作,以致工作效率低下。患者为此十分苦恼,怕别人看到自己的异常举动而极力控制自己,但无明显的改善。

2年前的某天,患者在银行进行储蓄时,忽然出现了一个念头“要是把银行抢了,就能有很多的钱!”患者被这个念头吓了一跳,匆忙离开了银行。之后患者感到非常不安,在严重时,只要看到银行都会感到紧张。另外,患者还担心自己会一时冲动而做出摸异性乳房或臀部的行为。

随着症状的持续发展,患者到精神科求诊,精神科医生给予药物治疗,但由于患者担心药物对肝脏有损害,而拒绝药物治疗,由医生介绍来进行心理治疗。

个人史:患者自幼生长于北京市城区的一个普通工人家庭,胞2行大,有一个弟弟,小他7岁。父母的脾气均比较暴躁,经常争吵,对患者经常责骂。记得在患者5岁左右的时候,有一天中午,患者独自拉着一个儿童玩具车,在院子里玩得正高兴,突然睡午觉的父亲冲了出来,一脚就把玩具车踩碎了并大声训斥他。患者不记得后来的情况,只记得当时自己被吓呆了,甚至没有哭出来!患者后来经常以此事为例向别人抱怨父亲对自己很不好。

在患者刚上小学时,弟弟出生了,父母便很少时间和精力注意他。他感觉父母不喜欢自己——“他们总是在不断地要求我应该做什么、应该怎么做,而且从未

训斥的记忆,似乎是“阉割焦虑”的变形。患者在弟弟出生后,体验到了强烈的丧失感,患者曾幻想“要是没有弟弟就好了”,但由于超我的强大力量使得欲望被压抑了。

3. 治疗

这个病例的治疗主要采取行为治疗的技术。在对患者进行一段时间的放松训练之后,要求其在治疗环境中“暴露”于纸篓、垃圾桶等物体前,阻止其一切检查行为,同时治疗师的指导下进行放松。治疗设置为每周2次,每次50分钟,并且要求患者每天自我训练一次。在进行行为治疗的同时,在浅层对患者的感情及生活经历进行探讨,帮助患者认识到自己的内心需求。

经过10周训练和治疗,患者的强迫行为明显减少。18周之后,患者认为自己已经恢复到了“正常”,治疗就此结束。

病例四 社交恐惧症

(一) 病历摘要

患者男性,33岁,已婚,初中毕业,个体经营者,身高1.70 m左右,穿着普通,清瘦,谈话直爽、主动,表情丰富,看上去比实际年龄年轻些。

主诉:与人交往时紧张、羞于见人18年。

现病史:患者羞于见人的感觉出现于15岁手淫之后,当时认为这是肮脏、下流的行为,为此内疚、自责,在学校不敢面对同学,害怕被人发现自己曾有“卑劣、下流”的行为。上课时无法再像以前那样认真听讲,学习成绩逐渐下降,由原来的优秀生、班长下降为“差学生”,结果高中入学考试失败。但是,由于手淫带来的兴奋和快感,总是控制不住想尝试。在每次手淫时都想像着和最漂亮、最优秀的女同学或女老师发生性关系,在学校里也渴望和女孩子有更多的交往。另一方面,因手淫而致的自责感和害怕被同学发现的担忧又使他尽力克制不去手淫。在学校时也尽力克制想和女孩子交往的愿望,同时害怕与她们来往。就这样,冲动和对冲动的克制几乎每天晚上都发生。在学校不敢和同学交往,不敢正视别人的目光,这种恐惧在女同学面前尤为严重。总是担心别人会看出他曾有过手淫行为,因而尽量回避上公共厕所。由手淫带来的这些困扰和学习成绩的滑坡使患者日益变得自卑,日益回避与别人的交往。每逢不得和别人说话时,总是紧张地直冒汗,当感觉到对方的目光在注视着时,就更是手足无措,不知说什么好。焦虑感严重时,常常伴有心慌、手抖和出汗。

为了挣脱内心的自卑,摆脱令他尴尬的困境,他于初中毕业后开始从事个体服装生意,希望通过挣钱来挽回失去的一切,幻想着成为有钱人之后娶一位高雅、年轻貌美的妻子,赢得无数人的羡慕和尊敬。数年后,他的服装生意从县城做到了京城,拥有了自己的店面和十几个伙计,收入也颇为可观,但怕见人、与人交往紧张的问题一直没有解决。离开家乡之后,他尤其怕见到以前的熟人,担心自己以前的经历被更多的人知道。与女性的交往一直是他最大的困难,20岁以后经朋友介绍交往了几个女朋友,每次赴约前都紧张万分,见面后也不知说什么好,他越是想表现的洒脱和有风度一点,就越是紧张,结果往往是几次见面之后就不欢而散。直到25岁认识了现在的妻子,她来自于农村,性情温和、善良,待人宽厚,使他的紧张感大大减轻,这是他10年来第一次能比较自如地和女性相处,心情也变得愉快了。到了半年之后商量婚事的时候,他又出现了紧张和焦虑,担心手淫的行为会影响性功能,影响生孩子,还担心自己的阴茎小会被妻子耻笑。第一次和妻子同房时,他非常紧张,以至于早泄。好在妻子体贴谅解,性生活中也常常主动,使他逐渐解除了焦虑。但成婚多年来就像他不敢上公共厕所一样,他也从不敢在性生活时开灯,惟恐妻子发现自己的阴茎小。直到几年前看了有性行为的录像之后,知道自己的阴茎不比别人的小时,才消除了这一顾虑。婚后的头几年里,患者和妻子感情和睦,性生活和谐,逐渐减轻了和女性交往时的紧张和焦虑,但每逢遇到看上去有知识、有教养或事业比较成功的漂亮女性时,仍克制不住地怦然心动,想入非非,晚上和妻子同房时就想像着是和那个女人而不是妻子。

近三四年来,随着婚姻生活的日趋平淡,他对妻子越来越失去兴趣,在性生活上也常常被动和应付。虽然在理智上知道妻子善良纯朴又温柔,相貌也不错,是自己应该满意的贤妻良母,但在内心深处却总渴望着气质高雅、漂亮、事业有成的女人。他自卑于自己文化素养低,身材不够魁梧,肌肉不够发达,在社交场合缺乏吸引漂亮女性的风度,在和同性朋友的交往中,也极易紧张焦虑,总是担心自己的形象,关注自己是否显得憔悴、疲惫。在生意场中他曾结识了一位成功能干的女性,很为之心动,总想多接近她些。但越是想接近她,就越是紧张得不知所措。就这样,他对和妻子的性生活越来越没兴趣,对婚外性生活的渴望却越来越强烈,有时走在马路上看到年轻漂亮或有知识的女性就会产生性冲动。一方面是强烈的渴望,一方面是自惭形秽。内心的冲突使他更回避和别人的交往,他告诉医生,找到一位他所渴望的女人是她惟一的奋斗目标,他想回老家拓展更大的生意,挣更多的钱去赢得这样一个女人。

背景资料:

患者生长于南方某省一个普通的农民家庭,排行老大,有2个妹妹,分别比其小2岁及3岁。父母亲都是老实厚道的农民,待人随和、宽厚,对孩子也从无严厉责骂,家庭气氛非常和睦。由于他天资聪颖,从小学习成绩优异,深得父母的喜爱。

在他四五岁时,曾看到裸体的父亲压在母亲的身上,母亲对他说:“你爸爸打我”,他就去抓父亲的胳膊,把父亲抓疼了,父亲挥手打了他一巴掌,他感觉很痛,哭了,然后母亲又来安慰他。从十一二岁起,他对女性以及女人的内衣出现了好奇感和神秘感,在窥探女性的欲望驱使下,他悄悄地看过母亲的内裤,当时觉得很兴奋,此后又有过几次类似的行为。15岁开始手淫,在一次手淫的时候,不巧被妹妹撞见,当时非常紧张、尴尬,妹妹没说什么就出去了,他为了挽回面子,还故作镇静地和妹妹打招呼。此后多年和异性交往时的紧张感都类似于手淫时被妹妹撞见时的体验。

在回忆个人成长经历时,他把15岁前后分成了两个部分:15岁以前的他非常自信、愉快,是品学兼优又非常活跃的好学生。15岁出现手淫行为以后,他逐渐变得胆怯、自卑、过分敏感,并尽可能地回避社交。初中毕业后一直从事个体生意的经营,多年来奋斗的动力就是摆脱自卑,他总是幻想着非常成功的那一天,甚至在梦中都不断呈现着他成为了一名专家、董事长或名演员,被女人欣赏,被男人尊重。

(二) 病例分析

根据病历资料,患者与人交往时紧张、焦虑,在异性面前尤为严重。在焦虑时伴有心慌、手抖、出汗等自主神经系统的症状,社交前即出现期待性焦虑和回避性行为,患者自己知道焦虑和紧张没有必要,但难以克制。病史迁延18年,明显影响了患者的生活质量和个人发展,给本人带来痛苦。访谈中未发现精神病性症状,自知力完好,主动求治,完全符合CCMD-3所列举的社交恐怖症的诊断标准。

从症状的心理动力学意义上分析,患者的社交恐怖症状是对内心冲突、妥协的产物,冲突来自于本我的性幻想和冲动与对抗这种冲动的超我的力量。一方面,他对年轻、漂亮和成功女性有强烈的性渴望和性冲动,另一方面又害怕惩罚(如害怕被妻子知道,怕染上性病,怕被警察抓住)。性冲动是来自于本我的内趋力,害怕惩罚象征着超我的力量。患者青春期出现的社交恐怖症状是幼年俄狄浦斯冲突再现的结果,具有典型象征意义的事件,是他幼年曾亲眼目睹父母性生活过程并挨了父亲的一巴掌,这一记忆一直保留至今,说明最初的阉割焦虑是非常强烈的。在青春期,这一焦虑通过手淫行为及窥探母亲内裤时的性兴奋再次被激活,他在手淫中总是幻想着漂亮的女同学甚至女老师,同时又害怕被人发现,害怕手淫会使自己的阴

茎变小,这种阉割焦虑使他恐惧社交、回避社交。

从患者的人格结构上分析,患者具有较突出的自恋性人格的某些特点:①过分关注自己的形象,过分在意别人对自己的评价,自卑于身材不够魁梧,肌肉不够发达等。②沉浸于对名誉、地位和个人成功的追求和幻想之中,表面上看,他对年轻貌美和成功女性的向往是为了满足性要求,但实际上,他是渴望通过征服成功漂亮的女人来抵抗阉割性焦虑,满足自恋。③对优越感的追求,在治疗过程中患者要求特殊待遇,和治疗师讨论的过程中,询问接受医生治疗是否比接受护士的帮助更为优越的问题。

可观察到的心理防御机制有:置换(displacement)及投射(projection)——将指向于本我性冲动的焦虑置换为社交恐怖,使对内在的焦虑投射到外界去并见诸行动(acting out)——冲动之后直接见诸于行动——刻苦的经营行为,是患者一贯的行为特点;否认(deny)——如果再找一个意中的女人并不让妻子知道,就不会伤害妻子;幻想(illusion)——经常幻想着自己成为一名专家或知名人物。显然,自我(ego)运用压抑的防御机制不够,致使本我的冲动经常直接浮现于意识之中,导致患者的道德性焦虑。

第二节 心理因素相关生理障碍

一、概述

+++++

心理因素相关生理障碍指一组与心理社会因素有关的以进食、睡眠及性行为异常为主的精神障碍。

二、典型案例分析

+++++

(一) 病历摘要

患者罗某,女性,18岁,高中二年级学生。

主诉:进食少、极度消瘦、下肢浮肿2年,易怒、情绪不稳3个月。

现病史:患者从小学到初中,学习成绩一直名列前茅。1997年考入高中,虽然学习很努力,但成绩平平,父母为此着急,患者也深感不安。一次,患者听同学议论

她身材偏胖(身高 163 cm, 体重 53 kg), 患者开始节食减肥, 每日进食少量主食(50~100 g), 逐渐不吃主食, 只进食蔬菜、水果、花生米。有时服泻药, 并增加运动量, 如跑步、打球等。2 个月后, 体重下降至 43 kg。患者仍然认为自己太胖, 继续节食, 遭到父母反对, 经常因此和父母争吵。

患者精力尚充沛, 能够坚持正常的学习, 1999 年初患者体重下降至 36 kg 而出现闭经、双下肢浮肿, 在父母的强迫下住当地医院治疗。检查发现患者子宫萎缩, 贫血, 头部 CT、胃肠功能及内分泌检查未见异常。给予白蛋白、脂肪乳输液治疗。2 个月后体重增加到 40 kg。但是, 当患者听别人议论她面色好看时, 又开始节食, 总担心自己发胖。逐渐出现乏力, 情绪不稳定, 经常因为小事向家人发脾气, 有时父母劝患者吃饭, 患者生气, 将饭菜摔到地上, 对父母大声喊叫, 摔东西。在父母再三的劝说动员下, 由母亲陪伴到我院进行心理咨询。

个人史: 平素体健。患者足月顺产, 为独生女。自幼受到父母亲过度的关注和严格的管教, 患者穿衣、吃饭、看书、学习、交友都要受到家长的干涉。随着孩子年龄逐渐增长, 父母感到患者越来越不听话。病前个性: 胆小、听话, 容易紧张, 敏感, 非常关注他人对自己的态度和评价, 缺乏主见。13 岁月经初潮, 月经规律, 1998 年 12 月闭经。

体格检查:

血压 110/70 mmHg, 体重 33.4 kg, 皮下脂肪极少, 皮肤干燥、弹性差, 乳房萎缩, 腋毛、阴毛脱落, 心率 61 次/分, 双下肢浮肿, 神经系统检查未见异常。

实验室检查:

血尿常规、肝肾功能、心电图检查均未见异常。

精神检查:

意识清楚, 接触被动, 语量少, 多低头不语, 言谈切题, 称自己没有什么病, 父母认为她有点儿瘦, 是他们让她来看病的。希望自己的体重增加一点儿, 最多不能超过 38 kg, 否则太胖、太难看了。患者认为发脾气的原因是自己不饿, 可是父母总是逼迫她吃饭。患者对吃饭非常反感。虽然自己不想发脾气, 但有时控制不住。

(二) 病例分析

1. 本病例有以下特点

(1) 患者认为自己“太胖”故意减少进食, 回避“导致发胖的食物”, 患者对吃饭非常反感。虽然自己不想发脾气, 但有时控制不住。符合厌食症状。

(2) 消瘦, 体重由原来的 53 kg, 减至 35 kg, 减轻 34%, 比平均体重减轻 15%

条件。

(3)学习紧张、家庭破裂或家人死亡、受到惊吓以及病前人格特点(敏感、容易焦虑、显著情绪不稳定、拘谨、刻板等)均可构成发病诱因。越来越多的证据显示,社会文化因素与生物学因素的相互作用对发病有明显影响。临床观察还发现患者同父母的关系一般是不好的,冲突可以是多方面的,女儿常将家庭问题以厌食症的形式表现出来。

5. 治疗

根据上述情况,结合本例的临床特点作如下分析:

患者为独生女,自幼受到父母过度爱护和严格管教,父母的过多关注影响了患者的心理和人格的健康发展,使患者缺乏独立性,容易紧张、敏感。当患者进入高中,激烈竞争的学习环境使患者内心充满了紧张不安,难以适应,变得关注自己,开始节食减肥。由于极度消瘦,父母不再向患者施加学习的压力,而将全部精力转移到患者的进食问题上,为此患者不断地与父母发生冲突,当患者感到无法承受时便出现发脾气、冲动行为。患者的行为及情绪问题一方面是用来表达对父母的不满,一方面是由于应付学习和生活上的压力,同时也是用来对抗和控制父母对自己过多干涉的一种手段。

这种以行为问题来表达和应付困难的方式是不适宜的。它反映出患者心理发育不成熟以及患者家庭关系的不和谐。神经性厌食症的治疗主要是心理治疗,可进行躯体辅助性治疗,必要时可配合精神药物治疗。对该患者进行行为治疗和家庭心理治疗是非常必要的。帮助家庭中的每个成员了解和改善彼此的关系,改变父母对女儿的过多关注,包括对女儿进食态度和行为的关注,把孩子视为成人,平等地对待,多给患者一些独立自主的机会,使其能有一个自我发展的空间,促进其人格健康发展,提高对环境的适应能力。

6. 预后

神经性厌食症的病程常为慢性迁延性病程。未经治疗的病例,其病程多呈慢性复发性,常有持久存在的营养不良、消瘦、人格缺陷及社会适应不良等问题。经过治疗的患者有40%至60%的病例有明显改善,部分病例经治疗后可以正常妊娠分娩。严重消瘦的患者可伴躯体并发症而危及生命,也有饿死、自杀的极端情况。约15%~23%的病人死于极度营养不良或其他并发症。

(李建茹 许克勤 沈东郁 杨蕴萍)

人格障碍

一、人格的概念

+++++

人格是个体心理特征的总和,具有明显的一贯性和恒定性,代表了一个人的一贯行为倾向和恒定的反应方式,是一个人的惯常行为模式。人格是在个体发育过程中逐步发展形成的心理属性,一般认为年满 18 岁始达成熟。在 6 岁以前,人格具有较大的可塑性,环境和教育对其有较大的影响,一旦人格成熟后,常常保持终生而很少改变。所以,人格反映的是一个人的心理本质。

人格一词是社会通用词语,使用于不同社会场合和专业范围时,其含义也往往有所不同。用于伦理道德场合,则有好坏善恶之意,例如,人格有高尚、低劣之区别;用于法律场合则有权利之意,例如,人格有不受侵犯之规定。不过,心理学所指的人格,乃指一个人的心理活动特征和行为反应模式而言。

在精神病学中,性格与人格有时互相通用,例如,我们可以说“病前性格”,也可以说“病前人格”。虽然严格说来,所指内容并不完全相同,前者系指病人病前的心理学惯常行为模式,后者则对这种行为模式增添了社会评价,但二者均为合理。个性指的是人格中的突出和特殊的部分,代表了一个人的特色或特点,是人与人相区别的心理标志。例如,我们常说某某人很有个性,某某角色的个性很鲜明。气质指

的是人格中的生物学素质,与遗传和躯体有关,是人格的物质基础和器质性成分,主要表现在对人对己的态度和对外界的情绪反应之中,通称为脾气或秉性。气质是人格中的稳定成分,也是人格发展的限制性因素,俗语说“有其父必有其子”,“江山易改,本性难移”,指的就是人格中的这一部分。如果按照传统习惯,将人的心理活动划分为智、情、意三个方面,有人则认为:智能是智慧的个性,气质是情感的个性,性格是意志行为的个性,智、情、意三方面表现的总和就是一个人的性格。

人格异常作为医学概念,主要应该包括那些具有精神疾病的行为色彩,或带有精神疾病发病倾向的人格障碍类型。目前我国(CCMD-3)将人格障碍分为9型,美国(DSM-IV)分为10型,世界卫生组织(ICD-10)则分为更多型。这些类型的划分,多以临床相关疾病所表现的症状为依据。不少的异常人格,终究难免发展成为相关精神疾病。诊断人格异常的社会标准是“苦恼自己,损害他人”。在异常人格中,要注意区分人格障碍与人格改变的不同。人格障碍与人格改变二者在出现的时间及方式上均有所不同。人格障碍是在发育过程中形成的,在儿童期或青春期出现,延续到成年。尽管它可以单独存在或与其他障碍并存,但并不是继发于其他精神障碍或脑部疾病。相反,人格改变是获得的,通常出现在成年期,在严重或持久的应激、极度的环境剥夺、严重的精神科障碍、脑部疾病或损伤之后发生。

二、人格障碍的分类

各国人格障碍的分类有不少区别,以下是中华医学会精神科学会 CCMD-3 有关人格障碍的分类:

- 60 人格障碍 [F60 特定的人格障碍]
- 60.1 偏执性人格障碍 [F60.0]
- 60.2 分裂样人格障碍 [F60.1]
- 60.3 反社会性人格障碍 [F60.2 社交紊乱型人格障碍]
- 60.4 冲动性人格障碍(攻击性人格障碍) [F60.30 情绪不稳型人格障碍,冲动型]
- 60.5 表演性(癡症性)人格障碍 [F60.4 表演型人格障碍]
- 60.6 强迫性人格障碍 [F60.5]
- 60.7 焦虑性人格障碍 [F60.6 焦虑(回避)型人格障碍]
- 60.8 依赖性人格障碍 [F60.7]
- 60.9 其他或待分类的人格障碍 [F66.8; F66.9]

三、典型案例分析

病例一

(一) 病历摘要

患者郭某,女,47岁,未婚,汉族,初中文化,某市区法院书记员。

现病史:自1984年11月以来持续上访,诉其所在单位领导对她进行迫害。郭某曾被接访单位疑为精神不正常,经当地司法精神病鉴定委员会诊断为“偏执状态”。郭某本人不同意,要求复核鉴定。1991年4月20日由最高人民法院委托某医院对其进行司法精神鉴定。

郭某自幼读书,初中毕业后参加工作,1975年调至现单位。平素性情固执,自己认定的想法,不易被说服。经常与同事发生口角,有时即使自己理亏也很少认错。喜爱司法工作,经常自己以司法干部的身份为别人打抱不平。曾在某法院审理她的一位亲戚的离婚案时参与诉讼当事人闹庭,干扰审判,而她自己则认为正当。在受到有关人员批评时,郭某则往往强词夺理拒不认错,或到上级部门申辩。曾为在单位与同事不和及调级调资的事,多次找过法院所在地区的领导。

1983年底,郭某因其住房翻盖与房管部门产生矛盾。随后为此长期走访于房管局及其上级部门,因此旷工100余天。单位领导对她提出批评,郭某不以为然。1984年11月8日,郭某去单位领工资时,与庭长发生冲突。自此,郭某不再上班,亦不到单位领工资,奔走于当地及北京各中央信访机关,控告其所在单位领导对她进行迫害。甚至在她所谓主要迫害她的人王某、李某离退休之后,依然认为王、李二人指使该法院其他人员继续对她进行迫害。

郭某上访申诉的主要理由是:①其所在的区法院副院长以权谋私,包庇罪犯,枉法裁判,并对她揭发此事进行打击报复。②法院对其同事的问题不仅不追究,反而将其提升为庭长,并把她调至他的庭里工作,意在对其进行迫害。③认为该法院退休职工王、李二人勾结房管局强行拆除她的住房,使她和母亲无家可归。④1984年11月她到法院领工资时,某领导人对她进行人身侮辱。⑤该法院受某退休职工指使,而出动警车把她当成精神病人四处搜寻。⑥法院动用组织手段通过所谓精神病鉴定给她戴上精神病帽子。

郭某在上访材料、交谈中及1988年9月进行精神病司法鉴定时,反复陈述王、

李二人对她进行政治迫害的主要依据有：①她家房子被拆只是迫害的插曲，以使她有家不能归。②她的办公桌被安排在与某领导人同一办公室内并坐在对面，系故意策划及迫害她。该领导人在工作期间借讨论案子之机来影射自己有不可告人之原因或有生理缺陷而大龄未婚。③她的住处及行动均有人监视跟踪。她无论到哪儿，都有人向她的熟人介绍说她有精神病。④她在街上被不相识的人骑自行车撞伤，系该法院唆使所为。⑤法院领导以答应法院某干部调出为条件，令该人在她的问题上出具伪证。⑥法院串通她的邻居砸她家的玻璃，骂她，成心迫害她。⑦法院在分房、调整工资、调级等问题上一贯卡她，迫害她。法院上述做法的目的，旨在把她置于死地。

就郭某投诉的主要内容，最高人民法院组织人员进行了专门调查。事实是：①1979年经某法官（郭某控告的法官）审理的案例中确有两例有错判、轻判情况，但只是认识问题，不存在以权谋私、包庇罪犯、枉法裁判等郭某所指控的内容。郭某并未参与该两案的审理，没有证据表明郭某在当时及以后对判决提出过不同看法，而且后来该两案的纠正与郭某无关，故谈不上就郭某揭发此事对她进行打击报复。②将郭某调到被提升的庭长手下工作属于正常调动，不存在迫害的问题。③1983年底郭某的住宅翻盖，系房管局对该片住宅进行正常改造，郭某在多次给予其周转房的情况下迟迟不肯搬出，引起邻居愤慨，联名出具见书面证，当众撬开郭某的房门，清点并搬出物品，妥善保管，随即由房管部门施工。现该房已翻盖完毕，仍由郭某使用，而郭某自己却不去居住，故不存在使郭某与其母亲无家可归的事实。④1984年11月郭某到单位领工资时，与庭长发生冲突，这是事实。但该庭长当时是以领导身份要求郭某不上班需请假，因郭某不服而导致口角，双方均有责任。不存在该庭长对郭某进行人身侮辱的情况。⑤法院领导为解决郭某与该庭长的冲突问题，在冲突后的当时及当晚确实派人、派车找过郭某和郭某的联系人及亲属。但那时并没有人正式说过郭某有精神病，也不存在把她当成精神病人四处追捕的事实。⑥1988年9月对郭某进行司法精神病学鉴定，系国务院信访局的接访人员疑郭某有精神失常的可能，会同当地市信访办公室，建议对郭某进行司法精神病学鉴定。鉴定过程虽未向郭某公开，但系独立进行，结论并未受到任何组织或个人的影响，不存在郭某所谓的用组织手段给她戴上精神病帽子的问题。以上调查结果经多方向郭某说服解释，均不能改变郭某的固定看法。

郭某告状8年，风雨无阻，废寝忘食，不顾生活困难和个人安危，坚持不懈，受挫气不馁，决心不动摇。她居无定处，行踪隐秘，风餐露宿，衣食无着。单位多次四处查寻，给她送钱送物均找不到人。托人带信告知只要回去上班，一切问题都好解

决,她还是不肯露面,仍然到处告状不息,事实上政府各有关部门早已被她告遍。此次郭某找到了全国政协,投诉于一位女政协委员,赢得了对方的同情,当即被其收留于其家中居住,并由这位女政协委员出面,通过政协政法组各位法界元老的帮助,又把诉状转到了最高人民法院处理。

精神检查:

神志清楚,定向完整,言谈切题,情感协调。在谈话中坚持其原来描述的内容及她的理由和根据,表示目前要解决的是摘掉精神病帽子,以便能过正常人的生活及正常工作,至于其所在工作单位对她所进行的政治迫害问题,可以留待以后解决。坚持自己的看法不动摇,未引出幻觉及其他精神病性症状。

诊断:

偏执性人格障碍

(二) 病例分析

本例在病史中及精神检查中均未发现精神病性症状,而是其行为明显偏离特定的文化背景和一般认知方式(尤其在待人接物方面),如本患者拒绝危房改造,在邻居见证下强行改造房屋。患者自幼性情固执,自己认定的想法,不易被说服。如她认定王、李二人迫害自己,在二人退休后仍在害自己,对领导人故意刁难自己的想法长期不变,长期与同事,邻人的关系异常偏离,符合人格障碍的诊断。

病例二

病历摘要及病例分析

1. 病人基本情况

患者李某,男性,35岁,职业为高级工程师。已婚,有一男孩7岁,妻子34岁,小学教师。

2. 现病史

病人自述从19~20岁(上大学时)开始就经常感到心情不好,觉得生活缺乏乐趣,必须不断强迫自己才能集中精力学习。上课注意力不集中,感觉自己记忆力差,课程紧张时觉得压力更大,整日忧心忡忡,非常羡慕别的同学能生活得轻松愉快。由于自己所学的专业对口,毕业后很容易找到了一个较理想的工作,单位经济效益很好,领导对他比较重用,让他负责搞一些重大的项目,经常到外地出差;病人感到压力更大了,担心自己做不好,工作时非常紧张,反复检查,如果在思考问题

时被人打断,就必须从头再来。由于注意力都在工作上,与同事的交往很少,没有知心朋友。曾因情绪低在另一家医院就诊,服用氯米帕明,但是效果不明显,故求助于心理治疗。

3. 治疗师对病人非言语行为的观察

(1)姿势:朝向治疗师,略向前倾。

(2)注意力:集中。

(3)思维:系统的、连续的。

(4)情感:压抑、不外露。

(5)相互作用:把控制权交给别人。

(6)顺应性:顺从、合作。

(7)价值观:重视精神生活的质量。

(8)家庭排行:老大。

(9)成长:在城市长大。

(10)交往模式:语速较快,语调一般,表情非常诚恳。顺从,合作,有礼貌,尊重治疗师并希望得到帮助。情绪低落,焦虑,自我评价低,认为自己无能,无吸引力。具有利他性的自责,表现为抑郁症状。

4. 临床诊断

按 CCMD-3 诊断和分类:

(1)病人感到压力更大了,担心自己做不好,工作时非常紧张,反复检查,如果在思考问题时被人打断,就必须从头再来。

(2)其人格的形成受家庭环境的明显影响,母亲有智力问题,没有工作,不会理家,也不会照顾自己和孩子,其母亲曾因睡觉翻身把婴儿压迫窒息而死,故病人出世后由父亲一手带大。父亲性格刚强、固执、专制,因妻子能力低不得不挑起所有家庭重担,心情郁闷,故常喝酒,对孩子要求严格,态度粗暴,稍不满意就责骂甚至动手打。

(3)父母经常争吵甚至互殴,病人的小伙伴们常借以上引起家庭不快的内容对病人进行嘲讽,病人经常受同学们奚落、欺负,因此感到很自卑,在受到奚落或欺负后也不敢反抗。在病人的记忆中,幼年生活是屈辱、自卑、压抑和孤独的。

(4)由于家庭缺乏温暖、自由、鼓励的气氛,因此病人没有自尊自信,情感表达受抑制,缺少与同龄人交往的经验和对快乐的体验。

按 DSM-IV 诊断:

轴 I:心境恶劣障碍

轴Ⅱ:回避型人格障碍

可利用的主要资源:对文学艺术的热爱,对未来幻想的能力。

5. 行为分析

行为分析是行为治疗中的重要内容,分反应、刺激、结果三部分,在此基础上找出治疗的重点,制定行为治疗计划。

问题一:伴有强迫特点的抑郁情绪。

(1) 反应

①动作:动作慢,不能集中注意力,不愿与人交往,工作困难(一旦被打断就很难继续,必须从头开始)。有时把做不完的工作拿回家去做。

②情绪:低,无兴趣,烦闷,见人紧张。

③认知:总认为自己不行,做不好,认为别人会看不起自己。

④生理反应:无特殊。

(2) 刺激

①诱发性刺激:不确定,间隔出现,无规律性。

②例外刺激:出差在外独自工作时心情较好。

(3) 结果

①短期(阳性反应):可以回避工作和家庭责任以及人际交往。

②长期(阴性反应):丧失发展的机会,人际关系差,孤独,自我评价低。

问题二:因与一年轻女子的情人关系不能确定而感到痛苦。

(1) 反应

①动作:反复向女友询问有关感情问题,经常打电话,约她见面,要求对他们之间的情感问题给予肯定的答复。

②情绪:悲伤,无助。

③认知:认为自己没有吸引力,能力不够,除了在经济上能支持自己的女友,没有别的优势。

④生理反应:病人没有机会与女友有亲密的接触。对夫妻性生活冷淡,每次性生活持续时间很短,且一年未有性生活。

(2) 刺激

诱发性刺激:女友不与他联系,找借口不与他见面,或其女友仍与前男友保持联系。

(3) 结果

短期(阴性反应):因情绪低影响目前工作和家庭关系。

见面后,两人碰巧都去某地出差,结伴坐火车前去。旅途中不免孤单寂寞,两人有机会进行较深层的交流,都感到对方与自己在性格上有几分相似,能够彼此理解,互相安慰。回京后决定结婚。婚后1年儿子出世。妻子生活节俭,只顾工作和家庭,没有业余爱好,故生活单调,没有家庭乐趣。妻为小学教师,收入不高,儿子已上小学,因此病人认为自己必须努力工作,多挣钱,以让妻儿过上好日子。

(9)婚外感情:1998年初,病人受领导委派,与一男同事一起去外地监管单位承建的项目。在外地遇见一年轻已婚女子,因生活所迫离开家乡独自在外打工。同事喜欢这个女子,就建议病人把她带回他们的住所。后来同事与该女发展成情人关系,但同事对该女的感情并不认真,不愿在经济上资助她,病人就劝同事对她好点儿,自己拿钱资助她。在同事与该女分手后,病人仍留她在城里,帮助她,希望她能移情于他(他很爱她)。回北京后病人仍与该女保持联系,给她寄钱,帮助她在家乡开美容店。该女接受帮助,但不答应做他的情人,故病人十分痛苦。

7. 建立医患关系

病人对治疗师的期望主要有四点:一是希望治疗师帮助他摆脱情绪困扰,提高工作效率。二是找一个交流的对象,因为别人不会总耐心地听他讲自己的经历和感受。三是寻找到支持、鼓励和建议。四是与治疗师分享秘密——他与一女性的婚外感情。

病人在过去的生活经历中形成了这样的行为模式:出于生活的压力,他不得不承担许多责任,甚至超过他能承受的能力。因生活经历所致,他不敢也不会表达自己的不满、苦恼、反抗和愤怒,也不会维护自己的权利。他于是通过消极抵抗的方式来拒绝别人加给他的过多要求,其抑郁情绪和强迫症状使他在无意识中达到了自己的愿望。因此病人总是接受别人的要求,然后拖延,最后对方不得不减少对他的要求,这样自己可以不承担责任。在治疗中治疗师应避免病人重复这种行为模式,少给他压力,少进行指导,鼓励情绪宣泄和自我表达。治疗关系是平等、温暖、双向交流、支持和鼓励的,治疗师以自己的行为做榜样,向病人示范自己喜欢的事应勇于承担,而不愿接受的事情可以适当拒绝。

8. 治疗计划

(1)认知水平:改变病人对自己的评价。病人认为自己除了上学时成绩好、工作认真外,没有别的足以吸引别人的优点。在治疗中,帮助病人发现真实的自我,发现他实际上是一个充满激情、富于幻想、热爱自由生活方式的人,不满足于单调、枯燥、沉闷、刻板的工作和枯燥的家庭气氛,他对上述女子的热烈追求是其内心的真实体现。重新评价自己,设计一个自己喜欢的工作和生活方式,才能彻底改变长

期的抑郁情绪。

行为水平:改变现有的行为方式,不接受过多的压力和责任,并要继续维护自己的权利。在单位应主动计划自己的工作,不是非得等别人指派。在与该女的交往中,应明确表达自己的愿望和感受。享受生活,给自己选择快乐的机会。

情绪水平:意识到多年来被压抑的愤怒和不满,并在适当场合以适当的方式表达出来。

(2)想像水平

①想像工作中怎样向领导陈述自己的感受,表明意愿并进行解释。

②想像如何向女友表达自己的感受。向她表示自己很爱她,愿意帮助她,但希望得到她的真诚回报。想像如果女友拒绝他,只索取金钱,怎样结束这种无偿资助。

③创伤修复。催眠,像象幼年时被父亲责骂的情境,想像自己成熟了,强壮了,可与父亲对抗。隐喻从一个旧的创伤中脱离出来,进入新的生活。

(3)交互作用水平:角色扮演,练习与领导对话及怎样向女友表白。并要求在实际情境中练习。

9. 治疗过程

由于病人经常不定期地出差,治疗的时间设置不完全固定,不出差时按规定时间接受治疗,出差时暂时中断,病人主动与治疗师联系。

治疗全过程有几个重点:一开始在治疗师的鼓励和引导下,病人主要回忆自己的生活经历和情感生活。然后治疗师帮助他逐步认识自己的内心需求和个人特质,理解其行为与内心需求的冲突及症状产生的基础。最后进行行为训练,改变行为模式及人际关系。在治疗过程中病人基本上是合作的。阻断在以下情况出现:

(1)在谈论婚外感情时,治疗师要求病人介绍自己的婚姻家庭,病人避重就轻,一带而过,直到治疗中期后才主动谈到自己的婚姻家庭。

(2)在谈到对恋人的经济资助时,治疗师暗示该女可能对他另有所图,病人断然否认,在治疗后期病人屡约该女见面,不久才发现对方可能只想要他的钱,承认自己吸引她的也只是钱

(3)当治疗师建议病人改变行为模式时,病人拒绝,认为改变会使其在单位的职位和收入受影响,生活增加压力。但病人越坚持,情绪越糟,工作效率下降,因此最后决定做出改变,而且取得较好结果。病人感到来自于治疗师的吸引是治疗师的温和、宁静、耐心、宽容和智慧,能倾听他所诉说的一切,给予充分的理解,并促进启发性的想像,提供一种从未有过的安全、温暖、无压力(轻松)的人际关系。但当

病人提出在治疗环境以外发展朋友关系时(请治疗师出去吃饭、谈话),遭到严肃而婉转的拒绝,病人感到很失望和伤心,但仍能坚持治疗并最后接受这种方式。治疗师感受到来自于病人的吸引是他的责任心、善良和对痛苦的忍耐,以及对于爱情的执著追求,但当治疗师要求病人主动改变时受到病人的消极抵抗,病人总把改变的责任推给治疗师。

移情与反移情:初次访谈结束时,病人感慨地对治疗师说:“以前别的大夫从未跟我谈过这些方面的内容。我很感动,谢谢你。下次我一定按时来。”这是一个良好的开端,病人的正性移情一直贯穿整个治疗过程,而且随着治疗的深入,开放性增加,情绪强度也逐渐增大。治疗师一开始不太愿意接受病人,因为他在许多地方接受过治疗。但后来治疗师被病人的经历和人格所感动,真诚地理解并愿意帮助他,反移情开始出现。治疗师作为一个年龄与病人相仿的女性,对待病人的婚外感情持客观、宽容和理解的态度,并与病人共同讨论如何解决婚姻和感情问题,对病人的改变起到支持和促进作用。

10. 治疗中的变化

治疗师与病人对感情和过去生活经历的探讨在几次之后就产生了效果,病人感觉压抑的情绪减轻了,强迫症状有所缓解。治疗师没有布置家庭作业,只要求病人在实际生活中去体验做自己想做的事和做自己认为应该做的事时的情绪感受。起初治疗的重点在于改善工作环境中的的人际关系和压力感,但病人更愿意讨论他与女孩的关系,因此治疗重点转移。在讨论感情关系中,病人在外地的工程结束,回北京后领导将其调到一个新的科室,让其当负责人,压力增大,因此有几次治疗专门讨论怎样减轻压力,并进行角色扮演。工作关系大致平衡时,突然发生意外。病人的妻子接听电话时发现病人的婚外恋情,当夜逼问,得知事情真相后非常痛苦,向父母及好友哭诉,并扬言要离婚。病人手足无措,向治疗师求救。治疗重心转移到处理当前家庭关系及要不要离婚、离婚后怎么办等一系列问题。同时问及经济问题,病人不准备再资助女友,女友对他逐渐疏远,病人也急于解决这个问题。这段时间病人非常焦虑,急需支持。因此治疗师破例增加治疗时间以给予足够的支持。

11. 结果

病人主动向领导说明情况,要求只负责一方面的工作,领导理解他,为其重新安排工作,压力感消失,人际关系改善,强迫症状消失,行为表现也自如轻松,不再过多地去为别人做贡献。

对自我评价的改变:病人对自己的工作能力和个性特点有了较客观的看法。

婚姻和情感:由于女友的冷淡和疏远,病人意识到她可能只是想利用他,并无真情。故准备当面与她谈清楚,若无希望,就分手,并索回钱财。对妻子抱有内疚感,但知道自己需要的不是这样的婚姻,因此同意妻子的离婚要求,并将房子和全部存款留给妻子及孩子。现在病人独自生活在另一所小房子里,他想开始新的生活。由于离婚他又变得抑郁了,他感到孤独、没有朋友。由于他在心理上和行为上还不能完全独立,治疗仍需继续。

评按:行为治疗是心理治疗的方法之一,对某些心理障碍有一定疗效。人格障碍伴有情绪障碍,用抗抑郁药对抑郁症状可能有某些疗效,但是对人格障碍往往难以奏效。用行为治疗可能会有帮助。现将一行为治疗实例奉献如上,仅供参考。

病例三

(一) 病历摘要

患者贺某,男,29岁(1968年6月4日生),汉族,未婚,高中肄业,无业,家住北京,1997年7月31日由某法院送来鉴定。

贺母及法院的书面材料提供以下情况:

贺父是工程师,贺母是医生,两人性情都很暴躁,经常发生冲突。据说,贺某的一位舅父、两位姨母均患有“精神分裂症”,曾在某精神病院诊治。贺某足月顺产,婴幼儿期身体发育无异常。在幼儿园时常和小朋友打架。7岁上学,读书不用功,经常调皮、捣乱、打架、欺负同学。因不听管教,常挨父亲打骂或体罚,但受母亲袒护、娇纵。然而贺某对母亲并不尊敬,有时向母亲发脾气,有时还打母亲。母亲不但不责怪儿子,反而以“为了缓和母子矛盾”为由,挨了儿子的打还向儿子赔礼道歉。从而贺某更变本加厉,为所欲为,只在父亲面前才有所收敛。

贺某虽然读书不用功,但是凭着小聪明成绩尚可,如期小学毕业,升入初中,依然品行不端,恶劣行为有增无减。贺某14岁读初二时其父出国,贺某更加放肆,稍不顺心就砸玻璃、摔家具、烧课本,大喊“我不给你们念了!”有时打得母亲头破血流,身上多处青紫。母亲无奈,只好带着女儿躲在娘家居住。其父在国外闻讯后,托贺某的叔叔把贺某接到外地代为抚养。贺某到外地后,更为放纵,表现为吸烟、饮酒、逃学、赌博。对叔叔的管教置若罔闻,并扬言要砍叔叔。1年后又送回北京。

在贺某16岁时其父回国。贺某不但不听父亲的话,还动手打父亲。上高中时仍然经常逃学,成绩很差,在17岁时倒卖邮票,用赚来的钱做赌资,有时聚众通宵达旦在家赌博。家人不敢过问,只好听之任之。1986年,贺某18岁,因盗窃自行

癔 症

第一节 概 述

癔症是指一种有癔症性人格基础和起病常受心理社会因素影响的精神障碍。主要表现为解离症状(部分或完全丧失对自我身份识别和对过去的记忆,CCMD-3 称为癔症性精神症状)和转换症状(在遭遇无法解决的问题和冲突时产生不快心情,并转化成躯体症状的方式出现,CCMD-3 称为癔症性躯体症状)。这些症状没有可证实的器质性病变基础,并与病人的现实处境不相称。本症除癔症性精神病或癔症性意识障碍有自知力障碍外,自知力基本完整,病程多反复迁延。常见于青春期和更年期,女性较多。

一、病因与发病机制

+++++

(一)社会心理因素

癔症的发病和临床类型,同病人的生理、心理素质有关。紧张、恐惧、情绪不稳定、易接受暗示、文化水平低、迷信观念重者,以及青春期或更年期的女性,较一般

人更易发生癔症。具有为人处世情感反应强烈、表情夸张、暗示性高、富于幻想、寻求别人注意和自我中心等表演性人格特征的人,在受到挫折或接受暗示后容易发生癔症。

(二) 生理机制

意识改变是癔症发病的基础。随着病人意识解离,有注意、警觉性、近记忆和信息整合能力等方面的损害,病人自我意识减弱、暗示性增高。个体受到生物、心理或社会因素威胁时,会出现类似动物遇到危险时的各种本能反应,如假死或返回儿童期的退行性行为等,同时有强烈持久的情绪紧张,产生感觉缺乏、肢体瘫痪等症状。

(三) 心理机制

(1) 躯体化作用,是通过躯体症状表达心理痛苦的病理心理过程。

(2) 转换,是病人对挫折的一种适应方式。

(3) 解离,指病人的一些观念和认知过程可从意识的主流中解离出去,或转为功能性症状,如遗忘及意识模糊等。

(4) 暗示或自我暗示机制,可明显影响本症的发生、发展和转归。

二、临床表现

(一) 癔症性精神障碍(解离障碍)

癔症性精神障碍病人的病前人格常异常,起病与精神因素有关。病人表现出来的症状可能是其关系密切的亲友所患躯体疾病或精神障碍的类似症状。常给人一种疾病的发作有利于病人摆脱困境、发泄情绪、获取别人同情和支持的感觉。主要表现为发作性意识范围狭窄,具有发泄特点的急剧情感爆发、选择性遗忘或自我身份识别障碍。常见类型如下。

1. 情感爆发

常在与人争吵、情绪激动时突然发作,表现尽情发泄、哭叫不休、捶胸顿足、撞头打滚。多人围观时,发作尤为剧烈。

2. 癔症性意识障碍

此症主要表现为意识范围缩小,发病突然,其言语、动作、表情反映心理创伤内

容,一般历时几十分钟即可恢复,清醒后对病中经历多不能完全回忆。

3. 癔症性漫游

除了具有癔症性遗忘的全部特征外,同时还有发生在白天觉醒时,离家或离开工作单位进行表面看来是有目的的旅行,旅行期间保留自我照顾能力(如进食、梳洗等),并能与他人进行简单的社会交往(如买票、问路、点菜)。

4. 癔症性身份障碍

表现对自己身份的觉察障碍,对自己原来的身份不能识别,常表现为鬼神或亡灵附体,此时病人暂时对周围环境完全无意识。常有局限和重复的一系列运动、姿势及发音。

5. 癔症性遗忘

病人无脑器质性损害,以选择性遗忘为主要表现,遗忘的那段时间或事件,往往与心理创伤有关。症状多变,主要表现明显的行为紊乱、哭笑无常、表演性矫饰动作、幼稚与混乱的行为、短暂的幻觉、妄想和思维障碍及人格解体等。多见于女性,病程很少超过3周,可突然痊愈而无后遗症,但可再发。

6. 癔症性假性痴呆

此症指病人在心理创伤之后突然出现严重智力障碍,如病人对提问可以理解,但给予近似的回答,给人以故意做作的印象,称为 Ganser 综合征。也可突然出现如儿童的幼稚、言语、表情和动作,称为童样痴呆。

(二) 癔症性躯体障碍(转换障碍)

癔症性躯体障碍包括运动障碍、感觉障碍和躯体化症状。在这些障碍中存在着运动丧失或受损,或感觉丧失(常为皮肤感觉)。

1. 感觉障碍

- (1)感觉过敏,表现为某部位皮肤对触觉特别敏感,实际并无神经病变。
- (2)感觉缺失,可为半身痛觉消失,或呈手套、袜套型感觉丧失。
- (3)癔症性视觉障碍,可表现为弱视、失明或管视等。
- (4)癔症性听觉障碍,多表现听力突然丧失,但听觉诱发电位正常。
- (5)梅核症(癔症球),病人常感到咽部有异物感或梗阻感,而咽喉部检查无异常。

2. 癔症性运动障碍

- (1)癔症性痉挛发作:常因心理因素或受到暗示突然发作,表现缓慢倒地,全身僵直或角弓反张。一般无外伤或大小便失禁。发作一般历时数十分钟,发作结束后昏睡或双眼紧闭,发作可1日多次。

(2) 癔症性瘫痪,可表现为偏瘫、截瘫或单瘫。被动活动常有明显抵抗,查体无神经系统器质性损害,但慢性病例可有废用性肌萎缩。

(3) 癔症性失音症或缄默症:病人无唇、舌腭或声带之任何器质性病变,但想说话却发不出声或用极低而嘶哑的发音交谈,称失音症。如不用言语回答问题,而是用手势或书写表达意思,进行交谈,称缄默症。

3. 躯体化障碍

此症以多种多样、经常变化的躯体症状为主。症状可涉及身体的任何系统或部位,查体与实验室检查不能发现该器官、系统的器质性病变。

三、癔症诊断标准

+++++

(一) 有心理社会因素作为诱因

(二) 表现有下述情况之一

- (1) 分离性遗忘症。
- (2) 分离性漫游症。
- (3) 分离性身份识别障碍。
- (4) 癔症性精神障碍。
- (5) 转换性运动和感觉障碍。
- (6) 其他形式癔症。

(三) 症状妨碍社会功能

(四) 有充分依据排除脑器质性精神障碍或非依赖物质所致精神障碍

四、病程和预后

+++++

多数初次发病者恢复迅速。如果病程超过1年,可能要持续多年才恢复。一般预后良好,多数未恢复的病人有癔症性人格障碍和社会适应困难。如果病人病前无人格缺陷,病因明确且能及时解决,病程短,治疗及时,大多数结局良好。

第二节 典型病例分析

病例一

(一) 病历摘要

患者季某,女性,49岁,工人,初中文化。

主诉:1年来数次发呆,发脾气,20天来反复发呆,诉有狐狸等附体感,无目的向外冲。

现病史:1999年3月患者为强身而练气功,于同年8月在连续几天上夜班后患者突然说不干了,表现目光呆滞,脾气暴躁。5天后自行缓解,能正常上班。

2000年3月10日因为工作原因,单位领导要求患者和其他职工在厂内居住,但是患者并不愿意。3月27日患者从工厂打电话给丈夫,让丈夫接自己回家。并对丈夫说:“我得走了,人家让我去哪儿我就得去哪儿。”回家后当夜未眠,平卧于床,眼望天花板不语。次日晨突然说:“我要走了,要升天了。”边说边向外冲,反复念叨:“他让我走。”凌晨5点左右患者突然使劲张大嘴,双上肢上举,双腿轮流抬起,目光呆滞,反复叫喊:“阿弥陀佛。我是天上来的大狐狸、瞎狐狸、瘸狐狸、野狐狸。我恶贯满盈,十恶不赦。”家人用力将患者按在床上,反复劝说患者别闹,患者不能听从,家人请来巫婆施巫术,2个小时后患者才安静下来。患者对家人说:“你们都出去,放我走吧。要不然我会害死你们的。他们指挥我,不让我跟你们说话。”下午患者要求家人搀扶其在屋中四处走动,用怀疑的目光四处张望,拒绝讲话,只与家人笔谈,称屋里有猫、狐狸和黄鼠狼在指挥自己,它们说要给自己上刑。如果自己说话他们就会听见,所以只能用笔谈。当晚口服地西洋 7.5 mg 后仅睡2小时,起来后就向外冲,到厨房找菜刀,目光呆滞,反复念叨:“要走了,要走了。”近2天来患者拒食,称肚子里有小猪,称自己吃的饭是给别人吃的,仍诉自己会害死家人。多次欲向外冲,被家人拦阻。于2000年3月29日首次收住我院。

既往史:体健。

个人史:同胞6人,患者行6。初中毕业后插队。1976年结婚。工作表现好,人际关系一般,夫妻感情好,生育一女。病前性格:内向,较固执,任性。因在家排行最小而受溺爱,依赖性强。不善交际,喜欢打扑克,看电视。

家族史:否认父母两系三代有精神病史。

体格检查:

未见异常。

实验室检查:

血常规、肝功能、心电图、脑电图、脑 CT 检查等均正常。

精神检查:

患者意识清楚,由家属送入病房。对问话,只用笔写回答,称:“如果用嘴说别人就知道了。”知道这里是医院,检查者是医生,入院时是晚上。能正确回答自己的姓氏,但能听到耳边有说话的声音,认为“花狐狸”在威胁自己,说:“狐狸让我干这干那。”有时说自己想的事就有声音说出去了。这种声音:“除了我和它们(指狐狸),别人都听不见。”

入院次日凌晨 2 点,患者突然表现双手高举,全身挺直,口中喃喃自语,旁人听不清内容。患者表情呆滞,对问话不回答。持续约 15 分钟后缓解。

患者认为确实有狐狸附在自己身上了,次日拒食,问其原因,说是不这样做不行,我要“饿死他们(指狐狸)。”

患者平时表现多卧床不语,对问话多不回答。不主动与周围人接触。

经肌内注射地西洋治疗,1 周后症状逐渐缓解,接触改善,对人院前后经过能够回忆。认为自己是练习气功练偏了,因为自己是按气功书本指导去练的,可能自己对书本意思的理解错了,对不起气功大师,但以后练气功还是要按老师说的去练。

在精神症状消失后,对上述有些症状只能部分记得。对人院前无目的向外冲,被按在床上,反复叫喊:“阿弥陀佛。我是天上来的大狐狸、瞎狐狸、瘸狐狸、野狐狸。”的经历不能完整回忆,经提醒后患者能部分叙述当时的情景,称:“当时感到害怕,好像我想逃跑,他们请巫婆给我治病,我记不清了。”

有些病中体验能够回忆,患者称:“当时厂领导让我住在厂里,我不愿意。难道我非听他们的不成,我心里窝火,我打电话给我丈夫,让他接我回家。回家以后我就不想回去了……他们让我去哪儿就去哪儿,我可不愿意。不知道怎么我就胡说要上天,我得走了,人家让我去哪儿我就得去哪儿。”患者称:“当时我确实认为自己是狐狸,不是我自己了……我当时感到有猫在监视我,我不敢说话,怕给传出去。”

(二) 案例分析

1. 诊断和诊断依据

(1) 患者女性, 49 岁, 起病和心中不快有密切关系, 患者因工作需要, 被安排住在工厂暂时不能回家, 患者心中不满。

(2) 主要症状

① 癔症性身份障碍: 患者自称是天上来的大狐狸、瞎狐狸、瘸狐狸、野狐狸、十恶不赦的狐狸, 和患者在病前有明显心中不快的事情有关, 主要为不愿住在工厂里, 在回家后就不打算回去。患者的身份变了就可以不回工厂, 自称十恶不赦的狐狸, 可能和不服从工作安排的负疚感有关。

② 癔症性遗忘: 患者在入院前曾喊: “我要走了, 要升天了。”边说边向外冲, 反复念叨: “他让我走。”凌晨 5 点左右患者突然使劲张大嘴, 双上肢上举, 双腿轮流抬起, 目光呆滞, 反复叫喊: “阿弥陀佛。”家人用力将患者按在床上, 反复劝说患者别闹, 患者不能听从, 家人请来巫婆施巫术, 2 个小时后患者才安静下来。患者对上述内容有部分遗忘。

③ 精神病性症状: 有时用怀疑的目光四处张望, 拒绝讲话, 只与家人笔谈, 称屋里有猫、狐狸和黄鼠狼在指挥自己(被控制感), 它们说要给自己上刑(被害感)。如果自己说话它们就会听见, 所以只能用笔谈(被监视感)。以上症状都和不顺心的经历有关。

④ 癔症性意识障碍: 有时出现朦胧状态, 表现为目光呆滞, 说话含糊不清, 在清醒后不能完全回忆。

诊断:

40.141 癔症性附体障碍

2. 鉴别诊断

(1) 气功所致精神障碍: 患者有练习气功史 1 年, 现仍对气功表示相信。但患者主要临床症状为附体体验, 其精神症状内容与气功没有密切联系。气功只能作为一种诱发因素。

(2) 精神分裂症: 患者病中存在有言语性幻听、被监视感、被害感等症状, 应与精神分裂症鉴别。患者的附体体验与被控制感不同。被控制感是患者自觉有外部力量控制自己的体验, 患者体会到思维、情感、意志和行为是一种从外界强加的被动体验, 而此患者感觉狐狸附在自己身上, 思维、情感、行为是附在自己身上狐狸的, 与自己是一体的, 不属于来自外界力量的被控制感。自己的想法只能被附体狐

狸听到,不存在内心被揭露感。因此,精神分裂症的诊断不能成立。

病例二

(一) 病历摘要

患者张某,女性,38岁,已婚,汉族,高中文化。

主诉:间断精神不正常5年,为兴奋、话多,多疑。半个月来,多疑伴冲动行为。

现病史:1996年(就诊前5年)初患者因其父去世表现伤心、夜眠欠佳。约三四天后表现兴奋、话多,认为其父用“恶气”喷她,认为周围人背后议论她,怀疑丈夫要把自己害死。夜眠差,有时想外出。家人劝她少说点儿话时,患者称:“这就是我爸爸让我说的,我也管不了。”曾到某医院治疗,具体治疗情况不详,2个月后病情逐渐好转。1996年5月自行停药后精神症状正常,能料理家务及卖菜。

在之后的4年中精神状况如常人,在2000年3月5日患者母亲因患脑血管意外突然行动不便。在其兄给患者送达其母患病信息后,患者对其兄说:“我看你怎么像鬼呀?”其兄将母亲病情告诉患者后患者表现呆愣,夜眠差。次日患者去娘家看母亲。回家后仍说害怕鬼,夜间不敢出门,也不让家人关灯。逐渐出现多疑,认为自己家盖房子的时候被放了“镇物”,认为母亲的病是因为中了煤气。同年3月7日其母病故后患者认为是其二哥毒死的。表现为话多,反复说家中的事。饭量大,说是在替母亲吃饭。患者病后侄媳妇常来照顾患者,便怀疑丈夫与侄媳妇关系不正常,骂侄媳妇是“坏女人”。情绪不稳,骂家人,并有毁物行为。于2000年3月23日首次收入我院。

既往史:体健。

个人史:同胞6人,患者排行第6,有2兄3姐。平素与其大哥关系融洽,与其二哥关系不好。适龄上学,学习成绩一般。高中文化。月经正常。1984年结婚,有2个孩子。夫妻感情好。婚后家中由患者主事,近几年以卖菜维持家庭收入。病前性格:患者小时候较内向,但婚后尤其是卖菜以后患者表现话多、开朗,好交往。因为其夫话少,贩卖和运输蔬菜,办理贷款等事均由患者出面办理。而卖菜过程中需与各种人打交道,患者应付自如。脾气急躁,尚随和。平日看问题常很极端,认为大哥好就好得完美无缺,认为二哥一无是处。无特殊爱好。

家族史:否认父母两系三代有精神病史。

体格检查:

未见特殊异常。

精神检查:

患者由家人扶入病房,对更衣查体欠合作。接触欠佳。对入院后一般情况不能完全回忆。语量较多,语速一般。患者承认5年前曾有过精神不正常,当时认为其父给她身上喷了“恶气”。入院前其母亲去世对患者刺激很大,感到“脑子乱”,控制不住地乱说。患者自觉母亲去世后附在自己身上了,饭量大,说是在替母亲吃饭。家人请神婆给其治病后,患者称,神婆说身上有黄鼠狼,并觉得有黄鼠狼附在自己身上了。其母在两个儿子家轮流居住,患者认为大哥对母亲“一百一”(非常好)时手竖大拇指,而提起二哥对母亲不好时马上眼圈发红,表情气愤地说:“他连水都不给我妈喝!”患者认为母亲死时嘴边有血,所以母亲的死有问题。认为邻居有时在背后议论自己,看不起自己。认为丈夫有外遇,和侄媳妇要好。最近侄媳妇总到她家帮助做家务,认为可能是丈夫给她钱了。患者不认识家人,有打人毁物行为,原因:一是看着丈夫就生气,二是心烦想出去串门家人不让,所以发脾气。患者表现情绪欠稳定,谈话过程中谈到伤心处即哭泣。对住院欠安心,对护理欠合作。

入院后小剂量氯丙嗪治疗,最高日量 300 mg,住院第2天电针治疗1次后患者说:“黄鼠狼”跑了,认为跑到邻居家了。

(二) 病例分析

1. 诊断依据

患者女性,中年起病,间断发作。5年前,其父去世后表现话多,认为死去父亲的“恶气”喷了她,有多疑表现及附体感。缓解期间正常。此次起病与其母去世有关,精神症状较明显,有被害观念,入院时对病中的一些情况记不起来,有意识朦胧现象,有片断妄想,如认为丈夫有外遇,实际是患者自己想像的,说二哥不好而大哥好,形容得很极端。有附体感,觉得母亲附在身上,受神婆暗示自觉黄鼠狼附体,具有一定的暗示性,病前性格较开朗。

诊断:

40.1 癔症性精神障碍

2. 鉴别诊断

(1)反应性精神病:患者两次发病均有明显精神因素。患者对其母的感情是很深的,起病较急。主要区别在人格状态上,有附体感又受暗示在反应性精神病很少见。

(2)精神分裂症:患者虽然有一些多疑及冲动表现,但其精神症状与心因有关,

其偏执内容是想像性的。间断病程,缓解期正常,缺乏精神分裂症诊断依据。

3. 治疗

患者入院后处于脱抑制状态,表现话多、情绪不稳,给予小剂量抗精神病药物及暗示治疗。精神症状缓解后逐渐减药,不需长期维持治疗,加强心理治疗。

病例三

(一) 病历摘要

患者李某,女,30岁,工人,小学文化。

主诉:发作性精神不正常10年,频发倒地、说话乱、冲动打人加重1个月。

现病史:病人于1990年与父亲吵嘴后,表现忧愁,继之以兴奋,话多。凭空说院子里有许多好东西,坚持要奶奶带她去拾,把自己拾回的瓦片说是:“金子”。并凭空看见妹妹和母亲身上有许多小虫在爬,半小时后表现如常人,病人事后不能回忆以上的体验。

1998年病人的父母吵架后,母亲喝毒药自杀死亡。病人获知后,当即晕倒,几分钟后醒来。醒后,病人表现话多,说她父亲害死了她母亲,并模仿她母亲的动作声音。病人舞拳弄脚,嚎啕大哭,转瞬又大笑不止,经周围人劝慰,两三个小时后安静下来。以后常感胸闷,头晕乏力,于某医院诊断为“神经衰弱”,具体治疗过程欠详,未见明显疗效,仍偶有自语自笑。

1999年,父亲与继母结婚,病人想起死去的母亲,悲愤交加,常与父亲发生争吵,自称是张某(病人母亲名),大吵大闹:“我要报仇,你得来陪我。”时哭时笑,经亲友劝慰后能平静下来。此后病人见到她父亲,就声嘶力竭地叫骂,有时摔东西、打人,在平静下来以后能干家务及外出购物等。表现如常人。

2000年5月,病人因领居家小孩到她家吵闹而生气,出现话多,凭空听见母亲说话声,说有人想害她,大呼:“妇女要翻身了,不要三·八了。”并自称是张某(病人母亲),以其母的身份向妹妹要钱,其妹给予人民币则拒收而要冥币,其妹不答应动手就打其妹。在得到冥币后,病人又不让烧,称如果烧了冥币就活不成了。患者在说话时就躺倒在地上,表现紧闭双目,张口呼吸及大声叫喊,吹气,以头撞地。被送至当地医院,诊断为“癔症”。经针刺治疗法,病情缓解。

2000年7月初,病人因家中琐事而心烦。表现为好发脾气,有时说些难以理解的话,如说:“给鱼池里的船安装上船尾,如果不照办我的儿子就会变哑。”又被送往医院治疗,在回家途中跳入鱼池,事后不能回忆。

近1个月来,病人常因小事而发脾气,稍不满意就倒地,哭笑无常,大喊大叫,有时冲动打人,事后自述不知,近日频繁发作不缓解,有时无故外出,事后不能回忆。于2000年7月15日,门诊以“兴奋状态”收入院治疗。

既往史:病人平素健康,既往无癫痫病史,无颅脑外伤史。

个人史:病人平时性格开朗,爱开玩笑,好表现自己,爱出风头。

家族史:父母两系三代中无精神病及癫痫家族史。

躯体检查和神经系统检查:

未见异常

实验室检查:

血常规、肝功能、心电图、脑电图、脑CT检查等均正常。

精神检查:

病人卧于床上,接触被动,对检查不合作,有定向力障碍,说自己是张某,送她入院的人是神仙。问话少答,答话欠切题,有片断的幻觉、妄想,凭空听见她母亲和她说话,担心有人要害她。表情平淡,自笑,在床上舞拳弄脚、大喊大叫,下床后突然倒地,以头撞地但无外伤,说这样脑子就会清醒些,夜间起床活动,事后不能回忆,有时冲动打人,无自知力。

(二) 病例分析

1. 诊断依据

患者为女性,于10年前首次出现精神症状,主要临床表现为在心因的影响下,反复发作性倒地,以头撞地,暴怒,哭闹,冲动及附体体验。有片断的幻觉、妄想及自笑,表情平淡。冲动打人等精神病性症状反复发作,持续时间为数小时,缓解后无异常表现,病前性格开朗,好表现自己。

CCMD-2-R中关于癔症描述为,癔症主要表现为分离症状和转换症状两种。“分离”反映对过去经历与当今环境和自我身份的认识完全或部分不相符。

生活事件或处境引起情绪反应,接着出现躯体症状,一旦躯体症状出现,情绪反应便褪色或消失,这种躯体症状便被称为转换症状。转换症状的确诊必须排除脑器质性病变。

本病例的临床表现为意识障碍,对人物及地点不能正确辨认,对异常行为不能回忆或只能部分回忆。癔症性情感爆发,表现为突然大哭或大笑,身份识别障碍和附体体验。根据以上表现,此病例符合癔症诊断,就其表现进一步分析发现,此病人存在片断幻觉、妄想及自笑、表情平淡、冲动打人等精神病性症状。在症状出现

后,经针剂治疗或劝说后,很快平静下来,一般不超过1天,以上表现符合癔症的临床特点,10年来多次发作,发作间歇期表现如正常人。

精神医学认为:精神刺激为癔症发病的主要因素,尤其当遭遇重大生活事件后,病人常难以控制,而癔症发作常有助病人逃避不愉快处境,并得到别人的支持和补偿,即所谓“继发受益”,但病人对此却常常否认。癔症病人症状反复发作后,可在无明显诱因下,受暗示或自我回想创伤经历而诱发,特殊性格素质在发病中有重要作用。癔症临床表现极为多样化,几乎可模仿一切躯体、神经、精神症状,但一般认为,典型癔症患者的人格特点多为情感丰富,暗示性强,以自我为中心,并善于模仿及富于幻想等。本例病人具备了上述人格特点。

诊断:

40.1 癔症性精神障碍

2. 鉴别诊断

(1)急性应激反应:急性应激反应虽有明显、强烈的精神刺激,但病人病前无突出的癔症性格,精神刺激消除、环境改变后,症状可获缓解或消失。本病人首次发病后,常在无明显诱因,而仅在暗示或自我暗示的情况下发病,且以意识状态改变、情感爆发、附体体验等为主要临床表现。

(2)癫痫大发作:本例病人每次倒地都与精神刺激、暗示或自我暗示有关,每次发作常持续数小时,发作时无抽搐、外伤、尿失禁等表现,无意识丧失,且常伴附体体验,周围人劝慰常使症状缓解,脑电图检查正常等可助鉴别。另外,应与情感性精神障碍相鉴别,由于本患者为间歇性病程,而且在发作时有情绪障碍,如忧愁、兴奋、话多等表现,但是每次发作时间短,而且其他精神病性症状不是继发于情绪症状之后,故可以排除情感性精神障碍的诊断。

3. 治疗

一般认为癔症属于神经症的一种,但也有的学者认为该病介于神经症与精神病之间,可以用心理治疗为主,在短期内辅以适当的药物治疗。但本例病人病情发作时处于意识朦胧状态,心理治疗难于奏效,且有精神病性症状,故治疗分以下两步。

(1)抗精神病药物治疗及电休克治疗:病人入院时呈兴奋状态,且无重大躯体疾病,给予其氟哌啶醇每日20mg,肌肉注射,但1天后症状仍未明显缓解,故考虑本病为电休克治疗适应证,同时又无相应禁忌证。逐渐将氟哌啶醇撤除后,给予其电休克治疗5次,病人意识逐渐清晰,但偶有自笑、语乱等表现,遂给小剂量奋乃静(8mg/d,口服)。

神残疾协会-适应行为量表(AAMD-ABS),通过日常生活技能、运动能力、社会功能等多方面来衡量。智能及适应行为能力的发育成熟期一般认为是出生后至17岁。因此,18岁以前由各种有害因素导致的智能损害为精神发育迟滞;而18岁以后由脑器质性损害等因素所致或后遗的智力缺陷则属痴呆范畴。

精神发育迟滞不是单一疾病,而是多因素所致的疾病综合体。患病率、致残率高,社会影响大。其诊断和治疗涉及到多学科的知识。因此,精神发育迟滞越来越受到医学、心理学、社会学、教育学及司法学界的共同关注。

二、临床特点

+++++

精神发育迟滞的主要临床症状特点是智力低下,社会适应能力差和一些精神症状。但是,不同的类型、不同程度表现各不相同。

(一)基本表现

1. 边缘智力

属于精神发育迟滞与正常智力之间的过渡状态。一般指智商70~85,伴有社会适应能力的轻微缺损。严格地讲不应归入精神发育迟滞,有的学者认为是由于躯体及社会环境因素等导致的智能延迟。一旦环境等阻挠因素去除,大多数智能的表现能突飞猛进,甚至有些可达到或超过正常的程度。

2. 轻度精神发育迟滞

较常见,占精神发育迟滞总数的85%。智商在50~70,有轻度社会适应缺陷。临床表现言语发育及社会适应能力的获得迟缓,但日常生活用语及实际生活能力问题不大,关键是学习能力差,运算困难,难以达到小学毕业程度。一般入学后才被发现,特别是对抽象概念理解困难。通过特殊教育可获得实践技术和实用的阅读和计算能力,在不需要学术知识的社会背景下,适应良好,但主动性、积极性较差,遇到不良刺激易产生应激反应或心理障碍。

3. 中度精神发育迟滞

约占精神发育迟滞的10%。言语理解及使用能力发育明显迟缓,最终达到的水平也很有限,不能完整表达意思。一般智商为35~49。生活自理和运动技能的发育也出现阻滞,一些人终身需要监护。学习能力低下,词汇贫乏,理解力极差,略识数,但只能完成10以下的简单计算。经过特殊训练可学会简单的人际交往、基本卫生和安全习惯,可从事简单非技术工作。有时情绪不稳,易冲动。

4. 重度精神发育迟滞

约占精神发育迟滞总数的 3%~4%, 智商 20~34, 普遍合并器质性疾病, 运动功能受损明显。仅能学会极简单语句, 不能自理生活, 无社会行为能力。

5. 极重度精神发育迟滞

仅占 1%~2%, 智能损害明显, 智商 < 20 , 理解或遵从要求或指令的能力也受到严重损害。大多数无法活动或活动严重受限, 大小便失禁, 无言语能力, 不认识亲人, 仅有原始情绪反应, 哭闹、尖叫、冲动。全部生活需人照料。

精神发育迟滞是多种“疾病”、多种原因所致的综合状态。代表性疾病, 特别是与我国关系密切的疾病有: 地方性呆小病、唐氏综合征、脆性 X 综合征、苯丙酮尿症、胎儿酒精综合征、儿童铅中毒、儿童艾滋病及其他影响儿童脑发育的疾病。除精神发育迟滞的不同程度的表现外, 各种疾病又有各自的临床特点。

(二) 临床常见类型特点

1. 地方性呆小病(endemic cretinism)

又称地方性克汀病, 是甲状腺功能不全性疾病中的一种。除智力和社会适应能力缺损外, 躯体发育不良是本病另一特征: 患者身材矮小, 下肢短于躯干, 腹部膨隆。骨骼及牙齿发育延迟, 性器官发育不良, 不少病人合并聋哑。检查发现: 血清蛋白结合碘及丁醇提取碘大多减低; 甲状腺吸碘率增高, 呈碘饥饿曲线; 血清胆固醇正常或稍低; X 线检查骨龄落后, 颅骨脑回压迹增多, 蝶鞍偶见增大; 脑电图可见低频率, 节律不整, 大多出现阵发性双侧同步 Q 波, 可见 α 波; 重者心电图可见低电压, T 波低平或双向, QT 间期延长及不完全性右束支传导阻滞。

轻者临床症状不突出, 有人称之为“地方性亚临床克汀病”。此病实际患病率很高, 但极易漏诊。

2. 唐氏综合征(Down's syndrome)

又称 21-3 体综合征、先天愚型或伸舌样痴呆。除智能及社会适应能力低下(一般为中度)外, 还伴有特征性异常体征: ①特征性面容: 圆脸、双眼距宽、眼裂外上斜、内眦赘皮、耳朵小且位置低、鼻梁低、舌体宽厚、口常半张或舌伸出口外且舌面沟裂深而多, 俗称阴书舌。②掌纹异常, 末指短小内弯。③关节韧带松弛或肌张力低下。④X 线显示髌臼角和髌角过小。⑤合并先天性心脏病和脐疝者多, 平均寿命短, 在童年晚期及成年期明显倾向于肥胖。

3. 脆性 X 综合征(fragile X syndrome)

是近年新认识的一种 X 连锁遗传性疾病。临床主要表现是智力低下, 一般为

7. 儿童艾滋病(CAIDS)

艾滋病已经成为威胁人类健康的大敌。艾滋病并不只发生于成人同性恋或异性恋者身上,许多儿童由于母婴传播或接收血液制品而成为可怜的牺牲品。受AIDS病毒感染的母亲所生子女有半数在生后第1年有明显的脑损害、精神发育迟滞和抽搐。艾滋病病毒(HIV)感染的儿童一般只能活几年。

8. 精神发育迟滞合并其他精神病(comorbid psychopatholgy)

近年来许多流行病学调查数据显示精神发育迟滞儿童合并其他精神病的发生率是30%~70%,而且发生率与精神发育迟滞的程度呈正相关,其中孤独性障碍最多;约有2%至3%合并精神分裂症;近50%有情绪障碍;还常有注意力缺陷、多动、自伤行为和重复刻板动作等。精神发育迟滞儿童人格特点也非常突出,悲观、自信心不足、忍耐性差、依赖性强。

第二节 典型病例分析

一、病例一

→ → → → → → → → → →

(一) 病历摘要

患者王某某,女,9岁。

主诉:因乏力、注意力涣散、学习成绩不佳5年,于2000年3月前来北京安定医院儿童精神专科门诊就诊。病史由患儿母亲提供,可靠。

现病史:患儿3岁随父母从外地来到北京。4岁进幼儿园,表现注意力不集中,食欲差,常乏力,不爱学习。6岁上小学后,学习成绩不好,在父母和老师帮助下,勉强及格。二年级学习更加困难,语文、数学常不及格。曾在某医院诊断为“儿童多动症”,使用利他林10 mg/d,治疗效果不明显,精力有提高,但食欲更差,学习成绩没有改善。三年级留级1次后,仍有语文、数学不及格,老师认为没法再教,建议去儿童精神科就医。患儿放学回家,能自觉地做家庭作业,但功课做不出来,常常趴在桌子上。平时在家中可帮妈妈做些家务事,扫地、洗碗,但易疲劳。在学校中与同学们关系较好,游戏中动作不灵活,常受到嘲笑或欺侮。

既往史:否认传染病、重大躯体疾病及癫痫抽搐病史,否认外伤及手术史,否认过敏及中毒史。

个人史:患儿为第1胎,母孕期体健,足月顺产,出生体重3600克。母乳喂养,2月能抬头,6月出牙,1岁会走,1岁2个月会讲简单话。幼时长得白白胖胖,不爱哭,听话,好喂养,父母均喜欢她。3岁以前在农村能与其他小孩一起玩。3岁随父母来到北京,父母以装修、喷涂、油漆为生。居室兼仓库,患儿常期玩弄油漆及涂料。性格特点:老实,比较内向,兴趣少,依赖性大。

家族史:父母非血缘婚。否认两系三代有癫痫、精神发育迟滞、痴呆及精神失常者。

体格检查:

神清,发育可,营养差,头部及四肢无畸形。皮肤黏膜完整无黄染、皮疹及色素痣,手掌皮纹正常,周身浅表淋巴结未触及肿大。双肺呼吸音清,心脏各瓣膜区未闻及杂音,腹平软,肝脾肋下未触及。脊柱、四肢活动正常。

神经系统检查:

头颅大小正常,可引出水平眼震,舌肌细颤,感觉未见异常,四肢活动自如,双手可引出细颤,肌力V级,肌张力不高,腱反射略低,未引出病理征。指鼻试验(+),Romberg's sign(+),对指、轮替试验(+)。

实验室检查:

血常规正常。肝功能正常。儿童血钙8.6mg/dl,儿童血磷3mg/dl,儿童血铅53μg/dl。EEG轻度异常。头颅CT正常。

精神检查:

意识清楚,定向力好,衣饰整洁,被动接触合作,文静,对任何问题回答均很认真。语言清晰、流畅。未引出幻觉、妄想。无明显思维联想障碍。注意力不集中,谈话检查中患儿注意力难以持久,经常被环境声音岔开。记忆力未见明显障碍。智力普遍性低下,一般常识尚可,能说出一年有几个月、分几季,知道我国的主要节日。词汇量较少,不会正确使用同义词或反义词。抽象思维能力、理解判断力均较差。说不清猫与老虎、汽车与火车的异同点。不能正确解释“坐井观天”、“胸有成竹”的意思。计算力差:不能完成2位数以上的加减法,不能完成100-7的连续计算。自知力存在,知道自己学习不好。情绪稳定,愿意上学,未见冲动、怪异行为。

WISC-R结果:FIQ 62,VIQ 58,PIQ 65。

(二)病例分析

1. 诊断、诊断依据与鉴别诊断

患儿的主要临床特点是:①女性,9岁。②以乏力,注意力涣散,学习成绩不佳

为主诉。缓慢起病,逐渐加重,病史5年。③生活在长期接触油漆、涂料环境中。④3岁前语言、运动及人际交往能力均发育正常。⑤学习成绩普遍较差。但患儿已掌握了日常生活用语,通过了小学二年级学习。生活能自理,且可做简单的家务劳动。⑥查体可发现手震颤、共济失调。

WISC-R 结果:FIQ 62,VIQ 58,PIQ 65;儿童血铅 53 $\mu\text{g}/\text{dl}$ 。

本例诊断应考虑:轻度精神发育迟滞,慢性铅中毒。但需与下列疾病鉴别。

(1)学习技能特殊发育障碍:学习技能特殊发育障碍指的是从发育早期阶段起获得技能的某一方面(如阅读或计算)的发育障碍,患儿智力一般正常, $\text{IQ} > 70$ 。患儿某方面的学习能力差不是由于视、听障碍或学习机会被剥夺所致。患儿表现为阅读或计算低能,或拼音困难等,也可有混合型存在,但其他方面均正常。这些特点显然与本例不同。

(2)儿童多动症:多动症儿童一般学龄前就多动。注意力不集中,影响学习和社会适应,似有精神发育迟滞的可能。但多动症儿童学习成绩波动较大,病史中发育迟缓不明显,智力检查一般正常,经教育训练或服用提高注意力的药物,症状明显好转,智力显著提高。本例患儿智力明显低于正常儿童,血铅高,学习成绩持续下降。这些都与多动症不符。

(3)儿童精神分裂症:一般病前无躯体及智力发育障碍。病后虽然有学习成绩下降、反应迟钝、淡漠、环境适应不良,但主要特征是思维、情感与行为的不协调,以怪为主,并不是真正的智力低下。本例以血铅高、智力低下、学习成绩持续下降为主,未见怪异思维和行为。故可以排除儿童精神分裂症的可能。

本例诊断:

70.1 轻度精神发育迟滞[F70]

11.4 慢性铅中毒[F55.8 不产生依赖的其他物质]

2. 治疗原则

(详见本章思考与分析一节)

(1)对因治疗,驱铅排毒。

(2)神经营养支持疗法。

(3)特殊教育,开发智力。

3. 本例思考

(1)轻度精神发育迟滞临床特点是什么?

(2)精神发育迟滞诊断思路是什么?

(3)精神发育迟滞与铅中毒是什么关系?

二、病例二

+++++

(一) 病历摘要

患者夏某,15岁,培蕾康复中心七年级学生。

主诉:于1999年7月因自幼呆傻,生活不能自理,对知识理解能力差,近2个月兴奋、话多、夜不眠而入院。

现病史:患者在出生时因难产,产程长而致缺氧窒息。此后生长发育比同龄孩子晚:1岁能坐,2岁能讲单词,2岁半会走路,3岁能讲成句话,生活自理能力及对新鲜事物的领悟力均差。8岁时上培蕾弱智学校,学习成绩一般,生活需老师协助。近2年来,学习成绩下降,常受到老师批评。近2个月以来,渐出现上课不专心听讲,多动,到处乱写乱画,下课后揪打同学,吃饭不知饥饱,回家后不停地说话(内容听不清),夜难入眠。故家属送其入院。

既往史:否认重大躯体疾病及癫痫抽搐病史,否认外伤及手术史,否认药物过敏史、中毒史及成瘾史。

个人史:独生子,其父母无血缘关系,母孕期正常,足月难产,出生时体重3800克,Apager评分8分。病前性格:内向,话少,胆小,任性,依赖性大。

家族史:两系三代否认有癫痫,精神发育迟滞,痴呆及精神失常者。

体格检查:

头颅无畸形,五官端正,皮肤黏膜完整无黄染及色素痣等,周身浅表淋巴结未触及肿大,双肺呼吸音清,心脏各瓣膜区未闻及杂音,腹平软,生理反射存在,病理反射未引出。

实验室检查:

未见明显异常。

精神检查:

患儿神清,容貌小于实际年龄。接触被动。生活自理能力差。常模仿周围人说话,自语时听不清其所讲内容,不知其表达何意。谈话时注意力不集中,常东张西望。智能缺损明显,对问话常不能理解,即使理解后,也不能回答出某些常识问题,如称“一棵树上十只鸟,打死一只,还剩九只”;讲不出“十一”是何节日。计算力差,一位数加减法计算慢而出错,不会计算 $100-7$ 的连续计算。记忆力尚好,可回忆是由父母送入院的。患儿情绪不稳,时而生气,时而傻笑,时而又哭泣。行为多

动,常抓摸别的患者,模仿工作人员或病人的动作,有时伸手向天,有时握紧双拳。

(二) 病例分析

1. 本例临床特点

- (1) 女性,15 岁。
- (2) 出生时产程长,缺氧窒息,发育受阻,生长发育比同龄人晚。
- (3) 智能差:认识能力、理解能力、计算力等均差。
- (4) 兴奋,话多,行为多动怪异,注意力不集中。
- (5) 生活自理能力差,无法适应社会生活。
- (6) 躯体检查未见其他器质性疾病基础。

患儿入院时兴奋、自语,行为多动怪异,应与精神分裂症鉴别:关键之处在于患儿自幼生长发育缓慢,无明显疾病界限,近 2 个月来兴奋是在其智能差,对周围环境适应不良等基础上产生的。

本例诊断:

70.2 中度精神发育迟滞[F71]

70.22 中度精神发育迟滞伴有显著的行为障碍[F71.2]

精神发育迟滞是一组以智力发育障碍为突出表现的疾病,是指生长发育阶段的儿童由生物、心理、社会多种因素引起,以智能发育不全或受阻为特征,以各种技能损害和社会适应困难为主要临床表现的一组发育障碍性疾病。

精神发育迟滞的主要临床症状是智力低下,社会适应能力差和一些精神症状。中度精神发育迟滞:智商 35~49。患儿语言发育水平较差,与其在短时间内接触中即能察觉。学习能力差:只能完成 10 以下的简单计算。有一定模仿能力,特殊训练后可学会简单人际交往及生活技能,在监护下可从事简单的体力劳动。

2. 精神发育迟滞的诊断标准

- (1) 智力明显低于同龄人的平均水平,一般说智商在 70 以下。
- (2) 社会适应能力不足,表现在个人生活能力和履行社会职能有明显缺陷。
- (3) 起病于 18 岁以前。

3. 精神发育迟滞的治疗

- (1) 治疗原则:早期发现,早期诊断,查明原因,早期干预。
- (2) 综合治疗
 - ① 病因治疗:对于某些病因较清楚的代谢、内分泌疾病可针对病因进行治疗。
 - ② 药物治疗:a. 对症治疗:对具有兴奋、冲动或伴有癫痫发作者要采用抗痉挛

药物治疗。b. 促大脑代谢治疗:常用药有脑复康、 γ -氨酪酸、脑活素、古立西等药。

③教育训练和行为指导:应加强与患儿家长的联系,加强和教师、心理学工作者的密切合作。精神发育迟滞的儿童也具有相当大的潜能,而非医学措施便显得更为重要。开始训练愈早,效果愈好。实施中应遵从不同程度的病人采用不同方法的原则。对轻中度者可进入特殊学校,尽早开始语言、劳动和生活技能教育训练。对重度者以养护为主,重点指导训练基本生活技能。

4. 本例思考问题

- (1)精神发育迟滞的诊断标准是什么?
- (2)精神发育迟滞临床表现有什么?
- (3)精神发育迟滞都有哪些治疗措施?

第三节 思考与分析

精神发育迟滞过去主要根据临床表现分为愚鲁、痴愚和白痴3级。随着智力测验的广泛应用,世界卫生组织依据智商数将精神发育迟滞分为轻度、中度、重度和极重度4级。然而,智商相同者的学业成绩、社会适应能力未必相等。故智商之高低仍不足以表示每个人之全部智能水平。因此,20世纪80年代后无论是国际疾病分类、美国精神疾病分类还是中国精神疾病分类均是根据智商水平和适应行为能力综合分级。教育界仍按接受教育的程度分为:可教育型、可训练型、依赖型和养护型。民政部门则依社会功能损伤程度分:四级智残、三级智残、二级智残和一级智残4级。为便于研究和临床应用,现将智残分级、教育部门的分级标准、传统分级和以智商水平加社会适应能力为指标的临床分级标准进行对比(表17-1)。

表 17-1 精神发育迟滞分级比较简表

临床分级	智商	适应能力	教育分级	智残水平	传统分级
轻度	50~70	轻度缺陷	可教育型	四级智残	愚鲁
中度	35~49	中度缺陷	可训练型	三级智残	痴愚
重度	20~34	重度缺陷	依赖型	二级智残	痴愚
极重度	<20	极重度缺陷	养护型	一级智残	白痴

一、诊断要点

1. 详细了解病史

(1)家族遗传病史:家族中有无先天畸形、脑性瘫痪、智力低下、癫痫或精神病史。

(2)父母婚育情况:是否近亲婚配;母孕期有无高危因素,如孕龄在16岁以下或40岁以上,孕期患过多病毒性感染(风疹、流感等),孕期肾性高血压、糖尿病、甲状腺疾患、妊娠中毒症、服用化学药物史、先兆流产、出血性休克及羊水过多症;围产期有无窒息、早产并发症、核黄疸等。

(3)生长发育史:喂养情况、走路及开始讲话的时间、早期教育情况、幼儿园及学校中的表现、气质特征及个性特点等。

(4)躯体健康情况:有无颅脑感染及外伤史、有无痉挛及抽搐病史、有无一氧化碳中毒及严重营养不良等病史。

(5)家庭经济文化背景:家庭经济情况、父母职业、父母文化水平、亲子关系及居住地的社会风气和养育孩子习惯等。

2. 全面的体格检查及实验室检测

特别注意身高、体重、头围与年龄的关系;有无与精神发育迟滞有关的指掌纹、面容及体态;有关的内分泌及代谢检查;头颅X线、CT及MRI;脑电图;染色体及基因检查等。

3. 详细的神经系统及精神检查

认真检查有无神经系统体征,特别要注意共济及协调动作,要了解神经系统软性体征,必要时反复检查确保无误;精神检查要重点了解语言、情感及行为表现,有无多动、自伤、重复刻板、幼稚行为,必要时要求家长或老师提供院外的表现情况,对临床心理发育状况进行初步评估。

4. 智力及心理发育状况的测评

(1)标准化智力测验:需由经过专门训练的技术人员采用标准化的测试工具认真测评。目前国内常用的智测工具有:盖塞尔发育诊断量表(GDS)、贝利婴幼儿发育量表(BSID)、图片词记测验(PPVT)、中国比奈智力量表(S-BIS)、韦克斯勒学前智力量表(WPPSI)、韦克斯勒学龄智力量表-修订本(WISC-R)等。要根据被试者的年龄、临床检查所了解的心身发育情况选择合适的测验。

(2)社会适应行为的评估:目前对社会适应能力的评定非常重视,是评定精神

对非生命物体特殊依恋,可有某些能力的超常发展;而不像精神发育迟滞儿童行为幼稚,依赖父母。

3. 特殊发育障碍

特殊发育障碍儿童也常有学习困难,易被误认为是智力问题。但仔细检查多数能力正常,学习成绩不平均,有些科目有困难,如阅读、计算或诵读困难,而其他成绩较好,社会适应能力缺损不明显。

4. 儿童多动症

由于注意力不集中影响学习和社会适应,貌似精神发育迟滞,但病史中发育迟缓不明显,智力检查一般正常,经教育训练或服用提高注意力的药物,症状明显好转,智力显著提高。

5. 儿童精神分裂症

一般病前无躯体及智力发育障碍。病后虽然有学习成绩下降、反应迟钝、淡漠、环境适应不良,但主要特征是思维、情感与行为的不协调,以怪为主,并不是真正的智力低下。

五、治疗和预防

+++++

精神发育迟滞,病因复杂,病程与生长发育并存,对社会功能影响大,预后不佳。因此,需积极地预防和治疗。

1. 综合治疗

(1)多方面合作:加强与患儿家长的联系和教师、心理工作者的密切合作是开展综合治疗的前提

(2)病因治疗:对某些病因比较清楚的代谢、内分泌疾病,要早期诊断,及时限制饮食或补充必需的元素,如苯丙酮尿症患者限低苯丙氨酸饮食;克汀病给予甲状腺素,地方性克汀病要及时补碘;铅中毒儿童,要排铅驱毒、神经营养支持治疗。

(3)药物治疗

①对症治疗:对兴奋不安,可用小剂量抗焦虑及抗精神病药;伴有癫痫发作者要采用抗痉挛药物治疗。

②促大脑代谢治疗:常用药有 γ -氨酪酸、脑复康、谷氨酸、脑磷脂、脑活素等。最近有人应用神经生长因子治疗精神发育迟滞,取得一定效果。

(4)教育训练和行为指导:不同程度病人采用不同的方法。对轻中度精神发育迟滞者,尽早开始进行语言、劳动和生活技能教育,特别是在专门的培育学校学习,

通过长期、耐心、科学的教育,很多患者成年后基本上可过接近正常的生活。对重症患者,需终身照顾,重点指导,训练基本生活技能。常用的方法有:

①临床教学法:这是一种典型的个别化教学训练方法,目的在于按照临床资料,为个别迟滞儿童设计适合其需要的教学方案。采用个别指导、独立学习和小组训练3种形式,通过“训练—测验—训练—测验”交替过程,逐渐提高能力。

②主题单元教学法:亦称循序渐进法,将各种课程系列地划分为若干小型,变为有逻辑顺序的主题学习单元,在各课协同配合下,按主题单元循序渐进地进行教育训练。

③任务分析法:运用行为分析的技巧,将各种训练任务—目标行为,做详细剖析,重点放在达到目标行为的操作方面。

④感觉统合训练:对于活动过度、注意力难集中的儿童,增强来自前庭、肌肉关节和皮肤等感觉输入,训练他们综合这些感觉,并同时做出适当的反应。

⑤行为矫正法:主要运用鼓励学习原则,矫正迟滞儿童的某些问题行为或特殊功能障碍,效果较好。实施前,首先要明确需矫正的“行为”,然后观察其前因、过程和结果;继之记录“问题行为”,并画出基线;最后选择有效强化物,由简入深、循序渐进地进行强化训练。

⑥开发右脑增智训练:临床观察和研究发现,大多数精神发育迟滞儿童主要障碍是抽象思维能力及对言语性材料反应能力差;而对直观形象的内容接受困难不大。智测结果也发现操作智商比语言智商好。提示右脑功能相对较好,有进一步开发的潜力。国内外许多学者已开展了这方面的工作,取得了良好的效果。也说明精神发育迟滞儿童的大脑尚留有潜能需开发。

2. 预防

(1)把好优生关:禁止近亲婚配,育龄妇女或有遗传病家族史的夫妇应接受优生咨询和产前诊断;广泛宣传科普知识,提高优生意识。

(2)加强孕期保健:注意营养,避免接触有害化学物质,戒烟,戒酒,防射线,防病毒感染等;保持愉快的情绪,多听轻松愉快的音乐等;碘缺乏区孕妇注意补碘。

(3)注意围产期保健:防产伤、窒息、感染等。

(4)做好优生、优教工作:合理喂养、加强护理防意外脑伤害,防感染中毒,注意心理发展和健全人格的培养。尽早对婴幼儿进行语言及智力开发,重视因材施教,培养良好的学习习惯。

(5)注意新生儿筛查:某些先天性代谢障碍,如苯丙酮尿症、甲状腺功能低下可以在产后早期检查出来,给予及时治疗能大大减少精神发育迟滞的发生或减轻智

力损伤程度。

(6)做好重危儿童监护工作:对于妊期异常和分娩时难产、早产、窒息、足月小样儿及中枢神经系统损伤的儿童应进行追踪观察,定期检查,一旦发现问题进行早期干预。

(7)创造良好的环境:给予必需的适宜刺激,包括感官的刺激和情感的交流。否则容易产生轻度的精神发育迟滞。

(8)科学用脑:人脑潜力很大,早期全面开发对成年后的智力有很大影响。特别是要克服人们习惯用右手,忽视左侧活动刺激的倾向。要注意左右脑全面开发,只有科学用脑才能人尽其才全面发展。

(郑毅 梁月竹)

不论是病史收集还是面对面地检查儿童,均必须有发育的观点。随着年龄的不同,儿童的行为与情绪均处于不同的发育阶段,故评估其行为与情绪必须考虑其相应的年龄因素。而且,要与所处环境联系起来考虑其是否异常。

2. 复杂性

儿童的病史常常由父母或老师等人提供,除年龄较大的儿童自己可以补充一些病史外,年幼者无法自己陈述,因此,病史资料比较间接。据此所得病史资料,对同一患儿可能有很大的差异,究其原因主要有以下3方面。

(1)信息来源不同:例如对焦虑、抑郁的患儿,其父母所看到的外在表现,与患儿自身的体验有很大差异。又如伙伴关系问题,常常是在家庭以外的活动中才能表现出来,父母很少亲临其境,因此,对于其伙伴关系中存在的真正问题也就很难说得清楚。故而父母与患儿反映的情况有时差异相当大。

(2)不同病史提供者的个人性格素质的差异:对同一儿童的同—行为有的人认为是异常,有的人认为是正常。不同的人反映的情况差异很大。例如一名性格特别好静的母亲,可能对正常儿童的活泼好动不能耐受,而视为多动症;而一名毫不关心子女的母亲,可能对儿童存在的明显发育迟滞、学习困难等熟视无睹。

(3)儿童在不同环境中的不同表现:有的儿童的攻击、破坏行为仅仅在家中表现出来,而在学校却是一名守纪律的好学生;有的儿童仅仅在离开家庭或与父母分离时,才出现胆小害怕,焦虑不安。

综上所述,在评估病史的可靠性时,要注意到可能存在的干扰因素,并加以克服。一般来说,多渠道的信息来源,注意不同情境的行为表现,注意儿童的相应发育年龄,必要时配合心理测验及其他实验室检查,加以综合考虑,有助于得出正确的诊断结论。

3. 心理测验在儿童精神障碍诊断中的应用

近些年来在儿童精神疾病的诊断或精神状态的评定中常应用心理测验的方法。心理测验的方法很多,最常用的是:

(1)智力测验:Wechsler 儿童智力量表(Wechsler intelligence scale for children),Wechsler 学龄前及初级智力量表(WPPSI),Stanford-Binet 智力量表(Stanford-Binet intelligence scale)等。

(2)社会能力发育测定:Vineland 社会能力成熟度量表(Vineland social maturity scale);社会适应评定量表(AAMD-ABS)。

(3)其他发育方面的测定:Denver 发育量表(Denver development scale)。

(4)儿童行为量表:Rutter 儿童行为量表, Achenbach 儿童行为量表, Conner

多动行为量表等。

(5) 儿童人格测验: 儿童用(7~13岁)Eysenck人格问卷(junior eysenck personality inventory)。

有些心理学家还喜欢用投射测验(projective techniques), 但这些测验在评分时主观成分太大, 其效度尚未充分确立。另外, 临床上也可以用让儿童自己讲一个故事等方法来达到类似的目的, 即了解儿童对家人及周围事物的感受。

心理测验为儿童精神障碍的诊断提供了方便, 增加了客观性和科学性。但是, 由于儿童心理现象的复杂性和目前儿童心理测验的局限性, 儿童心理测验的结果只能作为医生的参考。切忌以心理测验的结果来代替医生的诊断。

二、儿童精神疾病的治疗原则

1. 多方合作

儿童精神疾病的发生、发展与环境有密切的关系, 因此动员与儿童有关的人员共同关心儿童的精神健康十分必要。首先是动员其父母, 不仅要向他们了解儿童的生长发育及疾病情况, 而且还要把诊断结果、诊疗计划告诉他们, 要求和指导他们配合治疗。如果儿童的情况是由于家庭问题或父母的健康情况不良引起的, 也应尽可能协助解决。除此之外, 也要求家庭中其他成员一起配合治疗。如果儿童的精神问题与邻居关系有关或与学校表现有关, 那就需要同时取得有关人员的合作。如果儿童的精神状态与躯体疾病有关, 那当然应尽可能与儿科医生一起来进行治疗。

2. 药物治疗

药物治疗对大多数有精神健康问题的儿童来说, 还是必要的, 对部分病人甚至占主要地位, 因此, 了解和掌握各类精神科药物的详细情况是非常重要的。但近年来人们又非常注意药物对儿童发育的潜在的或远期的不良影响, 因此医生在选择用药时必须小心, 必须先熟悉药物的性能、剂量, 然后使用。

3. 心理治疗

广义的心理治疗其实包括两个方面, 一是调整环境, 二是调整个人。对后一方面, 目前比较切实可行的方法是对儿童进行正面的指导。指导的方法是对其良好的行为加以表扬、鼓励(包括精神的和物质的鼓励), 对其不良行为予以否定(不是用责骂或体罚的方法), 或者采取一些措施把儿童的精力引导到某些健康的爱好或行为方面来, 以替代其不良行为。治疗者要达到上述目的, 必须先花相当的时间和

儿童建立友好和信任的关系,而这在目前诊疗任务繁忙的情况下较不易做到,因此必要时也可以把有关知识教给家长或老师,由他们(已经与儿童有了信任和友好关系者)做大部分工作,而由心理治疗家定期进行检查和指导,这也是动员其他力量来进行治疗的一种方式。

对较大的儿童亦可进行小组集体治疗,其原则与成人心理治疗相同。但样板的作用在儿童身上更明显,因此在儿童集体心理治疗中树立样板比相互启发起的作用更大。组织家长座谈会,让他们相互交流情况和经验,并穿插某些知识讲座,这对提高家长的认识很有作用,因而通过家长对儿童起良好的作用,这也可以看作是一种间接的集体心理治疗。

4. 行为治疗

这实际上也属于心理治疗,其原则与成人的行为治疗相同,但在儿童有时可收到更好的效果。前述的表扬、鼓励的方法实际上就是一种行为治疗。用行为治疗的术语来说,就是当儿童出现成人所期望的行为(良好行为)时给以阳性的强化。行为治疗也可以减少儿童的不良行为。当儿童出现成人所不期望的行为(异常行为)时给以忽视或惩罚,以消除不良行为,但责骂和体罚要慎重,这不是好办法。只有在必要时,在儿童单一阳性强化效果不好时才配合使用,而且要让患儿明白,起到责打的效果。不可滥用,如使用不当(“打皮了”),不但有损于儿童的健康和自尊心,而且从长远来说并不能起消除不良行为的作用,甚至可以起相反的作用,或者使其不良行为转入消极对抗。在儿童出现不良行为时,重要的是找寻原因,找出能强化这种不良行为的因素,并加以消除。对较小的儿童来说,对其不良行为的过分重视,有时反会无意地起了强化作用;对其不良行为表面上不加注意,而对其正常行为或良好行为加以鼓励,这种做法倒可促使其消除不良行为。因为多数儿童都有希望吸引别人注意的倾向(许多成人也有这种倾向),因此其行为得到注意便等于得到加强。

5. 教育

对某些功课特差或有读写困难的患儿,组织起来采用适当的方式给以补习,这是治疗中的一个环节。对有社交障碍、手工操作障碍等问题的患儿,也可以组织一些针对性的活动,使其在锻炼中得到改善。

6. 住院及环境治疗

儿童精神障碍患者应尽可能一面治疗一面仍生活在家庭里,但有两种情况不得不让儿童离开家庭,改变环境治疗,一是家庭环境实在太差且无法改变,只好脱离家庭以脱离不良环境的影响;二是行为紊乱太严重,家长无法管理,只好换个环

境。住医院是环境治疗的一种,即住院观察以便明确诊断。另外,某些较复杂的诊断或治疗措施在其他机构无法进行者,需要住院治疗。

第二节 特殊发育障碍

一、理论基础

学习技能发育障碍(specific developmental disorders of scholastic skills),起病于儿童发育早期阶段,在同样接受教育条件下,表现出学习技能的障碍,但不是由于智能发育障碍,中枢神经系统损害,视觉、听觉障碍或情绪障碍所致。

诊断标准:至少具备下列 3 项中的 1 项。

1. 特殊阅读障碍:包括对文字的理解及阅读障碍,常伴有言语特殊发育障碍。
2. 拼音障碍:不能正确拼出音节,但其他功能一般正常。
3. 特殊计算能力障碍:主要是加减乘除的运算能力障碍,其他学习技能无明显障碍。

二、典型病例分析

(一) 病历摘要

患儿李某某,男,10 岁,小学四年级学生。

主诉:因读书常出错,学习成绩差 4 年,于 1999 年 9 月由母亲带来北京儿童少年心理卫生中心门诊就诊。

现病史:患儿自幼说话结结巴巴,入学后感到拼音、认读和听写课文困难,读课文不流畅,不愿朗读课文,常常读错字、漏字,或加字,有时甚至跳行。算术成绩尚可,一、二年级与同学交往尚好。三年级以后造句或写作文也感困难,经常被其他同学取笑,逐渐变得比较孤僻,不愿当众朗读课文。升入四年级后,数学应用题计算也有困难,学习成绩不断下降,语文经常不及格。老师让家长带孩子去看医生,查耳鼻喉和舌系带均正常;脑电图、头颅 CT 未见异常。日常生活能够自理,爱玩,喜欢看电视,爱画画。爱做小动作,但活动时左右肢体配合欠协调。饮食、睡眠好,大小便正常。

既往史:否认重大躯体疾病及癫痫抽搐病史,否认外伤及手术史,否认药物过敏、中毒及成瘾史。

个人史:独生子,其父母无血缘关系,母孕期妊娠反应较明显,足月顺产,出生时体重 3 400 克,Apager 评分 9 分。生后母乳喂养,6 个月能坐,1 岁会走,13 个月开始讲话,但口齿欠清楚。3 岁起去幼儿园,表现正常。病前性格:内向,话少,娇气,任性,依赖性大。

家族史:父母亲均为大学文化,从事技术工作。家庭关系、经济条件均好,对孩子比较溺爱。两系三代无癫痫,精神发育迟滞,痴呆及精神失常者。

体格检查:

发育正常,营养中等,头颅无畸形,五官端正,视力、听力粗查正常,皮肤黏膜完整无黄染及色素痣,周身表浅淋巴结未触及肿大,双肺呼吸音清,心脏各瓣膜区未闻及杂音,腹平软,肝脾肋下未触及。脊柱四肢无畸形、活动自如。生理反射存在,左右肢体协调性略差,轮替试验(+),病理反射未引出。

精神检查:

意识清楚,衣着整洁,年貌相符,步入诊室。接触略被动,交谈切题,查体合作。未发现幻觉、妄想。自诉学习有些困难,常认错、读错字,读课文不流利、常读错而被别的同学取笑。说话有时口吃,自感学习上不如同学,虽然想努力读好,但越紧张越出错,为此而自卑。读书缺乏信心,厌学,但喜欢美术课、体育课和自然课。注意、记忆正常。智力粗查,一般常识回答正确,能完成 100-7 的连续计算,理解、综合、判断能力正常,能正确解释常用成语。自知力存在,主动求治,希望医生能帮助他把学习成绩提高。情绪略紧张,有时焦虑不安。未见冲动、怪异行为。

韦氏儿童智力测验(C-WISC):总智商(FIQ)98,言语智商(VIQ)91,操作智商(PIQ)103。社会适应能力:正常。成就测验:阅读技能 4.6,拼写技能 5.3,计算能力 6.3。

(二) 病例分析

1. 临床表现特点

患儿的主要临床特点是:①男性,10 岁。②以读书常出错,学习成绩差 4 年为主诉。缓慢起病,逐渐形成。③自幼说话就略有结巴。运动及人际交往能力均发育正常。④临床以拼音、认读和朗读课文困难为特点,算术成绩尚好。⑤查体左右肢体协调性略差,轮替试验(+),余正常。⑥智力测查正常。成就测验中阅读技能明显低于正常儿童,拼写与计算能力基本正常。

郁药调节情绪和控制异常行为,如佳静安定、氯丙咪嗪、氟西汀等。

4. 本例思考

- (1)何谓学习技能发育障碍,其临床特点是什么?
- (2)特殊阅读障碍诊断应注意什么?
- (3)特殊阅读障碍易与哪些病相混淆?

第三节 广泛发育障碍

一、理论基础

广泛发育障碍(pervasive developmental disorders)是一组起病于婴幼儿时期特有的心理发育障碍,其特点为个体发育功能广泛损害,社会化行为缺陷,言语障碍,认识功能障碍,兴趣与活动表现异常。诊断必须结合个体生理、心理发育水平,综合加以衡量。其代表性疾病是儿童孤独症(childhood autism)。

儿童孤独症是一种严重的身心发育障碍性疾病,临床表现以人际交往障碍,沟通交流异常,兴趣和活动内容局限、刻板与重复为特征,多发病于婴幼儿期,通常在3岁以前就出现发育异常,男孩发病显著多于女孩。

法国学者凯纳(Leo Kanner)1943年在“孤独性情感交往障碍”一文中首先提出了“早期婴儿孤独症”的概念。此后许多学者对此病发生兴趣,又有“婴儿孤独症”、“凯纳综合征”、“儿童孤独症”、“孤独性障碍”等描述。20世纪70年代初,美国成立了国立孤独症儿童和成人协会,认为孤独症虽然发生于儿童,但会影响至成年。一部以描述孤独症为主题的奥斯卡获奖影片《雨人》,使人们对孤独症的认识达到了高潮。1987年美国学术界统一使用“孤独性障碍”这一名称,使孤独症的概念更广泛。我国习惯使用“儿童孤独症”,并于20世纪90年代中期,成立了“北京孤独症协会”,并相继成立了许多训练中心。

儿童孤独症并不少见,患病率为0.02%~0.13%。日本有调查显示每万名儿童中有10个。我国有3亿8千万14岁以下的儿童,但目前尚无孤独症患病率的调查,根据日本的患病率推算,我国应有30多万孤独症儿童。但由于以前儿科、儿保和精神科医生中能够正确识别孤独症的还很少,所以很少有报道。

儿童孤独症自古就有,但不为人们所认识。英国伦敦贝瑟恩医院于1799年收住一个5岁男孩,发现他从不与其他孩子交往,而成天沉浸于玩具士兵的游戏中,

以致达到与世隔绝的程度。此后,文献资料中,常有散在奇特儿童疑为孤独症的记载。如 18 世纪末和 19 世纪初,法国 12 岁与世隔绝的男孩阿维龙;与外界极度隔离的儿童维克多;年历推算、绘画及音乐超常的白痴学者等。

随着儿童精神医学的发展和科普宣传,孤独症已为多数人所认识。在我国儿童孤独症的诊出率越来越高;越来越多的孤独症儿童被识别出来。北京安定医院儿科,近 20 年来诊出率增加 3 倍多;南京儿童心理卫生研究中心,儿童孤独症的诊断从 1984 年门诊的 0.47% 升至 1996 年的 1%。这种逐年增多的现象已遍及全国。当然,目前我国专业人员很少,非专业机构中常有错诊和误诊的案例,给儿童及家庭带来不必要的痛苦。所以,科学地认识儿童孤独症,早期发现、早期治疗已是当务之急。

儿童孤独症的行为表现在孩子与孩子之间有很大的个体差异,并且随着儿童的发育,不同年龄也有不同表现。该病一般在出生后 30~36 个月起病。多数患儿早期症状在婴幼儿期即已出现,至 12~30 个月症状明显。少数患儿出生后的前 12 个月症状极轻或完全正常,12~30 个月症状变得明显,出现语言功能退化,本来已会表达的少数词汇消失,并呈现典型孤独症症状。但通常情况下,由于父母缺乏有关婴幼儿心理和行为发育程序的知识,再加上平时观察不密切,对病儿何时起病很难确定。

社会交往困难或异常、语言交流障碍、兴趣狭窄、刻板重复动作、强迫保持生活环境和行为方式不便为儿童孤独症特征性症状。

1. 社会交往障碍

大部分孤独症患儿婴幼儿期就出现对人缺乏兴趣,母亲将其抱着喂奶时,他们不会将身体与母亲贴近,不会望着妈妈微笑,平常不注视父母的走动。6~7 个月时还分不清亲人和陌生人,不会像正常小儿一样发出咿呀学语声,只是哭叫或显得特别安静。有的患儿即使 1~2 岁发育正常或基本正常,但起病以后表现有饥饿、疼痛或不舒服时,不会跑到父母身边寻求食物或安慰,或只是拉着父母的手去取东西,而不会以言语或姿势来表示。这种患儿往往对父母离开或返回无动于衷,即使父母站在身边也不会与之交往,更不会与父母对视,显得极其孤独。孤独症患儿也同样缺乏相互性社会交往,表现为不与周围小朋友交往,更不可能建立友谊。

2. 语言交流障碍

语言交流障碍在儿童孤独症中表现得较为显著,具体表现有以下几方面:①非语言交流障碍:孤独症患儿常以哭或尖叫表示他们的不舒适或需要。稍大的患儿可能会拉着大人的手走向他们想要的东西。缺乏相应的面部表情,常显得表情漠

然,很少用点头、摇头、摆手等表示他们的意愿。②语言发育延迟或不发育:病儿常常表现为语言发育较同龄儿晚,有些甚至不发育。有报道说病儿中约有一半终身保持缄默,仅以手势或其他形式表达自己的要求。也有些病儿2~3岁前语言功能出现以后,又逐渐减少甚至完全丧失。③语言内容、形式的异常:孤独症病儿语言功能即使存在,也同样有许多问题。病儿往往不会主动与别人交谈,不会维持或提出话题,或者只会反复纠缠同一话题,而对别人的反应毫不在意。他们常常是在“对”人说话,而不是“与”人交谈,语言交流十分困难。刻板重复性语言及模仿性语言也较多见,和病儿谈话时他常只会重复你的讲话。也有的会在当时或隔一段时间以后模仿电视、收音机或别人说过的话。有些病儿表现为自言自语或哼哼唧唧,自得其乐。另外,孤独症病儿还可有语音、语调、语速、语言节律及轻重音等方面的异常,讲出的话怪声怪气或平平淡淡,没有感情色彩。有的病儿对人称代词常错用,把“你”说成“我”,或把“我”说成“他”等。

3. 兴趣狭窄、坚持同一格式和仪式性强迫性行为

①兴趣狭窄和不寻常的依恋行为:孤独症病儿对一般儿童所喜爱的玩具和游戏缺乏兴趣,尤其不会玩富于想像力的游戏,而对一些通常不作为玩具的物品却特别感兴趣,如车轮、瓶盖等圆的可旋转的东西。有些病儿还对塑料瓶、木棍等非生命物体产生依恋行为。他们常对物体的非主要特性感兴趣,如喜欢反复摸光滑的地面、抱着木棍睡觉等。②不愿改变日常生活习惯:孤独症病儿对环境常常固执地要求一成不变,一旦发生变化就会焦虑不安。对日常生活习惯也是如此。如有些病儿只吃固定的食物,有些吃饭时要求坐固定位置。有的还喜欢把玩具或物品排列成行,如被搞乱,就显得痛苦或大发脾气。几乎所有的孤独症儿童都拒绝学习或从事新的活动。③仪式性或强迫性行为:如扭曲或在别人面前弹弄手指,拍手。有些病儿花费很多时间沉湎于记忆天气预报、一些国家的首都、家庭成员的生日等。稍大的病儿常反复问同一个问题和不可克制地去触弄或嗅闻一些物体。

4. 感觉和动作行为怪异

病儿对疼痛和外界刺激麻木,如一个突然的声响在正常小儿会引起惊跳,而孤独症病儿则若无其事。给他们讲话,他们像聋子一样没反应,很多父母就因为怀疑小儿“耳聋”而初次就诊。在病儿面前站个人,病儿好像没有看见,或只注意看对方的一双手或其他某一部位。病儿常以摩擦、拍打、撞头、咬硬东西、摇晃或旋转身体等动作以引起自身感觉,常出现旋转而不头晕。病儿自伤行为多见。

5. 认知和智能障碍

孤独症病儿的智能约有50%处于中度和重度低下水平(IQ低于49),约25%

为轻度低下水平(IQ 为 50~70),还有 25%可保持正常。一般医院门诊所见的病儿多属于中度或重度,那些轻度或正常智力水平的病儿也许被认为只是脾气古怪,而不作为病态前往医院就诊。不论病儿的智商是低还是高,其表现的主要症状均相似,只是智商低的病儿在社会交往和社会反应、刻板行为和自伤行为的程度上更为严重,癫痫发作也较多见。有部分孤独症病儿在智力低下的同时可出现“孤独性才能”,在音乐、计算、推算日期、机械记忆和背诵等方面呈现特异功能,被称为“白痴学者”。

6. 情感反应异常

情感反应平淡,或有与境遇不恰当的情感表现。他们常出现无理由的哭泣、大声啼哭,并且难以通过安抚使之平息。也有的无故地咯咯笑。对汽车、高楼和有毛动物等一般孩子所害怕的东西无畏惧感。

儿童孤独症表现多样,原因尚不清楚,有的学者研究发现可能是遗传及先天缺陷;有的认为是对孩子照料上的不足;也有出生前后的不利因素,脑损伤,大脑半球一侧化障碍,脑功能失调,视、听通路统合缺陷等理论;还有神经介质多巴胺、去甲肾上腺素、内啡肽及免疫缺陷学说。目前多数学者认为是多种原因共同作用的结果,即生物—心理—家庭社会因素共同影响。

由于病因尚不清楚,目前诊断和治疗主要以临床表现为主。诊断常采用多轴诊断系统,既要全面、准确了解症状表现,又要详细掌握生长发育、躯体健康状况、心理状态、家庭社会应激因素及智力水平。还可以参考一些心理和行为量表(如孤独症行为筛查表、克氏行为量表)。

二、典型案例分析

+++++

(一) 病历摘要

患儿杨某某,男,5岁,北京籍。

主诉:因孤僻,言语少,行为怪异3年余于2000年5月10日来北京安定医院儿童精神专科门诊就诊。病史由患儿母亲提供,可靠。

现病史:患儿出生于知识分子家庭,父母从事技术工作,家庭和睦、富有。患儿的降生对这个家庭无疑是锦上添花。看到活泼、可爱、漂亮的胖儿子,父母总是乐得合不拢嘴。患儿周岁时已会叫爸爸、妈妈,会说出几个单词。然而,好景不长。患儿1岁后言语能力发展极为缓慢,更让人担心的是,叫他的名字不作反应,对大

人的吩咐不理睬。曾误以耳聋去多处检查,“电测听”、“听诱发电位”均正常。老人们“贵人言语迟”的说法,多少给焦急的父母带来些安慰。可是,事与愿违,患儿的言语不但没有发展,行为也越来越古怪。不像别的小孩那样会伸出手作被抱的准备姿势,也不喜欢父母或其他小孩接近,一个人独处反而自在。喜欢在眼前反复扭动手指或拨动玩具汽车的轮子,对圆的瓶盖、电视广告、天气预报特别有兴趣。3岁去幼儿园,小朋友做游戏他则躲在墙角玩一块绒布。至今仍要大人喂饭,由大人照料他的大小便和日常生活。但其记忆力特别好,教他的儿歌会在无意之中完整地唱出来;到哪里去,走上一趟就记得回来的路。进一步观察还发现他玩积木,只是排成一行,不会搭桥、搭汽车,并且他顽固地坚持生活环境和方式原样不变,如有变动就烦躁和尖叫撞头。最近,常独自玩木棍,睡觉也要抱着木棍。患儿到处就医,几经周折,多处诊治,效果不好。饮食、睡眠、二便正常。

既往史:否认重大躯体疾病及癫痫抽搐病史,否认外伤及手术史,否认药物过敏、中毒及成瘾史。

个人史:独生子,其父母无血缘关系,母孕期妊娠反应较明显,足月顺产,出生时体重3 600克,Apager评分9分。生后母乳喂养,6个月能坐,1岁会走,13个月开始讲话,但口齿欠清楚。2岁明显话少,不愿与人交往。3岁起去幼儿园,行为表现明显异常。病前性格:内向,话少,任性,行为易冲动。

家族史:父母亲均为大学文化,从事技术工作。家庭关系、经济条件均好,对孩子比较溺爱。两系三代无癫痫,精神发育迟滞,痴呆及精神失常者。

体格检查:

发育正常,营养中等,头颅无畸形,五官端正,视力、听力粗查正常,皮肤黏膜完整无黄染及色素痣,周身表浅淋巴结未触及肿大,双肺呼吸音清,心脏各瓣膜区未闻及杂音,腹平软,肝脾肋下未触及。脊柱四肢无畸形、活动自如。生理反射存在,病理反射未引出。

实验室检查:

血常规正常。肝功能正常。EEG轻度异常。头颅CT正常。

精神检查:

意识清楚,年貌相符,衣着尚整洁,步入诊室。接触被动,问话不答,似没听见,手持木棍在诊室内走来走去。医生与其母亲谈话时,他会突然插话,内容尚贴切,但说话时不看着人,语言刻板、重复,人称代词乱用。能准确背出许多电视广告词,但不能回答是什么意思。情绪不稳,有时突然哭闹。对医生、打针没有恐惧感,但对医生的触摸非常敏感,拒绝检查。注意力集中在自己的行动中,对周围

人不注意。智力检查不合作。行为动作多,孤独不与外界来往,自娱自乐,其行为被干扰即发脾气。

心理测验不合作。

(二) 病例分析

1. 主要临床特点

患儿的主要临床特点是:① 男性,5岁。② 以孤僻,言语少,行为怪异3年余为主诉。缓慢起病,逐渐形成,找不出明显的发病期。③ 临床特点是接触被动,交往困难,问话不答,缺乏目光对视;感觉既迟钝又敏感;行为孤独不与人交往,对非生命的物体特殊依恋;机械记忆能力强;情绪不稳,有时突然哭闹;行为动作多,孤独不与外界来往,自娱自乐,其行为被干扰即发脾气。④ 查体左右肢体协调性略差,余正常。⑤ EEG示轻度异常,头颅CT示正常。

2. 诊断与鉴别诊断

该患儿起病于婴儿期,缓慢起病,逐渐形成,找不出明显的发病阶段;以孤僻,接触被动,交往困难,言语少,行为怪异为特点。临床突出表现为问话不答,缺乏目光对视;感觉既迟钝又敏感;行为孤独不与人交往,对非生命的物体特殊依恋;机械记忆能力强;情绪不稳,有时突然哭闹;行为动作多,孤独不与外界来往,自娱自乐,其行为被干扰即发脾气。未发现有幻觉和妄想。这些特点符合广泛发育障碍中的儿童孤独症的诊断。

但需与精神发育迟滞、儿童精神分裂症、Asperger综合征、Heller综合征、Rett综合征相鉴别。

① 精神发育迟滞患儿学习成绩普遍较差,病史有全面的智力低下,同时有社会适应能力缺陷。表现以幼稚、依赖性强为特点,而不是孤独和社会交往障碍。与此例明显不同,可以排除。

② 儿童精神分裂症属重性精神障碍,其心理功能严重受损,包括学习成绩下降,但应有相应的特征性精神症状,有幻觉、妄想、思维紊乱、情感不协调、缺乏自知力,不会主动求治。与此例明显不符。

③ Asperger综合征(Asperger's syndrome)又称儿童分裂样精神病,是一种病因未明的综合征,具有类似儿童孤独症的特征,表现为人际交往方面的损害,有局限、刻板、重复的兴趣和活动方式,但无明显的言语障碍及智能缺损。可与此例鉴别。

④ Heller综合征(Heller's syndrome)又称婴儿痴呆或衰变性精神病,是指在

起病前已肯定的言语及其他功能发育完全正常的阶段,起病后使已获得的功能逐渐减退以至丧失,对周围事物普遍地丧失兴趣。而此例患儿无肯定的言语及其他功能发育完全正常的阶段,对周围事物的兴趣不是普遍地丧失,而是对非生命的物体特殊依恋,兴趣古怪,机械记忆能力强,可与之鉴别。

⑤ Rett 综合征(Rett's syndrom)起病于 3 岁前,起病前发育正常或基本正常;起病后逐渐出现头颅发育减慢,已获得的手和言语功能部分或全部丧失,肢体运动障碍,有过度呼吸、生长发育迟滞和脊柱侧凸表现,多见于女孩。与此例明显不符。

本例诊断:

广泛性发育障碍:儿童孤独症

3. 治疗原则

孤独症的治疗应采取综合措施包括药物治疗、行为矫治和训练教育,要注意对家长的咨询,并鼓励家长积极参与,主动配合治疗。

(1)药物及饮食治疗:在正确诊断的基础之上,根据特定的症状表现特点、药物的药理作用、适应证、禁忌证和毒副作用选择药物。用药的目的在于改善特定的症状,也为照料和训练教育提供条件。①较常用的药物有:氟哌啶醇、利他林、丙咪嗪、氯丙咪嗪、氟西汀、利培酮,吗啡拮抗药——纳曲酮近来也有应用的报道;可改善活动过度、激动、攻击和刻板行为以及情绪不稳。但各种药物都有不同的毒副作用,要在医生的指导下应用。②维生素 B₆ 治疗孤独症:据研究报告,维生素 B₆ 可增加声音、词或言语的应用,改善睡眠,减少活动过度 and 激惹性,增加注意广度和对学习的兴趣,减少攻击和自伤行为。但仍处于试验阶段。③食物添加剂等可促使儿童行为问题的发生,包括活动过度和学习困难。为此,对孤独症儿童的食物应避免应用添加剂、色素和水杨酸等。

(2)教育训练及行为矫治:①针对孤独症儿童在人际关系、语言沟通、日常行为等方面的行为缺陷,作出弥补措施,促进认知能力的发展。②消除过分或不该有的行为,如莫名其妙的大笑、哭泣或害怕、自伤和暴怒等。③避免与消除固定僵化行为。常遵循下列原则:专业指导、家长参与、结合生活、循序渐进、个体化及避免一成不变。

孤独症的严重程度可分低功能和高功能两种。高功能患儿大多在最初的 1~2 年发育正常或基本正常,仍保持较简单的认知和语言交流功能,与父母和周围人也保持一定的情感联系,无癫痫发作,也无明显脑部器质性病征,以后出现的孤独症行为特征也较轻;而低功能患儿则反之。那些高功能患儿(占 5%~17%)可在学习和职业上取得一定的成就。多数病儿的结局不良,至成年期,很多孤独症病人

处于严重功能缺陷状态,需长期照管。如能早期进行有计划的医疗和矫治教育,并能长期坚持,可取得较好效果。

4. 本例思考问题

- (1) 广泛性发育障碍与儿童孤独症是什么关系?
- (2) 诊断标准和原则是什么?
- (3) 儿童孤独症治疗原则是什么?

第四节 儿童多动症

一、理论基础

+++++

儿童多动症即儿童多动性障碍,它是一种颇常见的儿童行为问题,主要表现为多动不宁的行为异常,注意力不集中,易分心,易激惹,好冲动,坐立不安等。在学龄儿童的发病率为 5%~9%,男:女之比约为 4:1。

这类儿童多动性行为障碍早在 1854 年就被霍夫曼观察到,并提出“多动综合征”来命名这类临床综合征。之后 100 多年来,围绕本病的命名、病因、临床表现及诊断治疗等进行了大量的研究,其命名及定义根据也屡有变更。根据最新的美国精神病学学会发表的《诊断和统计手册》(DSM-Ⅲ)以及国际疾病分类(ICD-10)的诊断标准,目前称它为注意缺陷多动障碍(attention deficit hyperactivity disorder, ADHD)。

导致本病的主要原因是:①遗传。由于男性多于女性,可以认为 ADHD 来源于父亲。②环境因素。当前社会中的各种污染,包括大气、食物污染,异食癖、缺乏照顾的儿童接触含铅量较高的塑料玩具、油漆制品,大量应用农药、激素、食物添加剂,上述都具有神经毒性,尽管不会影响所有的儿童,但是对那些生物学上的易感者尤其是有家族遗传倾向的儿童会有影响。③神经生理因素。根据 ADHD 患者的大脑前额叶抑制作用差而提出了“成熟延迟学说”。④神经病理和神经生化。丹麦的 Lon 等在 1984 年和 1989 年用放射性物质标记的方法发现,ADHD 儿童在两侧前额叶、尾状核和基底神经节区域的脑血流量减少。大多数研究表明,多巴胺在大脑某些区域含量降低。由此证实 ADHD 与中枢神经递质多巴胺关系密切。最新研究还发现,乙酰胆碱和尼古丁存在于 ADHD 患儿大脑中的有关区域(包括注意及记忆中枢)。影像研究也提示患儿前额叶、纹状体、扣带回、胼胝体等部位确实

在咬他似的。上课注意力不集中,常被老师提醒才能认真听一会儿课。上课嘴里常发出怪声,弄得同学哈哈大笑,扰乱课堂秩序。上课时扔书本、教室的门锁甚至老师的粉笔。弄得老师常把他安排单独坐一排。做事情丢三落四,经常忘记布置的作业,在家长的监督下完成作业。爱与同学打闹,摸人一下或碰掉同学的铅笔盒。做事情不能持久,喜欢看书,常要求父母买书讲给他听,但是坐不了一会儿就跑掉了。考试经常七八十分,交卷子最快,从不检查,有时甚至被老师叫到讲台上才能完成试卷。所丢的分都是粗心大意造成的。情绪不稳定,爱发脾气,不顺心不如意就生气摔东西。特别高兴时喜欢尖声喊叫。

既往史:体健。无药物过敏史。

个人史:独子。足月顺产,出生时无窒息史,生长发育与同龄儿无异,母乳喂养,1岁2个月会走路,1岁5个月会讲3个字,会走路以后往往以跑代步,而且跑得很快,从一个房间跑到另一个房间。5岁时上学前班。自幼顽皮多动,好破坏玩具及家中物品。家庭经济小康,气氛活跃,家长对患儿要求较严厉。教育方法尚科学民主。病前性格:活泼、好动、顽皮、任性、胆大、聪明。

家族史:父母两系三代否认近亲结婚史。无家族遗传病史。

体格检查:

发育营养可。无畸形。对指、翻掌检查不合作。余未见异常体征。

精神检查:

神志清晰,衣着整洁,年貌相符,接触不佳,多动不宁。在诊室内坐不住,翻动桌子上的办公用品,家长管教不听从,甚至搬动椅子,弄得丁当作响。注意力不能集中,不能与医生进行正常的交谈。在诊室内外来回跑动。甚至挣脱父亲的双手跑到诊室外来回晃动门把手。智力良好。不认为自己有多动的毛病,劝说下表示能配合药物治疗。情绪不稳定,较活跃,爱发脾气,叫喊。

心理测查:

WISC-R 示 FIQ 99,VIQ 100,PIQ 97

Bender-Gastalt Test 示 8.62

注意检测示失误率 14.05%

(二) 案例分析

1. 诊断与诊断依据、鉴别诊断

此患儿的主要表现为:①自幼行为多动;②自幼注意力不集中;③情绪不稳定,易冲动;④患儿无其他品行问题,无智力低下,轻度学习困难。

本例的诊断思路:该患儿为6岁男孩,自幼活泼,好动,胆大,任性,聪颖,体健。在此基础上出现过度活动,注意力集中困难,情绪不稳,轻度学习困难等表现。活动多的儿童并不一定都是多动,要注意多动与年龄的关系。与年龄不相称的活动水平过高是其特征性表现之一。在评定其活动过度时,要注意患儿在各种场合都动个不停,尤其是在不该动的场合,如课堂、集合、客人面前等。要注意其与年龄、智力水平的关系。多动症的“多动”一般都带有唐突、冒失、不顾危险、过分恶作剧、富有破坏性、事先缺乏缜密的考虑、事后不顾后果等特征,与正常儿童相比较,不仅是量的改变,还有质的改变。多动症患儿根据外界的需要对注意进行调节和滤过,但是他们的有意注意集中困难特别明显,很易因外界无关刺激而分心,使专心听讲的时间缩短,学习效果必然要受到影响,诸如忘记老师布置的作业,作业遗漏、倒置,答非所问,丢三落四。多动症患儿并不是所有时间注意力都不能集中,对于他们特别感兴趣的事情或在强大的动机驱动下,注意的时间可能会延长。多动症患儿的不稳定情绪常波动性大,易激惹,为小事而大发雷霆,凭冲动做事。冲动性常具有事先不经过审慎思考,不顾后果,带有破坏性,伤害他人也不利自己的特点。他们的智力水平正常或接近正常,有时偏低与检查时的注意力不集中有关。有的患儿还可出现一些神经系统软体征,如翻掌、对指运动不灵活,系鞋带和扣纽扣等精细协调动作笨拙。年龄偏大的患儿还可伴有行为问题,如说谎、逃学、吸烟、偷盗、打架斗殴等等。关于本病的预后,随着年龄的增长,一般青春期以后,多动行为逐渐减少,但是仍有不安静、易激惹、冲动、注意涣散等症状;有的患儿成人后仍保留有此类症状。综合起来说,约有1/3的患儿到成人之后,仍需要家人予以适当的照顾帮助;约有1/3的患儿可能有精神病、人格障碍、反社会行为、发育迟滞等问题。大约有1/4仍可有较好的成绩,能完成大学学业,担当较为复杂的工作。一般来说,有智力低下,有明显攻击等反社会行为,家庭环境不良,未及时治疗者,预后较差。多动症在儿童时期较常见,虽然有其特定的行为表现,诊断似乎容易,实际上并非易事。临床上常易与以下疾病或表现相混淆,鉴别要点总结如下。

(1)品行障碍:单纯品行障碍,主要表现为斗殴,外逃,偷窃,严重说谎等。

明显违反与其年龄相适应的社会规范或道德准则的行为,损害个人或公共利益,但无多动症的行为特征及注意缺陷,且用兴奋剂治疗无效。但是目前有多动合并品行障碍的诊断。

(2)常儿童多动:一般以3~6岁的男孩居多,也表现为好动和注意时间短暂。但此类儿童的多动常由于外界无关刺激过多,疲劳,学习目的不明确,注意缺乏训练,不善于正当转移,平时未养成有规律的生活习惯。

逐渐加量,一般晨起空腹服用为宜,因其在胃中(酸性环境)迅速吸收,不可用牛奶冲服,以免妨碍吸收。下午4时以后禁忌服药,以免招致失眠。为了避免耐药,寒暑假以及休假日停服。长期服用利他林不会造成成瘾。

药物常见的毒副作用:利他林常见的药物毒副反应有食欲减退,脸色苍白,恶心,头昏等。一般与剂量大小有关,适当减量或延长用药时间,便可减轻或消失。其他毒副反应如头痛、腹痛均属偶见,并可逐渐适应。此外,在服药期间从未见到过肝、肾损害或血象变化。

(2)多动症的非药物治疗:多动症的心理治疗以教育为主,针对这类孩子注意力不集中、易分心、多动、易激惹、自尊心低等特点及合并一些神经发育延迟,采用一些特殊的教育还是十分必要的。首先帮助父母及老师认识注意缺陷多动障碍是一种病,改变将病儿当作“坏孩子”的想法,不要歧视、粗暴打骂,要有耐心,改变单纯惩罚的教育方法,发现其优点及时加以表扬,以利于逐渐提高自尊心,提高激发学习兴趣。其次,给患儿提供专心致志的学习环境,父母尽量不要在孩子学习时打麻将、看电视,最好父母在孩子学习时,也一起看书学习,以自己的言传身教带动孩子。保持注意力除了排除外界干扰之外,还要注意培养孩子的内在自制力,让患儿善于控制自己的感情,约束自己的行为,克服内外干扰。心理治疗易实行的一个重要手段就是奖惩疗法,奖励的程度应随孩子坚持埋头做事的时间长短而定,可采用协议书、记分数、小红花等,到一定程度后奖励可以玩玩具,看电视或外出游玩。开始时注意要求不能过度,应循序渐进,逐渐提高程度标准,使患儿不失去信心,并使其兴趣逐步提高。当患儿的行为有所改进,能完成规定的家庭和学校作业时,要加以表扬和奖励,而对不合适的行为,要能容忍,说服教育,撤销奖励,如蛮不讲理就进行短时间的小惩罚,但是应注意学校和家庭训练要有始终如一的纪律要求。同时要加强学校联系,其间教育既不能太粗暴,也不能借机姑息迁就。

总之,教育要持久以恒,有信心,有耐心有爱心,坚持持久就会有收益。

3. 思考问题

- (1)多动的孩子一定是多动症吗?
- (2)为什么患了多动症的儿童要及时治疗?
- (3)什么样的多动症患儿需要药物治疗?

第五节 品行障碍

品行障碍(conduct disorder, CD)是指18岁以下儿童或少年反复出现违反与

②流浪不归:这类儿童常离家出走在外流浪。在童年早期可能是出自对外界的好奇而走失不能回家;也有因在家自尊心受到损伤,得不到父母的关心而出走;或因父母争吵拿子女作为出气筒愤怒而出走;或因学习成绩不好,怕见父母受处分而出走。当第1次出走后如获得满足,即出走行为得到强化,则可多次离家出走。

③偷盗:儿童1岁以内自我意识尚未形成,分不清什么是你的,什么是我的,故看见自己喜欢的就拿。1~2岁时自我意识开始萌芽,但仍不清楚“别人的”概念,3岁后通过教育知道什么是别人的,自己不能随意拿。由于儿童对新鲜事物的喜爱及好奇(自己没有的东西,均是新鲜事物),在幼儿园中常常把自己喜欢的东西带回家玩,或把同伴的玩具带回来。此时如父母沉默认可,久而久之养成为满足自己愿望随意拿别人东西的习惯。最初是拿家中的钱或物,当被父母询问时,怕受处分,只好否认。以后偷偷地干,明知故犯则成偷窃行为。当成为习惯后,可偷走同学物品,为了玩电子游戏可偷他人的钱或摸包,构成儿童品行障碍。这类儿童偷窃行为模式形成后,若不及时纠正,常在少年期成为违法犯罪者。

④逃学:儿童由于厌恶学习、反抗老师或家长、贪玩等原因,而背着父母,不去上学,常常背着书包离家后,就在外面游荡或与其他儿童玩。此类儿童常常学习成绩不好,品行不佳,还常常有说谎、打架等违反校规的行为。这类儿童的家庭气氛常常不好,父母的教育意见不一致,对儿童不关心,体罚多。有的被社会上流氓勾引,结成团伙进行违法行为。

⑤纵火:儿童常喜欢玩火,划火柴玩,燃爆竹类东西。这些事物具有新颖性及刺激性。若家长未能及时进行教育,儿童可把玩火柴、燃烧废物作为游戏,可造成意外性火灾。儿童因报复进行放火者少见,但亦有受电影电视的影响,因与伙伴游戏发生争吵,进行放火报复者。

⑥性攻击:多发生于12~15岁男性儿童,最初出于好奇心或恶作剧,对异性进行猥亵行为,在黄色电影及小说影响下也可产生强迫异性发生性行为。女性可因与异性发生性行为获得物质上满足,常可导致淫乱性生活或卖淫。这类行为涉及违反社会法纪,则构成违法行为。

二、典型病例分析

+++++*+++++*+++++*+++++

(一) 病历摘要

患儿陈某,男性,13岁,初中二年级学生。

主诉:因说谎,逃学1年余;加重3个月,常夜不归宿于1997年6月3日住院。病史由患儿母亲提供,可靠。

现病史:患儿自幼好动,以自我为中心,学习时好时坏。父望子成龙,“棍棒”教育;母爱子心切,常帮孩子蒙骗父亲过关。小学期间“棍棒”教育尚有效,“严管”之下考入某区重点中学。升入中学后,学习压力大,学习成绩下降。怕挨打,患儿开始用说谎蒙骗父亲,以逃学来躲避老师。常背着书包游荡,有时在电子游戏厅消磨时光。

半年前,开始与坏孩子为伍,偷母亲的钱,抢小同学的东西。曾跑到原小学,往老师茶杯中放粉笔末。在校园中将干树叶点燃,然后喊救火。乘老师跑出去救火之机,翻老师的衣服偷钱。事发后怕上学受老师盘问和学校处分,怕回家受父亲责罚,漫步街头,来到了火车站,想跑到姥姥“避难”。当乘客发现他孤身一人时,则自编一套故事谎说自己受后母虐待,逃出来去找姥姥。为此,大受乘客同情,好吃的食品、饮料、水果均源源不绝而来。次日由列车长送到姥姥家。自此,每当受父母处罚或不能满足其愿望时,则到火车站混入列车到处游玩,夜不归宿。每次均以撒谎、编故事获得生活必需品,在城市游逛时,则夜睡过街地道或火车站。父打骂体罚不再有效,学校处分也无所谓。父母束手无策只好前来求助心理医生检查有无病态。

既往史:否认传染病、重大躯体疾病及癫痫抽搐病史,否认外伤及手术史,否认过敏及中毒史。

个人史:患儿为第1胎,母孕期体健,足月顺产,出生体重3600克。母乳喂养,2月能抬头,6月出牙,1岁会走,1岁2个月会讲简单话。自幼好动、爱哭,较好喂养。性格特点:活泼,开朗,任性,以自我为中心,做事欠稳定。

家族史:父母非血缘婚。否认两系三代有癫痫,精神发育迟滞,痴呆及精神失常者。

体格检查:

神清,发育可,营养中,头部及四肢无畸形。皮肤黏膜完整无黄染、皮疹及色素痣,手掌皮纹正常,周身浅表淋巴结未触及肿大。双肺呼吸音清,心脏各瓣膜区未闻及杂音,腹平软,肝脾肋下未触及。脊柱、四肢活动正常。

神经系统检查:

头颅大小正常,未引出眼震,感觉未见异常,四肢活动自如,双手肌力V级,肌张力不高,腱反射正常引出,未引出病理征。

实验室检查:

血常规正常。肝功能正常。脑电图正常。头颅CT正常。

精神检查:

意识清楚,衣饰整洁,交谈接触好,定向力好,语言清晰、流畅。对问题回答不认真。未引出幻觉、妄想。无明显思维障碍。自述流浪生活很好玩,无拘无束,自由自在,生活丰富多彩,并能获得他人关心与爱护,在家只能受到处罚,父母关心的是考分多少,是否完成了作业,因此对家庭感到厌倦。当问及今后理想时,他一无所知,不能回答。注意力集中,谈话检查中患儿注意力能保持持久。记忆力未见明显障碍。智力正常,自知力存在,知道自己违反纪律,说谎,逃学,学习不好。情绪欠稳定,有时哭闹。自述愿意上学,未见冲动、怪异行为。

儿童行为量表(CBCL)结果:75;多动、违纪行为、攻击性行为问题突出。

(二) 病例分析

1. 临床表现特点

患儿的主要临床特点是:①男性,13岁。②以说谎,逃学,常夜不归宿为主诉。缓慢起病,逐渐加重,病史1年余。③家庭教育不统一,简单。④自幼好动,以自我为中心,任性,做事欠稳定。⑤精神检查未引出幻觉、妄想。无明显思维障碍。自述流浪生活很好玩,无拘无束,自由自在,生活丰富多彩,并能获得他人关心与爱护,在家只能受到处罚,父母关心的是考分多少,是否完成了作业。因此对家庭感到厌倦。当问及今后理想时,他一无所知,不能回答。注意力能集中,记忆力未见明显障碍。智力正常,自知力存在,知道自己违反纪律,说谎,逃学,学习不好。情绪欠稳定,有时哭闹。自述愿意上学,未见冲动、怪异行为。⑥查体和实验室检查无阳性发现。行为量表测试明显异常。

2. 诊断

按照ICD-10诊断标准(1992),品行障碍诊断标准须具备下列3项。

(1)发生于儿童少年期,持续半年以上。

(2)至少有下列行为中的一项。

- ①经常挑起或参与斗殴。
- ②经常故意伤害他人或虐待动物。
- ③经常故意破坏家里的东西或公共财物。
- ④故意纵火。
- ⑤经常偷窃。
- ⑥瞒过家长全天逃学,一学期3次以上。

⑦无明显原因离家出走,彻夜不归,至少2次。

⑧经常撒谎,并非为了逃避惩罚。

⑨其他触犯刑律的行为。

(3)不是其他精神障碍所引起。

本例诊断:

品行障碍

3. 鉴别诊断

由于某些精神疾病患者可出现品行障碍行为,故应在诊断品行障碍前,仔细收集病史及检查,以排除其他精神疾患。

(1)儿童多动症:多动症儿童也可出现一些行为问题,但以注意力不集中为主,而其行为异常表现比较轻。此患儿属多动气质,临床明显以行为问题为主,症状较严重,这些都与多动症不符,故可排除儿童多动症。

(2)儿童情感性精神病:儿童抑郁也可出现激惹和愤怒,并可采用杀人行为来达到自身求死的欲望。某些阶段性的破坏行为或偶发的抢劫、偷盗与轻躁狂有关。但儿童情感性精神病没有自知力,行为目的性较差,病程明显,与此病例不同。

(3)颞叶癫痫:某些神经系统疾病如癫痫儿童常出现的品行障碍及行为问题,某些颞叶癫痫精神运动性发作,发作中出现杀人、伤人行为,因此,在诊断品行障碍时,应注意排除以上疾病导致的行为问题。癫痫所致品行障碍,以发作性、盲目性为特点,发作后对发作时的情景不能回忆,一般脑电图异常。此病例脑电图正常,行为目的性明确,事后无遗忘,故可排除颞叶癫痫。

4. 治疗原则

儿童品行障碍行为及早发现,给以正面教育、调整环境,可望得到纠正。难于纠正者,可发展为青少年违法犯罪。品行障碍是多因素所致,而且有明显的人格异常倾向,因此,多种方法综合治疗、长期系统治疗是非常重要的。

(1)家庭治疗

①父母咨询指导:a. 父母管理训练(parent management training):这种方法基于这样一种理论,即由于父母对儿童的不良行为熟视无睹或者采用严格的惩罚来管理不良行为,这两种态度均鼓励及强化了儿童不良行为的发展。在父母管理训练中,反社会行为儿童的父母们应学习用适当的方法与他们的子女进行交流,学习用正面行为的强化辅以必要的轻度惩罚的方法;学会与子女用讨论及协商的方法进行教育。有关这种父母训练的研究显示这是一种颇有成效的方法,尤其是对那些具有一定攻击性行为的儿童。这种训练必须取得父母参加及合作。对那些父母

本身有这样或那样的问题而不可能参加持续性训练,本治疗就不可能实施。b. 家庭功能治疗(functional family therapy):本治疗是基于系统理论及行为心理学的结合而提出的。即不仅从个人也从整个家庭的角度来分析问题的存在。调查发现品行障碍儿童家庭成员间缺乏互相支持,本治疗旨在增加成员间的直接交流和互相支持。家庭功能疗法同父母管理训练法一样,从正面行为进行强化,帮助家庭成员间找到新的方法来解决他们的人际问题。这种方法也依赖家庭成员的积极性及合作。对严重品行障碍儿童本方法不那么适用及有效。

②家庭集体治疗:改善亲子关系,增强家庭相互支持功能。

(2)行为矫正

①解决问题技巧训练:针对症状,帮助儿童分析原因,考虑后果,找到解决问题的方法。本治疗是直接针对具有品行障碍儿童和少年的治疗方法。基于的理论是:品行障碍的儿童没有应用他们的认知能力去遏制不适当的行为。该方法试图帮助儿童发现问题、分析原因、考虑后果。最重要的是帮助他们发现解决问题的方法。

②自尊心、自信心培养:利用正负反馈技术,逐渐恢复已失去的自尊和自信。

(3)治疗躯体问题:如有问题要及时解决,同时注意营养,保证进食富含维生素和微量元素的食品。

(4)改善社会经济状况:咨询、联络等。本治疗旨在利用各社区内的优势帮助发展对社会有利的行为(Hamparian 1977)。其中较富有创造性的方法是与人学生或成人作“伙伴”,该伙伴既是朋友,又是顾问,也是行为样板。

(5)抗精神病药物治疗

①抗精神病药物,如氯丙嗪、氟哌啶醇、维思通等对冲动行为有一定效果,但考虑到药物的毒副作用和治疗的长期性,应慎用。

②锂盐、卡马西平、丙戊酸钠可用于控制攻击行为。

显然,品行障碍的治疗涉及家庭、学校、社会 and 医院,需要在儿童精神科医生的联络、指导下由父母、教师、社会工作者共同努力,采用多种治疗措施,持之以恒方能见效。

5. 本例思考

(1)品行障碍的临床特点是什么?

(2)品行障碍的诊断思路是什么?

(3)品行障碍应注意与哪些精神障碍鉴别?

第六节 儿童情绪障碍

一、理论基础

儿童情绪障碍(emotional disorders)是指发生于儿童少年时期,以主观痛苦和焦虑为特点,临床主要表现为焦虑、恐怖、抑郁和持续忧伤的一组疾病。其不同于一般的神经症性障碍,原因有四:①多数情绪障碍儿童至成年期并无明显的精神病理学预兆,说明两者之间并无连续性。②很多儿童情绪障碍是正常发育的极端,而其本身并无质的异常。③两者从理论假说上分析精神机制不同。④儿童期多种情绪障碍之间界线不清楚(ICD-10,1993)。

儿童情绪障碍的发生率在儿童精神障碍中占第2位,仅次于儿童行为障碍。其常见的类型有分离性焦虑症、恐怖症、学校恐怖症、强迫症和癔症。但这几种临床类型不易分型,常有重叠。

1. 焦虑症(anxiety disorder)

是在儿童时期无明显原因下发生的发作性紧张、莫名恐惧与不安,常伴有自主神经系统功能的异常。又可分为:①分离性焦虑:多见于学龄前儿童。当与亲人分离时深感不安而产生明显的焦虑情绪,担心亲人发生危险意外或自己被拐骗等。②过度焦虑反应:表现对未来过分担心、忧虑,不切实际的烦恼,常为一点小事儿影响情绪而惴惴不安。③社交性焦虑:当与人接触或谈话时会紧张、害怕、局促不安,尤其是当接触陌生人或在新环境中时更存在明显的社交和适应方面的困难。治疗以心理治疗为主,抗焦虑药物治疗为辅。

2. 恐怖症(phobia)

是指对某些物体或某些特殊环境明知不存在对自身具有真实的危险,却产生异常强烈的恐怖,伴有焦虑情绪及自主神经系统功能紊乱症状,并有回避行为以期达到解除恐怖所致的痛苦。常见类型有:①动物恐怖:儿童3岁后开始对动物产生恐怖,通常为单一动物类型,如鸟类、猫、狗、昆虫等。②特殊环境恐怖:如对黑暗、广场、高处、学校等特殊环境的恐怖。③社交恐怖:与人交往时产生恐怖,当时不能说话或做其他事情,有回避行为及自主神经系统功能紊乱症状。④疾病恐怖:对某些疾病造成的后果十分恐怖,以致情绪焦虑不安,进而延伸成对死亡的恐怖。治疗以心理治疗为主,抗抑郁剂及抗焦虑药治疗为辅。

3. 强迫症(obsessive compulsive neurosis)

是以强迫观念和强迫动作为主要症状,伴有焦虑情绪和适应困难的一种心理障碍。可表现为:①强迫观念:如强迫性怀疑、强迫性回忆、强迫性对立观念、强迫性穷思竭虑、强迫性意向。②强迫性动作:如强迫性洗手、强迫性仪式动作。③强迫性情绪:主要为强迫性恐惧,是对自己情绪的恐惧,害怕自己失去控制、会发疯、会做出出丑的事等。治疗以心理治疗合并氯丙咪嗪、帕罗西汀等药物治疗。

4. 癔症(hysteria)

是由精神因素导致的精神障碍。可分为:①分离性癔症:表现为情感爆发,如哭闹、屏气、冲动毁物,表演性自伤及四肢抽动,发作后可有部分遗忘。②转换性癔症:可表现为感觉障碍和(或)运动障碍,且易受暗示影响。③集体性癔症发作:表现为在集体场合下,一人发病后周围人目睹其发作情况,继之出现相同的或类似的发作。治疗包括心理暗示、电针治疗,小剂量安定及奋乃静等药物治疗,改善环境治疗等综合治疗。

儿童在发育过程中对各种有害因素反应较为敏感,尤其是遗传易感素质的个体受到不良环境因素的影响容易诱发疾病。对儿童时期来说关系最密切的环境就是家庭和学校,尤其对家庭环境依赖性更强,这种依赖不仅是物质的,而且是正常心理发育上的需要,需要父母的抚爱和支持,使他们得到安全感和信心去面对外面的环境和世界。当一个生命呱呱坠地后,他(她)要经历母乳喂养到人工喂养,从家庭内的抚养到集体托儿、入学、升学、转学以及抚养人的更替等,这些变动都客观地要求他们迅速地重新适应。如果家长过分保护、溺爱,会使儿童造成适应困难;如果家长对孩子苛刻要求,则会使儿童敢怒不敢言,久而久之只有恐惧、回避、自卑不安和抑郁。因此,关注儿童的心理发育,建立健全人格才是防患于未然的根本。

二、典型病例分析

(一) 病历摘要

患者陈某,女性,13岁,学生。

主诉:因强烈拒绝上学,对父母发脾气2个月于1999年11月入院。

现病史:患儿缘于1999年9月升中学后觉压力大,渐渐感到在早晨上学时非常紧张,出汗,头晕,恶心。而周六、周日则完全正常。曾就诊于当地医院,诊断不明,服用中药治疗(具体不详)。同年10月患儿因上学迟到遭老师批评而哭泣,上

课后不久腹痛而被送回家中。当受到父母关心后,患儿腹部不适渐减轻。次日,患儿反复整理书包不肯上学,家长见状强行送其上学。进入教室后患儿表情严肃,低着头走到自己座位上,不跟任何同学打招呼。放学后,患儿表现如常。当父母劝其明日应抓紧时间上学时,患儿一反常态:哭闹,大发雷霆。次日,非但坚持不去上学反而动辄便大发脾气,并自此闲于家中不肯上学。11月中旬,家长见患儿情绪略见稳定便劝其准备上学。患儿立即大哭指责父母:“你们太讨厌了!太烦人了!”并砸毁学习用具,将其母推倒。故家人将其送至北京市儿童少年心理卫生中心诊治。

既往史:否认重大躯体疾病史,否认外伤、手术史,否认药物过敏、中毒及成瘾史。

个人史:独生女,其母38岁方喜得千金,足月剖宫产,儿时发育正常,自幼娇生惯养,溺爱过度。7岁上学,成绩中等,1999年7月中考成绩不佳,经父母努力后于同年9月转至某重点中学。病前性格:内向,孤僻,胆小,固执,脾气大,任性,依赖性大。月经史:1999年2月初潮,末次月经:2000年11月25日。

家族史:父母两系三代亲属身体健康,否认有精神失常者。

体格检查:

未见明显异常。

实验室检查:

未见明显异常。

入院时精神状态:

意识清楚,各定向力完整,交谈初接触尚好,言谈切题,表情偏做作。当听到医生说近期不能回家时则大声哭叫、泪如雨下,将手中的随身听摔于床上。后经心理治疗及服用郁乐复25 mg/d,佳静安定0.8 mg/晚,2周后患者表现已较入院初情绪平稳,可礼貌与医生接触。

(二) 病例分析

1. 诊断与诊断依据

本例的临床特点有:①女性,13岁起病;病前性格:内向、胆小、依赖性大。②起病诱因:升入中学后压力大。③亚急性起病,病程2个月。④临床表现:拒绝上学,情绪不稳。⑤家族史阴性。⑥辅助检查:未见明显异常。

诊断思路及鉴别诊断:患儿系13岁女性,因父母高龄得女,溺爱有加,故过分依赖父母;目前正值青春发育期;因经非正规渠道转至某重点中学,面临功课增多、压力加大、重新适应新环境等应激而亚急性起病。表现最突出的症状是拒绝上学。

起初有焦虑,表现为躯体及自主神经症状:上学日紧张、头晕、出汗、恶心、腹痛,而在家则一切如常;被父母强制去上学后,表现紧张怯懦、被动退缩,恐惧心理异常严重;放学后如释重负;以后每当父母令其上学则会哭泣、吵闹、发脾气,甚至伤人毁物;始终不肯上学。少年女性出现上述情况应与逃学儿童鉴别,该患儿虽有逃学倾向,但其学习成绩中等并非很差,其伤人毁物乃情绪不稳、焦虑恐惧所致,并未见品行问题。故可看出其与逃学儿童有本质差别。

本例诊断:

学校恐怖症

学校恐怖症(school phobia)是儿童对学校特定环境异常恐惧并强烈地拒绝上学的一种情绪障碍,是恐怖症中的一个特殊类型。其发病年龄有3个高峰:5~7岁,可能与分离性焦虑有关;11~12岁,可能与升中学、功课增多、压力加大或改换学校重新适应新环境和人际交往困难等因素有关;14岁,可能与少年特征发育有关。该症以女性多见。

病因:①个性脆弱,过分依赖。该类儿童不能在精神、生活及学习上自立。②某些儿童因怕与父母分离(分离性焦虑)而拒绝上学。③学习困难,成绩不理想,缺乏克服困难的意志。④在学校受到挫折产生情绪反应,回避在家。

临床表现:起初为了达到不上学的目的,借头痛、腹痛或乏力等诉说博得家人同情允其不上学。当遭到反对强迫上学时,患儿表现哭泣、吵闹、焦虑不安、发脾气等,被父母送入学校后表现畏缩、孤僻、紧张害怕,甚至战战兢兢,心慌意乱,不敢正视老师,回答问题可出现口吃甚至站立不答。而放学后及节假日休息时则如释重负,看书游戏等都正常。

诊断标准:Bery、Nichols 和 Dritchard 对学龄儿童的学校恐怖症提出4条诊断标准:

- (1)去学校产生严重困难。
- (2)严重的情绪焦虑。
- (3)父母明知病儿在家是恐惧不去上学。
- (4)无明显的反社会行为。

2. 治疗

宜作综合治疗,以心理治疗为主,药物治疗为辅。

(1)心理治疗

①消除心理社会因素:查明产生学校恐怖的原因;与教师沟通消除紧张因素,增强学校的吸引力;与父母沟通避免强制,多加鼓励和支持,让家中同胞或邻居孩

子起示范作用。

②采用脱敏疗法,冲击疗法及认知行为疗法。

(2)药物治疗

①抗焦虑药:佳静安定、罗拉、安定等。

②抗抑郁药:小剂量多赛平,帕罗西汀等。

3. 本例思考问题

(1)学校恐怖的临床表现是什么?

(2)为什么将儿童和少年特有的情绪障碍和成人型神经病性障碍区别开来?

(3)儿童情绪障碍包括那几种类型?

第七节 抽动障碍

一、理论基础

+++++

抽动秽语综合征是一种慢性神经精神障碍的疾病,可不同程度地干扰损害儿童的认知功能和发育,影响社会适应能力,甚至可迁延致残。其发病率各家报道不一,为0.1%~0.5%,男孩多于女孩,男女之比约为(3~4):1,起病于2~15岁,平均起病年龄为7岁。

病因尚未阐明,近年研究认为可能与遗传因素(常染色体显性遗传,或多基因遗传等),神经生化因素(纹状体多巴胺能系统的多巴胺活动过度或受体超敏,去甲肾上腺素功能失调,5-羟色胺代谢失调,乙酰胆碱与多巴胺系统之间失衡, γ -氨基丁酸抑制功能降低,脑啡肽功能障碍等),脑器质性因素(脑室/脑及脑密度有异常,左侧基底节体积减少,脑电图慢波棘波增加,MRI弛豫时间不对称等),心理社会因素(本人受强烈精神创伤或其他重大生活事件的影响,母孕期反应及应激事件)及其他因素(可能与 β -溶血性链球菌感染,服用中枢兴奋剂)有关。

1. 临床表现

多数从眼、面肌开始抽动,逐步向肢体发展,涉及全身多部位肌肉抽动。抽动形式可能改变,症状起伏波动,可从一种形式转变为另一种形式,也可在原有症状的基础上增加新的症状。运动抽动或发生抽动可先后或同时出现。于精神紧张或身体疾病后加重,注意集中于某项兴趣活动、主观努力克制时可暂时减轻,睡眠时症状消失。此外还常伴发注意力不集中、多动、强迫思维或动作、冲动攻击、自伤行

为、学习困难、情绪障碍等。

2. 诊断标准

ICD-10 提出的 Tourette 综合征(抽动-秽语综合征)诊断标准如下:

- (1)起病于 21 岁以前,大多数在 2~15 岁之间。
- (2)有复发性、不自主性、重复的、快速的、无目的的抽动,影响多组肌肉。
- (3)多种抽动和一种或多种发声抽动同时出现于某些时候,但不一定必须同时存在。
- (4)能受意志克制数分钟至数小时。
- (5)症状的强度在数周或数月内有变化。
- (6)抽动 1 日发作多次,几乎日日如此,病程超过 1 年以上,且在同 1 年之中,症状缓解不超过 2 个月以上。
- (7)排除小舞蹈症、肝豆状核变性、癫痫肌阵挛发作、药源性不自主运动及其他锥体外系病变。

3. 治疗原则

综合治疗为原则。

(1)药物治疗

①氟哌啶醇:小剂量开始,1~2 mg 分 2~3 次口服,每日总量 1.5~16 mg,视疗效、年龄大小调整剂量,同时加服安坦以减少锥外反应。

②哌迷清:须监视心电图变化,小剂量 0.5~1 mg 晨顿服开始,少量增加,每日总量为 0.5~6 mg。

③泰必利:常用于症状轻者,100~400 mg/d。

④可乐定:对伴有注意力不集中和多动症状效果较佳。开始 0.037 5 mg,2 次/d,渐加至 0.075 mg,3 次/d。

⑤其他:如伴有强迫症状者可采用氟哌啶醇合并氯丙咪嗪或帕罗西汀等药物。

如伴有品行障碍、冲动攻击行为者可用丙戊酸盐。

如伴有自伤行为可用氟西汀、丙戊酸盐或纳曲酮。

如单一用药疗效不好时,可联合用药治疗。

(2)心理治疗

①对病儿:进行心理疏导及相反习惯训练等行为疗法。

②对家长及老师:进行心理咨询,取得合作,增强信心。

(3)针灸等中医治疗也可有一些辅助作用。

跺脚现象,常发出犬吠声,言谈较切题:“这两年来,我控制不住地眨眼、扭头,曾经好转过。可是上个月又重了,不是这抽就是那动,老师说我故意捣乱,同学笑话我,爸爸认为我不听话,可我不是成心的,我怎么办呀?我这毛病是该治,但是我不愿离开家,在家治就行了,我在这闷得慌,想家。”此时泪如雨下,并尖叫两声,情绪稍带焦虑。自此对医护工作较合作。

治疗经过:

经氟哌啶醇自小剂量用起至 8 mg/d,并配合安坦 6 mg/d 治疗。2 周后肢体抽动已基本消失,仅残留眨眼及轻哼声。

(二) 病例分析

1. 本患儿临床特点

- (1) 男性,12 岁。
- (2) 全身多部位不自主抽动,不伴意识障碍。
- (3) 伴不自主喉鸣,秽语。
- (4) 症状呈慢性过程,可波动,在原有症状基础上增加新的症状,总病程 2 年余。
- (5) 近期伴发焦虑等情绪障碍及自伤行为问题。
- (6) 体检及实验室检查无异常现象发现。
- (7) 氟哌啶醇治疗有一定效果。

2. 诊断与鉴别诊断

12 岁男童,出现全身多部位的抽动,应考虑与以下几种情况鉴别。

(1) 舞蹈症:该病多发于 5~15 岁儿童少年,以舞蹈样异常运动为特征,故应与之鉴别。但该患儿除肢体抽动外还有发声抽动,体检无发热、肌张力减低、关节肿大、风湿结节等风湿热体征。实验室检查:血沉,抗链球菌溶血素 O 结果正常,故不考虑小舞蹈症。

(2) 肌阵挛性癫痫:该患儿虽有肢体抽动,但其意识清楚,脑电图正常,不具有发作性特征,故可鉴别排除。

(3) Wilson 病:即肝豆状核变性,为铜代谢障碍所引起疾病,但该患儿体检未见角膜 Kayser-Fleisher 色素环,实验室检查肝功能正常,故可鉴别排除。

(4) 迟发性运动障碍:患儿无长期服用抗精神病药及突然停药史,故可排除此症。

本例诊断:

抽动-秽语综合征(Tourette 综合征)

3. 本例思考问题

- (1) 抽动-秽语综合征的临床特点有哪些?
- (2) 抽动-秽语综合征的诊断标准是什么?
- (3) 抽动-秽语综合征的治疗有哪些方法?

第八节 儿童行为障碍

儿童行为障碍(behavioural disorders of childhood)是一类发生于儿童日常生活中的行为障碍,如排泄、睡眠、进食和说话障碍等,并非由于器质性疾病所引起。本节就易误诊的儿童排泄障碍——遗尿症为例,提出诊疗要点和分析原则。

一、理论基础

+++++

功能性遗尿症(enuresis)指儿童 5 岁以后仍不能自主控制排尿,因而尿湿了床铺,或白天尿在裤子上,而又无明显的器质性病因。本症在儿童中的患病率较高,据估计,5 岁儿童约 10% 的有遗尿,10 岁儿童约 5%、18 岁的少年约 2% 有遗尿,在特定的成年人群如新入伍的水兵、新入学的大学生中,约 0.5%~3.8% 有遗尿,在遗尿患儿中,约 1 000 人中有 1 人伴有遗粪。本症男孩多于女孩,到 11 岁时男女发病比例为 2:1。

功能性遗尿症的病因目前尚未明确,一些研究表明,可能与遗传因素、睡眠障碍、婴幼儿时期排尿训练不良、强烈的应激因素及心理障碍有关。

临床表现:遗尿症可分为原发性遗尿及继发性遗尿两大类。原发性遗尿指从小到大一直尿床。继发性遗尿指 5 岁以前曾有一段时间已不尿床(至少 6 个月),5 岁以后又再次出现尿床。据调查,原发性遗尿占大多数,约 75%~80%。夜间遗尿最常见,约占 80%,以男孩多见;夜间遗尿者约有半数每晚尿床,甚至每晚遗尿 2~3 次,白天过度活动、兴奋、疲劳或躯体疾病后往往遗尿次数增多,夜间遗尿占 15%。日间遗尿较少见,约占 5%。约 2% 的 5 岁儿童每周至少夜间遗尿 1 次,8% 的 5 岁儿童每月至少夜间遗尿 1 次。随年龄的增加,遗尿症逐渐减少,在 12 岁儿童仅仅 1% 每月有 1 次夜间遗尿。遗尿患儿常常伴有睡惊、睡行症、多动综合征或其他行为障碍。

意识清楚,衣饰整洁,交谈接触好,定向力好,语言清晰、流畅。对问题回答认真。未引出幻觉、妄想。无明显思维障碍。注意力集中,谈话检查中患儿注意能保持。记忆力未见明显障碍。智力正常,自知力存在,情绪略低,有时紧张焦虑,交谈中,表现十分害羞,迫切要求医生治好他的病。未见冲动、怪异行为。

(二) 病例分析

1. 诊断及诊断依据

患儿的主要临床特点是:①男性,10岁。②以经常尿床,多处诊治无效为主诉。无明显原因,夜间尿床多年不愈,且伴紧张焦虑。③白天过于紧张,疲乏,心情不快时,夜间遗尿明显。④性格特点:比较内向,任性,以自我为中心,做事欠稳定。⑤精神检查未引出幻觉、妄想。无明显思维障碍。注意力能集中。记忆力未见明显障碍。智力正常,自知力存在,情绪欠稳定,有时哭闹。⑥查体和实验室检查无阳性发现。

诊断标准:

- (1)年龄在5周岁以上或智龄在4岁以上,觉醒时或入睡后,仍不能控制排尿。
- (2)5岁儿童每月至少有2次遗尿,6岁以上的儿童每月至少有1次遗尿。
- (3)不是由神经系统损害、癫痫、躯体疾病或服用药物(如精神药物、催眠药)所引起。

本例诊断应考虑:功能性遗尿症。此病诊断并不困难,关键是遗尿从表面上看是一种躯体症状,因此,要排除躯体疾病才可确定该诊断,如泌尿系统感染和畸形,尿路梗阻(包茎、尿道口狭窄),膀胱功能失调和低膀胱容量;隐性脊柱裂;神经系统疾病,如脊髓炎症、外伤或肿瘤所致的脊髓横贯性损害;癫痫,糖尿病及其他严重的躯体疾病,重性精神病或重度精神发育迟滞等所造成的对排尿不能自控。因此对遗尿症儿童必须作详细的检查,包括尿常规、尿糖,泌尿系统及神经系统的检查。同时要能透过遗尿这一现象找出心理症结。才能正确诊断,正确治疗。

本例诊断:

功能性遗尿症

2. 治疗原则

(1)习惯行为治疗:充分了解病史,分析造成遗尿的原因,给予相应的治疗措施。建立良好的作息制度和卫生习惯,掌握其尿床时间的规律,定时唤醒或使用闹钟,使之逐渐形成时间条件反射,能及时醒来排尿。此外,控制晚餐后任何形式液体的摄入量,以减少晚间的尿量。

(2)缓解精神压力:首先应了解可能存在的心理矛盾及可能导致遗尿的精神因素,对于可以解决的精神刺激因素,医师应指导父母予以解决,对于已经过去或无法解决的心理因素,则应指导患儿正确对待,帮助解除心理上的压力。

(3)药物治疗

①三环抗抑郁剂:作用机制不明,可能与抗抑郁作用、抗胆碱能作用及改善睡眠有关。常选用小剂量的丙咪嗪、阿米替林、去甲丙咪嗪、有效剂量 25~75 mg/晚,对大多数病人可使遗尿次数减少,服药后 1 周左右即可出现疗效,85% 的夜尿次数减少,30% 可以治愈。但停药后易复发,毒副作用大,特别是对心脏的毒性作用,有时可导致意外,故非万不得已,不宜采用。

②抗胆碱能药物,阿托品或东莨菪碱 0.1~0.3 mg,每晚睡前服 1 次,但疗效不如三环类药物。

(4)行为疗法:是目前治疗遗尿最有效的方法,且安全可靠,目前采用较多的是各种操作性处理技术,其中最常用的是 Finley(1973)提出的间断强化法,据此设计的电铃—电路方法,其疗效肯定、持久,治愈率可达 60%~80%。其具体操作如下:让尿床的患儿睡在一个特制的床单上,这个床单内放着分别用纱布包好的两个电极,电极的另一端分别与电铃或蜂鸣器及电池连结,当床单干燥时,电路不通,则电铃也不响,而当患儿开始遗尿时,少量的尿液就会使纱布潮湿导电,因此,可使其中的电路接通,唤醒患儿和(或)他的父母。若患儿未醒,父母应喊醒患儿入厕,并重新接好装置。多次应用后,患儿睡眠时,如果膀胱充盈,会自动起床入厕。治疗期间患儿应与父母同居一室,以便能经常唤醒患儿。因此,这类疗法必须得到家长及患儿的充分合作,且需治疗一段时间后才能显效,出现疗效后,每周给予巩固治疗 1~2 次。则疗效更能持续。

(5)中药及针灸治疗:中医的经典理论认为遗尿与肾、膀胱有关,提出用补肾法治疗,后世渐渐演化出许多方剂,如六味地黄丸等。还可采用针刺关元、气海、三阴交、大敦、膀胱俞、肾俞诸穴,每天针 1 次,取穴 2 对。对某些病例可有一定帮助。

3. 本例思考问题

- (1)功能性遗尿症临床特点是什么?
- (2)功能性遗尿症诊断思路是什么?
- (3)功能性遗尿症注意与哪些疾病鉴别?

严重程度标准:自知力丧失或不完整,且至少有下列情况之一。

- ①社会功能明显受损。
- ②现实检验能力受损。
- ③无法与病人进行有效的交谈。

病程标准:精神障碍至少持续 3 个月。

(二) 典型病例分析

1. 病历摘要

患儿于某某,男,12岁,于2000年5月27日入院。

主诉:患儿因精神失常9个月,失眠、呆愣、自语不上学加重1周伴语乱、生活懒散、不主动进食收入院。

现病史:患者于1999年7月因小事与同学闹矛盾、吵架,最后发生动手打架。回到家中自觉委屈,闷闷不乐,活动减少,目光发直,反应动作变慢,晚上睡不好觉,家人未注意。患儿继续上学,但老师反映患儿上课注意力不集中,经常发呆走神,眼睛不看黑板,自己唠叨什么似的,谁也听不清楚,学习成绩明显下降,2000年春节患儿突然整夜不睡觉,话多语无伦次,反复重复电视里武打片的内容,总提及与同学打架之事,干什么都没意思。家人带其到当地县医院服用神康宁治疗,约20天后以上表现基本消失,言谈举止正常如初,一直在家休息未上学。服用神康宁1个月后自觉症状好转而自行停药,于2000年3月20日症状复发且加重,异常兴奋、话多,自语明显,具体内容听不清,无法与之进行交谈,不理旁人,生活自理能力下降,不知道料理个人卫生,表情显得特别紧张害怕,浑身总打哆嗦,说话令人费解,什么“观音菩萨如来佛祖谁都不是好惹的”“观音菩萨保佑我,我怕什么”,话总是停不下来,都是一串串地出来,总是自己一个人嘻嘻傻笑,但周围并没有什么可笑的事情和话题。不待在家里总想往外跑,有时突然打开家中所有窗户,有时不让妈妈离开自己,甚至用绳子将妈妈的手与自己的手捆在一起,有时候双手上举像飞机一样,家人问他干什么也不讲话,令人费解。对家人感情疏远,没有礼貌,有时甚至对家人拳打脚踢。家人无法护理送来我院。门诊以“兴奋状态”收住。

既往史:体健,否认心、肝、肾等重大躯体疾患,无骨折、外伤及药物过敏史。

个人史:独子,母孕期体健,足月顺产,母乳喂养,生长发育无异常,7岁上小学,顺利读至初中,学习成绩优良,任班干部,与同学老师关系好,相处融洽。病前性格:内向,话少,孤僻,不爱活动,敏感,小心眼,遇事好想不开,耐心,老实。

家族史:父母两系三代内无近亲结婚史,无家族遗传病史,无精神病遗传史,无

懂,有的谈话断断续续的。年龄小者妄想少见,即使有也不固定,不系统,片段,零乱。代之以病理性幻想,其特点是内容荒谬离奇,与现实脱离,自身不能区分想像与真实,活动受幻想支配,自认为是幻想中的角色,沉溺其中,对客观事物不关心。此患儿就把现实与幻想混为一谈,认为自己生活在神话当中,自娱自乐,不能把幻想与现实区分开来,以至于用绳子把自己和妈妈捆在一起怕自己飞了。

③在情感方面最常见的是淡漠、表情呆滞,对家人疏远无情,对事物丧失好奇心。有的则表现紧张恐惧,无具体指向性,莫名其妙,常有无缘无故的情绪波动。

④年幼患儿常以行为异常为主要表现,如多动,刻板动作,违拗及古怪行为等。此患儿就在幻觉及病理性幻想基础上继发出一系列古怪离奇的行为表现。病程长达9个月余,不能适应正常的学习及社会生活,对病态无认识能力,排除了其他精神疾病,故应诊断为儿童精神分裂症。

(3)预后估计

儿童精神分裂症一般预后不佳,起病较缓慢,年龄越小,预后越差,自知力恢复不好,病程长,有阳性精神病家族史者预后较差,病前智力差者预后更差。随着精神科药物的使用,诊断水平的提高,特别是早期发现,早期治疗预后明显改善。

(4)鉴别诊断

儿童精神分裂症一般应与儿童孤独症、儿童躁狂症、脑器质性精神障碍及精神发育迟滞相鉴别。

①儿童躁狂症:是情感病的躁狂相,以兴奋躁动,情感高涨为特点。需与兴奋冲动为主的儿童精神分裂症鉴别。躁狂症情感活跃、高涨、兴奋,与思维内容及环境协调,而且有抑郁与躁狂交替发作的特点,而儿童精神分裂症表现为突出的精神活动的不协调,怪异,矛盾,与躁狂症不同。

②儿童孤独症:儿童精神分裂症也有孤独、情感及言语障碍,需与孤独症鉴别。儿童孤独症发病年龄较早,一般多起病于3岁之前,而儿童精神分裂症多起病于学龄期以后,孤独症有特殊的交往障碍和对环境的异常反应,感觉过敏或迟钝,对事物变化具有强烈的抵触倾向。普遍伴有智力低下,无儿童精神分裂症的幻觉妄想、联想障碍,孤独症一般没有明显的发病时期,故可鉴别。

③脑器质性精神障碍:脑器质性损伤如病毒性脑炎,可以首发精神症状,出现精神运动性兴奋或抑制,伴幻觉妄想等,易误诊为精神分裂症。但此类病人病前常有躯体异常症状如发热、抽搐,细致检查可发现意识障碍,注意、记忆、定向障碍及大小便失禁,神经系统阳性体征及脑电图或CT等异常表现,可与精神分裂症鉴别。

④精神发育迟滞:儿童精神分裂症由于与外界隔离,常可出现智力及社会适应问题,应注意与MR鉴别。MR属发育迟滞,没有明显的发病时期,且病程不是进行性,常伴有躯体发育异常或畸形,可有神经系统体征,而无幻觉妄想、思维混乱及怪异行为,可资鉴别。

(5)治疗

儿童精神分裂症的治疗应采取综合治疗的措施。需要药物治疗,心理治疗,家庭治疗和教育训练相结合。

①药物治疗:儿童精神分裂症的治疗以药物为首选。大多数精神症状只有通过药物才能改善。在精神分裂症的早期或精神症状明显阶段应给予积极的抗精神病药物,最好住院治疗。根据病情及病人状况,选用不同的药物。目前抗精神病药物种类较多,至今已有高效、速效、长效多种药物,达数十种。但其药理作用大体相同。只是剂量大小,作用强弱和毒副作用轻重不同而已。治疗应充分系统,一般从小剂量逐渐加量到一定的治疗量,维持治疗约2个月,视病情缓解而逐渐减量,减至最低有效治疗量停止减少(一般为治疗量的 $1/3 \sim 1/4$),依次减量巩固治疗数月或数年,一般为2~3年或更长时间,则可避免或减少复发。

各种抗精神病药物的采用,要根据症状的性质个体差异、疾病的阶段,如果儿童精神分裂症具有急性兴奋躁动特征者,可选用氯丙嗪、甲硫达嗪、奋乃静、氟哌啶醇、维思通、奥氮平等。对退缩淡漠者可选用三氟拉嗪、氯氮平,对缄默甚至木僵患儿则可采用舒必利。新药维思通是一种5-HT和多巴胺平衡拮抗剂。15岁以下儿童需在严密观察下谨慎使用。维思通对精神分裂症的阴性和阳性症状均有显著疗效,另外,五氟利多等长效抗精神病药12岁以下的儿童禁用。

抗精神病药物有治疗作用,但当药物达到有效治疗量时会产生一些毒副作用,如头昏、眼花、嗜睡、乏力、心动过速、皮疹、锥体外系反应(如肌张力增高、反应迟钝、肢体震颤等),甚至白细胞减少、中毒性肝炎等,一般采取减量或停药或增加小剂量抗胆碱能药物,如安坦 $1 \sim 2 \text{ mg}$ 每日2~3次。如果治疗4~6周精神症状无改善,可考虑调换药物,一般不主张联合用药,因为这样做毒副作用较多。治疗过程中切忌不规律服药或骤停药物,药物治疗过程中还要定期查肝功能、血常规及心电图等,以防止躯体毒副作用。

②家庭治疗:为了使患儿及其家庭正确了解这种疾病,使患儿的社会功能损伤降到最低,从开始就应给他们个别的和集体的指导和支持。开始时由于患儿不合作,故沟通起来可能会有困难,因此需要耐心,让患儿及家长正确认识此病,采取积极配合的态度,这样有利于保证患儿按要求服药,而且可以帮助患儿父母发现和处

理一些不可预知的情况。

③心理治疗:这里指的是广义的心理治疗,包括心理支持、行为矫正、工娱治疗以及教育训练等。根据疾病的不同阶段,采取不同的方法。

a. 急性住院阶段:要尽量创造安静舒适的生活环境,医护人员要与患儿建立良好的医患关系,这样有助于消除患儿对新环境的紧张恐惧,做好耐心细致的护理工作,在生活心理上给患儿一个良好的支持,使其他治疗能够顺利进行。

b. 稳定治疗阶段:急性期过后(一般住院后 10 天),组织患儿参加学习、文娱、游戏等简单的劳动,激发患儿对生活的兴趣,转移其对症状的过分注意,使其逐渐正确认识疾病,增强适应环境的能力,更好地配合药物治疗。

c. 恢复阶段:支持性心理治疗适用于精神分裂症恢复期的患儿,对其病态的精神活动进行理性教育,如疏导等,提高其对疾病的认识能力,消除不健康情绪,端正对待所患疾病的态度,树立向疾病做斗争的信心,同时教给患儿父母巩固疗效的方法。在治疗过程中,不能忽视对患儿进行培养教育,内容包括文化、知识学习,组织纪律的培养,道德品质和文明礼貌以及培养良好的生活习惯,避免过分包办代替。对年龄小的儿童安排好进入学校学习的时机和相应的准备工作,年龄大的青少年患者,需加强生活技能及职业技能训练。通过教育能密切其与周围人的关系,恢复正常人际关系和社会适应能力,通过积极的康复训练、教育对病儿的康复及回归社会有特殊的效应。

二、儿童情感性精神障碍

(一)理论基础

儿童情感性精神障碍,顾名思义是指儿童在情感方面的精神异常,是一组以情感高涨或低落为主要症状的精神疾病。临床特点表现为躁狂、抑郁交替发作,单相发作或者混合型发作,伴有言语思维和行为方面的改变。在缓解期间精神活动正常,具有缓解和复发的倾向。该病在儿童期较少见,但是近年来其发病率有上升趋势。我国报道的发病年龄最小的是 10 岁,男孩多于女孩(4:1)。临床上的病态表现以兴奋话多居多。该病目前无明确的致病因素,较多方面的报道提示可能与脑功能和脑结构改变、遗传基础,以及与中枢神经传导介质尤其是去甲肾上腺素和 5-羟色胺有密切关系。另外随着当前社会发展变化,重大的生活事件、童年期不幸遭遇、缺乏社会支持等因素影响,均可能在原有遗传素质的基础上促使发生情感性

障碍。

儿童情感性精神障碍包括两种类型:躁狂症和抑郁症。前者以情感高涨、兴奋、狂躁为主,后者以情绪低、语慢、行为障碍为特点,二者常交替出现。

躁狂症的诊断要点:持续 1 周以上的情感高涨或易激惹,表现具备以下各项中的 3 项:①言语增多;②联想加快;③注意力不集中;④自我评价过高;⑤感觉自我良好,精力充沛;⑥睡眠减少,无疲劳感;⑦活动明显增多;⑧性欲亢进;⑨行为轻率,不顾后果。

抑郁症的诊断要点:以心境低落为主持续 2 周以上,具有以下各项中的 4 项表现:①无兴趣及愉快感;②精力减退明显,疲倦;③动作迟缓;④自我评价过低,自责;⑤联想困难,脑子迟钝;⑥自杀自伤念头及行为;⑦失眠早醒;⑧体重减轻;⑨性欲减退明显。在儿童还常伴有一些多动、不听话、不遵守纪律、捣乱、攻击别人、打架逃学的行为。对于年龄偏小的儿童还可伴有许多躯体不适,如食欲下降,体重减轻,头痛胃痛,疲乏,胸闷气短等。

儿童情感性精神障碍的诊断主要是依靠详细的病史、体格检查及神经系统检查、精神检查和临床观察。诊断步骤首先应全面了解病史,包括孩子的生长发育、学习情况、家庭及社会背景、亲子关系、适应能力、躯体情况、性格特点及有无重大精神刺激等。

在此基础上由医生对患儿进行详细的精神和躯体检查。由于儿童言语表达情感体验能力差,医生主要通过观察其面部表情、姿势、动作、词语量、语词和活动来综合判断,要结合病史反复验证,排除干扰因素,最后确定诊断。必要时可作辅助诊断,主要是排除器质性疾病,如可作头颅 CT、脑电图检查等。

(二) 典型案例分析

1. 病历摘要

患儿张某,男,15 岁,学生,初中二年级,汉族。

主诉:因抑郁、发呆与兴奋、话多交替发作 5 个月,近几日彻夜不眠、打人摔东西而入院。

现病史:患者于 1998 年 9 月起无明显原因经常呆愣不语,家里人与他说话,患者好像没听见一样,坐着发呆。其父亲让他去扫地,他慢慢腾腾半天也扫不完。同年 10 月起出现胆子特别小,家里来了很熟的客人也躲着不见。自己一个人躲在储藏室里,家里人怎么叫也不出来。有时父亲从外地回来也不敢见。整天愁眉苦脸,对什么都不感兴趣,父母让他去看电影他说没意思,对精彩的电视节目也失去了以

往的兴趣。对丰盛的饭菜也觉着没胃口。饭量持续下降,身体逐渐消瘦。患者在这段时间里学习成绩急剧下降。同年10月后已不能继续上学。患者的这些异常表现在上午较严重,晚上明显减轻。

1999年1月起患者无原因地突然转忧为喜,整天有说不完的话,从不在家呆着,在外面乱跑,爬到3米多高的墙上往下跳。骑着自行车在马路上横冲直撞,见到汽车也不躲让,胆子特别大。自己说心情特别好,将来要干一番轰轰烈烈的大事业。夜里不睡觉,一会儿学外语,一会儿学音乐,一会儿又要帮家里洗衣服。觉得食欲特别好,吃得特多,身体一天比一天强壮。当姐姐批评他学习不好时,他大发脾气,拿起罐头瓶将姐姐打伤。总向父母要钱。去饭馆吃饭一次吃几十串羊肉串,并慷慨大方地请好朋友一起吃,称自己有的是钱。喜欢找女孩玩,有时在女孩家呆着不走,被人家轰走还会去找人家。近几日患者彻夜不眠,暴跳如雷,打人摔东西,在家中无法护理,遂于1999年2月8日被强迫送入我院治疗,门诊以“躁郁性精神病”之诊断首次收住院。

既往史:1岁时曾患“缺钙”,经治疗痊愈。平时体健,余无异常。

个人史:北京出生,同胞4人,行4,母妊娠期及生产过程无异常。足月顺产,牛奶喂养,出生后缺钙,2岁时才会走路,学说话正常,少儿期发育正常,父母从小对他娇生惯养,患者从小时起常说一不二。8岁上学,学习成绩差,上课时常做小动作,不认真听讲,三年级时开始逃学,小学未留级。上初中后学习成绩仍很差,有时逃学,1998年10月学校认为他有病,建议他休学治疗,以后一直未复学。病前性格:平时家庭关系较好,对父母较尊敬。内向,不爱说话,不善交际,朋友较少,固执,脾气暴躁任性。

家族史:阴性。父母与3个姐姐均体健,家庭成员关系一般。

体格检查:未见异常。

精神检查:

意识清楚,定向力完整,知道这里是安定医院,由父亲送来住院,知道现在是1999年2月8日,周围穿白大褂的是医务人员,能说出自己的姓名和年龄,自行步入病房,衣着整洁,年貌相符。入病房后主动向医生与护士敬礼,并说同志们辛苦了,表示听医生的话,帮助其他病友。在病房内四处走动,与其他病友聊天,手舞足蹈,一会就招来一群人围着他,患者更显得高兴,说得更起劲。饮食好,失眠,服镇静药后才能入睡,生活能自理,大小便正常。未引出感知觉异常,无幻觉。语量多,滔滔不绝,声音高,语速快,难以打断,经常旁征博引,高谈阔论。内容连贯而切题。

谈话内容如下:

问：“你今年多大了？”

答：“我今年15岁，明年16岁，你看我像不像二十几岁的小伙子，壮不壮，我能力举千斤，中国举重队要是收我，让我去比赛，准拿金牌，你知道金牌是真的还是假的吗？我知道，那金牌是镀金的，并不值钱。我家有真金的戒指、项链，99%的纯金，可值钱了，你知道我有多少钱？我有一万元……”

问：“你现在情绪怎样？脑子好使吗？”

答：“我情绪可好了，我觉得非常愉快，心理特高兴，无忧无虑。我能学各种知识，上大学。不，我不上大学，我要当运动员，你知道马拉多纳吗？他是足球明星，是踢球的。中国队太臭了，输给香港队，那场球我看了，我哭了，要是让我去，准输不了。我还可以做电影明星，去拍电影，我喜欢武打片，我要练功，功夫不负苦心人，拍成武打片后，去香港台湾放映，我要拿奥斯卡奖。”

问：“你以前有没有情绪不好的时候？”

答：“有，有时候情绪低，胆小，不愿见人，总不想动，乏力，脑子不好使，不想说话，没食欲，什么都不想干。现在可不是了，自己全变了，就像变形金刚，我是擎天柱……”说着，表演变形金刚中汽车人擎天柱的动作。

从以上对话中看出患者有明显的语量多，语速快，联想过程加快。患者思维内容丰富，多幻想，不荒谬。有明显的夸大观念，过高评价自己，高傲自大，自命不凡，夸大自己的健康，觉得自己有过人的才华。注意、记忆、智能均正常。自知力缺失。患者否认自己有精神病，对自己目前所处的精神状态不能正确判断和认识。谈话过程中表现欢欣喜悦，轻松愉快，说话时眉飞色舞、喜笑颜开，自诉内心十分愉快，没有什么忧愁和烦恼，干什么都有信心，也不怕困难。谈到前些日子曾情绪不好时，表现出伤心忧愁，但很快恢复原状，思维与情感十分协调，并易引起周围人共鸣。有明显感染力。患者在病房整天忙个不停，对周围环境很快就熟悉，毫无陌生感。一会儿找其他病友聊天，一会儿又帮助护士干活，显得精力充沛。交谈中说自己要上大学，挣大钱干一番轰轰烈烈的大事业。食欲极好，吃得多。喜欢找护士聊天，表现病理性意志与低级意向增强。生活自理好。未见冲动、毁物及其他异常行为。

辅助检查：未见异常。

2. 案例分析

(1) 病例特点

- ①患者男性，15岁，病前性格内向。
- ②急性起病，逐渐加重，病程5个月。

类病态人格的表现,均可见于儿童精神分裂症。随着病程的进展,分裂症的核心症状包括思维联想障碍,分裂性不协调情感以及幻觉妄想等症状更加明朗化,可与儿童情感性精神障碍相鉴别。

②精神发育迟滞:精神发育迟滞伴有抑郁时,由于智力低,表达能力受到限制,因而不像一般智力正常的抑郁症患儿会表达自己的情感体验,故中、重度精神发育迟滞伴抑郁症的主要表现为忧伤和动作迟缓或激动不安,有一定言语表达能力的患儿,能够诉说其愉快的体验。精神发育迟滞伴躁狂症可表现与智力正常儿童类似的躁狂症状,智力低者其情感障碍主要表现为欣快,易激惹,活动增多,整天手忙脚乱,可出现自语和与思维不协调的症状。

③器质性或躯体疾病所致精神障碍:也可以产生类似躁狂或抑郁的表现,但一般应有较明确的致病因素、阳性体征和实验室检查结果,可资鉴别。

④反应性精神障碍:在儿童较为常见。在受到强烈精神创伤后可发生情绪低沉、悲伤哭泣,少数患儿可表现躁狂状态。一般发生与精神因素密切相关,持续时间短,以往无类似发作史,通过心理治疗一般恢复较快,可以与情感性精神障碍相区别。

(3) 儿童情感性精神障碍的治疗

在诸多的治疗方法中,药物治疗对于情感性精神障碍,尤其是躁狂症和重性抑郁症是最常用的和最重要的治疗方法,也是维持治疗的重要措施。药物治疗和心理治疗的综合使用则更有利于疾病的康复。

①躁狂症的药物处理原则:首选碳酸锂,一般为每天 30 mg/kg,从小剂量开始增加,出现疗效后不再增加剂量,应保持血锂浓度在 0.6~1.2 mmol/L。若已达到治疗剂量持续 2 周仍然无效,或出现严重毒性反应,应停药或换用其他治疗。药物治疗应在医生指导下进行,因锂盐的治疗剂量和中毒剂量接近,故应定期查血锂浓度,以便调整药物剂量,避免中毒反应发生。碳酸锂的常见毒副作用有:恶心、呕吐、腹泻、倦怠、双手细震颤、体重增加及口干、多尿、烦渴,偶可出现心电图的异常。当血锂浓度达到 1.5 mmol/L 时,即可出现锂中毒。典型的锂中毒表现为急性脑病综合征。具有不同程度的意识障碍,可伴有共济失调、构音不清、腱反射亢进、阳性锥体束征,随着病情的发展可出现血压下降、心律失常、肺部感染、少尿或无尿,出现昏迷。当血锂浓度超过 2.5 mmol/L 以上时可危及生命。锂中毒时无特殊解毒剂,主要治疗措施包括立即停药和清除过多的锂,以及支持和对症处理。碳酸锂对躁狂症有肯定的疗效,但是由于它的起效时间较慢,一般需 5~7 天以后才能发挥抗躁狂作用,所以对于急性躁狂、兴奋冲动症状明显者,必须及时控制症状,可选

用氯丙嗪或氟哌啶醇等抗精神病药物口服或肌肉注射,待兴奋控制后再改用碳酸锂治疗;或者以抗精神病药加用锂盐合并治疗,但此时锂的剂量不宜过大,待躁狂症状减轻时缓撤抗精神病药物,单用锂盐治疗。另外,近年来心境稳定剂如卡马西平、丙戊酸钠也被做为抗躁狂药应用于临床,疗效较好,毒副作用小,不易中毒,较碳酸锂更为安全。

②抑郁症的药物治疗:对于急性抑郁要积极用药物控制,以防自杀及不良后果发生。常用抗抑郁剂有单胺氧化酶抑制剂、三环类抗抑郁剂、四环类抗抑郁剂以及5-羟色胺再摄取抑制剂。目前临床常用的药物有丙咪嗪、阿米替林、多虑平、麦普替林等。用药一般从小剂量开始,逐渐增加至有效剂量。起效时间需3~14天,如临床上常用的丙咪嗪治疗,剂量范围在1.5~5 mg/kg,日剂量不超过150 mg,50 kg体重以上者,可以用到250 mg,每日分3次口服,血药浓度范围为150~300 mg/ml,病程至少2~4个月。选用一种药物治疗,如果1个月未见效,可以加用心境稳定剂,或改用其他药物。儿童服用三环类抗抑郁剂常见的毒副作用有:头晕、嗜睡、口干、瞳孔散大、便秘、视物不清、体重增加,最严重的毒副作用为心血管毒性,治疗过程中应定期作心电图检查。还应注意定期血药浓度的测定,以便及时调整用药剂量,避免药物的毒性反应发生。偶尔可出现易激惹、多动和攻击行为,6岁以下儿童应慎用。近年来,随着5-羟色胺再摄取抑制剂的问世,氟西汀、帕罗西汀、氟伏草胺、舍曲林等新型抗抑郁剂,也相继应用于儿童抑郁症。但尚属试验性阶段,需细心观察,谨慎调整剂量。另外抗焦虑药常与抗抑郁药联合使用,因抗焦虑药现已被证实也有抗抑郁作用。常用的药物有阿普唑伦、氯硝安定。阿普唑伦每日每kg体重0.05 mg,最多不超过0.1 mg。亦可每晚服用0.4~0.8 mg。

儿童情感性精神障碍的治疗除了药物之外,心理治疗也很重要。主要是消除儿童的心理负担,改变患者的价值观念,增强自信心,根据病情变化及时进行行为指导。另外,暂时离开有精神刺激的场所(学校、家庭)。最好能住院治疗,向家长介绍关于疾病的一般常识,要求患者父母给予关心和照顾,尽量创造一个良好的家庭治疗和康复环境。对于病情较严重的儿童,在住院治疗病情控制稳定之后,回到家中应指导其父母定期门诊复查病情及血药浓度,调整药物剂量,做好维持治疗十分重要。千万不要随便停药减药,应遵医嘱而行。

3. 本例思考问题:

- (1) 儿童情感性精神障碍的诊断程序如何?
- (2) 儿童情感性精神障碍的主要药物治疗有哪些?
- (3) 在碳酸锂治疗的过程中应注意哪些问题?

第十节 思考与分析

儿童精神医学(child psychiatry) 近百年来已逐渐成为精神医学的一个独立分支,这是因为各学科的发展,特别是神经生理学、儿童心理学以及行为科学使人们日益明确儿童不是成人的简单雏形,而是具有一定特点的特殊人群。因此,儿童精神障碍的表现、诊断和治疗均有其特殊性。

一、客观与主观性

+++++

儿童精神障碍的诊断主要是临床诊断,亦称为临床现象学诊断。临床诊断的主要依据是可靠的病史及检查,因此,病史来源的客观准确和丰富正确的临床主观经验的结合是正确诊断与处理儿童精神障碍的重要条件。而正确地掌握收集病史及检查的方法,能正确地评估手头的资料,是一项技巧性很强的工作。因此,正确收集与分析病史及进行精神状况检查,是从事儿童精神卫生临床及研究工作的基础。

二、发展变化性

+++++

儿童正处于成长和发展的时期,婴儿(0~1岁)、幼儿(1~3岁)、学龄前(3~7岁)、学龄初期(6~12岁)和学龄中期(11~15岁)的儿童生理和心理社会发育水平不同,各自具有其年龄特征。儿童精神疾病也因发生的时期不同,也各自有其年龄特征。儿童精神疾病发生的年龄阶段及其年龄特征的研究,对探讨病因、评估临床年龄特点以及预后和结局,以至作出诊断及拟定治疗措施均有重要意义。

1. 病因学年龄特点

儿童的精神发育障碍在出生时或出生不久就显现出来,提示在病因学中生物学因素占主导地位。儿童孤独症起病于出生后至30个月内,虽对病因进行了多方面的研究,但至今未能阐明。根据其起病年龄及伴有智力发育落后,多数学者相信生物学因素是主要因素。随着儿童年龄的增长,受到的环境影响愈来愈大,儿童的情绪障碍和行为障碍的发病率也愈来愈高,心理社会因素在发病中占的成分也愈大。可见,生物学因素和心理社会因素由于精神疾病发生的年龄阶段不同所占的成分亦不同,但也要看到,不少儿童精神疾病则是两者共同作用的结果。

2. 临床表现的年龄特点

多动症在3~5岁以前表现全身活动过度,且以粗大活动过度为主。到了6~7岁以后,则常以细小活动过度为主,如上课时小动作不停和屁股在椅上扭转,而且在有限制的环境下,如教室、家中来客和就餐等时,则动得格外厉害。到青少年时期,活动过度就自然减少。又以儿童精神分裂症为例,年龄越小则无妄想,多为病理性幻想,随着年龄增大则向妄想过渡。感知障碍在幼小儿童以幻视、幻触和幻嗅等较常见,内容简单而原始;年龄较大者则以幻听为主,内容由简单而复杂。这是不同年龄阶段其神经系统成熟程度不一的特征表现。

3. 神经系统发育过程的年龄特点

不少儿童神经发育障碍属于成熟延迟所致。随着儿童的年龄增长,这些神经发育障碍会逐渐减轻,以至消失。如功能性遗尿,5岁儿童的普通患病率在男孩为7%,女孩为3%;10岁男孩为3%,女孩为2%;到18岁,男性为1%,而女性为0。又如口吃,以3岁时最多见,到9岁后则无新发生者。由此说明,不少神经发育障碍常随着年龄增长而变动,年龄到18岁以后,这种变动就少见了,也说明这时神经发育已经成熟。

4. 儿童神经系统脆弱性和代偿性特点

婴幼儿期是大脑发育变化较大的时期,不仅体积增大最快(新生儿的脑重约390克,到9岁时增加至660克),且神经突触不断增加和纤维髓鞘化日益完善。这时神经细胞十分脆弱,极易损伤。可另一方面,未成熟脑组织的代偿性也高,如婴幼儿脑对缺氧特别敏感,易遭损害,但若治疗及时和护理良好,常因代偿而使损害减轻。又如2岁左右幼儿已养成控制小便的习惯,但尚不稳定,一旦受惊或精神紧张时,又发生遗尿。当精神紧张消失后,小便控制就很快恢复。至于小儿的行为问题和不良习惯,因性格尚未定型,可有较大的可塑性,而容易矫正。儿童期各种精神疾病几乎有一共同特点,即发现越早,治疗效果越好。反之,则代偿功能已大大减低,治疗效果就很差。

总之,不同年龄的儿童有不同的生理和心理特点。如自言自语、自笑,在成年人提示有精神分裂症的可能,但对学龄前儿童来说,正常儿童独自玩耍时自言自语、自笑是常可见到的;再如,3岁以前的儿童尿床是常事,而10岁以上的儿童仍然经常尿床则考虑为病态,很可能是儿童功能性遗尿症。另外,同样年龄的儿童,其智力与能力的差别也很大。在不同智力和发育水平的儿童,精神症状的表现也有差别,如同样是儿童精神分裂症,智力正常与智力低下儿童表现出的症状也有明显区别,前者可表现出明显的思维障碍;而后者可能以愚蠢幼稚行为为主,因此,在

作出儿童精神障碍的诊断之前,一定要考虑年龄和发育因素。

三、因果关系不明确

由于儿童尚处于生长发育阶段,神经系统发育尚未完善,因此,同一病因可导致不同症状,如肝豆状核变性,可以首发精神症状,也可以以肝炎等躯体症状为首发表现。另外,不同病因亦可出现相同的表现,如多动症状可为许多儿童精神障碍的共同表现形式之一。

四、儿童精神症状的特殊性

儿童精神障碍多以情绪和行为异常为突出表现,即使是以思维障碍为主的精神分裂症也与成人明显不同。常首先表现出情感和行为方面的异常,如孤僻退缩,对亲人不亲,冲动、怪异行为,往往给人一种不听话的感觉。至于思维方面也与成人有所不同,儿童常以形象思维为主,表象突出,如病理性幻想常见于儿童精神分裂症,而成人没有。

五、儿童精神障碍的治疗特点

综合治疗是儿童精神障碍治疗的重要原则。儿童精神疾病的病因常是生物学因素和心理社会因素共同作用的结果,这些因素在病因中虽有主次之分,但治疗总以生物、心理和社会诸方面的综合治疗为宜,因此,不应单纯依靠药物和手术等治疗,亦应重视心理治疗、训练和教育、家庭和环境治疗等。应突出地体现儿童精神科医生、护士、心理学家、社会工作人员、教师、儿童保健人员的相互配合、协同工作的重要性,家长在其中也将发挥积极作用。

(郑 毅 杨建虹 梁月竹)

精神活性物质与非依赖性物质 所致精神障碍

一、精神活性物质所致精神障碍

精神活性物质或称为成瘾物质,该类物质可影响用药者精神活动并使之形成瘾癖即药物依赖。常见的精神活性物质有酒类、鸦片类、大麻、催眠剂、镇静剂、抗焦虑剂、麻醉剂、兴奋剂、致幻剂和烟草等。药物依赖主要由多次重复使用而形成,也可由长期治疗而引起,后者常被称为医源性成瘾。这类物质可导致依赖综合征、戒断综合征、精神病性症状和情感障碍、智能障碍、遗忘综合征和人格改变等各种精神障碍。

(一) 药物滥用及药物依赖

1. 药物滥用临床特点及诊断标准

(1) 药物滥用临床特点

药物滥用(drug abuse)一词中所指的药物包括各种成瘾药物,由非法制造或由医疗用药经违法途径转化为非医疗目的药物常被称为毒品。由于有些人滥用的并

非药物,而是一些化学物质(如烟草、酒、挥发性溶剂等),故亦使用“物质滥用”(substance abuse)这一内涵更为广泛的名词。

药物滥用系指反复、大量地使用某种(些)具有依赖潜力的药物,其用药行为不具有医疗或科研目的。用药者往往采用自身给药的有害使用方式,且会导致药物依赖性的形成。药物滥用与通常所称之“用药不当”不是同一含义。

(2) 药物滥用诊断标准

1) 以有害的方式使用某种物质以致临床上出现明显的痛苦烦恼或功能缺损,表现为在 12 个月之内出现下列 4 项中的 1 项以上者。

① 由于多次应用某种物质而导致工作、学业或家庭的失责或失败(例如由使用物质而多次旷职或工作表现差,旷课、停学或被除名;忽视子女或家务)。

② 在对自身可能有危险的场合多次应用某种物质(例如在应用物质后运动功能有缺损时驾驶汽车或开机器)。

③ 多次发生由于使用某种物质而出现违法问题(例如因应用某种物质后品行不端而被拘捕)。

④ 尽管由于某种物质的效应而导致或加重了一些已经持续存在的或曾经多次发生的社交或人际关系问题,但仍然继续应用该物质(例如与配偶为酗酒造成的不良后果争吵,甚至打架)。

2) 目前症状表现尚不符合该物质的物质依赖诊断标准。

现时也有人主张将药物滥用一词代之以有害使用(harmful use)。

2. 药物依赖临床特点及诊断标准

(1) 药物依赖临床特点

药物依赖(drug dependence)也称为药物成瘾(drug addiction)。由滥用药物过渡到强制性地以有害方式使用并形成躯体依赖和精神依赖状态时即形成药物依赖。躯体依赖以突然停药后出现戒断症状为标志,精神依赖则表现为对药物的强烈心理渴求。

(2) 药物依赖诊断标准

目前做出药物依赖性的诊断时,更强调精神依赖的形成和与之相关的行为表现。符合以下条件时可以诊断为药物依赖。

以有害的方式使用某种物质以致临床上出现明显的痛苦烦恼或功能缺损,表现为在 12 个月之内出现下列 3 项以上者。

1) 耐受性,表现为以下二者之一。

① 需要明显增加剂量才能达到中毒或所需效应。

⑤瞳孔扩大,汗毛竖起或出汗。

⑥腹泻。

⑦呻吟。

⑧发热。

⑨失眠。

上述戒断症状可导致明显的痛苦烦恼,或在社交、职业等方面的功能缺损。

(2)治疗原则:①停止使用阿片类药物。②药物治疗。

1)美沙酮替代递减治疗

剂量:重度依赖者(每日海洛因滥用剂量超过1 g),美沙酮替代剂量为30~40 mg/d,轻、中度依赖者美沙酮10~20 mg/d,分1次或2次服用。理想的治疗剂量应当既控制戒断症状又不产生美沙酮的过度镇静等毒副作用。

递减过程:递减原则应该是先快后慢,开始撤药时每日递减药量的20%左右,减至10 mg左右时改为每1~3日减1 mg。大多数人能在3~4周内完成脱瘾。美沙酮与其他阿片类药物同样具有成瘾性,无限制地延长治疗时日将不可避免地使海洛因成瘾者成为美沙酮依赖者。

注意事项:服药应在工作人员的监督下服用,以防药品流失。开始服用美沙酮应距末次滥用阿片类药物6小时,以避免两药的协同作用。

2)可乐定脱瘾治疗

可乐定是 α_2 肾上腺素能受体激动剂,其主要作用部位在中枢,可以抑制撤药后出现的流泪、流涕、打哈欠、骨肌肉酸痛、恶心、呕吐、厌食、出汗、寒战、焦虑、心动过速等症状。服药后0.5~2小时上述症状缓解。

疗程:为10~12天。

剂量及剂量的调整:成人一般使用剂量为20 $\mu\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{d})$,最高日量为1.0~1.2 mg。可乐定最高剂量的治疗时间应维持3~4天。第1日剂量不宜过大,约为最高剂量的2/3,第2日加至最高剂量,3~4天逐渐减量,每日递减10%。

注意事项:①可乐定的服用剂量应根据脱瘾者的年龄、健康状况、滥用药物剂量、戒断症状的严重程度及患者对于药物副毒作用的耐受程度等具体情况进行调整。②可乐定有降血压作用,服药期间应卧床休息,护理人员陪伴,以免由于体位性低血压而摔伤。当血压低于80/60 mmHg、心率低于50次/分时应减低用药剂量。

3)纳曲酮预防阿片类依赖复发治疗

盐酸纳曲酮为吗啡受体长效竞争性拮抗剂,能产生对阿片受体的主、客观上的

阻断效应达 24~72 小时。

治疗前准备:纳曲酮治疗要求用药者绝对中断使用阿片类药物 7~10 天之后进行,此时尿液吗啡检测结果应为阴性。纳曲酮治疗前肌肉注射纳络酮 0.8 mg,观察戒断综合征 45 分钟,如未出现戒断症状,治疗方能开始。

剂量及剂量调整:纳曲酮开始剂量为 5~10 mg,如出现戒断症状则治疗应推迟,如未出现戒断症状可每日增加 5 mg,巩固治疗用量为 50 mg/d。

疗程:原则上,只要有复吸的可能就应施行这项治疗。一般应维持治疗半年以上。

2. 阿片类中毒

(1)诊断:正在使用阿片类药物或刚使用以后,出现瞳孔收缩(或因严重超量而缺氧以致瞳孔扩大),呼吸抑制,嗜睡或昏迷,言语含糊不清,注意或记忆缺损。尿液或血液吗啡检测可为阳性。

(2)治疗原则

①立即停止用药。

②以口服方式用药者应洗胃。

③保持呼吸道通畅,必要时吸氧。

④药物治疗:吗啡拮抗剂纳洛酮:静脉推注 0.4~0.8 mg。如果呼吸功能改善不明显,每 2~3 分钟重复一次。纳洛酮作用持续时间较短(1~3 小时),而阿片类药物(如美沙酮)作用持续时间较长,可再度进入昏迷,此时可给予 1 000 ml 液体中加如纳洛酮 4 mg,维持 12 小时,或每 2~3 小时重复注射 0.4~0.8 mg。

3. 典型病例

现病史:患者黄某某,男性,26 岁,于 16 岁与朋友聚会时(1990 年),朋友给其一支夹带有海洛因的香烟,吸用后出现恶心、呕吐、头疼,随后出现舒适和放松似飘飘欲仙的感觉。病人出于好奇,持续使用,约 10 天左右病人停用这种夹带有海洛因的香烟后,出现哈欠,流泪,流涕,无力,出汗,寒战,骨肌肉疼痛,心情烦躁,失眠等不适症状。2 到 3 个月后自觉快感出现不如以前明显,随即开始加大海洛因的使用剂量。尽管剂量不断增加,但在半年后快感消失。此时,每日使用海洛因滥用剂量达 2 g。为增加用药效应,患者将使用方式改为烫吸。每日使用 4~5 次,否则病人即出现上述的不适症状,快感已经不如开始时强烈,仅仅持续极短的时间,或者不出现。为能更快地缓解不适,病人于 1993 年开始静脉注射海洛因,每日使用剂量为 1~2 g。

病人自开始使用海洛因至今 10 年间,先后 10 次自己停药或者住院脱毒,但均

因种种原因如失眠、烦躁,或者一些不顺心的事而再次开始使用海洛因。10至20天内滥用剂量即恢复到每日1g。

病人平素身体健康,否认重大躯体疾病史。自15岁起开始吸烟,无饮酒史。病人于1993年后无与他人合用注射器史,每次静脉注射前均不消毒。使用溶剂为矿泉水或白开水,根据当时情况而定。

体格检查:

病人发育良好,营养较差,消瘦。双上肢及双侧足背部可见注射痕迹,双上肢静脉呈条索样。

实验室检查:

尿液吗啡检测阳性,肝转氨酶高于正常,余未见异常。

入院诊断:

阿片类(海洛因)依赖

治疗:

美沙酮递减治疗。

(三)酒滥用所致精神障碍

1. 酒依赖与酒戒断综合征的治疗

(1)酒戒断综合征诊断:曾经大量长期饮酒,停止或减少饮酒几小时或几天出现肢体震颤、激越、静坐不能、恶心、呕吐、大汗、易激惹、感知异常、幻觉等。严重者可出现震颤、谵妄或癫痫大发作。

(2)治疗原则

①不能仅仅着眼于生理症状,而要基于生物—心理—社会医学模式进行全面考虑,其完整的脱瘾治疗应包括脱酒治疗、预防复发及康复和后续照管等步骤。

②药物治疗:地西泮(安定)替代治疗,每日饮500克50%~60%(V/V)的白酒者,可用地西泮40~60mg/d,按病人的具体情况,如戒断症状轻重、躯体状况等,第1天常给予上述剂量的2/3~3/4。充分治疗剂量应维持2~3天,随后5~7天地西泮每日递减15%~20%。如果治疗期间出现抑郁情绪可在治疗期间给予抗抑郁剂。

2. 醉酒

(1)诊断

①单纯醉酒:系急性酒中毒,在一次大量饮酒后出现的反常行为,最初表现为脱抑制行为,如话多、兴奋、易激惹、冲动。随饮酒量增加进入抑制状态,表现为判

断力下降、共济失调、言语不清、水平眼震、记忆丧失、嗜睡和昏迷,伴有呕吐和心率增快。深度抑制可导致死亡。

②病理性醉酒:少量饮酒后出现中毒症状,常以深睡结束。

(2)治疗原则

①轻者无需特殊治疗,重者应洗胃及实行血液透析。

②维持水电解质平衡。

③吗啡拮抗剂纳洛酮:肌肉或静脉给药 0.4~0.8 mg。如果改善不明显,可每 2~3 分钟重复一次。此后给予 1 000 ml 液体中加入纳洛酮 4 mg 维持。

3. 震颤谵妄

(1)诊断:为酒急性戒断的严重症状,临床表现为长期大剂量饮酒后突然停酒几小时或几天出现意识模糊、时间地点定向错误、近记忆困难、幻觉妄想(幻觉多为恐怖性)和恐惧不安;体征可见粗大肢体震颤和自主神经功能障碍(出汗、心跳快、血压高、瞳孔扩大),可伴有脱水、电解质紊乱、肝功能异常。

(2)治疗原则

①地西泮,10~40 mg 静脉注射,直至症状缓解。随后给予地西泮维持剂量 20~60 mg/d 达 5~7 天。此后以每日递减 5%~10%。在递减过程中如果症状反复,则调至前 1 天剂量并维持 2~3 天再行逐日减量。

②可给予抗精神病药物:氟哌啶醇 4~10 mg/d。

③维持水电解质平衡并给予维生素 B₁ 100~200 mg/d,3~5 日。

④流食,避免噎食窒息。

4. 酒中毒性幻觉症和妄想症

(1)诊断:长期饮酒后在意识清楚时出现幻觉(多以幻听为主),或妄想(多以嫉妒妄想或被害妄想为主),可同时伴有兴奋、激越、伤人或自伤等行为异常。

(2)治疗原则

①戒酒。

②抗精神病药物治疗,多选用氟哌啶醇或奋乃静治疗,治疗方法和治疗用量同精神分裂症治疗。

5. 慢性酒中毒性脑病

(1)诊断:多指长期饮酒所导致的柯萨科夫精神病(Korsakov psychosis)和威尼克脑病(Wernicke's encephalopathy)。柯萨科夫精神病表现为极度近记忆缺失,虚构或错构症,可由震颤谵妄过渡而来。威尼克脑病缘于维生素 B₁ 摄入不足或吸收不良所致,表现为意识障碍、共济失调、眼球震颤或动眼麻痹、情感淡漠、记忆障碍。

人的声音,有说他好的,也有骂他的,如“小华子,操你妈”,还有说他强奸女人,告诉他他儿子被人害了,还有人要杀他等,但就是看不见说话人,找也找不着。有时又似乎能看见别人看不见的东西,如鬼、人等。患者称曾看见过一米多高的人变成了巴掌那么大的小人,还是女人,曾被自己“抓住”过。

交谈间反应较迟钝,思维迟缓,病理性赘述。可引出大量被害妄想,患者诉有人要杀他,还说自己的肝肾没有了,让人给挖走了。

主动注意减弱,对周围事物无明显主动反应,被动注意范围较狭窄。

计算力差,一般运算困难,理解判断、抽象思维及概括能力欠佳,反应较迟钝,欠准确。

远近记忆力保持尚可,近记忆力欠佳,瞬间记忆障碍明显,华某记不清入院具体天数,记不清近日来的经历,不能倒数四位数字。

对病态表现无自知力,无主动求治心,但可被动服从治疗。

情感不稳定,易激惹,谈至伤心处流泪,病友打搅则易激怒、冲动。

除希望饮酒外,无其他高级意向要求,卧床少动,与周围环境无主动接触,生活料理需人督促。

治疗经过:

入院后经服哌啶醇和地西泮替代递减治疗,症状逐渐减轻。于住院 49 天自动要求出院。

出院诊断:

酒精所致的精神和行为障碍:急性中毒伴有谵妄(ICD-10:F10.03),酒依赖综合征(ICD-10:F10.23),精神病性状态(ICD-10:F10.53)

(四) 镇静催眠剂依赖之戒断症状

镇静催眠剂主要包括巴比妥类和苯二氮卓类药物,如司可巴比妥(速可眠)、地西泮(安定)、三唑仑(海洛神)、罗拉(罗拉西泮)等。

1. 诊断

长期使用(数周或更长)中等或高量的催眠镇静剂,一旦停止用药或减少用量时,出现恶心或呕吐,全身不适或无力,心动过速或出汗,焦虑或激动,姿势性血压下降,手和舌与眼睑粗大震颤,失眠加重,癫痫大发作。

2. 治疗原则

(1) 同类药物替代递减治疗。

(2) 治疗方案:根据滥用剂量使用地西泮 20~60 mg/d 分 3 次服用进行替代。

充分剂量维持 2~3 天后以每日 20% 的速度递减。在递减过程中出现焦虑激动或睡眠障碍者给以三环类抗抑郁剂。

3. 典型病例

患者顾某,男性,65 岁,大学文化,退休。

主诉:因服用镇静安眠药 30 余年,停药该类药物后失眠、自语、行为紊乱 2 周入院。

现病史:20 世纪 60 年代末期,患者因睡眠不佳开始服用镇静安眠药,最初的 3 年患者只在入睡困难时口服地西洋 2 片。70 年代末期患者开始不间断地于睡前服用地西洋 3~4 片。20 世纪 80 年代初期,患者为了达到满意的睡眠效果,开始尝试使用多种药物,先后使用的药物有地西洋、佳静安定、舒乐安定、水合氯醛等,且用药剂量逐渐增加。20 世纪 80 年代末期,患者自觉停药后心神不宁、易激惹、注意力涣散、全身乏力、做事缺乏效率,服用镇静安眠药可以使以上的不适明显缓解,便主动服用镇静安眠药以缓解躯体及精神不适,使用剂量不断增加,至 1995 年患者每日需使用地西洋或佳静安定 40 余片方可勉强度日。于是患者换用速可眠,每日用量 20 余片。随着用药时间和用药剂量的不断增加,患者家属发现其对周围事物日渐冷淡,个人生活也变得马虎随便,爱好丧失,1998 年底已无法正常工作。患者家属反复劝其停用镇静安眠药,患者本人也感到一种无形的压力。1999 年 8 月 23 日患者开始自行减服速可眠,8 月 30 日停药。停药当日患者即出现坐立不安、易激惹、失眠等症状。停药第 5 天患者生活已不能自理,情绪极度不稳定,每到夜幕降临患者的异常表现也随之增多。患者对其家属说能看到有人在墙上跳舞。言语凌乱,有时突然大声叫喊。其家属无法护理,故于患者停用镇静安眠药后第 14 天送患者住院治疗。

既往史:否认其他病史。

体格检查:

未见任何异常体征。

实验室检查:

血生化、血常规、心电图、脑电图、腹部 B 超等均正常。

精神检查:

意识不清,时间、地点、人物定向丧失,认为身处农村,不认其妻。苍老面容,接触困难,生活不能自理,对检查不合作。自述能看到墙上、床上和地上有虫子爬行,言语不连贯,表情恐惧。

入院诊断:

镇静安眠药依赖

治疗经过:

(1)促大脑代谢治疗。

(2)地西洋替代递减治疗 35 天,最高日剂量 30 mg 维持 4 天。

1999 年 10 月 14 日痊愈出院。

(五)兴奋剂所致精神障碍

中枢神经系统兴奋剂与阿片类麻醉剂的作用截然不同,兴奋剂可使个体处于高度警觉状态、活动增加、睡眠减少和食欲减低;大剂量时,可导致刻板动作;超大剂量的致死原因不是像阿片类所引起的呼吸抑制,而是由于心血管系统合并症或抽搐。

这类药物包括苯丙胺、甲基苯丙胺、MDMA、MDEA、MDA 等。考虑到甲基苯丙胺和 MDMA 会形成依赖的可能性和对于人体的危害,我国将其列为第一类精神药品。

据报道,我国滥用者所滥用的“摇头丸”为甲基苯丙胺和 MDMA 的混合物与掺杂物,因滥用后可即兴随音乐剧烈地摆动头部而不觉痛苦,因此得名“摇头丸”或“摇头乐”。滥用者多为城市青年。

1. 滥用后一般表现及急性中毒

苯丙胺在中枢为兴奋作用,在外周发挥拟交感作用。

外周作用包括提高收缩压和舒张压,低剂量时由于心输出量增加而反射性地降低心率,高剂量可出现心动过速和心律失常。

中枢兴奋作用包括刺激延髓呼吸中枢使呼吸频率和呼吸深度增加。对于脑干、间脑和皮层的兴奋作用可使肢体活动增加、睡眠减少和体温升高。大剂量使用可导致刻板动作。对下丘脑侧部的摄食中枢的抑制作用,曾使其作为食欲抑制剂而用于治疗肥胖症。

苯丙胺对精神活动的影响包括其振奋精神和导致欣快的作用。振奋作用可能与增强中脑网状结构的去甲肾上腺素能神经活动有关。用药后出现的欣快、焦虑和抑郁等情绪变化与其影响边缘系统的多巴胺功能有关。对于皮层的多巴胺神经元的影响可能是导致长期滥用者判断力和自知力损害的结果。

2. 长期滥用中毒

典型的慢性中毒症状有幻觉、偏执观念和妄想,同时伴有注意力和记忆损害。苯丙胺精神病是由苯丙胺滥用引起的且持续时间较长的中毒性精神障碍。其基本

特点是:援引观念,被害妄想或夸大妄想,并在意识清晰的状态下出现幻听或幻视,症状表现与偏执型精神分裂症相似,也正是由于二者症状的相似性才引出有关精神分裂症生化模式的学说。具有苯丙胺样作用的药物(如二乙胺苯丙酮和利他林)大都可引起苯丙胺精神病。中毒性精神病可在长期用药中逐渐出现,也可在一次静脉注射后发生。一般多在用药后 36~48 小时出现,当药物被注射滥用时则更容易发生。上述症状在停止滥用后的数星期内可以自行恢复。恢复期间幻觉最先消失。

3. 治疗与预防

治疗与预防措施参见可卡因部分内容。本部分将就苯丙胺滥用时所特有的医疗问题加以介绍。

一次大剂量滥用可导致兴奋、意识障碍、头痛、胸痛、高血压危象、心动过速、大汗、瞳孔扩大,进一步可发展为谵妄、感知觉障碍、呼吸急促、心律紊乱、高热、抽搐、休克、昏迷直至死亡。

抢救措施包括控制兴奋,补充能量和防止受伤。对于极度兴奋的患者在选用镇静药物时应谨慎从事。巴比妥类会加重谵妄,且会加重兴奋后抑制;抗精神病药物如氟哌定醇、氯丙嗪虽然可以控制谵妄和自伤行为,但有时会导致抽搐发作。因此控制兴奋多主张静脉给予地西泮或苯妥英钠,必要时应施行心电监护。由于 β -受体阻滞剂可使 α -肾上腺素能的翻转作用会使血压增高,因此对于出现高血压危象者宜使用柳胺苄心定(labetalol)或 α -受体阻滞剂如酚苄明(phenoxymethamine)和酚妥拉明(phentolamine),也可以直接使用血管扩张药如硝普钠(nitroprusside)。利尿和尿液酸化有利于药物的排出。对于极重病例可采用腹膜透析或血液透析。

医疗预防重点在于减少对药品的需求,教育重点人群为青少年。教育青少年了解毒品,使他们认识到,使用兴奋剂可能会带来短暂的舒适,但是会带来终生的痛苦。同时辅导青少年正确处理负性生活事件的方法,培养他们欣赏勤奋好学、助人为乐的高尚人格品味,使心理成熟向健康方向发展,增强防毒能力。同时培训家长和教师,使他们及时发现青少年滥用药物的蛛丝马迹并及时制止。

4. 典型病例

现病史:患者张某某,男性,19岁,某服装学院大学2年级学生。患者常于周末与朋友一起光顾住家附近的迪斯科舞厅。半年以前在朋友的劝说下服用半片“摇头丸”,用药半小时后即感到头晕,随即出现爱讲话,愿和他人交谈,口渴,出汗,磨牙等症状。在通宵的跳舞过程中不觉疲乏,并随其他舞者不住地摇头。起初只是到周末才和朋友一起服用摇头丸,2~3个月后,即使不是周末也要自己去舞厅,

为的是能找到这种药片,并体验用药后舒服的感觉,同时服用剂量逐渐增加。就诊前每次服用2~3片。服药6~8小时后感到疲乏无力,入睡醒来后觉极度饥渴,情绪郁闷,精神不振,此时希望夜晚尽快到来,以便尽快体验用药后的舒适感。由于其父母发现其学习成绩下降,双手轻微震颤,且听其他同学反映其经常旷课,经常出入舞厅,故携其前来就诊。

查体及治疗经过:

入院尿苯丙胺类检查呈阳性反应。精神检查:意识清楚,消瘦,双上肢静止性震颤。反应较迟钝,未述特殊不适,但言语量较少,语音较低,称虽服用摇头丸并没有上瘾。入院后给予促大脑代谢治疗。睡眠不佳给予阿普唑仑片对症治疗。治疗1周后,体质较前恢复,情绪较入院时稍显活跃,在本人强烈要求下由父母接出院。

出院诊断:

苯丙胺类药物滥用,苯丙胺类药物依赖

(六)可卡因滥用所致精神障碍

可卡因是成瘾性最强的药物之一。可卡因来自一种生长于南美的叫做“Erythroxylon”的古柯类植物。目前,古柯叶的主要产地为秘鲁、玻利维亚、哥伦比亚等。

1. 可卡因滥用与依赖

可卡因主要滥用方式有:咀嚼古柯叶,鼻吸、静脉注射和抽吸可卡因等。中低剂量时可卡因引起愉快感、警觉度提高、精力旺盛、不知疲倦,以及包括听、视和触觉在内的各种感官的灵敏度显著提高、自信心增强、丧失食欲和睡眠需要减少或睡眠不能。生理反应有收缩压和舒张压增高、高热,心率减慢,对延髓呼吸中枢则起兴奋作用。

大剂量时可卡因的以上作用加强,会出现无目的刻板动作甚至精神病样表现。快感代之以抑郁情绪与欣快感相混杂的体验,过分自信,情感变化迅速,易出现类似于轻躁狂的冲动行为,伴有思维速度加快,语量过多,谈话内容不适当等。随后则表现为过度疲倦、睡眠增多和抑郁少动。其中一些体验令滥用者感到厌恶。因此很多滥用者将可卡因与海洛因混合滥用,以期用后者减轻这种不适的体验。

长期和反复滥用可卡因可出现一些体表特征,如鼻中隔穿孔、“快克”角膜炎(“快克”是一种表面麻醉剂,抽吸时滥用者的角膜可能被自己吐出的含有“快克”的烟雾所麻醉,因此当揉搓眼睛时可能由于不感到疼痛用力过大而损伤角膜)和因过度磨牙而造成的牙齿损伤等。

有关可卡因的耐受性研究发展迅速。在过去很多年中可卡因一直被认为只有心理依赖性而无躯体依赖性,近年来的临床研究和生物化学研究结果均证实可卡因长期使用可引起中枢神经系统的适应性改变,即可引起躯体依赖。

在停用可卡因后 4~8 小时滥用者会出现极度疲乏及困倦,进入较长时间的睡眠,并感到无精打采和情绪低沉,同时伴有饥饿感及对可卡因的强烈渴求。有些人在此期间还会出现自杀企图和行为。

2. 精神障碍的临床表现及诊断

(1) 急性中毒

可卡因为致惊厥剂,单剂量即可诱发癫痫发作,重复使用可引起癫痫慢性化,可卡因所致高热亦可诱发癫痫发作。此外,可卡因滥用还可引起颅内出血、抽搐、持续性或机械性重复动作、共济失调和步态异常。以上异常大多会在停药后逐渐消失。

(2) 慢性中毒

长期大量使用可卡因还可引起类似慢性脑器质性综合征的症状,病人表现为反应速度下降、短期记忆力下降和共济运动障碍。以上表现可在停用可卡因后相当长一段时间内持续存在。

在精神活动方面,长期滥用者会出现过度警觉,重者可出现类似精神分裂症样的疑心和关系妄想。同时常伴有不同程度的刻板动作、固定妄想和自知力丧失。依滥用剂量的不同病人还可出现听觉过敏和片断的幻听,有时还可出现注意力障碍和思维障碍等类躁狂症的表现。在情感活动方面,长期滥用会导致心境障碍和体验愉快感的能力下降。有个案病例报道有人停用可卡因 10 年后仍有无力、不能体验愉快感和对可卡因的渴求感。

可卡因性精神病:“可卡因性精神病”特指长期滥用可卡因后所引起一系列精神症状,主要表现为偏执妄想,现实检验能力下降,焦虑不安,刻板重复动作,生动的幻听、幻视和幻触等。其他精神障碍有谵妄、进食障碍和人格障碍等。

3. 治疗

对于可卡因滥用者应针对病人身体、精神、婚姻、家庭及就业等各方面的问題制订综合治疗措施。

(1) 药物治疗

药物治疗包括:针对戒断症状和由于滥用药物所致的躯体和精神障碍进行对症治疗。抗抑郁剂和多巴胺受体激动剂是目前常用的治疗药物。常用的抗抑郁剂有:去甲丙咪嗪、丙咪嗪、氟西汀、丁氨苯丙酮;多巴胺受体激动剂有:溴隐亭、金刚

烷胺、硫丙麦角林(pergolide)、氯苯咪唑啉(mazindol);其他药物还有抗癫痫药(如卡马西平)、阿片受体拮抗剂(如纳曲酮)、阿片受体部分兴奋剂(如丁丙诺非)。此外,钙通道阻滞剂及抗精神病药物及复合维生素B、维生素C和叶酸也被试用于可卡因滥用的治疗。

对于出现类似精神分裂症样的病人可选用诸如氯丙嗪、氟哌啶醇等抗精神病药物。但通常不需要使用,原因之一是抗精神病药物可加重病人对可卡因的心理渴求,可能的原因为抗精神病药物阻断多巴胺受体所致。其次,可卡因中毒性精神病通常持续短暂,症状一般在48~72小时之内消失。

目前可卡因急性中毒还没有特异性的拮抗剂治疗。动物实验提示卡马西平能有效地控制可卡因滥用引起的癫痫发作,进而减少可卡因中毒的死亡率。

药物治疗的另一方面是预防复吸治疗。对可卡因致欣快作用的渴求是导致复吸的主要原因。目前认为多巴胺系统在可卡因奖赏过程中起重要作用,因此预防复吸治疗的目标是恢复由于滥用可卡因而受到破坏的多巴胺系统的功能。常用的药物有溴隐亭。其理论基础是溴隐亭可能会逆转长期滥用可卡因而引起的多巴胺受体超敏感化和多巴胺耗竭,通过释放足够量的多巴胺来减轻渴求并最终达到多巴胺系统的内稳态而不引起复吸。常用日剂量为2~10 mg,使用方法为缓慢加量多次口服。

(2) 非药物治疗

无论处在哪一时期的病人,非药物治疗都是必不可少的重要组成部分,而在防止复吸和巩固操守方面则更强调包括行为治疗、心理治疗、家庭治疗、小组治疗、康复治疗 and 各类预防复吸治疗和就业培训等在内的综合治疗措施。药物治疗可作为上述治疗的辅助手段。

4. 典型病例

患者周某某,男性,21岁,于1999年3月4日因吸食可卡因和海洛因3年余入院治疗。患者于14岁时随舅舅前往德国学习,3年前因在餐馆打工下班后感疲劳且无聊,在当地朋友的劝说下开始鼻吸可卡因。吸后感兴奋并可体验到舒适感,数天后开始自己购买可卡因,数月后开始烫吸“熟可卡因”即“快克”,为克服在吸食可卡因过程中体验到的恐惧和不安,于1年前开始同时吸食海洛因。开始还可以维持在晚上吸毒,白天勉强工作。但近1年来,已不能正常工作,被解雇。患者曾多次在当地接受美沙酮维持治疗,但治疗期间仍不断吸食可卡因,美沙酮维持治疗也从未超过20天。应其本人要求,回国由其母亲陪伴来院治疗。经系统美沙酮替代递减治疗和抗抑郁治疗3周后出院,出院尿液吗啡及可卡因检查阴性。出院后

患者即返回德国。

3 个月后,患者再次以吸食可卡因和海洛因不能自行停药而入院。经 15 天美沙酮和抗抑郁剂系统治疗后经认知心理治疗于 30 天后出院。出院诊断可卡因依赖和海洛因依赖复发。

(七) 致幻剂滥用所致精神障碍

致幻剂是一类在不影响意识和记忆的情况下改变人的知觉、思维和情感活动的化合物。致幻剂大体上可分为麦角衍生物(如麦角酰二乙胺, LSD)、吲哚烷胺类(如西洛西宾)、苯烷胺类(如麦色卡林)和其他类(如苯环乙哌啶, PCP)。其中以 LSD 和 PCP 最具代表性。从药物作用的特点可划分两大类,与 LSD 类似者包括麦色卡林、西洛西宾、二甲基色胺(dimethyltryptamine, DMT)等,与 PCP 类似者有麻醉药氯胺酮(ketamine)、右啡烷(dextrorphan)等。

1. 致幻剂滥用与依赖临床表现及诊断

致幻剂滥用主要集中在年轻人。目前在西方年轻人中主要以吸烟和静脉注射的方式滥用为主。

致幻剂具有较高的依赖潜力,除作为精神病研究以外,几乎没有药用价值。致幻剂以心理依赖为主,戒断症状表现为焦虑或抑郁情绪、睡眠增多、食欲增加、非真实感、人格解体及其他交感神经系统耗竭的症状。上述戒断症状会持续数日或数月,少数甚至可持续数年。

致幻剂会引起人的感知觉和情绪的改变。滥用者多在用药后产生幻觉或错觉、空间定向障碍、人格解体、情绪变化、眩晕、体感异常和颤抖。同时可体验到欣快、愉悦的感受。过量中毒可导致高血压、抽搐和心律失常。死亡的原因多为心律失常和脑血管意外。

如果在用药过程中经历的是愉快体验就称之为“快乐之旅”(good trip);反之是以焦虑、恐怖为主时则称之为“倒霉之旅”(bad trip)。用药后的体验具有不可预测性,即使过去都经历“快乐之旅”,下一次用药可能就要经历“倒霉之旅”,因此“倒霉之旅”并没有一个可靠的办法可以预防。无论是经历“快乐之旅”还是“倒霉之旅”,其主观感受可持续 6~12 小时。但症状完全消失则需要 12~24 小时。

“回闪症状”(flashback)是 LSD 以及其他作用类似的致幻剂滥用时所特有的精神症状。其特点为,在不用药情况下出现的既往用药反应。“回闪症状”甚至可在停药数年后发生,诱发因素多为进入黑暗或安静的环境、吸食大麻或苯丙胺、饮酒后、疲劳、焦虑或紧张情绪时。目前多数学者认为“回闪症状”可能是由于储存在

体内的药物的再释放所引起。

2. 治疗

由于致幻剂依赖戒断时无明显戒断综合征,因此戒断时无需特殊治疗。当滥用药物过程中经历“倒霉之旅”时,需及时采取治疗措施,以防自伤或伤人。治疗多采用交谈的方式,让患者充分了解目前的状态是由于服药所引起,以克服恐惧。对于恐惧症状严重者可口服氯丙嗪 25 mg 或地西泮 10 mg,药物治疗会加强交谈的效果。但剂量不宜过大,因氯丙嗪与滥用药物的抗胆碱作用叠加后有诱发谵妄的危险。

长期滥用者引起的中毒性精神病表现为认知障碍或情感障碍。中毒病程迁延时与精神分裂症或情感性精神病的表现极其类似,如果不通过了解病史,有时很难鉴别。出现慢性中毒性精神病时可选用治疗精神障碍的药物治疗。

3. 典型病例

患者宋某,女性,19岁,职业服装模特,患者在某迪斯科舞厅跳舞时被带到我院,经尿液检查苯丙胺类阳性。后患者承认曾服用摇头丸,但平时主要服用一种被称作“小邮票”的药物,用药后可感到周围所看到的人或物都变为一种特殊的形状和颜色,别人说话的声音也变得遥远,对于这种变化觉得非常好笑,于是不住地自笑,同时体验到一种莫名其妙的舒适感,5~6小时药物作用逐渐消失,为寻找用药感受会接着服用半片,药物作用消失后感到疲乏无力并很快入睡。第2天睡醒后无特殊不适,但觉懒散,不愿见人,不愿讲话,有时因此而找借口不去工作或进行形体训练。每到夜色降临时很想去舞厅以便可以找到机会服用药物。入院后未做特殊处理。经1周心理治疗后出院。

出院诊断:

致幻剂滥用

(八)挥发性有机溶剂的滥用与依赖

挥发性有机溶剂主要有醇类、汽油、芳香烃类(苯和甲苯)和亚硝酸类等。

挥发性溶剂的滥用者,除亚硝酸酯外,多集中在9~19岁的青年和青少年。国外亚硝酸类气雾剂的滥用多集中在年长者或同性恋者。

1. 挥发性溶剂的滥用与依赖

滥用方式多为鼻嗅或口吸。若是胶状物则通常涂于塑料袋或纸袋底部,将袋口集中在口鼻上闻吸,直到产生快感或液体全部蒸发。滥用者多三五成群聚在一起滥用。多数青少年为偶尔尝试,其中约10%成为持续滥用者。据有关调查显

示,挥发性有机溶剂的滥用常与日后形成烟草滥用、酒精滥用及其他毒品滥用有关。

人类对于挥发性溶剂具有明确的心理依赖、强制性和反复滥用以及戒断后复吸的特点。依赖多在经常滥用后 3~6 个月形成。滥用者通常固定使用某一类型的含有溶剂的胶水、涂料或清洁剂,甚至固定使用某一品牌。国外报道有些依赖者每天可使用每支含 21 ml 的胶水 25 支。

目前对于溶剂的躯体依赖性仍存有争议。有些学者认为,可能是由于大多数溶剂在体内的作用时间很短,且间断用药的方式使躯体依赖症状不容易被观察到。典型的症状可在撤药后 6~24 小时出现,表现为细微的静止性震颤、易激惹、焦虑、失眠、对刺痛感过敏,少数病例会出现抽搐发作。

由于挥发性溶剂的滥用人群为青少年,而此类物质的神经毒性很强,因此对青少年滥用者危害极大。这一类物质的中枢作用类似于乙醇或巴比妥类的中枢抑制剂,伴随用药后的欣快感,滥用者闻吸后都会出现言语不清、共济障碍、知觉障碍、眩晕和宿醉样感觉,上述感受持续约 15~45 分钟,此后进入 1~2 小时昏睡和僵住状态,并逐渐清醒。在滥用时或清醒后还会体验到一些畏光、复视、恶心、腹泻、胸痛和肌肉关节痛等不适感。中毒严重者可导致中枢抑制,出现大小便失禁,最终可因呼吸心脏抑制而死亡。

慢性中毒者表现为头痛、头晕、乏力、失眠多梦、记忆力减退等。依滥用溶剂种类不同,会出现心肌受损、肝细胞变性和坏死、再生障碍性贫血、白血病、周围神经炎、小脑及大脑变性等。

2. 治疗原则

- (1)立即停止滥用有机溶剂。
- (2)促大脑代谢治疗。
- (3)对于戒断期出现较严重失眠和焦虑的患者可短期使用抗焦虑药物。

3. 典型病例

患者白某某,男性,13 岁,因好闻汽车尾气 6 年余由其母亲携其就诊。患者从 6 岁开始,好闻汽车尾气。开始家长对此未予理会,但后来发现每次其父在发动摩托车时,患者都要停留在汽车尾部闻吸尾气,当父母制止他时患者会哭闹,表示不悦,由于孩子随其祖母长大,平素比较娇惯,因此未予阻止。此后患者每每听到邻居发动汽车都要过去闻吸。因患者对上学没有兴趣,自二年级停学后一直未上学。就诊时患者周身散发出汽车尾气的味道,患者不住地哭闹,智力水平停留在 6~7 岁。由于患者家属不同意住院治疗,因此给予地西洋及多塞平带回家治疗。1 周

后,再次就诊时患者情绪较前稳定,1 周来未再因不允许闻吸汽车尾气而发脾气,睡眠也有所改善。此后未再来门诊治疗。

(九)烟草滥用与尼古丁依赖

烟草滥用特别是吸烟是本世纪影响人类健康、引发各种疾病和导致死亡的最重要原因之一。

1. 烟草滥用

烟草的滥用方式大致有 3 种:咀嚼、鼻吸和口吸。吸烟是最常见的滥用方式。

吸烟的方式大致有 3 种:偶尔吸烟者只是满足于饭后或某些特殊场合吸烟。中等程度吸烟者多使用固定品牌的香烟,并以相对固定的间隔享用,间隔时间因人而异,从 15 分钟到 2、3 个小时不等。依赖严重者的吸烟方式常为“链式吸烟”(chain smoking),这些人除吃饭或睡觉以外,总是烟不离口。

2. 吸烟与烟碱依赖及戒断症状

烟碱可导致一定程度的心理依赖和躯体依赖。在部分吸烟者,心理效应的原因可由于中枢神经系统的兴奋作用而引起,也有的滥用者则更欣赏在短暂兴奋后的抑制作用。

吸烟习惯形成的原因并非由于烟草可导致“飘”的感觉所致,究竟烟碱在烟草依赖中起决定作用抑或只是一种伴随因素,目前尚存在争论。

烟碱的生理依赖即戒断时的症状和体征比较轻微。典型的烟碱躯体戒断症状在突然停吸后 1~2 小时出现。戒断症状包括对吸烟的渴求增加、坐立不安、注意力下降和易激惹。这些症状会持续数日,数周甚至数月。

3. 治疗与预防复吸

(1) 淡化性治疗

淡化性治疗是指不依靠任何药物,用逐渐递减吸烟数量的方法达到戒烟的目的。方法是将原来烟碱含量较高型香烟更换为烟碱含量较低者,随后再开始逐渐减量,或者开始时鼓励患者抽吸本人不喜欢品牌的香烟,以减少在想像吸烟时的愉快回忆。并在此基础上逐渐减量直至完全停止吸烟。

(2) 可乐定治疗

可乐定可减轻戒烟时出现的渴求感、易激惹、焦虑和坐立不安等戒断反应。其作用机制可能与抑制在烟碱戒断时蓝斑和杏仁核部位肾上腺素能神经的亢进活动有关。但可乐定用于戒烟治疗的剂量应大大低于阿片类脱瘾治疗所使用的剂量。可乐定透皮剂因其释放速度恒定、血液浓度变化小、毒副作用较轻,因而较口服制

剂更适合于烟碱依赖的脱瘾治疗。

(3) 心理治疗与社会支持治疗

心理治疗包括行为矫正性治疗和认知治疗,目的在于改变吸烟者已形成的与吸烟有关的行为方式和思维常规模式。可以根据接受治疗者的特点进行个别心理治疗、集体心理治疗和家庭治疗。运用心理治疗中行为矫正、奖惩与惩罚、共立戒烟协议书、厌恶疗法、放松疗法等技术,帮助患者树立自信心,纠正吸烟的不良习惯。

4. 典型病例

患者刘某,女性,26岁,证券公司职员。因吸烟5年,近1年吸烟量增加,不能自行戒除而就诊。患者于5年前开始因找工作的事感到心神不定而开始吸烟。近1年因工作紧张,同时与丈夫因家庭琐事经常发生口角,感到心情烦闷吸烟量增加,每日吸纸烟30~40支。每每遇心烦时吸烟,直至心情平静为止。自己也曾试图减量或完全戒除,但均告失败,且吸烟量逐渐增加。患者近来失眠,咳嗽加剧,常感到周身无力,爱发脾气。除双肺呼吸音粗和散在哮鸣音外,体格检查和神经系统检查无阳性所见。经可乐定0.3~0.4 mg/d,曲唑酮100 mg/d治疗15日,吸烟量减少至1~2支/d。

半年后患者再次就诊,述经上次治疗后保持2个月未吸烟,但3个月前因与公婆发生口角开始再次吸烟,且吸烟量增加很快,此次就诊前每日吸烟40~50支。采取如上治疗15天后停止吸烟,继续20天心理治疗。此后未再来就诊。诊断:烟草依赖。

二、非依赖性物质所致精神障碍

+++++

系来自体外不具有依赖性,但可影响个体精神状态的物质所致的精神障碍,亦称中毒性精神障碍。

(一) 铅中毒所致精神障碍

1. 诊断标准

(1) 有明确的铅接触史。

(2) 急性中毒精神症状表现为急性谵妄状态,由于幻视,病人表现恐惧、不安、兴奋,并可以出现被害妄想。同时可出现四肢抽搐,癫痫样发作,恶心、呕吐,腹绞痛,中毒性肝病和肾病,以及贫血躯体和神经系统体征。

(三) 锰中毒精神障碍

常见于开采锰矿、冶炼金属锰及在陶瓷、玻璃、塑料、干电池等工业工作者。锰是一种细胞毒,选择作用于中枢神经系统纹状体苍白球及视丘等部位,使纹状体抑制性神经介质多巴胺含量减少。中毒早期有功能性的改变,停止接触后可完全恢复,也可发生神经细胞退行性变,锰中毒主要为慢性中毒。

1. 诊断

(1)精神症状:①早期出现脑衰弱综合征,如头痛、头晕及记忆力减退,可失眠,也可出现嗜睡;可有性功能减退,全身无力尤以四肢为重。这些症状有时可缓解有时加重。②有的病人易激动,出现强制性哭笑,有的表现欣快,有的迟钝淡漠。

(2)躯体及神经系统体征:①锥体外系损害症状。帕金森综合征,严重时表情呆板,呈面具脸,步伐小而急促,出现前冲和后退步态,轮替动作不灵活,小书写症,言语困难,含糊不清等。②锥体系统损害症状,如腱反射亢进,踝阵挛、腹壁反射减弱或消失,出现病理反射。③自主神经功能紊乱。④甲状腺机能轻度亢进,有的病人可引起肝、肾功能改变。⑤锰中毒病人血锰、尿锰、粪锰可以增高。

2. 治疗原则

(1)离开中毒环境,给以多钙质的食物。

(2)驱锰治疗:依地酸钠钙肌肉注射或静脉点滴。

(3)精神症状:地西泮 2.5~5 mg,每日 3 次,或利眠宁 10 mg,每日 3 次。

(4)对症治疗:安坦、东莨菪碱、开马君(kemadrin)等抗胆碱药以及左旋多巴等。

(四) 苯中毒所致精神障碍

苯是工业上广泛应用的原料和溶剂,主要由呼吸道吸入机体,皮肤也可吸收少量。急性中毒时,主要损伤中枢神经系统,慢性中毒时骨髓及血液变化占主要地位。

1. 诊断

(1)急性苯中毒精神症状表现为:酒醉状态,吸入高浓度的苯可出现意识障碍,谵妄或昏迷,同时伴有神经系统症状及体征,如脸红、手足发麻、多汗等。重者出现抽搐,瞳孔散大,对光反应迟钝等。可见流泪、咳嗽、结膜充血等黏膜刺激症状。

(2)慢性苯中毒的早期可出现脑衰弱综合征,并出现白细胞数降低及血小板减少和出血倾向等造血系统功能的障碍。

等。诊断“一氧化碳中毒”，治疗给予高压氧及静脉输入营养脑细胞药物等。10天后病情平稳遂改用中医调整治疗，20天后病人出现兴奋话多，无故发脾气，言语凌乱，如说：“农村就不中煤气，农村的房没有房顶。”还说：“我要跟老公公自卫。”夜眠差，有时半夜起来乱翻东西，病情加重2天，整夜不眠，影响他人休息，故转入我院。

既往史：1974年患肺结核后治愈，患慢性“胃病”10余年，否认其他病史。

个人史：胞4行2，适龄上学，初中毕业，1971年参加工作，工作能力一般，1980年结婚，夫妻感情好。病前性格：较开朗，大方，但不善交往，不善言谈。

家族史：家族中无精神疾病患者。

体格检查：

未见任何异常体征。

实验室检查：

生化、血常规、心电图、脑电图、B超均正常。

精神检查：

意识清楚，接触尚好，年貌相符，对检查合作，对答切题，定向力完整。否认有“幻觉”，承认有时自己跟自己讲话，但没有听见外边人说话，未引出妄想内容。远近记忆力、计算力、理解力均减退，如患者将100减7计算为83，83减7计算为76，而将76减7计算为80。情感淡漠，谈及其子夭亡时，无任何痛苦反应。自知力存在。患者在住院期间（入院后25天）出现过幻嗅、幻视、幻听，病人称：病房内总有臭味，认为是同室病人排的气而与人吵架，有时“看”到床底下有青蛙在一个小水坑里而钻到床下去捉青蛙，有时“听见”门外有人在叫她，出去找却没人。

入院诊断：

一氧化碳中毒性精神障碍

治疗经过：

1. 促大脑代谢治疗。
2. 奋乃静治疗最高日量24 mg。

1998年7月2日痊愈出院。

病例二

王某，男性，37岁，已婚，汉族，中专文化，某医院医师，于1992年5月12日首次住院。

主诉：2个月前因“煤气中毒”不省人事，恢复活能工作，10日前疑心被监视。

现病史：患者于1992年3月28日夜間发生煤气中毒，清晨被人发现时已意识

不清,昏倒在地,口吐白沫,当即被灌了几口醋,不久患者有了知觉,随即被送往急救中心抢救,经高压氧仓治疗病情恢复,10天后出院。出院后能坚持上班,完成本职工作。但此间患者仍感倦怠乏力,喜卧床,生活懒散,见了熟人不爱打招呼,但未引起家人注意。4月24日因孩子吃东西问题与爱人发生口角,5月2日出现经常窥视门镜,说门外站着一个20多岁的女人,怀疑被人监视,晚上把所有的灯都打开,经常乱开电视机但又不看。自己做饭后全部吃光,不给别人吃,有时生吃蔬菜,其妻问其为什么生吃菜,患者回答:“这种菜不叫生菜吗?所以我就生着吃。”日常生活需家人督促,如洗脸、刷牙都需别人督促,当叫他刷牙时就刷很长时间,如果没有人让他停止,他就持续刷个没完。5月7日到某医院就诊,当时检查计算力 $100-7$ 不知等于多少,于5月12日以“痴呆状态”收住我院。

意向活动:对今后的生活、工作无任何打算。

既往史:高血压史14年,曾患肺结核,后治愈。

个人史:同胞4人,行4,中专文化,1976年参加工作,工作表现好。平素性格开朗,热情助人,善交际。家族史阴性。

体格检查:

未见任何异常体征。

实验室检查:

血生化、血常规、心电图、脑电图、腹部B超等均正常。

精神检查:

意识清。感知觉:患者承认在家时经常看见有一个大姑娘站在门外。思维:语量少,语速一般,思维内容贫乏,回答问题简单,未引出妄想内容。智能:计算力差, $7+8$ 不知等于多少, $100-7$ 回答等于75。不能回答“坐井观天”、“画蛇添足”的含义,不知国庆节是什么节日。近记忆力减退,不能倒背5、6、7,当给病人看4样东西后,让病人回忆,只能回忆出3种,问其吃早饭了吗?回答“没吃”(实际已吃过)。远记忆力尚可。情感平淡。入院诊断:

一氧化碳中毒所致精神障碍

治疗经过:

奋乃静10mg/d治疗35天,促大脑代谢治疗35天。

1992年6月26日痊愈出院。

病例三

1. 病历摘要

患者女,37岁,已婚,汉族,大专文化。

主诉:2周来情绪低落,想死,夜眠差。加重2天,不语,行为怪异。

现病史:患者于1997年底无明显诱因出现右脚疼痛并波及右侧大腿及腰部。疼痛为持续性,同时发现右腹股沟处有数个形如花生米大小的肿物,无压痛。1998年10月22日—12月10日住某医院,诊为“非霍奇金淋巴瘤A期”,给予化学治疗10次。病情稳定后于1999年8月6日开始皮下注射重组人干扰素 α -2a 300万单位,每周3次,历时4个月。

1999年12月14日患者无明显精神诱因出现情绪低落,总说自己得病花了许多钱,觉得自己的精神支柱全垮了,入睡困难。1999年12月25日乘家人不备用手触电插销,企图自杀,被家人阻止而未遂。后又拿了剪刀要自杀,家人急送我院门诊。印象“抑郁状态”,于12月25日起给予氟西汀口服每日20mg,阿普唑仑每日0.8mg等药物治疗,未见明显效果。表现为脾气大,急躁,常因故打家人。患者有时诉说自己活着难受。常双手不停地摸衣服、被子,家人问话不予回答,目不转睛盯着一个地方。12月26日表现拒食,拒服药,呆愣不语,晚上觉得恐怖,说一闭上眼可以看见许多东西,觉得脑子特别乱。于1999年12月27日住我院。

既往史:于1997年患“非霍奇金淋巴瘤A期”,曾接受放射治疗。在入院前连续注射重组人干扰素 α -2a,历时4个月。

个人史:性格偏内向,随和,生活节俭,无特殊不良嗜好。

家族史:否认父母两系三代有精神病,性格异常及自杀史病人。

体格检查:

发育正常,毛发较稀疏。腹股沟及其他各处浅表淋巴结均未触及。心肺未见异常。腹软,肝脾未及。神经系统检查未见异常。

精神检查:

意识清楚,定向力完整。由家属扶入病房。更衣查体不合作。主被动接触差。饮食、起居需督促。语量少,语音低,对问话大多不作回答,在反复询问下偶尔说:“别问了,我心里什么都知道!”记忆、智能检查由于病人不合作无法详查。谈话时注意力尚能集中。交谈中患者流露出对未来丧失了信心,难以面对现实,甚至问医生:“我还能活着出这屋吗?”患者明显沮丧,表情忧愁,卧床不语,有时在床上保持某一姿势可以数分钟不动,或用手反复摸被子边缘,不与周围人接触。

治疗经过:

入院后停用重组人干扰素 α -2a, 每日睡前口服阿普唑仑 0.4~0.8 mg 及阿米替林 25 mg/d。1 周后精神状况逐渐好转, 患者言谈切题, 接触良好, 忧愁表情消失, 即停用阿米替林。自知力恢复, 患者称当时不知道为什么总是想死, 而且没有高兴的时候。于 2000 年 1 月 21 日临床痊愈出院。出院后随访 2 个月, 精神状况稳定。

诊断:

非成瘾物质所致精神障碍

2. 病例分析

(1) 诊断及诊断依据

此病例为女性, 中年发病。因患“非霍奇金淋巴瘤”皮下注射干扰素 4 个月后出现明显抑郁症状及自杀行为和睡眠障碍, 经停药后 1 周抑郁症状缓解, 符合有关文献报道的内容, 干扰素所致的精神病性毒副反应的可能性很大。

抑郁状态是精神科常见症状之一, 其自杀行为具有极大的危险性, 对病人的生存构成直接威胁, 而有些药物可以引起抑郁状态及其他精神症状, 应当引起各科医生的足够重视。

对药物所致抑郁状态首先应当停药, 给予适当的抗抑郁药或弱安定剂。精神障碍预后尚好。

(2) 鉴别诊断

①情感性精神障碍: 此患者精神症状表现为抑郁状态, 入院前表现有自杀行为, 需与情感性精神障碍的抑郁症鉴别。情感性精神障碍的抑郁症是以心境障碍为主导症状的精神疾患, 一般应持续数月, 伴有相应的思维和行为改变。但需排除脑器质性疾病与躯体疾病所致的精神障碍及其他原因所引起的情感障碍。此患者有“非霍奇金淋巴瘤”病史 2 年, 皮下注射干扰素 4 个月 after 出现抑郁症状, 经停药后 1 周后症状缓解, 而重性抑郁症多数病例抗抑郁药需使用 4 周左右才开始显效, 以后症状逐渐减轻直至消失, 另外抑郁症一般不经治疗常需要 6~7 个月才能缓解。本病例不符合上述过程, 不能诊断为抑郁症。

②应激所致精神障碍: 患者患有“非霍奇金淋巴瘤”, 曾接受化学抗癌治疗, 患者对自己所患的严重疾病的应激反应, 可能出现抑郁症状。但是本病例在用干扰素以前患者已经接受过化学治疗, 患者对疾病知情已经历时数月之久, 但是并无抑郁情绪, 可见本病例不符合应激所致精神障碍。

③脑器质性精神障碍: 此患者患“非霍奇金淋巴瘤”2 年, 需排除转移性脑瘤所

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名=精神障碍典型病例分析

作者=

页数= 3 9 4

S S 号= 1 1 0 8 7 3 9 5

出版日期=

封面页	
书名页	
版权页	
前言页	
目录页	
第一章	精神障碍及精神状态的检查
第二章	精神分裂症
第三章	情感性精神障碍
第四章	其他精神病性障碍
第五章	应激相关障碍
第六章	阿尔茨海默病
第七章	脑血管病所致精神障碍
第八章	癫痫所致精神障碍
第九章	躯体感染所致精神障碍
第十章	颅脑损伤所致精神障碍
第十一章	颅内肿瘤所致精神障碍
第十二章	脑变性疾病所致精神障碍
第十三章	躯体疾病所致精神障碍
第十四章	神经症及心理因素相关生理障碍
第十五章	人格障碍
第十六章	癔症
第十七章	精神发育迟滞
第十八章	儿童期精神障碍
第十九章	精神活性物质与非依赖性物质所致精神障碍
附录页	